RENOVA · GUIA CLÍNICO

Guia de ortopedia

plantão e ambulatório

Para o médico que assume a vaga de ortopedia no SUS e é, ali, o ortopedista de plantão e de ambulatório: o que perguntar, examinar, pedir, fazer na urgência, reduzir, imobilizar, receitar, seguir no retorno e o que vai para a cirurgia pela regulação.

Revisão	3ª revisão — 28 de outubro de 2026 (texto de 21 de outubro de 2026)
Conteúdo	11 capítulos · 54 tópicos · 167 manobras de exame · 37 procedimentos passo a passo, cada um com os 4 quadros da animação · cola do plantão com 98 textos prontos
Revisão por ortopedista	ainda não — texto próprio da Renova, baseado nas diretrizes citadas em cada tópico

Material de estudo e apoio à decisão. As doses são para adulto sem comorbidade, salvo onde o texto diz o contrário; confira a bula, o protocolo do serviço e o paciente à sua frente. A mesma versão está em guia-ortopedia.vercel.app e no app Guia de Ortopedia para Android, onde as ilustrações são animadas e a cola copia com um toque.

Como usar este guia

Cada tópico segue a ordem em que você atende. As seções são sempre as mesmas, para você achar o que precisa sem ler tudo:

Resumo	Uma linha: o que é e o que decide a conduta.
O que perguntar	Anamnese dirigida.
Exame físico	As manobras, em ordem: como fazer e o que significa quando positiva.
Sinais de alarme	O que não pode passar e o que fazer com cada um.
Imagem	Quando pedir e como escrever o pedido.
Na urgência	O que você, ortopedista de plantão, faz hoje — e com que o paciente vai para casa, fica ou é transferido.
Procedimentos	Redução, tala, gesso, bloqueio, punção, infiltração: quando, material, passo a passo e o depois.
Conduta	O não medicamentoso e a orientação ao paciente.
Receita	Adulto sem comorbidade, com os cuidados.
Imobilização	Tala, gesso ou órtese, quando cabe.
No retorno	O seguimento no ambulatório: controle, troca de gesso, quando indicar cirurgia.
Cirurgia e regulação	O que sai da sua mão — cirurgião, centro terciário, outra especialidade — e com que urgência.
Atestado e retorno	Dias sugeridos e quando rever.
Dicas e fontes	Bizus e as diretrizes em que o texto se baseia.

COMECE POR AQUI (PRIMEIRO DIA)

O que não espera	O que você resolve hoje e o que vai para a cirurgia	1.5 · p. —
Regulação	Como pedir a vaga e o que escrever	1.6 · p. —
Raio-X	Pedir e ler, por região	1.1 · p. —
Medicar a dor	Da veia à receita	1.2 · p. —
Bloquear e sedar	Hematoma, digital, fáscia ilíaca	1.7 · p. —
Tala e gesso	A técnica, passo a passo	1.3 · p. —
Puncionar e infiltrar	Joelho, ombro, punho, quadril	1.8 · p. —
Atestado	Dias por condição	1.4 · p. —

Nos nomes de tópico, "Sai da sua mão" abre sempre a seção de cirurgia e regulação: é o limite do que se resolve no serviço. Tudo antes disso é conduta sua.

Sumário

1 Primeiro dia: bases 5

O que vale para todo plantão e toda consulta de ortopedia — você é o ortopedista: leia antes do primeiro paciente.

1.1 Como pedir o raio-X 6
1.2 Analgesia em escada 9
1.3 Imobilizações e órteses 12
1.4 Atestado e afastamento 16
1.5 O que não espera: o que você resolve hoje e o que vai para a cirurgia 18
1.6 Regulação no SUS: quem vai para a cirurgia e como pedir 21
1.7 Anestesia local, bloqueios e sedação para reduzir 24
1.8 Punção e infiltração: joelho, ombro, punho e mão, quadril 30

2 Urgências do plantão 37

O que chega de ambulância: o que você faz nas primeiras horas é o que decide o membro — antibiótico, redução, tala, e a vaga pedida com o laudo certo.

2.1 Fratura exposta 38
2.2 Síndrome compartimental e gesso apertado 43
2.3 Fraturas da diáfise: fêmur, tíbia e úmero 47
2.4 Luxações de quadril, joelho e tornozelo 52
2.5 Fraturas do tornozelo (maléolos) 57
2.6 Fratura do úmero proximal 61
2.7 Fratura da patela e ruptura do aparelho extensor 65
2.8 Fraturas de pelve e sacro no idoso (e a pelve instável) 68

3 Coluna 72

Lombalgia é a consulta mais frequente; o trabalho é separar a mecânica (a maioria) do alarme (raro, mas grave).

3.1 Lombalgia aguda mecânica 73
3.2 Lombociatalgia e hérnia de disco 76
3.3 Cervicalgia e cervicobraquialgia 79
3.4 Fratura vertebral por fragilidade 82

4 Ombro 85

Quatro diagnósticos cobrem quase tudo: impacto/manguito, ombro congelado, instabilidade e artrose. Três manobras separam.

4.1 Síndrome do impacto e tendinopatia do manguito 86
4.2 Capsulite adesiva (ombro congelado) 89
4.3 Luxação e instabilidade do ombro 93
4.4 Fratura de clavícula 97

5 Cotovelo, punho e mão 99

Quase tudo é tendão ou nervo e tem uma manobra com nome; a exceção que não pode escapar é a fratura de escafoide.

5.1 Epicondilite lateral e medial 100
5.2 Síndrome do túnel do carpo 103
5.3 Tenossinovite de De Quervain 105
5.4 Dedo em gatilho 107
5.5 Fratura do rádio distal (Colles) 109
5.6 Fratura de escafoide (suspeita) 113
5.7 Rizartrose (artrose da base do polegar) 115

6 Cotovelo, mão e dedos: trauma 117
Reduzir, imobilizar na posição certa e devolver o movimento cedo — a mão que fica rígida por 4 semanas de tala mal posta é pior que a fratura.

6.1 Luxação de cotovelo e fratura da cabeça do rádio 118
6.2 Fraturas de metacarpo e falanges (soco e esmagamento) 122
6.3 Dedo luxado, dedo em martelo e lesões de tendão 127
6.4 Ferimentos da mão, unha e ponta do dedo 132

7 Quadril 137
Dor no quadril de verdade dói na virilha; dor na lateral é bursa/glúteo; dor na nádega é coluna. O idoso que caiu e não anda vai para o hospital.

7.1 Osteoartrite de quadril 138
7.2 Bursite trocantérica (síndrome dolorosa do grande trocanter) 141
7.3 Fratura de quadril no idoso 143
7.4 Criança mancando: quadril 146

8 Criança: fraturas e cotovelo 148
O osso da criança dobra, remodela e cola rápido; o cotovelo é a exceção que vai para a cirurgia hoje — e a história que não bate com a fratura é notificação.

8.1 Fraturas na criança: tórus, galho verde e fise 149
8.2 Fratura supracondiliana do úmero na criança 154
8.3 Pronação dolorosa (subluxação da cabeça do rádio) 158

9 Joelho 161
Trauma com derrame em horas é ligamento ou fratura; derrame no dia seguinte é menisco; dor sem trauma é patela ou artrose.

9.1 Osteoartrite de joelho 162
9.2 Entorse de joelho: LCA, LCM e LCP 165
9.3 Lesão meniscal 168
9.4 Dor patelofemoral e condromalácia 171
9.5 Cisto de Baker e bursites do joelho 174

10 Tornozelo e pé 176
A regra de Ottawa decide o raio-X da entorse; o calcanhar que dói de manhã é fáscia; o Aquiles que estala pede Thompson.

10.1 Entorse de tornozelo 177
10.2 Fascite plantar 180
10.3 Tendinopatia e ruptura do Aquiles 182
10.4 Fratura de metatarso e do 5º metatarso 186
10.5 Hálux valgo, metatarsalgia e neuroma de Morton 188

11 Articulação aguda e infecção 191
Toda monoartrite aguda com febre é séptica até a punção dizer o contrário.

11.1 Monoartrite aguda e artrite séptica 192
11.2 Crise de gota 195

A Índice de manobras de exame 197
B Índice de medicamentos das receitas 199
C Cola do plantão — 98 textos prontos para o prontuário e a receita 200

CAPÍTULO 1

Primeiro dia: bases

O que vale para todo plantão e toda consulta de ortopedia — você é o ortopedista: leia antes do primeiro paciente.

1.1	**Como pedir o raio-X** Duas incidências no mínimo, sempre com a região e o lado; o pedido mal escrito volta com a radiografia errada.	6
1.2	**Analgesia em escada** Dipirona ou paracetamol fixo + AINE por poucos dias; relaxante à noite se há contratura; tramadol só por 3 a 5 dias quando o resto falhou.	9
1.3	**Imobilizações e órteses** Na primeira consulta, tala (gesso ou órtese) — gesso circular só após o edema baixar; a tala sempre com o aviso escrito dos sinais de aperto.	12
1.4	**Atestado e afastamento** Afastar o mínimo que a função exige; o repouso prolongado atrasa a recuperação da maioria das condições ortopédicas.	16
1.5	**O que não espera: o que você resolve hoje e o que vai para a cirurgia** A lista curta do plantão: o que você, ortopedista de plantão, faz nas primeiras horas (antibiótico, redução, tala, punção, abrir o gesso) e o que, feito isso, vai para o centro cirúrgico ou o centro terciário pela regulação — hoje, não no retorno.	18
1.6	**Regulação no SUS: quem vai para a cirurgia e como pedir** Você é o ortopedista do serviço: o que você não opera vai ao cirurgião ou ao hospital de referência pela regulação — urgência pela central (vaga zero quando é hoje), eletivo pelo SISREG/CROSS ou pelo NIR — e o pedido bem escrito é o que faz a vaga sair.	21
1.7	**Anestesia local, bloqueios e sedação para reduzir** Para reduzir e suturar você precisa de três coisas que faz sozinho — bloqueio de hematoma, bloqueio digital e infiltração local — e de uma que só faz com monitorização e uma segunda pessoa: a sedação.	24
1.8	**Punção e infiltração: joelho, ombro, punho e mão, quadril** A punção é o exame da articulação quente e o alívio do derrame tenso; a infiltração de corticoide é o seu tratamento de ombro, joelho, túnel do carpo, dedo em gatilho, De Quervain e trocanter — técnica simples, assepsia rigorosa e no máximo 3 por articulação por ano.	30

1.1 Como pedir o raio-X

CID — · **Também** radiografia, incidências, RX, pedido de exame, imagem

> Duas incidências no mínimo, sempre com a região e o lado; o pedido mal escrito volta com a radiografia errada.

O QUE PERGUNTAR

- Onde dói exatamente (aponte com um dedo) e houve trauma? Trauma pede raio-X mais cedo; dor sem trauma e sem alarme costuma esperar.
- Já fez raio-X dessa região? Peça para trazer o laudo e as imagens (no celular serve) antes de repetir.
- Gestante ou pode estar? Pelve, quadril e coluna lombar só com proteção e indicação clara.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Regra dos dois	Antes de pedir, confira os quatro pares: 2 incidências (AP e perfil), 2 articulações (acima e abaixo no osso longo), 2 lados (comparar na criança, quando há dúvida), 2 tempos (repetir em 10 a 14 dias se a suspeita clínica persistir com raio-X normal).	Ficou de fora uma das incidências → a fratura pode não aparecer.

SINAIS DE ALARME

- Suspeita de fratura de escafoide, colo do fêmur ou fratura por estresse com raio-X normal: trate como fratura (imobilize) e repita o raio-X em 10 a 14 dias ou peça ressonância/tomografia.
- Trauma de coluna cervical com dor na linha média, déficit neurológico, > 65 anos ou mecanismo de alto impacto: tomografia, não raio-X — e colar cervical até o exame.

IMAGEM

- Ombro: “RX de ombro D — AP verdadeiro (Grashey), perfil escapular (Y) e axilar”. A axilar é a que mostra a luxação posterior.
- Cotovelo: “RX de cotovelo E — AP e perfil”. No perfil, o sinal do coxim gorduroso posterior indica fratura oculta (cabeça do rádio no adulto, supracondiliana na criança).
- Punho: “RX de punho D — PA, perfil e oblíqua”. Suspeita de escafoide: acrescente “série do escafoide (PA com desvio ulnar)”.
- Mão e dedos: “RX de mão (ou do 2º dedo) D — PA, oblíqua e perfil”.
- Coluna lombar: “RX de coluna lombossacra — AP e perfil”. Na lombalgia aguda sem alarme e com menos de 6 semanas, não pedir.
- Coluna cervical sem trauma: “RX de coluna cervical — AP, perfil e oblíquas”. Com trauma, tomografia.
- Quadril: “RX de bacia AP e RX de quadril D — perfil (Lauenstein)”. A bacia AP compara os dois lados.
- Joelho: “RX de joelho D — AP com carga, perfil e axial de patela”. Na artrose, acrescente “Rosenberg (PA com 45° de flexão, com carga)”, que mostra o estreitamento que o AP esconde.
- Tornozelo: “RX de tornozelo D — AP, perfil e mortise (AP com 15–20° de rotação interna)”. Pé: “RX de pé D — AP, perfil e oblíqua, com carga”.
- Ultrassom é o exame de tendão, bursa e cisto (ombro, Aquiles, De Quervain, Baker). Ressonância é de ligamento, menisco, disco e fratura oculta — pedir depois de 4 a 6 semanas de tratamento que não funcionou, salvo alarme.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão você lê o próprio raio-X: siga sempre a mesma ordem — alinhamento, cortical osso a osso, articulações, partes moles (coxim gorduroso, derrame, ar) — nas duas incidências, e compare com o outro lado na criança. Laudo vem depois; a conduta é sua agora.
- Raio-X normal com clínica de fratura (escafoide, colo do fêmur, fise na criança, cabeça do rádio com coxim): imobilize como fratura, trate a dor e marque a segunda imagem; não é "contusão".
- Pedir imagem avançada no plantão só quando muda a conduta de hoje: tomografia na coluna com trauma, pelve, articular complexa (platô, pilão, calcâneo), Lisfranc; ressonância urgente na cauda equina e na suspeita de artrite séptica de quadril da criança sem ultrassom.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

Leitura do raio-X de trauma em 60 segundos



Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Toda radiografia que você pediu, antes do laudo.

Material e anestesia: As duas incidências na tela, o outro lado se criança.

Passo a passo

1. Identificação, lado e incidências certas (é o paciente certo? faltou a axilar, o mortise, o perfil verdadeiro?).
2. Alinhamento: as linhas que devem bater (umeral anterior e radiocapitelar no cotovelo; Shenton no quadril; linhas de Gilula no punho; espaço claro medial no tornozelo).
3. Córtex osso a osso, em volta de cada osso, nas duas incidências: degrau, interrupção, dobra (tórus), densidade (impactação).

4. Articulações: congruência, espaço, fragmento solto, luxação; fises na criança (largura igual à do outro lado?).
5. Partes moles: coxim gorduroso (cotovelo), derrame (joelho no perfil), ar (exposta), edema que aponta o lugar.

Depois: Escreva o que viu no prontuário ("RX de punho: fratura do rádio distal com desvio dorsal de 20°, sem traço articular"); peça a incidência que faltou antes de decidir.

CONDUTA

- Escreva no pedido: região, lado, incidências e a pergunta clínica ("trauma há 2 dias, dor na tabaqueira anatômica — fratura de escafoide?"). O radiologista responde ao que foi perguntado.
- Raio-X normal não exclui fratura nas primeiras 2 semanas, nem lesão de partes moles. A clínica manda.
- No idoso com dor no quadril e raio-X normal que não consegue andar: ressonância ou tomografia no mesmo dia — fratura oculta do colo é comum.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- No retorno, confira a imagem que faltava (controle em 7–10 dias com a tala; segunda série do escafoide em 10–14 dias; tomografia que foi pedida) antes de liberar carga ou tirar o gesso.
- Ressonância e tomografia ambulatoriais saem pela regulação: escreva a pergunta clínica e a urgência ("lesão do LCA? — candidato a reconstrução") e mantenha o tratamento enquanto espera.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: o raio-X que você não consegue interpretar com segurança (foto para o cirurgião de sobreaviso ou para a regulação — nunca libere "normal" na dúvida), e a tomografia ou ressonância que o serviço não tem (pedido pela regulação com a pergunta clínica escrita).

Atestado	Não se aplica.
Retorno	Com o resultado em mãos, mesmo que normal — o laudo pode mudar a conduta.

DICAS

- No perfil de cotovelo, procure a linha umeral anterior: ela deve cruzar o terço médio do capítulo. Na criança, se não cruza, é fratura supracondiliana até prova em contrário.
- Pedir "RX de joelho" sem incidência rende um AP só. Escreva as três.

Baseado em: ACR Appropriateness Criteria (musculoesquelético); Ottawa Ankle, Foot and Knee Rules; Canadian C-Spine Rule.

1.2 Analgesia em escada

CID — · **Também** dor, anti-inflamatório, AINE, relaxante muscular, opioide, receita de dor, como medicar a dor

> Dipirona ou paracetamol fixo + AINE por poucos dias; relaxante à noite se há contratura; tramadol só por 3 a 5 dias quando o resto falhou.

O QUE PERGUNTAR

- Toma AAS, anticoagulante, corticoide ou já teve úlcera ou sangramento digestivo? Define se pode AINE e se precisa de omeprazol.
- Tem doença renal, insuficiência cardíaca, hipertensão difícil ou mais de 65 anos? AINE em dose baixa e por 3 dias, ou nenhum.
- Gestante? Dipirona com cautela, paracetamol é a base; AINE contraindicado no 3º trimestre.
- Já tomou algo? Quanto? Muitas vezes a dor "não passou" porque a dose era de meio comprimido quando doía demais.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Degraus	1º: dipirona ou paracetamol em horário fixo. 2º: somar AINE (naproxeno ou ibuprofeno) por 5–7 dias. 3º: relaxante muscular à noite, se há contratura. 4º: tramadol por 3–5 dias, mantendo os anteriores. Gelo (20 min, 3–4×/dia) nas primeiras 48–72 h e calor depois, nas contraturas.	Precisou do 4º degrau por mais de uma semana → a hipótese pode estar errada: reavalie.

SINAIS DE ALARME

- Dor desproporcional ao exame, que piora com estiramento passivo dos dedos e com dormência, depois de trauma ou gesso: síndrome compartimental — pronto-socorro agora, abra o gesso no caminho.
- Dor noturna que acorda e não alivia com posição, com emagrecimento ou câncer prévio: imagem e investigação, não analgésico.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão a escada começa pela veia: dipirona 1–2 g EV lenta (ou cetorolaco 30 mg EV, dose única, 15 mg em > 65 anos ou renal) e, na fratura ou luxação, morfina 2–4 mg EV a cada 5–10 min até controlar (0,05–0,1 mg/kg) com antiemético — antes do raio-X, não depois.
- Bloqueio regional vale mais que opioide: bloqueio de hematoma no rádio distal, digital no dedo, fáscia ilíaca no fêmur e quadril (ver Anestesia local, bloqueios e sedação).
- Alta com receita escrita e dias contados; o paciente que sai do plantão com "tramadol se dor" volta em 2 dias sem dormir.

CONDUTA

- Dor aguda (até 2 semanas): esquema fixo nos primeiros 3 dias, depois "se dor". Diga quantos dias e quando parar — o paciente não sabe sozinho.
- Dor crônica (mais de 3 meses): AINE contínuo não é solução; fisioterapia, exercício e, se preciso, duloxetina ou amitriptilina em dose baixa, com reavaliação em 4 semanas.
- Tópicos (diclofenaco gel 2–4×/dia) funcionam em joelho, mão e tendões superficiais e poupam o estômago do idoso.

- Corticoide oral: curso curto (prednisona 20 mg/dia por 5 dias) só em casos definidos — ombro congelado em fase dolorosa, radiculopatia com dor intensa; não é analgésico de rotina.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).
Ciclobenzaprina 5 mg	1 comprimido à noite por 5 a 7 dias; pode subir a 10 mg se tolerar.	Dá sono e boca seca; evitar em idoso, glaucoma, arritmia e com outros sedativos. Não dirigir após a dose.
Tramadol 50 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 3 a 5 dias, só se a dor não ceder com o resto.	Lista A2 da Portaria 344 (tarja preta): até 100 mg por unidade sai em receita de controle especial em duas vias, não na notificação A. Náusea e tontura são comuns; cuidado em idoso, epilepsia e com antidepressivo (serotonina).

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- No retorno de dor aguda em 7 dias: reduza um degrau de cada vez (tire o opioide primeiro, depois o AINE); dor igual ou pior é diagnóstico errado ou complicação (gesso apertado, infecção, trombose), não dose insuficiente.
- Dor crônica musculoesquelética (> 3 meses): exercício supervisionado, duloxetina ou amitriptilina em dose baixa, infiltração quando há alvo; AINE contínuo e opioide crônico não são plano.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: dor crônica que precisa de opioide por mais de 2–4 semanas ou de procedimentos (bloqueio facetário, radiofrequência) — clínica da dor pela regulação; a dor desproporcional da síndrome compartimental (fasciotomia) e a dor da artrite séptica (drenagem) não são da analgesia, são da cirurgia.

Atestado	Depende da condição; a analgesia por si só não afasta.

Retorno	Em 7 dias para dor aguda com AINE; antes, se efeito adverso (dor epigástrica, fezes escuras, edema).

DICAS

- Naproxeno e ibuprofeno são as escolhas mais seguras entre os AINEs para o coração. Diclofenaco e nimesulida: mais risco cardiovascular e hepático; se for usar nimesulida, no máximo 15 dias.
- Nunca dois AINEs juntos (inclui o "injetável" do pronto-socorro de ontem).
- Dipirona e paracetamol podem ser somados: mecanismos diferentes.

Baseado em: NICE NG193 (dor crônica); NICE NG59 (lombalgia); Bulas (Anvisa); Portaria 344/98.

1.3 Imobilizações e órteses

CID — · **Também** tala, gesso, tipoia, bota imobilizadora, splint, órtese, munhequeira, joelheira

> Na primeira consulta, tala (gesso ou órtese) — gesso circular só após o edema baixar; a tala sempre com o aviso escrito dos sinais de aperto.

O QUE PERGUNTAR

- Trabalha com as mãos ou dirige? Define a órtese e o atestado.
- Mora sozinho, sobe escada? Muleta e bota precisam de alguém em casa nos primeiros dias.
- Diabetes, neuropatia ou má circulação? Imobilizar com mais acolchoamento e revisar em 48 h — a pele sofre sem sentir.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Checagem pós-imobilização	Depois de colocar: pulso distal, enchimento capilar < 2 s, sensibilidade e movimento dos dedos. Articulação imobilizada em posição funcional (punho 20° de extensão, tornozelo 90°, dedos em semiflexão). Escreva os sinais de alarme no atestado ou numa orientação.	Dedos frios, roxos, dormentes ou dor que aumenta → afrouxar ou retirar na hora.

SINAIS DE ALARME

- Dor crescente, dormência, dedos pálidos ou azulados ou dor ao estirar os dedos com a tala: síndrome compartimental ou gesso apertado — retirar a imobilização imediatamente e avaliar; se não melhorar em minutos, pronto-socorro.
- Imobilização de membro inferior (bota ou gesso) por mais de uma semana sem andar: avaliar profilaxia de trombose em quem tem fator de risco (obesidade, anticoncepcional, trombose prévia, câncer, > 60 anos).

IMAGEM

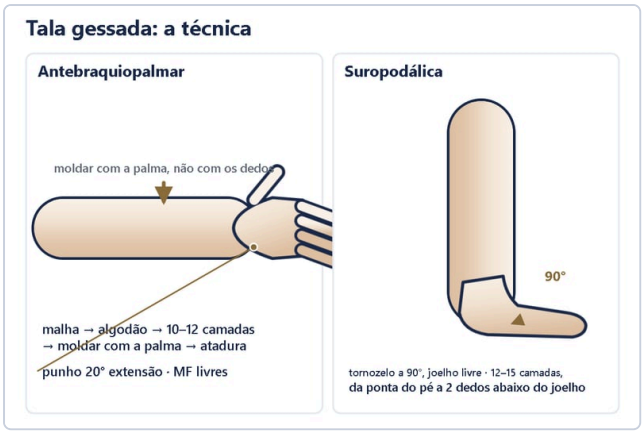
- Após reduzir ou imobilizar uma fratura: raio-X de controle com a imobilização, nas mesmas incidências, em 7 a 10 dias (o edema baixa e a fratura pode desviar).

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

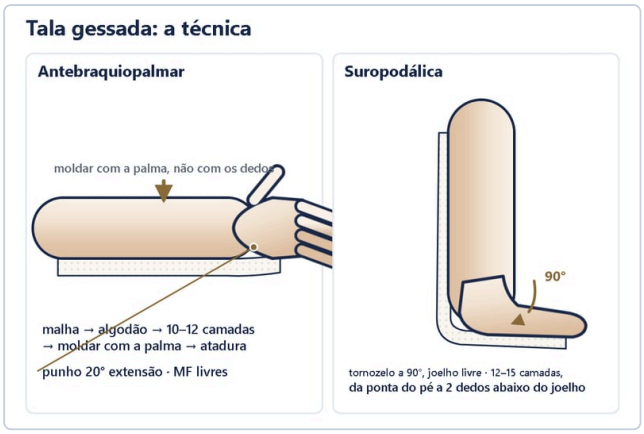
- Na urgência a imobilização é tala (gessada ou órtese), nunca gesso circular fechado sobre edema que vai crescer: tala bem acolchoada, atadura frouxa, membro elevado, e a orientação escrita com os sinais de aperto e o telefone do serviço.
- Depois de reduzir uma fratura, a tala é moldada em três pontos para segurar a redução (ver Procedimentos) e o raio-X é feito com ela; se a redução não ficou, refaça agora — depois de 7 dias não reduz mais.
- Alta só depois de: pulso, enchimento capilar, sensibilidade e movimento dos dedos conferidos e anotados; muleta ou tipoia entregues; retorno marcado (24–48 h no diabético, idoso, criança e na tíbia/antebraço; 7–10 dias nos demais).

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

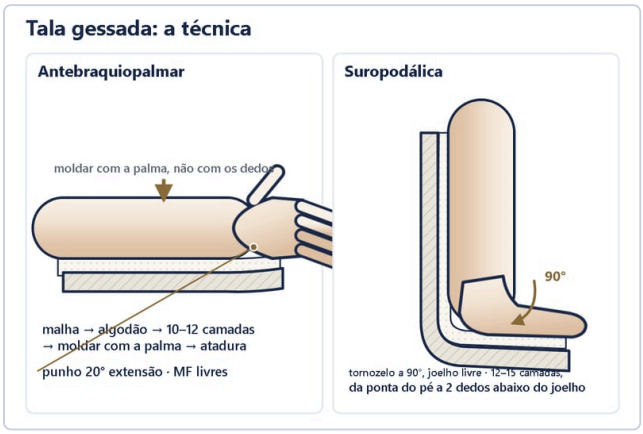
Tala gessada (antebraquiopalmar e suropodálica) — a técnica



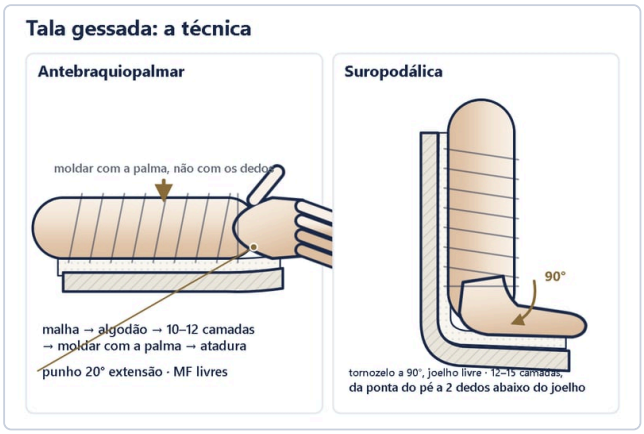
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Toda fratura ou entorse grave na fase aguda; depois de redução.

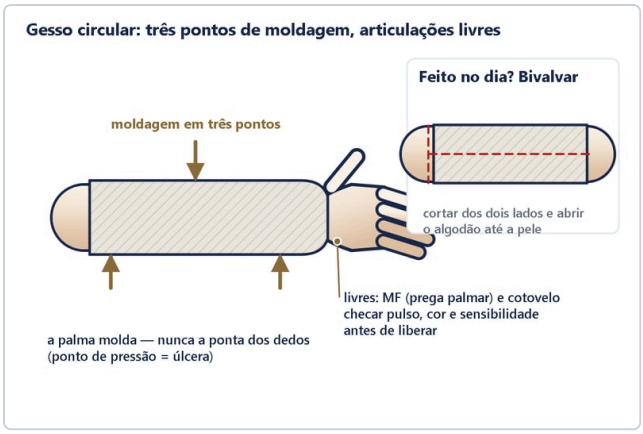
Material e anestesia: Rolo de gesso (10 cm para antebraço e braço; 15 cm para perna), algodão ortopédico, malha tubular, atadura de crepe, água em temperatura ambiente, tesoura; um ajudante para segurar a posição.

Passo a passo

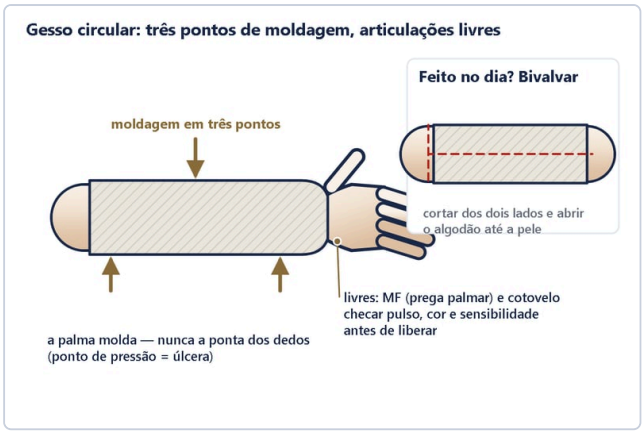
1. Meça a tala no membro são (ou no doente antes de molhar): antebraquiopalmar da prega palmar distal ao terço proximal do antebraço (dedos livres); suropodálica da cabeça da fíbula até os dedos (tornozelo a 90°), mais o estribo em U se é o tornozelo.
2. Camadas: 8–10 no membro superior, 12–15 no inferior; malha tubular e 2–3 voltas de algodão, mais nas proeminências (estiloides, olécrano, maléolos, calcanhar, cabeça da fíbula).
3. Molhe a tala, esprema sem torcer, alise entre as palmas; aplique e enfaixe com crepe sem apertar (espiral frouxa).
4. Molde com as palmas das mãos (nunca com as pontas dos dedos: fazem pressão pontual) na posição funcional ou na de redução, e segure até endurecer (5–8 minutos).
5. Confira a borda nos dedos (a metacarpofalângica deve fletir; os artelhos livres) e o neurovascular distal.

Depois: Raio-X com a tala quando há fratura; orientação escrita; secagem completa em 24–48 h (não apoiar antes); retorno marcado.

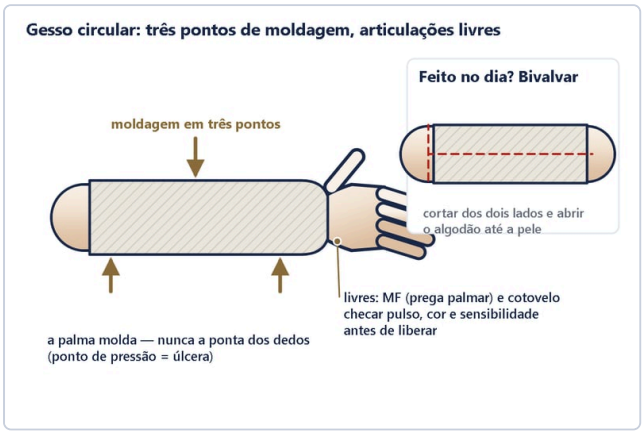
Gesso circular bem moldado (e bivalvado quando feito no dia)



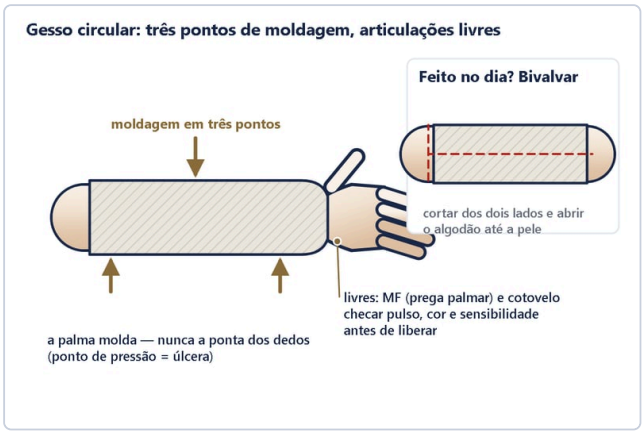
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Na troca de 5–7 dias (edema resolvido) ou no dia, bivalvado, quando a redução exige.

Material e anestesia: Gesso ou fibra sintética, algodão, malha tubular, serra de gesso para bivalvar.

Passo a passo

1. Malha e algodão uniformes (2 voltas, 3 nas proeminências); sem dobras.
2. Rolo de gesso em espiral, sobrepondo metade da largura, sem tensão (desenrole sobre o membro, não puxe); 4–6 camadas no membro superior, 6–8 no inferior; articulação na posição funcional ou de redução.
3. Molde em três pontos sobre a fratura enquanto endurece: dois pontos de um lado nas extremidades, um do lado oposto sobre o ápice do desvio; ovalize o antebraço (índice de gesso < 0,8).
4. Feito no dia da fratura: bivalve com a serra nos dois lados, corte o algodão até a pele e feche com atadura — abre-se em 1 minuto se apertar.

Depois: Raio-X de controle; orientação escrita; reforce ou troque o gesso bivalvado em 7–10 dias.

CONDUTA

- Tipoia (ombro, clavícula, cotovelo): no máximo 2–3 semanas contínuas; a partir da 1ª semana, tirar para mover cotovelo, punho e dedos várias vezes ao dia — senão o ombro congela.
- Órtese de punho (munhequeira com talas): De Quervain, túnel do carpo noturno, entorse leve de punho. Dia e noite nas primeiras 2 semanas; depois só à noite ou ao esforço.
- Tala gessada antebraquiopalmar: fratura do rádio distal (depois da redução, se desviada) até o controle em 7–10 dias, quando você troca por gesso circular; escafoide suspeito (com o polegar incluído: gesso "antebraquiopalmar com polegar").

- Bota imobilizadora (robofoot): entorse grau II–III, fratura de base do 5º metatarso ou de maléolo estável (Weber A/B com tálus centrado); Aquiles roto em equino com cunhas. Andar com carga conforme a dor, com muleta se precisar. Sem bota no SUS: tala posterior + estribo e, na troca, gesso suropodálico fazem o mesmo.
- Joelheira articulada ou imobilizador de joelho: entorse de ligamento colateral e após trauma com derrame até a avaliação; não deixar mais de 2–3 semanas sem mobilizar.
- Colar cervical: só no trauma até a imagem. Na cervicalgia sem trauma, não usar — enrijece e piora.
- Gesso circular: você, na troca de 5–7 dias com o edema resolvido — ou no mesmo dia, bivalvado (aberto nos dois lados) e fechado com atadura, quando a fratura precisa do gesso para segurar a redução.
- Sempre entregue a orientação escrita: elevar o membro acima do coração, mexer os dedos, não molhar o gesso, não enfiar objetos para coçar, e os sinais de alarme.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno de 7–10 dias: raio-X com a tala (desvio secundário?), pele (escara? maceração?), troca por gesso circular bem moldado ou por órtese; a partir daí, controle a cada 2–3 semanas até consolidar.
- Gesso que afrouxou (edema baixou), quebrou ou molhou: troque no mesmo dia; gesso apertado: abra até a pele agora, antes de qualquer outra coisa (ver Síndrome compartimental).
- Fim da imobilização: tire, examine o foco (dor? mobilidade?), raio-X se foi fratura, e comece o movimento no mesmo dia; rigidez de 2–4 semanas é esperada e passa com uso.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a fratura que a imobilização não segura (perda de redução no controle de 7–10 dias, articular com degrau, instável) — fixação cirúrgica pela regulação em dias; a exposta, a compartimental e a com pulso ausente — hoje. O resto do gesso é seu até consolidar.

Atestado	O da condição; some 1–2 dias se a imobilização impede o trabalho (membro dominante, dirigir).
Retorno	48 h depois de qualquer imobilização em diabético, idoso ou criança; 7 a 10 dias nos demais, com o raio-X de controle quando há fratura.

DICAS

- PRICE nas primeiras 48–72 h: proteção, repouso relativo, gelo 20 min 3–4×/dia (com pano), compressão e elevação. Depois disso, movimento cedo é o que cura mais rápido.
- Tipoia por 6 semanas "para garantir" é a maior causa de ombro congelado iatrogênico.

Baseado em: AAOS OrthoInfo — cast and splint care; NICE NG38 (fractures: non-complex); BOAST (British Orthopaedic Association) — compartment syndrome.

1.4 Atestado e afastamento

CID — · **Também** dias de atestado, afastamento do trabalho, INSS, licença, CID no atestado, quantos dias

> Afastar o mínimo que a função exige; o repouso prolongado atrasa a recuperação da maioria das condições ortopédicas.

O QUE PERGUNTAR

- O que faz no trabalho, exatamente? Carrega peso, fica em pé, digita, dirige? O mesmo joelho afasta 2 dias um escriturário e 3 semanas um pedreiro.
- Tem como remanejar a função (trabalho leve) em vez de afastar? Escreva a restrição no atestado ("sem carga acima de 5 kg por 14 dias").
- É autônomo ou carteira assinada? Muda quem paga a partir do 16º dia.

SINAIS DE ALARME

- Pedidos repetidos de atestado com exame normal e sem melhora: investigue ganho secundário, depressão ou condição que você não diagnosticou — e não prolongue sem reavaliar presencialmente.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão o atestado sai junto com a alta: dias contados pela lesão e pela função (ver conduta), restrição escrita ("sem apoiar o membro direito", "sem carga acima de 5 kg"), CID só com consentimento, e o atestado de acompanhante do responsável da criança ou do idoso.
- Acidente de trabalho ou de trajeto: o atestado é o mesmo, mas a empresa precisa da CAT (comunicação de acidente de trabalho) — o médico pode emitir e o paciente deve saber que o afastamento conta de forma diferente.
- Afastamento > 15 dias previsto desde o dia 1 (fratura de perna, tendão operado): avise que o INSS assume a partir do 16º e que a perícia se marca pelo Meu INSS com o seu atestado e o seu laudo.

CONDUTA

- Dias sugeridos (ajuste à função): lombalgia aguda 2–5 (escritório) / 7–14 (braçal); entorse de tornozelo grau I 3–5, grau II 7–14, grau III 14–21; fratura do rádio distal sem cirurgia 4–6 semanas para mão dominante no trabalho manual (2–3 semanas no escritório, só com a órtese); epicondilite 0 com restrição / 7–14 no braçal; túnel do carpo 0–7 com órtese; luxação de ombro reduzida 14–21; fratura de clavícula 21–42 conforme o trabalho; artroscopia de joelho 14–30; LCA operado 30–90; prótese de quadril ou joelho 60–90.
- CID no atestado só com consentimento expresso do paciente (anote no prontuário). Sem consentimento, atestado sem CID vale igual.
- Mais de 15 dias de afastamento de empregado com carteira: o INSS assume a partir do 16º — oriente a agendar a perícia pelo Meu INSS.
- Atestado para a escola, academia ou esporte: diga o que pode e o que não pode ("liberado para natação; sem impacto por 4 semanas").
- Retorno gradual é atestado também: "apto ao trabalho com restrição de carga por 14 dias". Empresas aceitam e o paciente volta antes.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- No retorno, o atestado acompanha a fase: imobilizado → fora do trabalho ou restrição total; consolidando → restrição parcial; liberado → apto. Renove presencialmente, com a data do próximo controle.

- Laudo para a perícia: diagnóstico, data, tratamento feito e previsto, limitação atual e prognóstico de retorno — uma folha, objetiva; é o que o perito lê.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a perícia (INSS a partir do 16º dia para empregado com carteira; o atestado é seu, o benefício é deles), a reabilitação profissional (INSS/CER) e o laudo para o trabalho que exige avaliação de outra especialidade (psiquiatria, fisiatria).

Atestado	Veja a lista na conduta.
Retorno	Sempre marque o retorno dentro do prazo do atestado — nunca deixe a renovação "por telefone".

DICAS

- O atestado com restrição de função ("apto com restrição") resolve a maior parte dos pedidos de "mais dias".

Baseado em: CFM Resolução 1.658/2002 e 2.217/2018 (atestado e CID); Lei 8.213/91 (auxílio por incapacidade: 16º dia); MDGuidelines / ACOEM (duração de afastamento).

1.5 O que não espera: o que você resolve hoje e o que vai para a cirurgia

CID — · **Também** urgência ortopédica, pronto-socorro, emergência, o que não pode esperar, cirurgia hoje, vaga zero, lista do plantão

> A lista curta do plantão: o que você, ortopedista de plantão, faz nas primeiras horas (antibiótico, redução, tala, punção, abrir o gesso) e o que, feito isso, vai para o centro cirúrgico ou o centro terciário pela regulação — hoje, não no retorno.

O QUE PERGUNTAR

- Como foi o trauma (altura, velocidade, torção)? Alta energia pede imagem completa, pelve e coluna examinadas, e cuidado com lesão associada.
- Febre, calafrio, articulação quente e inchada que não deixa mexer? Pense em infecção antes de pensar em gota — e puncione.
- Perdeu o controle da urina, dormência nas nádegas ou períneo, fraqueza nas duas pernas? Cauda equina: ressonância e descompressão em horas.
- Hora do trauma, jejum, anticoagulante, vacina do tétano — as quatro perguntas de quem pode ir para o centro cirúrgico hoje.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Os 5 P do membro em risco	Dor desproporcional (Pain), palidez (Pallor), parestesia, paralisia e ausência de pulso (Pulselessness) — o pulso é o último a sumir; não espere por ele.	Dor desproporcional + dor ao estiramento passivo já é síndrome compartimental até prova em contrário: abra tudo e acione a fasciotomia.
Checagem neurovascular distal, antes e depois de tudo	Em toda fratura ou luxação: pulso, enchimento capilar, sensibilidade e motricidade distais, antes e depois de qualquer redução ou tala. Anote com a hora.	Déficit que aparece após a sua manipulação → desfaça o que fez (afrouxe, reposicione) e reavalie; déficit vascular → vascular hoje.

SINAIS DE ALARME

- Fratura exposta: antibiótico EV na primeira hora, tétano, lavagem, curativo, alinhamento e tala — e desbridamento cirúrgico em até 24 h (ver Fratura exposta).
- Luxação de qualquer articulação grande (ombro, cotovelo, quadril, joelho, tornozelo, dedo): raio-X, redução por você com bloqueio ou sedação, raio-X de novo (ver os tópicos de luxação); quadril em até 6 h; joelho é artéria poplítea até prova em contrário.
- Membro sem pulso após fratura ou luxação: alinhe e reduza; sem pulso ainda → vascular agora (6 h de isquemia).
- Síndrome compartimental (dor desproporcional, piora ao estiramento passivo, compartimento tenso): abra gesso e algodão até a pele; fasciotomia em horas.
- Artrite séptica (monoartrite quente, febre, não mexe): punção agora, cultura, antibiótico EV depois da punção, internação; drenagem cirúrgica hoje — não AINE e casa.
- Síndrome da cauda equina: retenção ou incontinência urinária, anestesia em sela, fraqueza bilateral — ressonância e descompressão em horas (neurocirurgia/coluna pela regulação de urgência).
- Déficit neurológico progressivo em radiculopatia (pé caído que piora, mão que não segura): ressonância em 24–48 h e cirurgia de coluna.

- Fratura de quadril ou de colo do fêmur no idoso: internação hoje, bloqueio da fáscia ilíaca, cirurgia em até 48 h — aqui ou pela regulação; não "esperando vaga" em casa.
- Criança: supracondiliana desviada (Gartland II–III), fise desviada, fêmur, artrite séptica do quadril — cirurgia hoje (ortopedia pediátrica); mão sem pulso é vaga zero.
- Ruptura completa de tendão (Aquiles, quadríceps, patelar — não estende o joelho ou não faz flexão plantar): imobilize na posição certa; decisão conservador × cirurgia em 48 h (Aquiles) ou cirurgia em 1–2 semanas (extensor do joelho).
- Fratura de escafoide, colo do fêmur ou tálus suspeita com raio-X normal: imobilize e imagem avançada — não aguarde 2 semanas sem proteger.
- Dedo com perfusão comprometida, amputação com osso exposto, tendão flexor cortado, ferida sobre articulação ou mordedura de mão, injeção de alta pressão: cirurgia da mão hoje (ver Ferimentos da mão).

IMAGEM

- A imagem não atrasa o tratamento: antibiótico, redução do membro sem pulso e abertura do gesso vêm antes do raio-X; o raio-X vem antes de toda redução eletiva e depois de todas.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- A regra do plantão em uma linha: primeiro o que salva o membro (perfusão, compartimento, infecção), depois o que salva a articulação (redução, punção), depois o que salva a função (tala certa, tendão no prazo) — e só então o telefone.
- Tudo o que está nesta página fica internado ou vai transferido; nada vai para casa "para voltar amanhã".

CONDUTA

- Trate o que é seu antes de ligar: analgesia EV, antibiótico da exposta, redução, tala, punção, tétano, jejum, acesso venoso, exames pré-operatórios (hemograma, coagulograma, creatinina, tipagem, ECG se > 40 anos).
- Depois, a vaga: sobreaviso do seu hospital se opera aqui; central de regulação de urgências (vaga zero se risco de vida ou de membro) se não — com o laudo de 8 linhas (ver Regulação no SUS) e as imagens.
- Transporte adequado (ambulância com maca para fêmur, pelve, coluna, quadril reduzido), acompanhante, prontuário e raio-X junto; registre protocolo, nome do regulador e horário.
- O que fica internado com você aguardando: reavaliação neurovascular e do compartimento a cada 2–4 h, anotada; dor crescente é reexame, não mais morfina.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g/2 mL	2 mL EV lento agora; depois de 6/6 h.	—
Morfina 10 mg/mL	2 a 4 mg EV a cada 5–10 minutos até controlar a dor (até 0,1 mg/kg na primeira hora), com antiemético e monitorização.	Idoso e DPOC: metade da dose.
Cefazolina 1 g (frasco-ampola)	2 g EV agora (3 g se > 120 kg) na fratura exposta, antes do raio-X; depois 2 g de 8/8 h.	Gustilo III: + gentamicina 5 mg/kg/dia. Alergia grave: clindamicina 900 mg EV 8/8 h.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- No retorno do que foi operado fora: a ferida, o raio-X e a reabilitação são seus; qualquer dúvida sobre o implante ou a carga é ligação para o cirurgião, não adivinhação.

- Faça a lista do que seu serviço tem (sobreaviso? centro cirúrgico? tomógrafo? banco de sangue?) no primeiro dia: ela define, para cada item acima, se é “aqui” ou “regulação”.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão, hoje: desbridamento da exposta, fasciotomia, fixação da fratura de quadril, redução aberta, drenagem da artrite séptica, descompressão da cauda equina, lesão vascular, reimplante, cirurgia da mão, supracondiliana desviada — cirurgião ou centro terciário pela regulação de urgência, com o laudo e o que você já fez.

Atestado	Internação ou transferência; atestado do dia para o acompanhante de criança ou idoso dependente.
Retorno	Reavaliação a cada 2–4 h enquanto aguarda; depois, o retorno do que foi feito.

DICAS

- Monoartrite aguda com febre é artrite séptica até a punção dizer o contrário. Gota é diagnóstico de exclusão nesse cenário.
- A luxação de ombro posterior passa despercebida no AP; a incidência axilar mostra.
- O que destrava a vaga é a classificação com o risco no laudo: “Gustilo III”, “Gartland III”, “pulso ausente há 2 h”.

Baseado em: BOAST — Open fractures; Compartment syndrome; Supracondylar fractures; NICE NG124 (hip fracture); NICE NG59 (cauda equina); AAOS — pediatric supracondylar fractures; Portaria GM/MS 2.048/2002 (vaga zero).

1.6 Regulação no SUS: quem vai para a cirurgia e como pedir

CID — · **Também** regulação, vaga zero, SISREG, CROSS, transferência, centro terciário, como encaminhar para cirurgia, AIH, TFD, NIR

> Você é o ortopedista do serviço: o que você não opera vai ao cirurgião ou ao hospital de referência pela regulação — urgência pela central (vaga zero quando é hoje), eletivo pelo SISREG/CROSS ou pelo NIR — e o pedido bem escrito é o que faz a vaga sair.

O QUE PERGUNTAR

- É urgência (horas) ou pode esperar dias? Fratura exposta, luxação irredutível, membro sem pulso, compartimental, séptica e cauda equina são horas; a maioria das fraturas fechadas que vão operar pode esperar 2 a 7 dias em casa ou enfermaria, bem imobilizada.
- O seu hospital tem cirurgião ortopédico de sobreaviso, centro cirúrgico e anestesista? Se tem, o caso é interno: acione o sobreaviso. Se não tem, é transferência.
- O paciente tem como voltar para o retorno? Quem mora longe entra no TFD (tratamento fora de domicílio) para transporte e, se preciso, estadia.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
O laudo de regulação que consegue vaga	Escreva em 8 linhas: identificação e idade; mecanismo e hora do trauma; o diagnóstico com lado e a classificação (“fratura exposta Gustilo II de tíbia D”); estado neurovascular distal com horário; o que você já fez (redução, tala, antibiótico, analgesia, tétano, jejum desde que horas); comorbidades e anticoagulante; o que pede (“cirurgia ortopédica com urgência — desbridamento em até 24 h”); seu nome, CRM e telefone de contato.	Laudo sem classificação, sem neurovascular ou sem o que já foi feito volta com pedido de complementação e o paciente perde horas.
Vaga zero	Quando é urgência com risco de vida ou de membro e não há vaga, o regulador pode mandar mesmo assim (“vaga zero”) — o hospital de referência não pode recusar (Portaria 2.048/2002, Resolução CFM 2.077/2014). Você pede à central de regulação de urgências (pelo SAMU 192 ou pela central da sua região) e registra o número do protocolo no prontuário.	Recusa verbal do hospital de destino não existe para urgência: insista com o regulador e anote nomes e horários.

SINAIS DE ALARME

- Não deixe o paciente esperando a vaga sem tratar: antibiótico da fratura exposta, redução da luxação, abertura do gesso apertado e analgesia são suas, agora, enquanto a regulação acontece.
- Transporte: paciente com fratura de fêmur, pelve instável, luxação reduzida de quadril ou suspeita de lesão de coluna vai de ambulância com maca, imobilizado — nunca “de carro com a família”.
- Criança com fratura que não bate com a história, fraturas em várias idades ou fratura de fêmur em quem não anda: além da regulação, notifique (ficha do SINAN e Conselho Tutelar — Lei 13.431/2017). É obrigatório e protege a criança.

IMAGEM

- Mande as imagens junto: foto do raio-X no celular, laudo e, quando possível, o CD. O destino decide a vaga pela imagem.

- Tomografia antes de transferir só se muda o destino ou o transporte (coluna, pelve, articular complexa) e se você a tem; não atrase a transferência de urgência por exame que o destino vai repetir.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Urgência cirúrgica (hoje): fratura exposta, luxação que você não reduziu, membro sem pulso ou com compartimental, artrite séptica, cauda equina, fratura de quadril, supracondiliana desviada na criança, luxação de quadril ou de joelho. Estabilize, trate o que é seu e peça vaga pela central de urgências com o laudo.
- Cirurgia em dias (eletiva de urgência): rádio distal desviado, tornozelo instável, clavícula com indicação, úmero proximal desviado, metacarpo com rotação, patela desviada, Aquiles roto. O paciente vai para casa imobilizado, em jejum só no dia, com o laudo e o pedido no SISREG/CROSS ou no NIR do hospital, e retorno marcado para conferir se a vaga saiu.
- Internação (AIH): quem vai operar aqui ou aguarda transferência, idoso com fratura de quadril, fratura de fêmur ou pelve, infecção. Preencha a AIH com o CID da fratura (S...) e o procedimento; o NIR faz o resto.

CONDUTA

- Eletivo ambulatorial (meses): prótese de quadril e joelho, artroscopia, túnel do carpo, hálux valgo, Dupuytren. Pedido pelo SISREG (ou CROSS em SP) com CID, resumo e o que já fez — fisioterapia e infiltração contam como "tratamento conservador cumprido" e aceleram a fila.
- Outras especialidades pela mesma regulação: cirurgia da mão (tendão, nervo, reimplante), vascular (pulso ausente), neurocirurgia (coluna com déficit), cirurgia pediátrica/ortopedia pediátrica, reumatologia, fisiatria. Escreva para quem é.
- Fisioterapia no SUS: encaminhe por escrito para a unidade de referência (ou o CER — Centro Especializado em Reabilitação) com diagnóstico, o que pode e o que não pode fazer ("carga parcial, sem flexão > 90° por 6 semanas"). Enquanto espera, entregue os exercícios em casa.
- Órteses e próteses (OPM): bota, tala, muleta, cadeira de rodas, colete e palmilha saem pelo CER ou pela farmácia de OPM do município com o seu pedido e o CID; quando não há, a tala gessada substitui a bota e a órtese de punho.
- TFD: paciente de outro município que precisa de cirurgia na referência — o pedido (laudo + formulário do TFD) sai da sua unidade; o município paga transporte e ajuda de custo.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- No retorno, confira se a vaga saiu (o paciente costuma não saber): pergunte, ligue para o NIR, reescreva o pedido se devolvido.
- Mantenha o tratamento enquanto espera: tala bem feita, raio-X de controle na data, analgesia, profilaxia de trombose se imobilizou a perna. Fratura que consolida torta por espera de 6 semanas é responsabilidade de quem seguiu.
- Pós-operatório que volta para você: ferida (curativo, pontos em 10–14 dias), raio-X na data do cirurgião, fisioterapia, atestado — e qualquer febre, secreção ou dor nova é ligação para o cirurgião no mesmo dia.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: tudo o que precisa de centro cirúrgico que você não tem, de especialidade que você não é, ou de UTI. Urgência: central de regulação de urgências (vaga zero se preciso). Eletivo: SISREG/CROSS ou NIR. Sempre com laudo, imagem e o que você já fez.

Atestado	Atestado do dia e dos dias até a cirurgia, com a restrição ("sem apoiar o membro direito").
Retorno	7 dias após qualquer pedido de regulação, para conferir se saiu; antes se piorar.

DICAS

- A frase que destrava vaga é a classificação com o risco: “Gustilo III”, “Gartland III”, “tornozelo instável com desvio talar”, “pulso ausente há 2 h”. Sem ela, o regulador lê “fratura” e põe na fila.
- Anote no prontuário hora do pedido, protocolo e nome do regulador. É o que vale se der problema.

Baseado em: Portaria GM/MS 2.048/2002 (urgência e vaga zero); Portaria GM/MS 1.559/2008 (Política Nacional de Regulação); Resolução CFM 2.077/2014; Portaria SAS 55/1999 (TFD); Lei 13.431/2017 e ECA art. 13 (notificação).

1.7 Anestesia local, bloqueios e sedação para reduzir

CID — · **Também** bloqueio de hematoma, bloqueio digital, bloqueio do nervo femoral, fáscia ilíaca, sedação, cetamina, lidocaína, anestesia para redução, dose máxima de lidocaína

> Para reduzir e suturar você precisa de três coisas que faz sozinho — bloqueio de hematoma, bloqueio digital e infiltração local — e de uma que só faz com monitorização e uma segunda pessoa: a sedação.

O QUE PERGUNTAR

- Alergia a anestésico local (rara; quase sempre foi reação vasovagal ou à adrenalina)? Peso (a dose máxima é por kg)? Hepatopatia, arritmia, uso de antiarrítmico (lidocaína)?
- Para sedar: comeu há quanto tempo? Vias aéreas difíceis (pescoço curto, barba, apneia do sono)? Cardiopatia, hipertensão descontrolada, psicose (cetamina), idoso frágil (dose menor)?
- Quem fica com você? Sedação é com dois: um sedando e vigiando, outro reduzindo.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Dose máxima do anestésico local	Lidocaína sem vasoconstritor: 4–5 mg/kg (adulto de 70 kg: 300 mg = 30 mL a 1% ou 15 mL a 2%). Com adrenalina: 7 mg/kg. Bupivacaína 0,25–0,5%: 2 mg/kg (máx. 175 mg sem vaso). Some tudo o que vai usar (bloqueio + infiltração) antes de começar.	Zumbido, gosto metálico, dormência perioral, agitação ou sonolência → intoxicação: pare, oxigênio, chame ajuda; convulsão → midazolam; colapso → emulsão lipídica 20% 1,5 mL/kg em bolus.
Checagem antes de sedar	Monitor (oxímetro, pressão, cardioscópio), oxigênio, aspirador, bolsa-válvula-máscara e material de via aérea testados; acesso venoso; jejum conhecido (sedação leve para redução não exige jejum formal, mas anote); escala de sedação e sinais vitais a cada 5 minutos.	Saturação < 92%, apneia, laringoespasmo (cetamina) → interrompa, ventile, chame o anestesista.

SINAIS DE ALARME

- Nunca anestésico com vasoconstritor em bloqueio de hematoma, nem em dedo na prática do serviço (a evidência moderna aceita adrenalina em dedo, mas o protocolo da maioria dos serviços brasileiros ainda não — siga o seu).
- Bloqueio de hematoma em fratura exposta ou pele infectada: contraindicado (leva infecção ao foco).
- Sedação sem monitorização, sem oxigênio ou sozinho: não. Se o serviço não tem estrutura ou anestesista de sobreaviso, reduza com bloqueio e analgesia EV, ou transfira.
- Cetamina: evite em hipertensão grave, cardiopatia isquêmica, psicose, glaucoma agudo, < 3 meses; laringoespasmo é raro mas acontece — tenha a máscara na mão.

IMAGEM

- Raio-X antes de qualquer redução (exclui fratura que muda a técnica) e depois (confirma a redução). A única exceção é o membro sem pulso ou com pele em sofrimento: reduza primeiro.

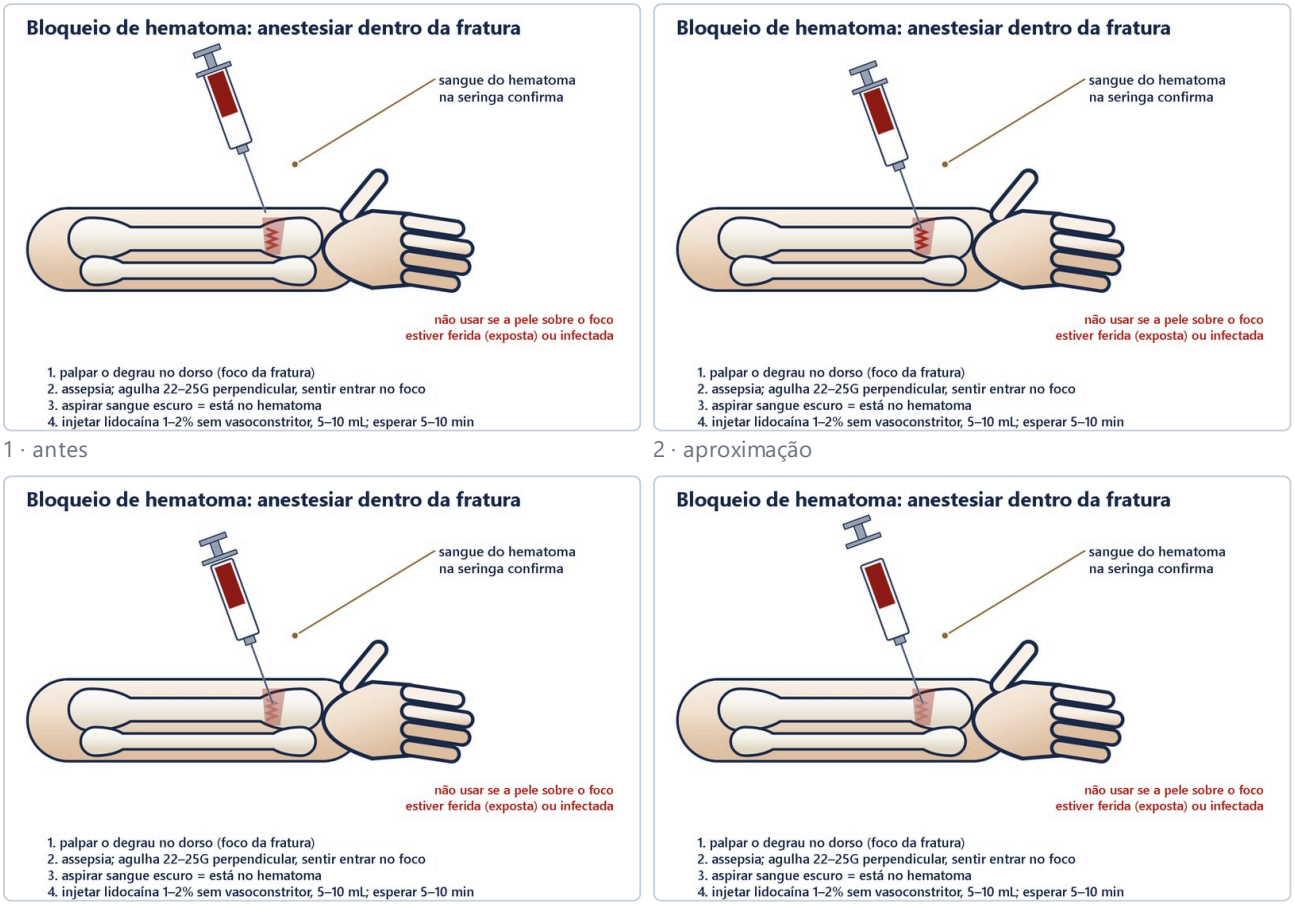
NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Redução de rádio distal, metacarpo e falange: bloqueio de hematoma ou digital, 10–15 minutos de espera, e reduza. Não precisa de sedação na maioria dos adultos.

- Luxação de ombro: lidocaína intra-articular 20 mL a 1% (tão eficaz quanto sedação, com alta mais rápida) ou sedação. Cotovelo, quadril, joelho e tornozelo: sedação (ou anestesista); uma tentativa boa vale mais que três ruins.
- Fratura de quadril ou de fêmur aguardando cirurgia: bloqueio da fáscia ilíaca ou do nervo femoral — é o padrão de analgesia (NICE), reduz opioide e delirium. Faça ao internar, com monitorização.
- Criança: sedação é com pediatra ou anestesista, exceto pronação dolorosa (sem anestesia). Analgesia antes de qualquer manipulação: dipirona EV por kg (cetorolaco só a partir de 16 anos) e, na fratura, morfina 0,05–0,1 mg/kg EV ou fentanil intranasal 1,5 mcg/kg conforme o protocolo.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

Bloqueio de hematoma (fratura do rádio distal e similares)



1 · antes · 2 · aproximação · 3 · a manobra · 4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Fratura fechada com menos de 24–48 h, para reduzir ou para tolerar a tala. Não em fratura exposta nem pele infectada.

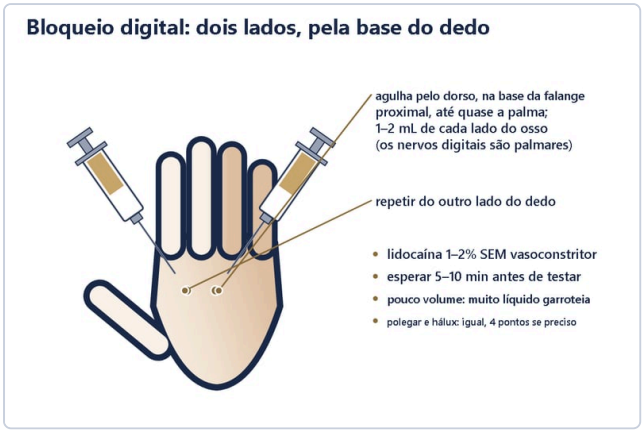
Material e anestesia: Clorexidina, luva estéril, seringa 20 mL, agulha 22G, lidocaína 1% sem vaso 10–15 mL.

Passo a passo

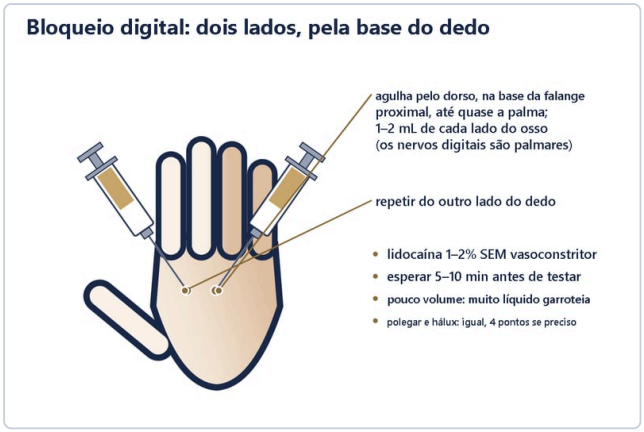
1. Antissepsia ampla no dorso do punho; localize o foco pela dor e pelo raio-X.
2. Entre pelo dorso, entre os tendões extensores, em direção ao foco; aspire — sangue escuro confirma que está no hematoma.
3. Injete 10–15 mL devagar; complemente 2–3 mL em volta do estiloide ulnar se dói.
4. Espere 10–15 minutos (use para montar a tala e o pedido de raio-X). Reduza.

Depois: Anote hora e dose. Tala, raio-X de controle, orientação escrita.

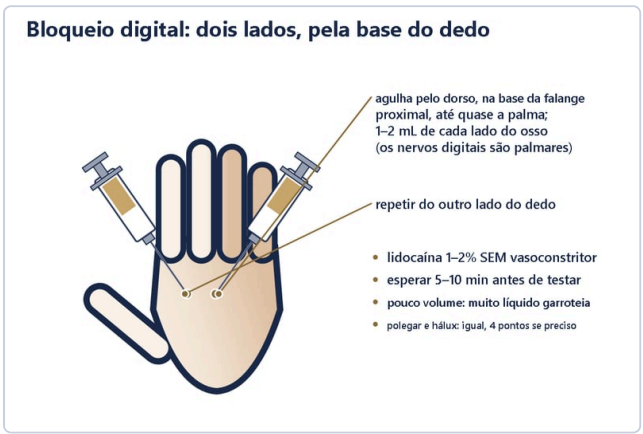
Bloqueio digital



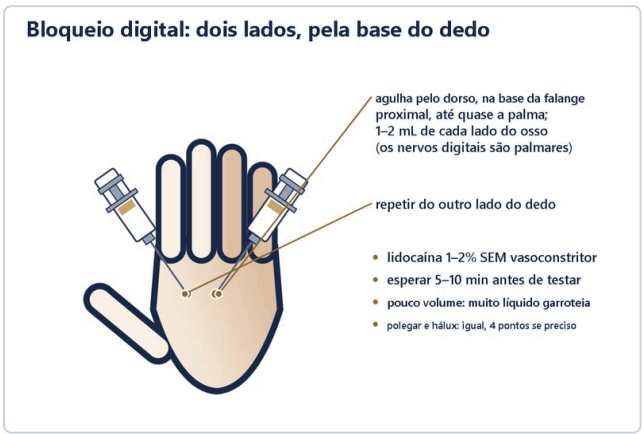
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Qualquer dedo: redução, sutura, unha, drenagem. Não se infecção na base do dedo.

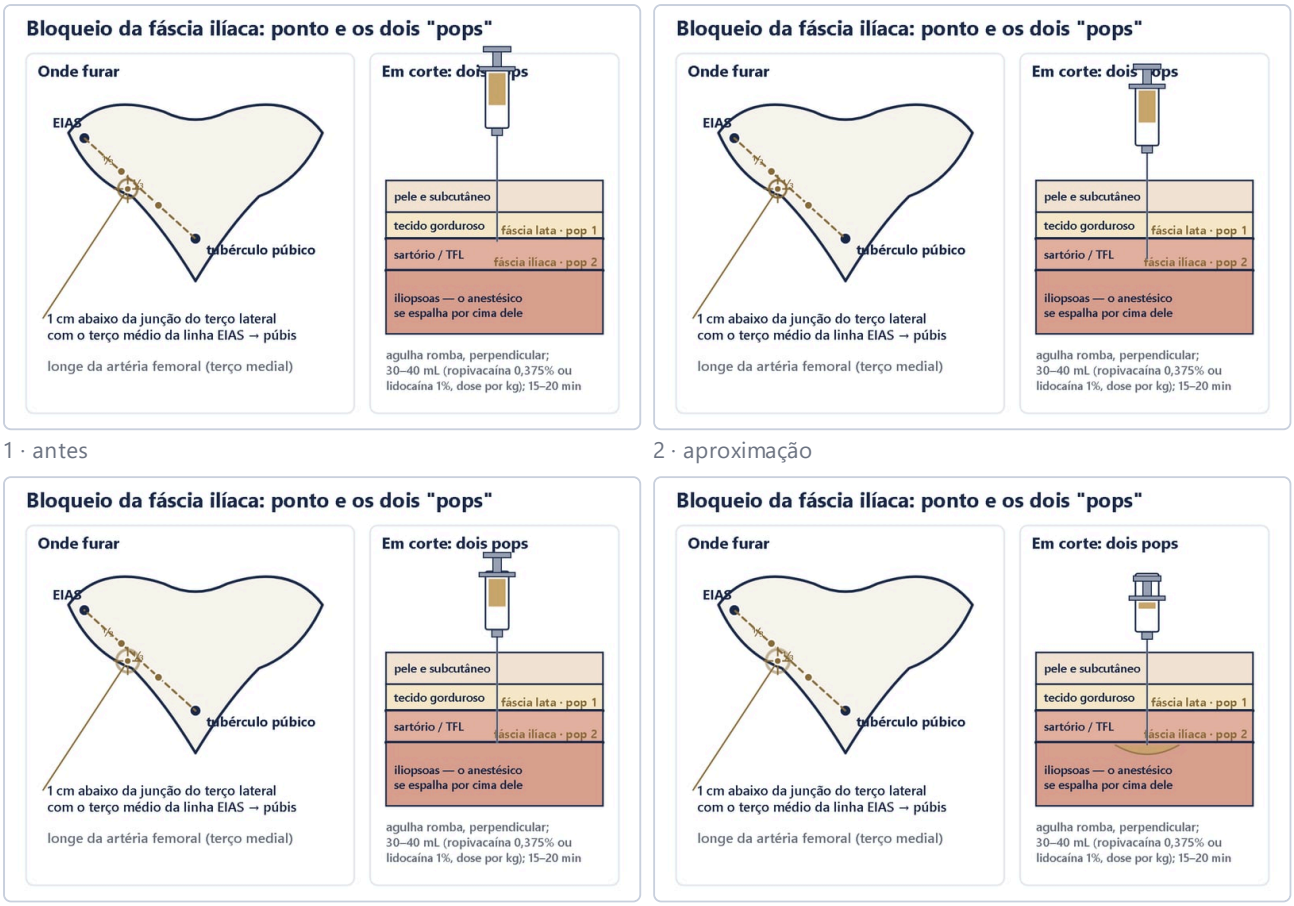
Material e anestesia: Lidocaína 1–2% sem vaso, agulha 25–27G, seringa 5 mL.

Passo a passo

1. Pela face dorsal da base do dedo, agulha perpendicular junto ao osso, aspire e injete 1–1,5 mL de cada lado (nervos digitais dorsal e palmar), retirando a agulha para o lado palmar; total 2–4 mL por dedo.
2. Alternativa de uma só punção: transtecal — 2 mL na bainha do flexor na prega palmar distal, com o dedo em extensão.
3. Espere 5–10 minutos; teste com pinça antes de começar.

Depois: Avise que a dormência dura 1–3 horas; sem garrote por mais de 20 minutos.

Bloqueio da fáscia ilíaca (analgesia da fratura de quadril e fêmur)



Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Fratura de colo ou transtrocantérica, diáfise de fêmur, aguardando cirurgia. Monitorizado, com acesso venoso.

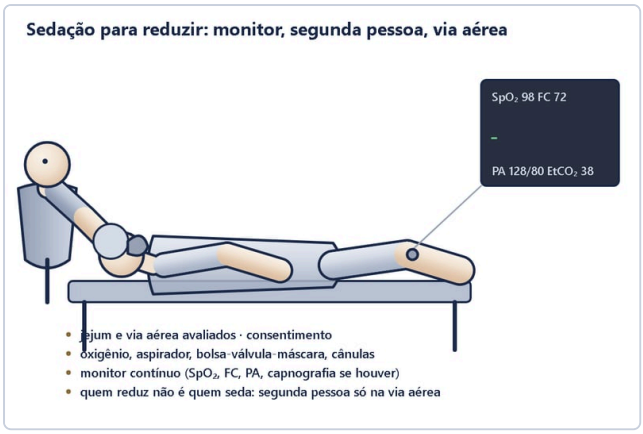
Material e anestesia: Bupivacaína 0,25% 30–40 mL (máx. 2 mg/kg) ou ropivacaína 0,375%, agulha 22G 50–80 mm de bisel curto, antissepsia; ultrassom se houver (preferível).

Passo a passo

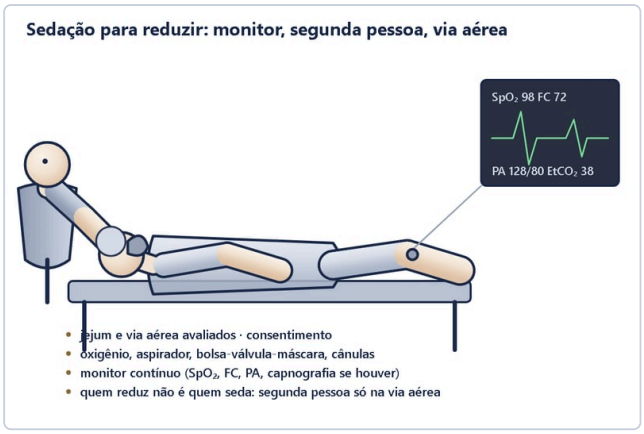
1. Trace a linha da espinha ilíaca anterossuperior ao tubérculo púbico; marque a junção do terço lateral com os dois terços mediais; o ponto é 1 cm abaixo dela.
2. Agulha perpendicular à pele: sinta dois “cliques” (fáscia lata e fáscia ilíaca). Aspire.
3. Injete 30–40 mL em frações de 5 mL, aspirando entre elas; a resistência baixa quando está no plano certo.
4. Efeito em 15–30 minutos, dura 6–12 horas; pode repetir a cada 12 h com a dose máxima respeitada.

Depois: Anote dose, hora e sinais vitais; mantenha dipirona fixa. Sem efeito em 30 min: bloqueio fora do plano — não repita acima da dose.

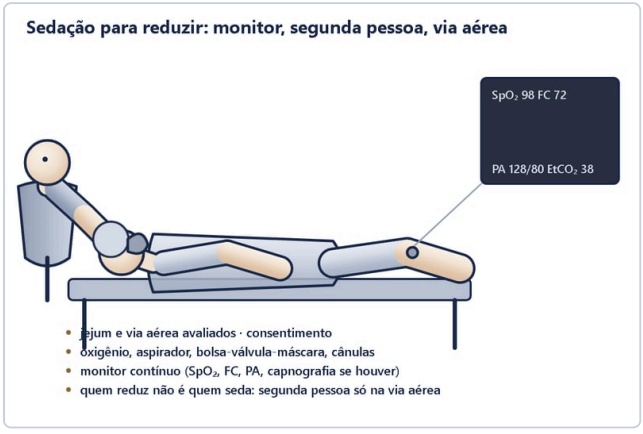
Sedação para redução (adulto, com monitorização e segunda pessoa)



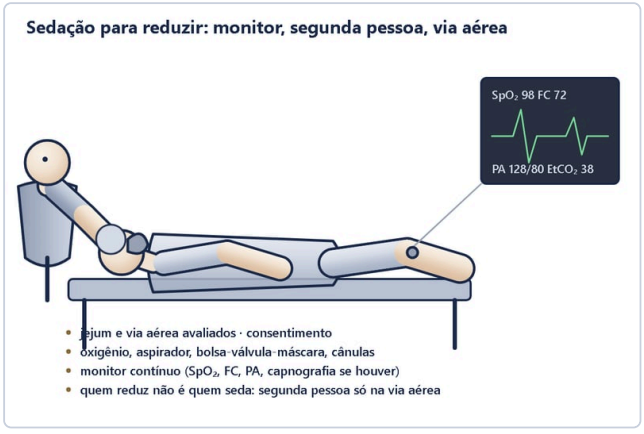
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Luxação de cotovelo, quadril, joelho, tornozelo, ombro que não cedeu ao bloqueio, fratura que precisa de tração sustentada.

Material e anestesia: Monitor, oxigênio, aspirador, bolsa-máscara, acesso venoso; cetamina, midazolam, propofol e os antídotos (flumazenil, naloxona) conforme o protocolo do serviço.

Passo a passo

1. Esquema mais usado para redução: cetamina 0,5–1 mg/kg EV lento (ou 4 mg/kg IM) — analgesia e dissociação, mantém via aérea; pode associar midazolam 0,03–0,05 mg/kg para a agitação ao despertar.
2. Alternativa: propofol 0,5–1 mg/kg EV em bolus lento, repetindo 0,25–0,5 mg/kg a cada 1–2 min (apneia e hipotensão: só com quem sabe ventilar). Midazolam 0,05–0,1 mg/kg + fentanil 1 mcg/kg é mais lento e deprime mais a respiração.
3. Reduza com o paciente relaxado (1–2 min após a dose). Uma tentativa, firme e lenta.
4. Observe até acordar, sentar e beber sem náusea; sem dirigir por 24 h; acompanhante obrigatório.

Depois: Registre drogas, doses, horários, sinais vitais a cada 5 min e o estado neurovascular antes e depois.

CONDUTA

- Analgesia EV no plantão: dipirona 1–2 g EV lenta; cetorolaco 30 mg EV (15 mg em > 65 anos ou renal; dose única); morfina 2–4 mg EV a cada 5–10 min até controlar (0,05–0,1 mg/kg); tramadol 100 mg EV lento com antiemético. Fratura dói: medique antes do raio-X.
- Infiltração local para sutura: lidocaína 1–2% com ou sem adrenalina (com adrenalina sangra menos em couro cabeludo e face; evite em ponta de nariz e orelha no serviço que não usa), agulha fina, injete ao retirar; bicarbonato 1 mL para 9 mL de lidocaína reduz a ardência.

- Criança: lidocaína 1% máximo 4 mg/kg (0,4 mL/kg); anestésico tópico (lidocaína-prilocaína) 45–60 minutos antes para punções; a presença dos pais e a distração valem como analgesia.
- Depois de qualquer bloqueio ou sedação, o exame neurovascular é repetido e anotado — o que estava dormente antes não pode virar "culpa do bloqueio".

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- No ambulatório, bloqueio digital e infiltração local servem para dedo em gatilho, De Quervain, unha e pequenas suturas; não precisa de pronto-socorro.
- Paciente que foi sedado volta em 24–48 h ou liga: náusea, sono excessivo ou dor nova são motivo de reavaliar.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: sedação em criança (pediatra/anestesista), paciente ASA III–IV ou via aérea difícil (anestesista), redução que falhou com sedação adequada (cirurgia sob anestesia geral — regulação), intoxicação por anestésico (UTI).

Atestado	O da condição; some 1 dia após sedação (não dirigir, não trabalhar em altura ou máquina).
Retorno	O da fratura ou luxação reduzida; 24 h por telefone após sedação.

DICAS

- A lidocaína a 1% tem 10 mg/mL; a 2%, 20 mg/mL. Para a mesma dose em mg, a 1% dá o dobro do volume — e volume é o que faz o bloqueio de hematoma funcionar.
- Reduzir ombro com lidocaína intra-articular: 20 mL a 1% pela via posterior (2 cm abaixo e 1 cm medial ao ângulo posterolateral do acrômio, em direção ao processo coracoide). Espere 15 minutos.

Baseado em: ACEP — Procedural sedation and analgesia 2014/2019; NICE NG124 (nerve blocks in hip fracture); BOAST — Fragility hip fracture (fascia iliaca block); Bulas (Anvisa): lidocaína, bupivacaína, cetamina, propofol, midazolam; AAGBI — Local anaesthetic toxicity.

1.8 Punção e infiltração: joelho, ombro, punho e mão, quadril

CID — · **Também** artrocentese, punção articular, infiltração de corticoide, triancinolona, infiltrar o joelho, infiltração subacromial, infiltração do túnel do carpo, infiltração do dedo em gatilho, como infiltrar

> A punção é o exame da articulação quente e o alívio do derrame tenso; a infiltração de corticoide é o seu tratamento de ombro, joelho, túnel do carpo, dedo em gatilho, De Quervain e trocanter — técnica simples, assepsia rigorosa e no máximo 3 por articulação por ano.

O QUE PERGUNTAR

- Diabetes (a glicemia sobe por 2–5 dias após corticoide)? Anticoagulante (não contraindica a punção; comprima mais)? Alergia a anestésico? Infecção de pele no caminho da agulha (contraindica)?
- Já infiltrou esta articulação, quando e quantas vezes? Prótese no local (não infiltrar: risco de infecção da prótese; punção só para cultura, com o cirurgião)?
- Vai operar nos próximos 3 meses? Corticoide intra-articular até 3 meses antes de prótese aumenta infecção.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
O que fazer com o líquido	Observe cor e viscosidade. Mande: celularidade com diferencial, Gram e cultura (frasco estéril), pesquisa de cristais (tubo com heparina ou seco, microscopia polarizada), glicose se possível. Nunca jogue fora o líquido de uma articulação quente.	Turvo ou purulento, > 50.000 células com > 90% neutrófilos → séptica até a cultura: antibiótico EV após a coleta e drenagem (ver Monoartrite). 2.000–50.000 → inflamatório (gota, pseudogota, reumatoide). < 2.000, claro → mecânico. Sangue → hemartrose (fratura, LCA, anticoagulado).

SINAIS DE ALARME

- Articulação quente + febre: puncione e colha antes de qualquer antibiótico; não infiltre corticoide em dúvida de infecção.
- Dor, calor e febre 24–72 h depois de uma infiltração: artrite séptica pós-infiltração (rara, mas é sua) — punção, cultura, antibiótico EV e cirurgião.
- Hemartrose após trauma com raio-X normal: ressonância (LCA, osteocondral) — a punção alivia e diagnostica (gordura no sangue = fratura).

IMAGEM

- Raio-X antes de infiltrar artrose (grau e exclusão de outra coisa); ultrassom guia quadril, ombro glenoumeral e infiltrações de tendão quando disponível — no joelho e subacromial a técnica por referência anatômica funciona.

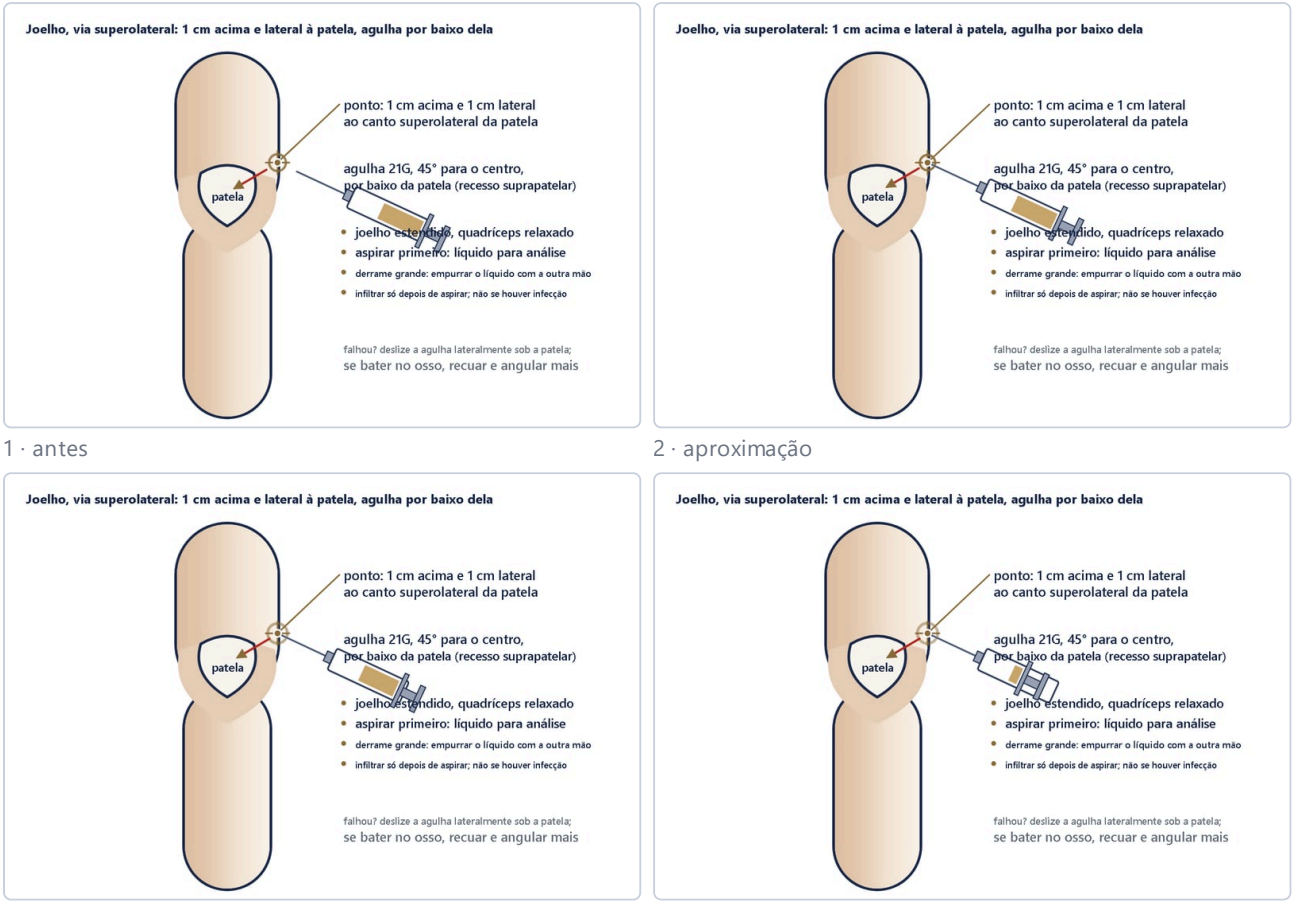
NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Joelho quente que chegou no plantão: punção agora, líquido para o laboratório, e a conduta sai da contagem — séptica interna; gota ou pseudogota trata e vai para casa com retorno.
- Derrame tenso e doloroso após trauma: esvaziar (hemartrose) alivia e permite examinar os ligamentos; infiltrar 5–10 mL de lidocaína 1% depois ajuda o exame.

- Bursite pré-patelar ou do olécrano tensa: punção (cultura se quente), compressão; infecção → antibiótico (ver Cisto de Baker e bursites).

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

Punção e infiltração do joelho — via superolateral



1 · antes

2 · aproximação

3 · a manobra

4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Derrame a esclarecer ou a esvaziar; artrose em crise; pseudogota. Não com celulite sobre o local, nem prótese.

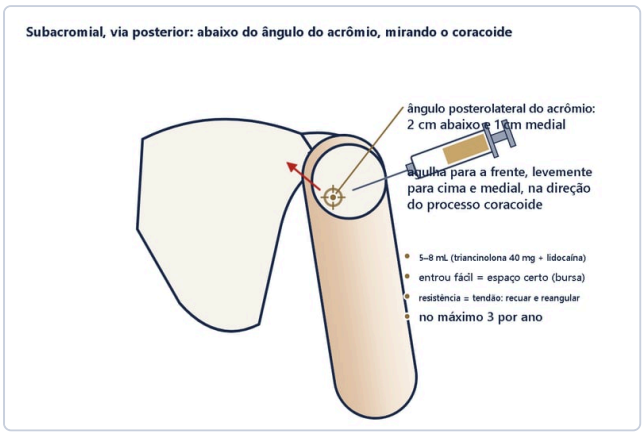
Material e anestesia: Clorexidina alcoólica, campo e luva estéril, lidocaína 1% 3–5 mL (pele), agulha 18–21G 40 mm para punção (21G para infiltrar), seringas 20–60 mL, frascos; para infiltrar: triancinolona 40 mg (1 mL) ou metilprednisolona 40 mg + lidocaína 1% 4–5 mL.

Passo a passo

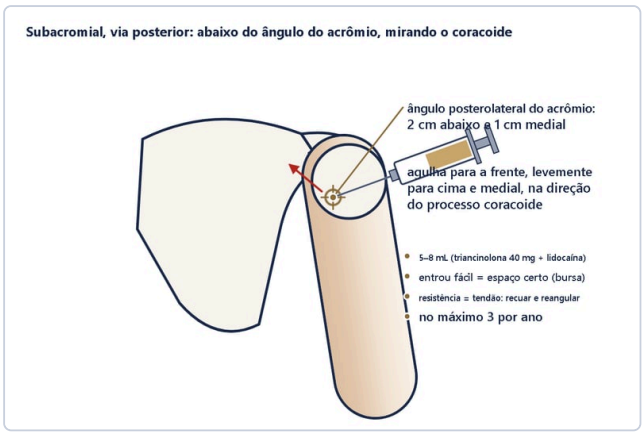
1. Paciente deitado, joelho estendido (ou 15–20° com rolo), quadríceps relaxado. Marque 1 cm acima e 1 cm lateral ao ângulo superolateral da patela.
2. Antissepsia ampla; botão anestésico na pele.
3. Agulha horizontal, levemente para baixo e para o meio, por baixo da patela em direção ao centro; aspire ao avançar. Líquido vem fácil quando há derrame; se não vem, mobilize a patela com a outra mão e comprima a bolsa suprapatelar.
4. Esvazie o que der (troque a seringa mantendo a agulha); depois, sem tirar a agulha, injete o corticoide com o anestésico.
5. Curativo, compressão e repouso relativo por 24–48 h.

Depois: Anote volume e aspecto; alívio do corticoide em 2–7 dias, dura 4–8 semanas; máximo 3–4 por ano. Diabético confere glicemia por 3 dias.

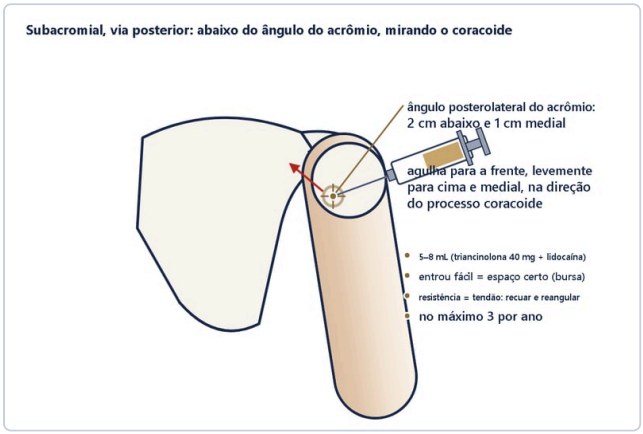
Infiltração subacromial — via posterior



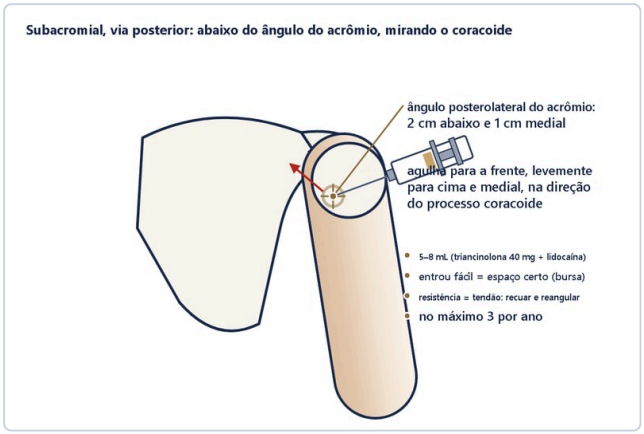
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Síndrome do impacto, bursite, tendinopatia do manguito e tendinite calcária que não melhoram com fisioterapia; também como teste (dor some = origem subacromial).

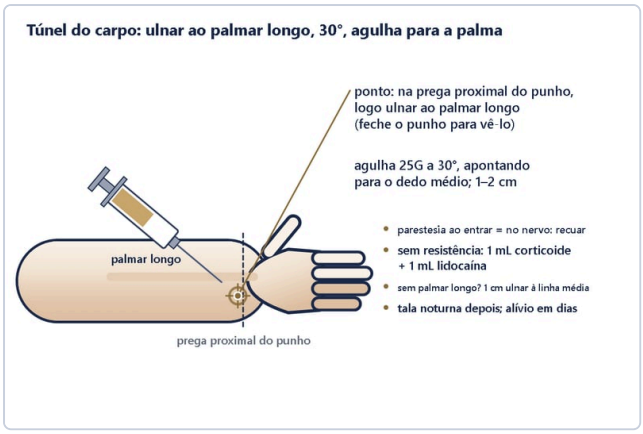
Material e anestesia: Triancinolona 20–40 mg ou metilprednisolona 40 mg + lidocaína 1% 5–8 mL; agulha 21–22G 40 mm.

Passo a passo

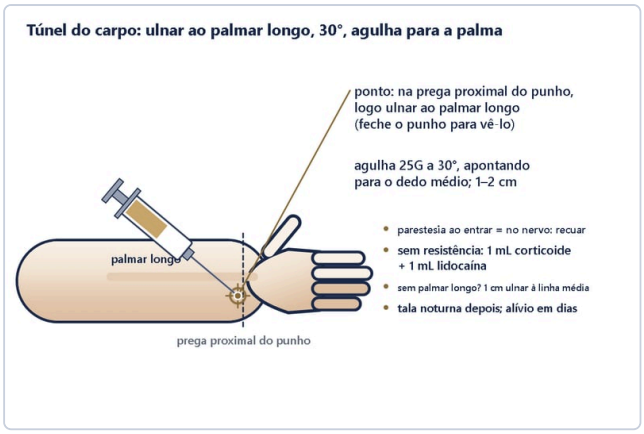
1. Sentado, braço pendente. Ponto: 2 cm abaixo e 1 cm medial ao ângulo posterolateral do acrômio (o "canto" que você palpa).
2. Agulha para a frente e levemente para cima, em direção ao processo coracoide (sinta o espaço sob o acrômio); se bater no osso, recue e redirecione para baixo.
3. Injete sem resistência (resistência = está no tendão: recue 2–3 mm). Mova o braço depois para espalhar.

Depois: Fisioterapia começa em 1 semana — a infiltração é a ponte. Máximo 2–3 por ano. Nunca no tendão do bíceps ou no Aquiles.

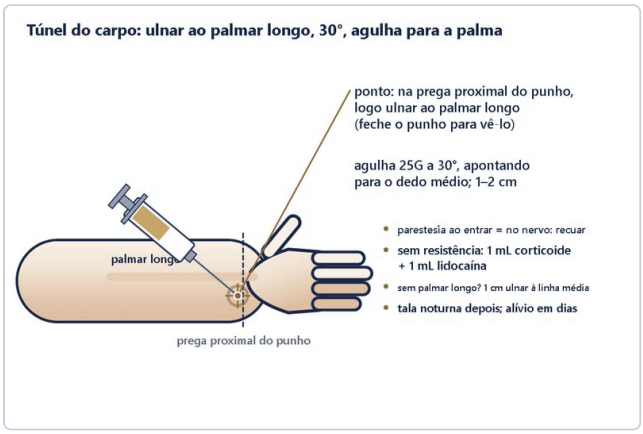
Infiltração do túnel do carpo



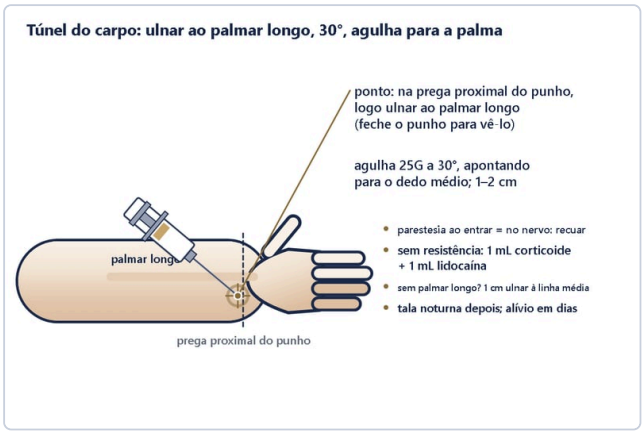
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Síndrome do túnel do carpo leve a moderada, gestante, ponte para a cirurgia. Não se atrofia tenar (é cirurgia).

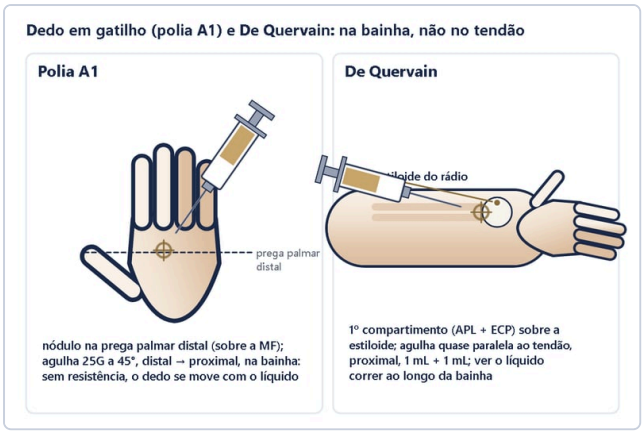
Material e anestesia: Metilprednisolona 40 mg ou triancinolona 20 mg + lidocaína 1% 1 mL; agulha 25–27G 25 mm.

Passo a passo

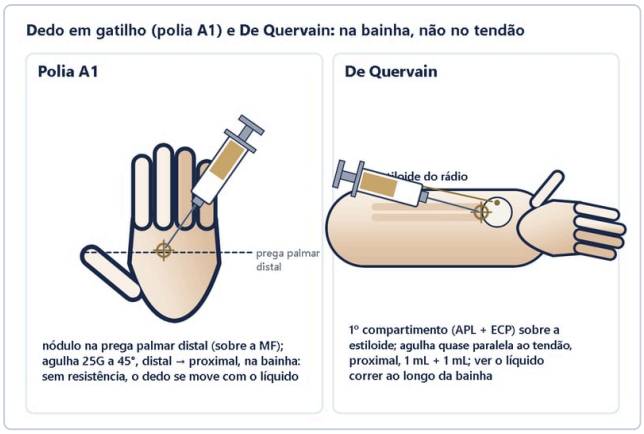
1. Punho em leve extensão, palma para cima. Ponto: 1 cm proximal à prega distal do punho, ulnar ao tendão do palmar longo (peça para opor polegar e mínimo com o punho fletido para vê-lo; sem palmar longo, 1 cm ulnar à linha média).
2. Agulha a 30–45° em direção distal, avance 1–2 cm até passar o retináculo (leve "clique").
3. Parestesia em choque = encostou no nervo: recue e redirecione mais ulnar. Injete sem resistência.

Depois: Órtese noturna continua. Alívio em dias; repetir no máximo uma vez. Sem melhora em 6 semanas: eletroneuromiografia e cirurgia.

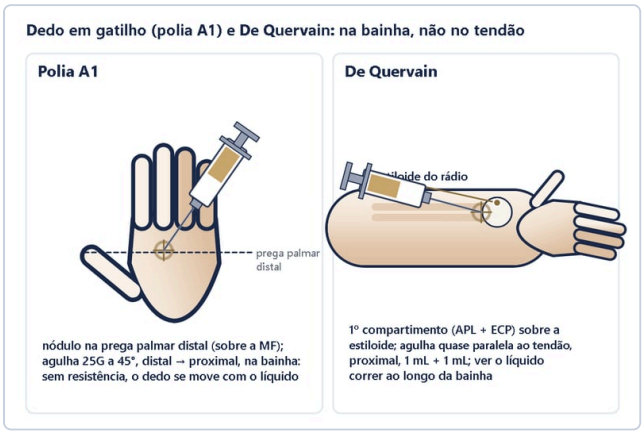
Infiltração do dedo em gatilho (polia A1) e do De Quervain



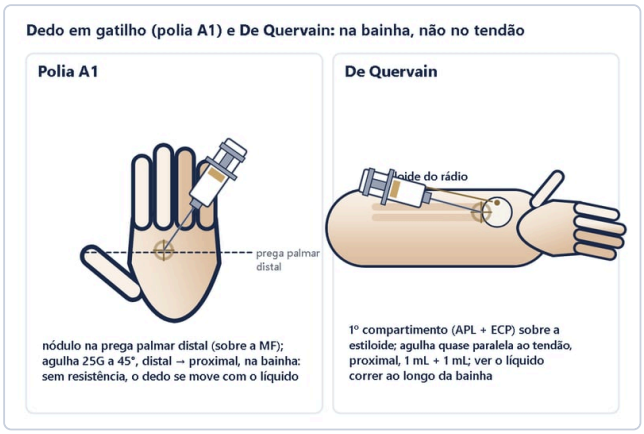
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Dedo em gatilho que trava; De Quervain sem melhora em 2–4 semanas de órtese (ou já na primeira consulta na lactante).

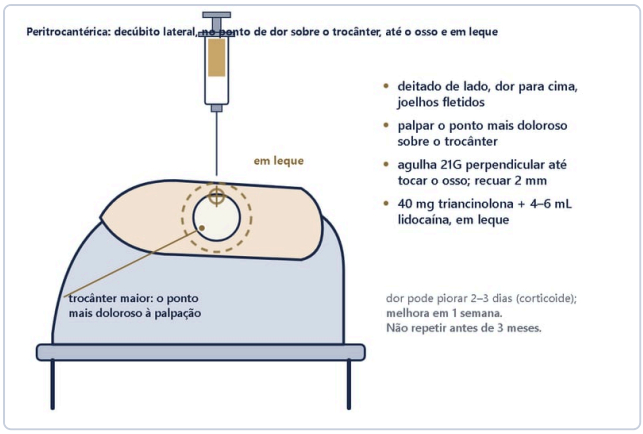
Material e anestesia: Triancinolona 10 mg (gatilho) ou 10–20 mg (De Quervain) + lidocaína 1% 0,5–1 mL; agulha 25–27G.

Passo a passo

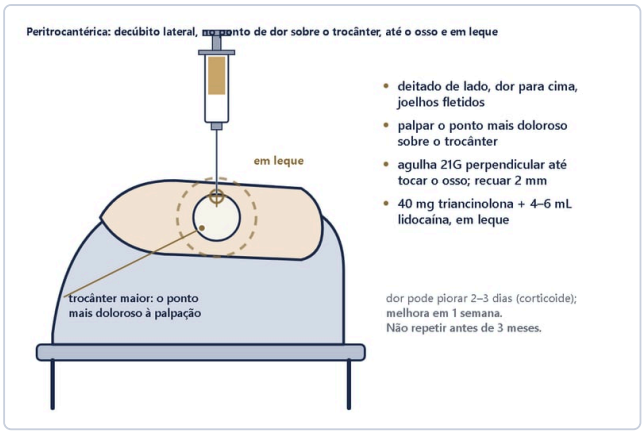
1. Gatilho: nódulo da polia A1 na palma, sobre a cabeça do metacarpo (prega palmar distal nos dedos; prega metacarpofalângica no polegar). Agulha a 45° distal, até sentir a bainha; se o dedo fletido mexe a agulha, está no tendão: recue 1–2 mm e injete sem resistência.
2. De Quervain: palpe o 1º compartimento sobre o estiloide radial; peça extensão do polegar para ver os tendões; agulha paralela aos tendões, proximal, dentro da bainha (o líquido corre ao longo do compartimento). Fique subcutâneo o mínimo possível (atrofia e despigmentação da pele).

Depois: Resolução em 1–3 semanas; segunda dose após 6 semanas se recidivar; falha de duas → cirurgia (liberação da polia / abertura do compartimento).

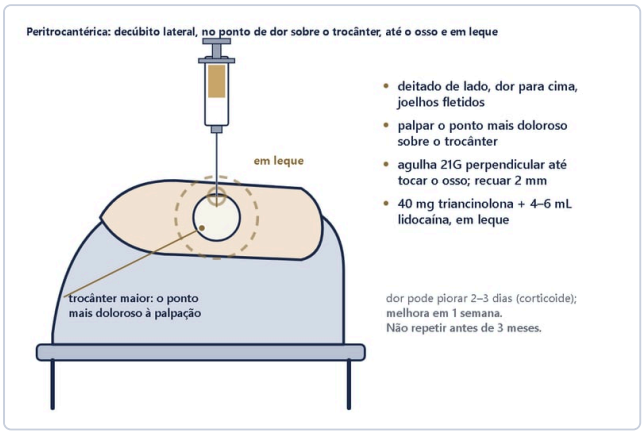
Infiltração peritrocantérica



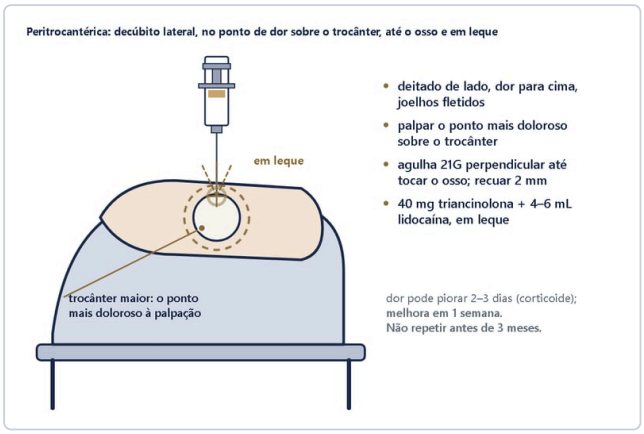
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Síndrome dolorosa do grande trocanter que impede o exercício.

Material e anestesia: Triancinolona 40 mg ou metilprednisolona 40 mg + lidocaína 1% 5–8 mL; agulha 22G 50–90 mm (obeso: longa).

Passo a passo

1. Decúbito lateral, lado doente para cima, quadril levemente fletido. Marque o ponto de máxima dor sobre o trocanter.
2. Agulha perpendicular até tocar o osso; recue 2 mm e injete em leque (3–4 direções) ao redor do ponto.

Depois: Exercício de glúteo começa em 1 semana — infiltração sem exercício recidiva. Máximo 2–3 por ano.

CONDUTA

- Assepsia como cirurgia pequena: clorexidina alcoólica, luva estéril, agulha nova para cada entrada, não toque o trajeto. Infecção pós-infiltração é 1 em 10–50 mil quando a técnica é limpa.
- Corticoides: triancinolona (40 mg/mL) dura mais e atrofia mais a pele — fique dentro da articulação ou bursa; metilprednisolona 40 mg é a alternativa; betametasona 6 mg (dipropionato + fosfato) serve para tendão/bainha. Nunca em tendão de carga (Aquiles, patelar, quadríceps).
- Anestésico junto: lidocaína 1% 2–8 mL conforme o espaço — dá o alívio imediato que confirma o alvo. Avise que a dor pode piorar 24–48 h (reação ao cristal) antes de melhorar.
- Contraindicações: infecção local ou sistêmica, prótese, fratura intra-articular, articulação instável, anticoagulação descompensada (INR > 3,5), mais de 3 infiltrações no ano na mesma articulação.
- Ácido hialurônico: efeito pequeno no joelho e caro; sem ele no SUS, não é perda. PRP: sem evidência para indicar.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Marque o retorno em 2–4 semanas para medir a resposta: alívio bom = continuar a fisioterapia e repetir só se recidivar; alívio nenhum = o diagnóstico ou o alvo estavam errados.
- Registre em cada infiltração: articulação, droga, dose, data — é o que permite dizer "já são 3 este ano" e indicar a cirurgia na hora certa.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: artrite séptica (drenagem cirúrgica), infiltração guiada por imagem que você não tem (quadril, facetas, sacroilíaca — radiologia intervencionista pela regulação), infecção de prótese (cirurgião da prótese, sem antibiótico antes da cultura).

Atestado	1–2 dias após infiltração de articulação de carga; 0 nas demais.
Retorno	2–4 semanas; 48 h se dor crescente, calor ou febre.

DICAS

- Joelho que "não tem líquido" mas tem tecla: comprima a bolsa suprapatelar com a mão livre enquanto aspira — o líquido vem.
- Infiltrou e a dor sumiu na hora, mas voltou em 2 horas: o anestésico confirmou o alvo; o corticoide ainda vai agir em 2–7 dias. Explique antes, não depois.

Baseado em: AAOS — Joint aspiration and injection; ACR — Synovial fluid analysis; BSR/BOA — Hot swollen joint; Cochrane — Intra-articular corticosteroid for knee OA; Corticosteroid injection for CTS; Trigger finger; De Quervain; LEAP trial (BMJ 2018).

CAPÍTULO 2

Urgências do plantão

O que chega de ambulância: o que você faz nas primeiras horas é o que decide o membro — antibiótico, redução, tala, e a vaga pedida com o laudo certo.

2.1	**Fratura exposta** Toda ferida sobre o foco de fratura é exposta até prova em contrário: antibiótico EV na primeira hora, tétano, lavagem, curativo, alinhamento e tala — e a cirurgia de desbridamento em até 24 horas, pela regulação se você não opera.	38
2.2	**Síndrome compartimental e gesso apertado** Dor desproporcional que piora ao esticar os dedos passivamente, em perna ou antebraço com fratura, gesso ou esmagamento, é síndrome compartimental até prova em contrário: abra tudo até a pele, meça se puder e a fasciotomia é em horas — não espere o pulso sumir.	43
2.3	**Fraturas da diáfise: fêmur, tíbia e úmero** Fêmur e tíbia desviadas vão para a haste: você alinha, imobiliza, trata a dor e o sangramento e pede a vaga; úmero é a exceção — a maioria consolida com a tala em pinça e a órtese funcional, e você segue no ambulatório.	47
2.4	**Luxações de quadril, joelho e tornozelo** Quadril luxado reduz em até 6 horas (necrose da cabeça), joelho luxado é artéria poplítea até prova em contrário, tornozelo luxado reduz antes do raio-X se a pele sofre — as três são suas na primeira hora, e todas ficam internadas.	52
2.5	**Fraturas do tornozelo (maléolos)** A fratura isolada do maléolo lateral com o tálus no lugar (Weber A ou B estável) é sua: bota ou gesso, carga e 6 semanas; o tálus deslocado, o maléolo medial fraturado ou a sindesmose aberta (Weber C) são cirurgia — você reduz, imobiliza e agenda.	57
2.6	**Fratura do úmero proximal** A idosa que caiu, com o braço colado ao corpo e um hematoma que desce pelo braço: a maioria (sem desvio ou com desvio moderado, mesmo em 3 partes no idoso) trata com tipoia e movimento precoce — e é sua do início ao fim; cirurgia é para o jovem desviado, a luxação e a cabeça partida.	61
2.7	**Fratura da patela e ruptura do aparelho extensor** A pergunta é uma só: consegue levantar a perna esticada contra a gravidade? Consegue → aparelho extensor íntegro, patela sem desvio: imobilizador em extensão e carga, é sua. Não consegue → patela desviada, tendão patelar ou quadríceps rotos: cirurgia em 1–2 semanas.	65
2.8	**Fraturas de pelve e sacro no idoso (e a pelve instável)** O idoso que caiu, dói na virilha ou na nádega e tem o colo do fêmur normal costuma ter fratura de ramo púbico ou de sacro: analgesia, levantar com andador e tratar a osteoporose — é sua; a pelve de alta energia com instabilidade é cinta, sangue e centro de trauma.	68

2.1 Fratura exposta

CID T14.2 / S82.2 / S52.5 · **Também** osso para fora, ferida sobre a fratura, fratura aberta, Gustilo, antibiótico na fratura exposta, tétano na fratura

> Toda ferida sobre o foco de fratura é exposta até prova em contrário: antibiótico EV na primeira hora, tétano, lavagem, curativo, alinhamento e tala — e a cirurgia de desbridamento em até 24 horas, pela regulação se você não opera.

O QUE PERGUNTAR

- Mecanismo e energia (atropelamento, moto, queda de altura = alta energia = Gustilo III mesmo com ferida pequena)? Hora exata do trauma? Ambiente (esgoto, terra, fazenda, água)?
- Vacina antitetânica: quando foi a última dose, quantas doses na vida?
- Comorbidades: diabetes, tabagismo, imunossupressão, anticoagulante; alergia a antibiótico; jejum desde que horas.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Classificação de Gustilo (anote)	I: ferida < 1 cm, limpa, baixa energia. II: 1–10 cm sem grande lesão de partes moles. IIIA: > 10 cm ou alta energia com cobertura óssea possível; IIIB: perda de partes moles que precisa de retalho, contaminação pesada; IIIC: lesão arterial que precisa de reparo. A classificação definitiva é no centro cirúrgico, mas a provisória decide antibiótico e urgência.	III → gentamicina junto; IIIC → vascular agora.
Neurovascular distal, antes e depois de tudo	Pulsos, enchimento capilar, cor, temperatura, sensibilidade e motricidade distais; compare com o outro lado; anote com horário.	Pulso ausente após alinhar → lesão arterial: vascular e cirurgia agora (6 horas de isquemia quente).
Ferida e compartimentos	Olhe uma vez, bem, com luz: tamanho, contaminação, exposição óssea, sangramento; tensão dos compartimentos; fotografe para o prontuário e para o cirurgião. Depois cubra e não abra mais.	Compartimento tenso e dor ao estiramento passivo → síndrome compartimental pode coexistir.

SINAIS DE ALARME

- Sangramento ativo: compressão direta e elevação; torniquete só na hemorragia exsanguinante que não para, com a hora anotada.
- Pulso ausente ou mão/pé frio: alinhe e imobilize; se não volta, angiotomografia ou direto ao vascular — não espere o ortopedista do destino.
- Gustilo III, lesão vascular, politrauma, fratura de pelve ou coluna associada: centro de trauma, transporte avançado.
- Criança com fratura exposta: mesmo protocolo de antibiótico (cefazolina 30 mg/kg), sedação com pediatra para alinhar, ortopedia pediátrica.

IMAGEM

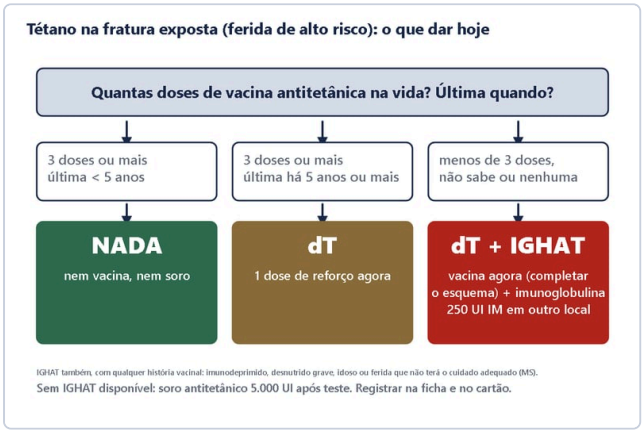
- Raio-X em duas incidências incluindo as articulações acima e abaixo, com a tala provisória — não atrase o antibiótico pelo raio-X. Tomografia se articular ou pelve, se disponível, sem atrasar a transferência.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

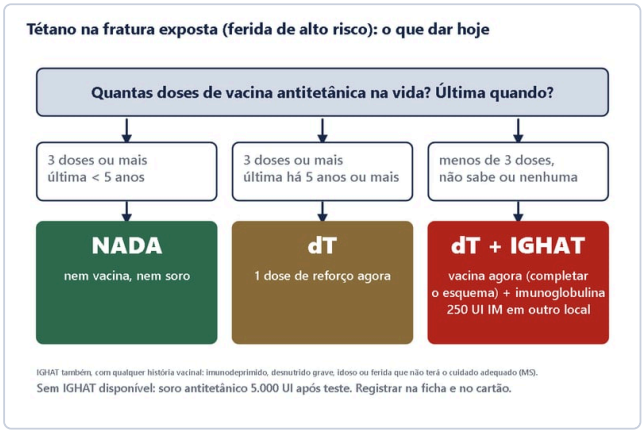
- Na primeira hora, nesta ordem: analgesia EV; antibiótico EV (cefazolina 2 g, 3 g se > 120 kg; Gustilo III: + gentamicina 5 mg/kg EV 1×/dia; contaminação com terra/fezes/água parada: + metronidazol 500 mg EV 8/8 h ou penicilina cristalina 4 milhões UI 4/4 h); tétano conforme a vacina.
- Ferida: retire só sujeira grossa visível, lave com soro fisiológico abundante (1–3 L, sem pressão alta), não explore com dedo nem escove; curativo estéril úmido com soro; não feche a ferida.
- Alinhe o membro com tração suave (dor e perfusão melhoram) e imobilize com tala que inclua as articulações vizinhas; reavalie pulso e sensibilidade e anote.
- Jejum, acesso venoso, exames pré-operatórios (hemograma, coagulograma, creatinina, tipagem), e a regulação com urgência: "fratura exposta Gustilo [x] de [osso] [lado], antibiótico às [hora], desbridamento em até 24 h". Se o seu hospital opera: sobreaviso agora.
- Desbridamento e estabilização cirúrgica em até 24 horas (até 12 h em contaminação pesada) — é o que define infecção e consolidação; a ferida fechada por você no plantão é o erro que mais custa.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

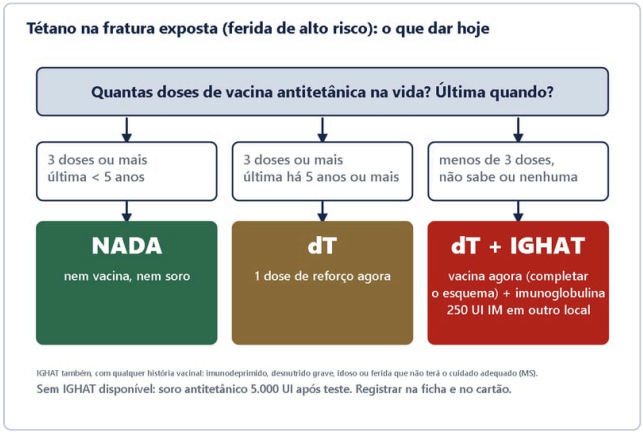
Profilaxia do tétano na ferida da fratura exposta (ferida de alto risco)



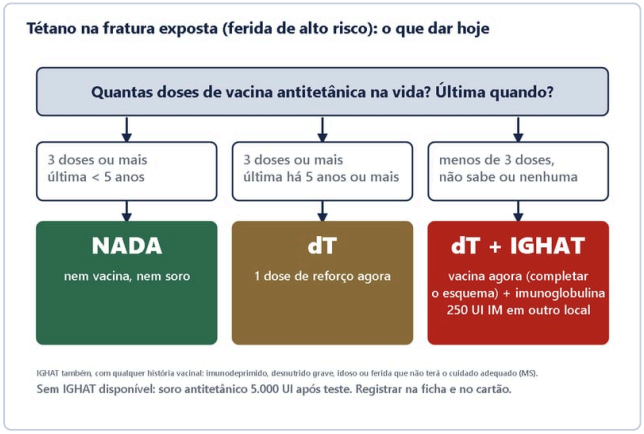
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Toda fratura exposta é ferida de alto risco (profunda, contaminada, com tecido desvitalizado).

Material e anestesia: Vacina dT (ou dTpa) e imunoglobulina antitetânica humana (IGHAT 250 UI IM) ou, na falta, soro antitetânico 5.000 UI após teste.

Passo a passo

1. 3 doses ou mais, última há < 5 anos: nada.
2. 3 doses ou mais, última há 5 anos ou mais: reforço dT.
3. Menos de 3 doses, desconhecido ou nenhuma: dT agora (e completar o esquema) + IGHAT 250 UI IM em outro local.
4. IGHAT também, com qualquer história vacinal, no imunodeprimido, desnutrido grave, idoso ou quando a ferida não vai ter o cuidado adequado (Ministério da Saúde).

Depois: Anote lote e data; complete o esquema na unidade básica.

Tala de alinhamento da perna (fratura de tíbia)



1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Qualquer fratura de tíbia ou tornozelo instável, para transporte e para aguardar a cirurgia.

Material e anestesia: Gesso 15 cm (12–15 camadas), algodão ortopédico, atadura de crepe, 2 ajudantes.

Passo a passo

1. Analgesia feita; um ajudante segura o joelho, outro traciona o calcanhar devagar até o membro ficar reto; você segura a fratura.
2. Acolchoe bem calcanhar, maléolos e cabeça da fíbula; tala posterior da raiz da coxa (joelho a 15–20°) até os dedos, tornozelo a 90°; some uma tala em U (estribo) nos maléolos se o tornozelo é a fratura.
3. Enfaixe sem apertar, molde com as palmas (não com os dedos), mantenha a tração até endurecer.

4. Pulso, sensibilidade, cor e movimento dos dedos depois; eleve o membro ao nível do coração.

Depois: Raio-X com a tala; cheque o compartimento a cada hora nas primeiras 6 h.

CONDUTA

- Antibiótico até 72 h ou até 24 h após a cobertura definitiva da ferida; Gustilo I–II: cefazolina por 24–48 h após o desbridamento. Mais tempo não reduz infecção e seleciona germes.
- Fratura exposta de dedo (falange distal com unha): pode ser sua — lavagem, antibiótico oral (cefalexina 500 mg 6/6 h por 5–7 dias), reparo da unha, tala; ver Ferimentos da mão.
- Explique à família: duas ou mais cirurgias são a regra (desbridamento, fixação, cobertura); infecção e retardo de consolidação são riscos mesmo com tudo certo.
- Tabagismo e diabetes dobram a infecção e a não união: diga isso no primeiro dia.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Cefazolina 1 g (frasco-ampola)	2 g EV agora (3 g se > 120 kg), depois 2 g EV de 8/8 h, por até 72 h ou até 24 h após o fechamento da ferida.	Alergia grave a betalactâmico: clindamicina 900 mg EV 8/8 h (ou vancomicina 15 mg/kg 12/12 h).
Gentamicina 80 mg/2 mL	5 mg/kg EV 1× ao dia (dose única diária), enquanto durar a cefazolina.	Só em Gustilo III; ajustar na insuficiência renal; evitar em idoso com creatinina alterada (alternativa: ceftriaxona 2 g/dia).
Dipirona 1 g/2 mL	2 mL EV lento (até 2 g) de 6/6 h.	—
Morfina 10 mg/mL	2 a 4 mg EV a cada 5–10 minutos até controlar a dor (máximo 0,1 mg/kg na primeira hora), com monitorização.	Antiemético junto (ondansetrona 4–8 mg EV); cuidado em idoso e DPOC.
Vacina dT	0,5 mL IM, conforme o esquema do tétano (ver procedimento).	—

IMOBILIZAÇÃO

- Tala gessada incluindo as articulações acima e abaixo, bem acolchoada; a ferida acessível por uma janela no curativo, não na tala.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Depois da cirurgia, o retorno é seu: curativo, sinais de infecção (secreção, febre, dor que aumenta após o 3º dia), raio-X nas datas do cirurgião (2, 6, 12 semanas), fisioterapia, carga conforme a fixação.
- Infecção de ferida operada ou osteomielite (secreção persistente, fístula): cultura e o cirurgião que operou — não trate com antibiótico oral "para ver".
- Consolidação da tíbia exposta leva 4–6 meses; sem calo em 6 meses é retardo (enxerto, troca de haste) — cirurgia de novo.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: todo desbridamento e fixação (cirurgião ortopédico, aqui ou pela regulação de urgência, em até 24 h); Gustilo IIIB (retalho — cirurgia plástica/mão); IIIC (vascular agora); politrauma e pelve (centro de trauma).

Atestado	Internação; depois, 8–12 semanas no mínimo, conforme osso e trabalho.
Retorno	Enquanto aguarda a cirurgia: a cada 4 h (compartimento, perfusão). Pós-operatório: 7–10 dias (ferida), 2 e 6 semanas (raio-X).

DICAS

- “Ferida pequena longe da fratura” em perna de moto é exposta até o cirurgião dizer que não. Trate como tal.
- O antibiótico na primeira hora reduz infecção mais do que qualquer coisa que o centro cirúrgico faça depois. É a sua parte.

Baseado em: BOAST 4 / NICE NG37 — Open fractures; EAST 2011 — Antibiotics in open fractures; Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde (tétano acidental); Gustilo & Anderson 1976/1984.

2.2 Síndrome compartimental e gesso apertado

CID T79.6 / M62.2 · **Também** compartimento, dor desproporcional, gesso apertado, dedos roxos no gesso, fasciotomia, dor que não passa com morfina, pressão compartimental

> Dor desproporcional que piora ao esticar os dedos passivamente, em perna ou antebraço com fratura, gesso ou esmagamento, é síndrome compartimental até prova em contrário: abra tudo até a pele, meça se puder e a fasciotomia é em horas — não espere o pulso sumir.

O QUE PERGUNTAR

- Dor que aumenta apesar da analgesia (precisou de mais morfina na última hora)? Formigamento ou dormência nos dedos? Sensação de pressão, "gesso apertado"?
- Mecanismo: fratura de tíbia (a causa mais comum), antebraço (supracondiliana na criança, rádio e ulna), esmagamento, reperfusão após lesão vascular, queimadura circunferencial, anticoagulante.
- Gesso ou tala há quanto tempo? Elevou demais o membro (acima do coração reduz a perfusão)?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Dor ao estiramento passivo	Estenda passivamente os dedos (compartimento flexor do antebraço) ou os artelhos (compartimento posterior profundo da perna) e faça dorsiflexão passiva (compartimento posterior). Compare com o que a fratura em si justifica.	Dor intensa, desproporcional, ao estiramento → o sinal mais precoce e confiável.
Palpação dos compartimentos	Perna: anterior, lateral, posterior superficial e profundo; antebraço: volar e dorsal. Tenso, lenhoso, doloroso.	Compartimento tenso → suspeita forte; mole não exclui (idoso, hipotenso).
Neurovascular	Sensibilidade (1º espaço interdigital do pé = fibular profundo, compartimento anterior), força (dorsiflexão do hálux), pulsos, enchimento capilar.	Parestesia é o 2º sinal; paresia é tardio; pulso ausente é o último — nunca espere por ele.
Pressão compartimental (se tem o aparelho ou agulha com manômetro)	Agulha no compartimento suspeito, no nível da fratura; ΔP = pressão diastólica − pressão do compartimento.	ΔP < 30 mmHg (ou pressão absoluta > 30–40 mmHg) → fasciotomia. Na dúvida clínica, a clínica manda.

SINAIS DE ALARME

- Paciente que não consegue informar (sedado, intubado, criança pequena, lesão nervosa) com fratura de tíbia ou antebraço: monitorização horária de compartimento e pressão — o diagnóstico tardio é a regra nesses casos.
- Mais de 6–8 horas de síndrome estabelecida: necrose muscular, contratura de Volkmann, rabdomiólise (creatinina, potássio, CK, hidratação) e amputação. O relógio começou no início da dor desproporcional, não na sua avaliação.
- Síndrome compartimental do pé (esmagamento, Lisfranc), da coxa (fêmur com sangramento) e glútea (longa permanência no chão): mesmos sinais, menos lembradas.

IMAGEM

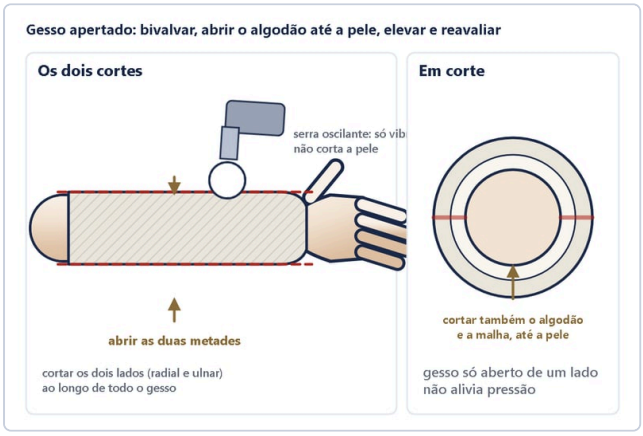
- Nenhuma imagem diagnostica; o raio-X mostra a fratura e a tomografia atrasa. Exames: CK, creatinina, potássio, mioglobina na urina quando suspeita de rabdomiólise.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

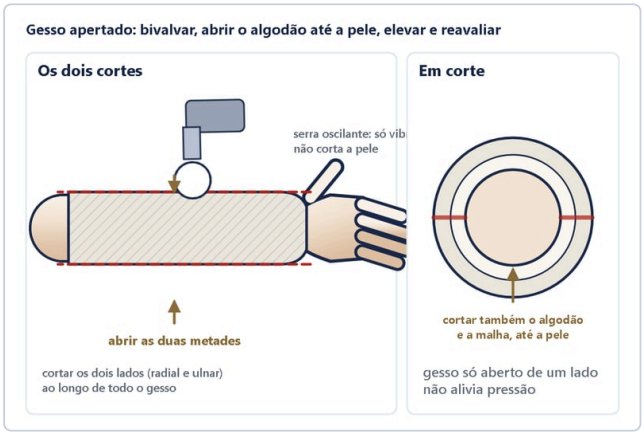
- Suspeitou: corte o gesso ou a tala, o algodão e o enfaixamento até a pele, em toda a extensão, nos dois lados (bivalvar); afaste as metades. Isso reduz a pressão em 50–85% e muitas vezes resolve o "gesso apertado".
- Membro no nível do coração (não elevado, não pendente); retire compressão; corrija hipotensão (a perfusão depende da diastólica); oxigênio; analgesia sem mascarar (reavalie a cada 30–60 minutos e anote hora e achados).
- Melhorou em 30–60 minutos com a abertura: mantenha aberto, observe de hora em hora por 12–24 h, novo gesso só com o edema controlado.
- Não melhorou, ou compartimento tenso com dor ao estiramento desde o início: é síndrome compartimental — fasciotomia em horas. Cirurgião ortopédico ou vascular aqui, ou regulação de urgência com "síndrome compartimental de [segmento] [lado], início [hora], ΔP [x] mmHg — fasciotomia" e transporte imediato.
- Fratura associada: a fixação (haste, fixador externo) é feita na mesma cirurgia da fasciotomia; a sua tala provisória vai junto.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

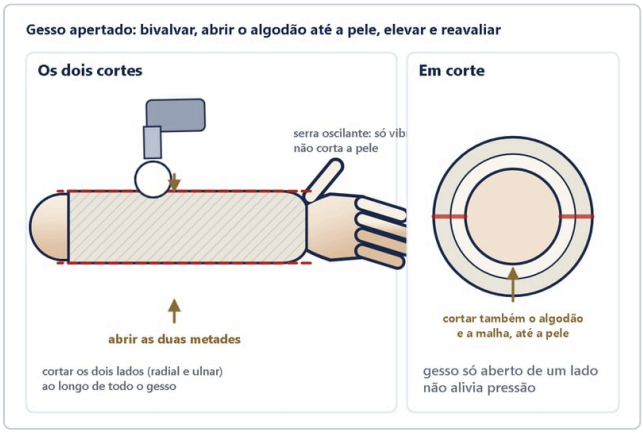
Bivalvar o gesso e abrir tudo até a pele



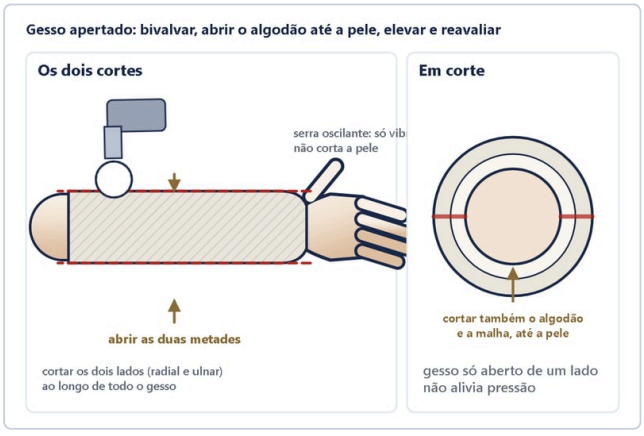
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Qualquer dor crescente, parestesia, dedos frios ou edema que apareceu depois da imobilização. Não existe "esperar para ver" com gesso fechado.

Material e anestesia: Serra oscilante de gesso ou tesoura de gesso (tala), afastador de gesso, tesoura de curativo.

Passo a passo

1. Serra ao longo de todo o comprimento, nos dois lados (medial e lateral), sem apoiar sobre proeminências ósseas; na tala, corte o enfaixamento.
2. Corte o algodão e a malha tubular até ver a pele em toda a extensão — gesso aberto com algodão intacto não alivia.
3. Afaste as metades 1–2 cm; se houver edema, mantenha só a tala posterior com faixa frouxa.
4. Examine a pele (escara de pressão sob o gesso?), pulsos, sensibilidade e dor ao estiramento. Anote a hora.

Depois: Reavalie em 30 e 60 minutos. Sem melhora: síndrome compartimental — cirurgia.

CONDUTA

- Prevenção é a sua rotina: tala (não gesso circular) na fase de edema; enfaixamento frouxo; orientação escrita com os sinais de aperto e telefone do serviço; retorno em 24–48 h na fratura de tíbia e antebraço e no diabético.
- Toda fratura de tíbia e todo antebraço de criança internados: checar compartimento e anotar a cada 2–4 h nas primeiras 24–48 h.
- Depois da fasciotomia: a ferida fica aberta e é fechada ou enxertada em 5–7 dias; o retorno é com o cirurgião e depois com você (curativo, fisioterapia, raio-X da fratura).

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g/2 mL	2 mL EV lento de 6/6 h, enquanto avalia.	—
Morfina 10 mg/mL	2 a 4 mg EV a cada 10 minutos se dor, anotando quanto precisou — a necessidade crescente é sinal diagnóstico, não motivo para aumentar sem reexaminar.	Não mascare: o exame do estiramento passivo é repetido a cada reavaliação.

IMOBILIZAÇÃO

- Depois de abrir: tala posterior frouxa, membro no nível do coração; sem gesso circular por 48–72 h.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Paciente que ligou ou voltou com "gesso apertado": tire na hora — é a consulta que não espera na fila. A maioria é gesso apertado simples; a minoria é a síndrome que você só reconhece se examinar.
- Contratura de Volkmann ou pé caído de síndrome não tratada: fisiatria, órtese e cirurgia reconstrutiva (transferência tendinosa) meses depois.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a fasciotomia (cirurgião ortopédico ou vascular, aqui ou pela regulação de urgência em horas), rabdomiólise com injúria renal (UTI/nefrologia), lesão vascular associada (vascular).

Atestado	O da fratura; após fasciotomia, 8–12 semanas.
Retorno	A cada hora até definir; pós-fasciotomia: 48 h (ferida), 7 dias, 3 semanas.

DICAS

- Os “5 P” em ordem de aparecimento: dor (desproporcional, ao estiramento), parestesia, pressão — e só depois paresia e ausência de pulso. Decida nos dois primeiros.
- Oxímetro normal no dedo não exclui síndrome compartimental. Nunca.

Baseado em: BOAST — Diagnosis and management of compartment syndrome 2016; AAOS CPG — Acute compartment syndrome 2022; McQueen & Court-Brown — compartment pressure monitoring.

2.3 Fraturas da diáfise: fêmur, tíbia e úmero

CID S72.3 / S82.2 / S42.3 · **Também** fratura de fêmur, fratura de tíbia, fratura de perna, fratura de úmero, fratura do braço, osso quebrado no meio, tração, haste

> Fêmur e tíbia desviadas vão para a haste: você alinha, imobiliza, trata a dor e o sangramento e pede a vaga; úmero é a exceção — a maioria consolida com a tala em pinça e a órtese funcional, e você segue no ambulatório.

O QUE PERGUNTAR

- Mecanismo e energia; outras dores (pelve, coluna, cabeça — o fêmur raramente vem sozinho); hora do trauma; dormência ou fraqueza distal (radial no úmero, fibular na tíbia proximal).
- Fêmur no idoso com queda da própria altura e bisfosfonato há anos: fratura atípica (pergunte dor na coxa semanas antes; raio-X do outro fêmur).
- Jejum, comorbidades, anticoagulante, alergia — o paciente de fêmur vai operar em 24–48 h.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Membro e partes moles	Deformidade, encurtamento, rotação, edema de coxa (sangramento de 1–1,5 L no fêmur), feridas (exposta?), bolhas (flictenas na tíbia).	Coxa tensa e crescente → sangramento: acesso calibroso, hemograma, tipagem.
Neurovascular com horário	Fêmur: pulsos pedioso e tibial posterior, sensibilidade do pé. Tíbia: compartimentos, fibular (dorsiflexão, 1º espaço). Úmero: nervo radial — extensão do punho e dos dedos, sensibilidade do dorso da 1ª comissura.	Paralisia radial no úmero (10–15%): anote; a maioria é neuropraxia e recupera em 3–4 meses — não indica cirurgia por si só, salvo se aparece após a manipulação ou em fratura exposta.
Articulações vizinhas	Quadril (fratura de colo associada em 5% das diáfises de fêmur — peça raio-X de bacia sempre), joelho (ligamentos após haste), tornozelo, ombro e cotovelo no úmero.	Dor no quadril ou raio-X de bacia alterado → colo associado: muda a cirurgia.

SINAIS DE ALARME

- Fêmur bilateral, pelve ou politrauma: choque hemorrágico — ATLS, sangue, centro de trauma.
- Embolia gordurosa (24–72 h): dispneia, confusão, petéquias em axila e conjuntiva, hipoxemia — oxigênio, UTI; a fixação precoce previne.
- Tíbia: síndrome compartimental nas primeiras 48 h (ver tópico) — é a fratura que mais faz.
- Fratura de fêmur em criança que não anda ou história incompatível: suspeita de maus-tratos — notificação obrigatória.

IMAGEM

- Raio-X AP e perfil do osso inteiro, com as articulações acima e abaixo; bacia AP em todo fêmur (colo associado); raio-X de controle após a tala. Tomografia só por decisão do cirurgião (articular, colo).

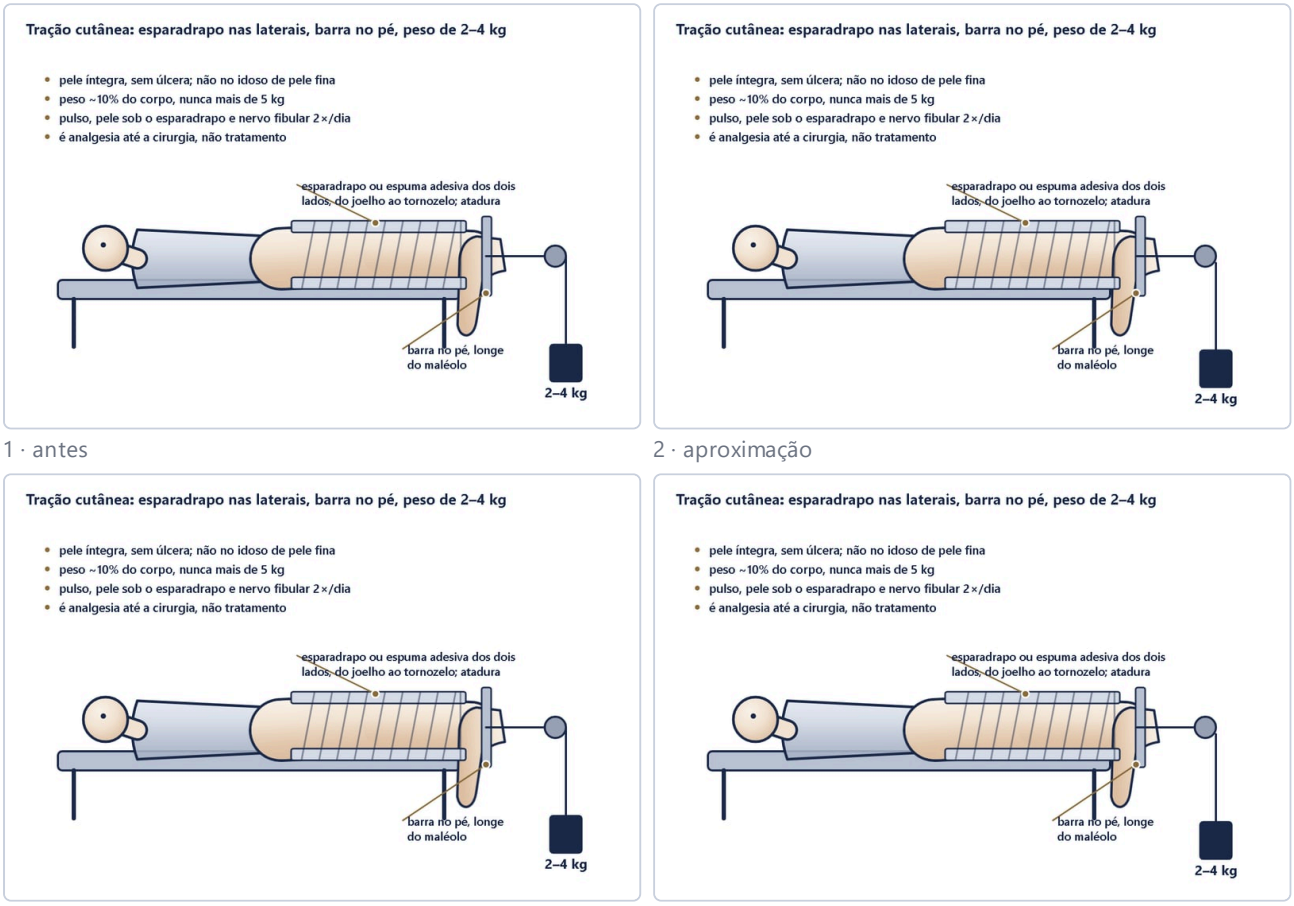
NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Fêmur: analgesia EV e bloqueio da fáscia ilíaca; tração cutânea (3–5 kg) ou tala longa de Thomas/tala gessada da virilha ao tornozelo para transporte; acesso venoso calibroso, hemograma, tipagem, cristaloide; jejum; internação; cirurgia (haste intramedular) em 24–48 h — aqui ou pela regulação como urgência (“fratura diafisária de fêmur, fechada, estável hemodinamicamente, tração aplicada”).

- Tíbia desviada: alinhar com tração, tala posterior longa (coxa aos dedos) bem acolchoada, elevar ao nível do coração, checar compartimento a cada 2 h; internar; cirurgia (haste) em dias — urgência se exposta, compartimental ou pele em sofrimento. Tíbia sem desvio (< 5° de angulação, < 1 cm de encurtamento, < 50% de contato… critérios do cirurgião): gesso inguinopodálico pode ser o tratamento — discuta com o cirurgião antes de mandar para casa.
- Úmero: tala em pinça de confeiteiro (coaptação) ou tala gessada em U do ombro ao cotovelo + tipoia; exame do radial antes e depois; alta para casa com retorno em 7–10 dias para trocar pela órtese funcional (Sarmiento). Cirurgia só com critérios (ver regulação).
- Toda diáfise: profilaxia de trombose se vai ficar deitado (enoxaparina 40 mg SC/dia), analgesia multimodal, controle do sangramento (hemoglobina em 6–12 h no fêmur).

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

Tração cutânea do fêmur (até a cirurgia)



1 · antes

2 · aproximação

3 · a manobra

4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Fratura diafisária de fêmur aguardando a haste; conforto e controle do sangramento. Não em pele lesada ou insuficiência vascular.

Material e anestesia: Kit de tração cutânea (esparadrapo largo ou fita de espuma com estribo), atadura, peso 3–5 kg (soro ou peso próprio), cordão, polia ou a cabeceira.

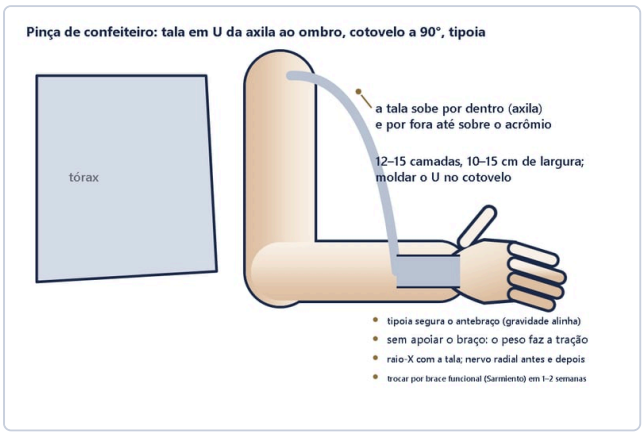
Passo a passo

1. Analgesia feita (bloqueio da fáscia ilíaca ideal). Raspe se preciso; proteja os maléolos com algodão.
2. Aplique as fitas nas faces medial e lateral da perna, do joelho ao tornozelo, deixando o estribo 10 cm abaixo do pé; enfaixe de distal para proximal sem apertar.

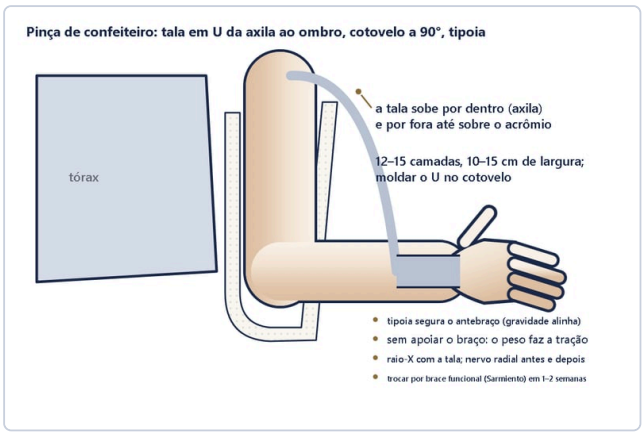
3. Pendure 3–5 kg (máximo 10% do peso) pelo cordão, no eixo do membro; pé da cama levemente elevado.
4. Pulsos, sensibilidade e pele do calcanhar a cada 4 h; afrouxe se dor, bolha ou dormência.

Depois: Raio-X com a tração; mantenha até o centro cirúrgico. Alternativa: tala gessada longa posterior sem tração.

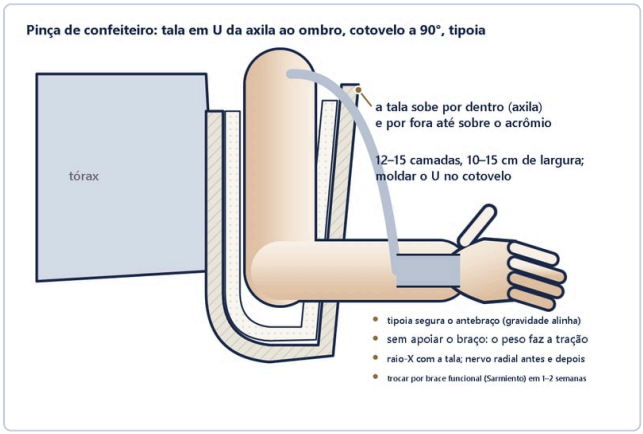
Tala em pinça de confeiteiro (coaptação) do úmero



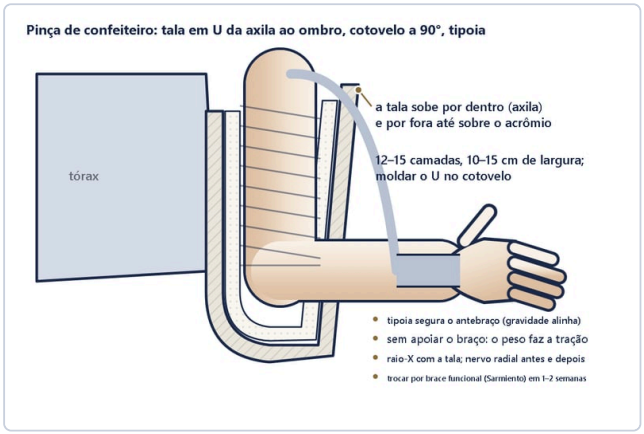
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Fratura diafisária de úmero fechada, primeiros 7–10 dias (até a órtese funcional).

Material e anestesia: Gesso de 10–15 cm (10–12 camadas), algodão, atadura, tipoia, um ajudante segurando o antebraço.

Passo a passo

1. Paciente sentado, cotovelo a 90°, ajudante faz tração leve pelo antebraço. Meça da axila, por baixo do cotovelo, até acima do acrômio pela face lateral.
2. Acolchoe axila e cotovelo. Tala em U: face medial do braço (axila) → em volta do cotovelo → face lateral até o ombro, moldando ao úmero para corrigir varo.
3. Enfaixe com crepe, tipoia. O cotovelo fica livre para fletir e estender com a tipoia.

Depois: Raio-X com a tala; radial reexaminado. Troca pela órtese funcional (brace) em 7–14 dias, quando o edema baixa; mover ombro em pêndulo e cotovelo desde já.

CONDUTA

- Úmero conservador (a maioria): tala por 1–2 semanas → órtese funcional (brace de Sarmiento) por 8–12 semanas, apertada diariamente conforme o edema baixa; pêndulo e cotovelo desde o início, ombro ativo a partir de 3–4 semanas; raio-X a cada 2–3 semanas; consolidação em 10–12 semanas em 90%. Alinhamento aceitável: até 20° de angulação anterior, 30° de varo, 3 cm de encurtamento.
- Fêmur e tíbia operados: carga conforme o cirurgião (haste bloqueada costuma permitir carga parcial precoce); fisioterapia; profilaxia de trombose por 4–5 semanas; raio-X em 2, 6, 12 semanas.
- Tíbia em gesso (sem desvio, se o cirurgião concordou): gesso inguinopodálico 4–6 semanas, depois bota ou gesso de Sarmiento até consolidar (12–16 semanas); raio-X semanal no primeiro mês (desvio tardio).
- Tabagismo atrasa a consolidação da tíbia em semanas e dobra a não união — diga.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g/2 mL	2 mL EV lento de 6/6 h na internação; 1 comprimido de 6/6 h em casa.	—
Morfina 10 mg/mL	2 a 4 mg EV a cada 10 min até controlar, depois 2–4 mg EV de 4/4 h se dor, com antiemético.	Monitorização; cuidado em idoso.
Enoxaparina 40 mg	1 seringa SC 1× ao dia enquanto internado ou com o membro inferior imobilizado sem carga, por até 4–5 semanas.	Ajustar se clearance < 30 mL/min; não iniciar antes de definir sangramento no politrauma.
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Tramadol 50 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 3 a 5 dias, só se a dor não ceder com o resto.	Lista A2 da Portaria 344 (tarja preta): até 100 mg por unidade sai em receita de controle especial em duas vias, não na notificação A. Náusea e tontura são comuns; cuidado em idoso, epilepsia e com antidepressivo (serotonina).

IMOBILIZAÇÃO

- Fêmur: tração cutânea ou tala longa. Tíbia: tala posterior da coxa aos dedos. Úmero: tala em pinça de confeiteiro + tipoia, depois órtese funcional.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Úmero no retorno: troque a tala pela órtese funcional em 7–14 dias; raio-X a cada 2–3 semanas; sem calo ou com movimento no foco em 12 semanas: retardo → cirurgia (placa). Paralisia radial que não melhora em 3–4 meses: eletroneuromiografia e exploração cirúrgica.
- Fêmur e tíbia operados: ferida em 10–14 dias, raio-X em 6 e 12 semanas, carga progressiva, fisioterapia; dor no joelho após haste de tíbia é comum e melhora com fortalecimento.
- Material que incomoda (parafuso de bloqueio, placa saliente) sai depois de 12–18 meses, se o paciente quiser — cirurgia eletiva pela regulação.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: toda diáfise de fêmur e toda tíbia desviada ou instável (haste intramedular — cirurgião, aqui ou pela regulação de urgência em 24–48 h); úmero com indicação cirúrgica (exposta, bilateral, politrauma, lesão vascular, paralisia radial após manipulação, obeso ou mama grande em que a órtese não segura, alinhamento inaceitável, não união) — cirurgia em dias.

Atestado	Fêmur e tíbia: 12–16 semanas no mínimo. Úmero: 8–12 semanas; escritório 3–4 semanas com a órtese.
Retorno	Internado até a cirurgia. Úmero: 7–10 dias, depois a cada 2–3 semanas até consolidar.

DICAS

- Raio-X de bacia em todo fêmur: a fratura de colo escondida é a que vira necrose porque ninguém olhou.
- No úmero, o brace funciona porque o peso do braço alinha a fratura: paciente sentado ou em pé, nunca deitado o dia todo.

Baseado em: AAOS OrthoInfo — Femur shaft; Tibia shaft; Humerus shaft fractures; BOAST — Diaphyseal fractures; The management of fragility fractures; Sarmiento — Functional bracing of humeral shaft fractures (JBJS 2000); NICE NG37/NG38.

2.4 Luxações de quadril, joelho e tornozelo

CID S73.0 / S83.1 / S93.0 / T84.0 · **Também** quadril saiu do lugar, luxação de quadril, luxação da prótese, luxação de joelho, joelho saiu do lugar, luxação de tornozelo, fratura-luxação do tornozelo, pé virado

> Quadril luxado reduz em até 6 horas (necrose da cabeça), joelho luxado é artéria poplítea até prova em contrário, tornozelo luxado reduz antes do raio-X se a pele sofre — as três são suas na primeira hora, e todas ficam internadas.

O QUE PERGUNTAR

- Mecanismo: painel do carro no joelho fletido (quadril posterior), prótese de quadril (como sentou, há quanto tempo da cirurgia, quantas vezes já saiu), hiperextensão ou alta energia no joelho (luxação que pode ter reduzido sozinha), inversão violenta com fratura no tornozelo.
- Hora exata da luxação (o relógio do quadril é de 6 horas); dormência ou formigamento (ciático no quadril, fibular no joelho).
- Jejum, comorbidades, anticoagulante.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Postura típica	Quadril posterior: perna encurtada, fletida, aduzida e rodada para dentro (a mais comum, 90%); anterior: abduzida e rodada para fora. Joelho: deformidade ou joelho frouxo em várias direções com equimose (reduziu sozinho). Tornozelo: pé deslocado, pele tensa e pálida sobre o maléolo.	Luxação evidente → reduza assim que houver analgesia/sedação (quadril e joelho) ou imediatamente se a pele está em sofrimento (tornozelo).
Neurovascular, antes e depois	Quadril: ciático (dorsiflexão e flexão plantar do pé, sensibilidade da perna). Joelho: pulsos pedioso e tibial posterior comparados, índice tornozelo-braço (ITB) se tem Doppler, nervo fibular (dorsiflexão, 1º espaço). Tornozelo: pulsos, enchimento capilar, pele.	Joelho com pulso assimétrico, ITB < 0,9 ou sinais duros (sangramento, frêmito, isquemia) → angiotomografia ou vascular agora; pulso normal não exclui lesão de íntima: observar 24–48 h com pulsos seriados.
Estabilidade do joelho após redução	Lachman, gaveta posterior, varo/valgo a 0° e 30°.	Frouxidão em 3 ou mais planos → luxação de joelho (lesão multiligamentar) mesmo que chegou reduzido.

SINAIS DE ALARME

- Luxação de joelho: 20–30% têm lesão da artéria poplítea; sem reparo em 6–8 horas, amputação em até 80%. Vascular e centro de trauma no mesmo dia, pulsos de hora em hora.
- Quadril que não reduz com sedação adequada em uma ou duas tentativas (fragmento interposto, fratura de colo associada): redução aberta — cirurgia em horas, sem novas tentativas.
- Luxação de quadril com fratura de acetábulo ou de cabeça femoral (comum): tomografia após reduzir; o cirurgião de pelve decide.
- Tornozelo luxado com pele pálida e tensa: necrose de pele em horas — reduza antes do raio-X.

IMAGEM

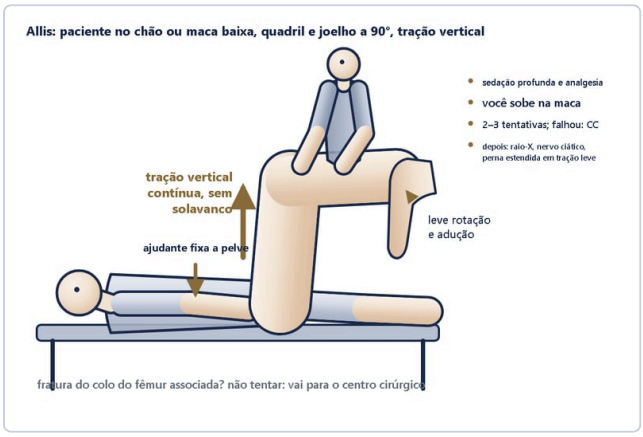
- Raio-X antes de reduzir quadril e joelho (fratura associada muda a técnica); tornozelo com pele em risco: reduza primeiro, raio-X depois. Após toda redução: raio-X de controle e, no quadril, tomografia (fragmentos, congruência). Joelho: angiotomografia se qualquer alteração vascular; ressonância em dias para o planejamento.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

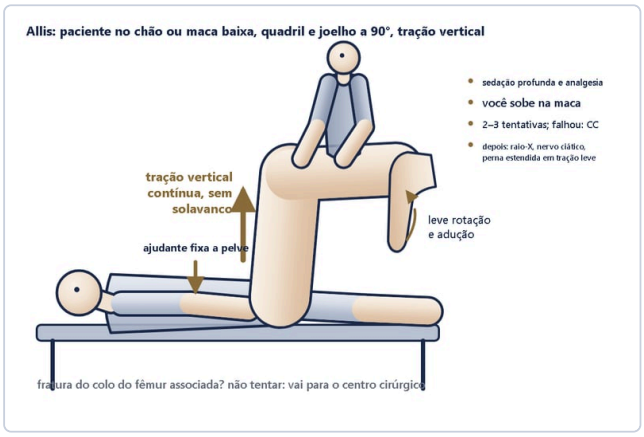
- Quadril nativo posterior: sedação (ou anestesista), redução pela técnica de Allis ou Captain Morgan, uma tentativa firme; raio-X e tomografia depois; internação com tração cutânea ou repouso e sem carga; cirurgia se fragmento, instabilidade ou fratura — regulação. Reduzido e estável sem fratura: o cirurgião decide carga protegida por 4–6 semanas.
- Prótese luxada: mesma redução sob sedação (mais fácil); raio-X; órtese de abdução ou orientação de posição; avisar o cirurgião da prótese — segunda luxação ou mais: revisão cirúrgica.
- Joelho: reduza com tração longitudinal (sedação), imobilizador em 20° de flexão, pulsos a cada hora, ITB; qualquer alteração → vascular agora. Sempre internado e sempre centro de trauma ou cirurgião de joelho pela regulação (lesão multiligamentar e possível lesão vascular).
- Tornozelo (fratura-luxação): reduza agora (ver procedimento), tala posterior + estribo, raio-X, internação ou alta com cirurgia agendada em dias — regulação com urgência se irredutível, exposta ou pele comprometida.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

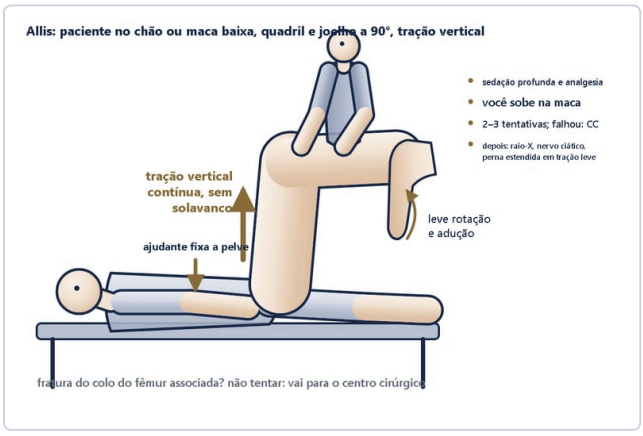
Redução da luxação posterior do quadril — Allis



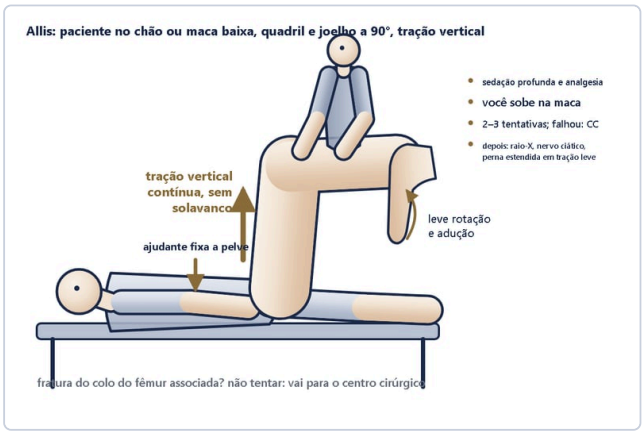
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Luxação posterior nativa ou de prótese, com raio-X feito e sedação adequada. Não insista se não reduzir em 1–2 tentativas.

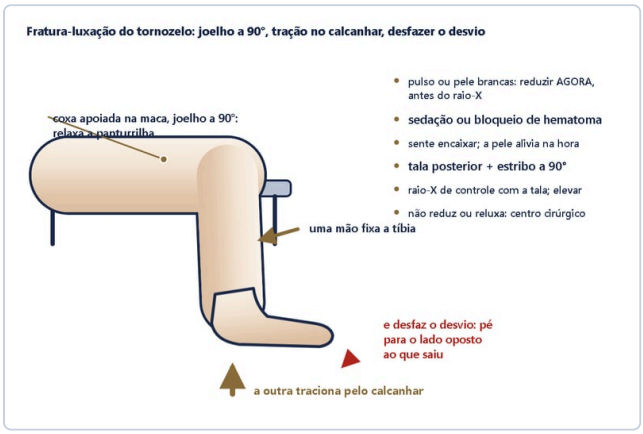
Material e anestesia: Sedação (cetamina ou propofol, monitorizado), 2 ajudantes, maca baixa e firme (ou o chão da sala com colchão).

Passo a passo

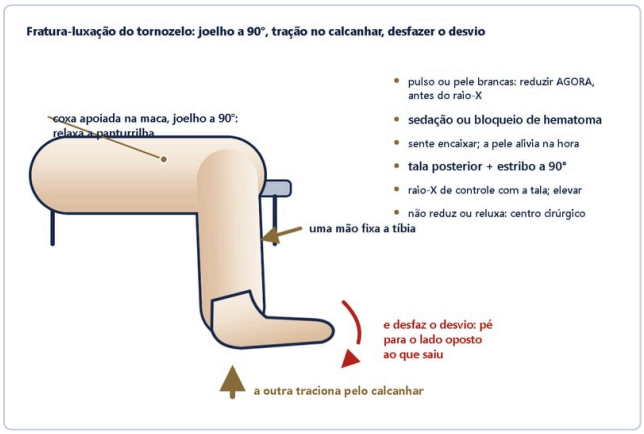
1. Paciente deitado; um ajudante estabiliza a pelve com as duas mãos nas espinhas ilíacas.
2. Flexione o quadril e o joelho a 90°; segure a perna atrás do joelho com os dois braços e faça tração vertical contínua, para cima, usando o corpo.
3. Com a tração mantida, pequenos movimentos de rotação interna e externa e leve adução; o "clunk" da redução é audível/palpável.
4. Captain Morgan (alternativa com menos esforço): seu joelho sob o joelho do paciente, pé apoiado na maca; eleve com a alavanca do seu pé enquanto traciona.

Depois: Confira estabilidade (flexão a 90° com adução leve sem reluxar), neurovascular, raio-X e tomografia; tração cutânea ou repouso; anote o tempo luxado.

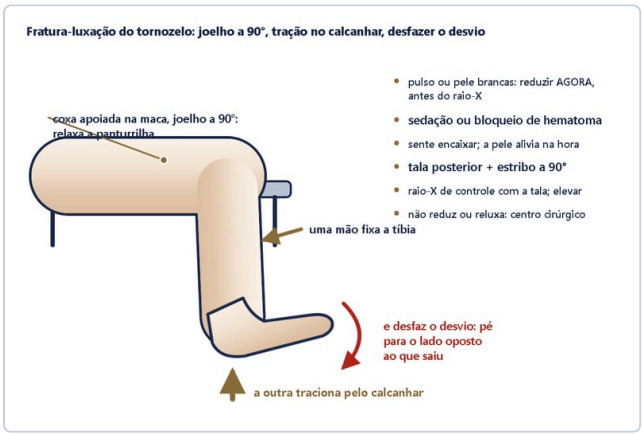
Redução da fratura-luxação do tornozelo



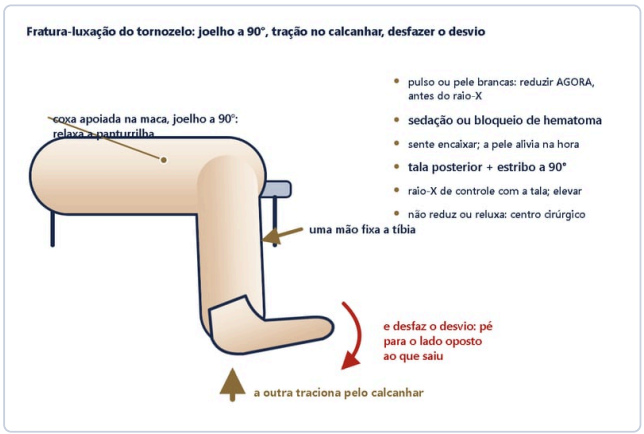
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Qualquer luxação do tornozelo — antes do raio-X se a pele está tensa ou o pé frio.

Material e anestesia: Analgesia EV ± sedação leve (ou bloqueio de hematoma no foco da fíbula), 1–2 ajudantes, material de tala (posterior + estribo).

Passo a passo

1. Joelho fletido (relaxa a panturrilha), ajudante segura a perna. Segure o calcanhar com uma mão e o dorso do pé com a outra.
2. Tração no eixo da perna por 1–2 minutos, depois leve o pé na direção contrária à deformidade (na luxação lateral, para medial) e para a posição neutra, com dorsiflexão a 90°.
3. Reduzido: a forma volta, a pele relaxa, o pulso melhora. Mantenha a posição enquanto a tala posterior e o estribo são aplicados e endurecem.

Depois: Raio-X AP, perfil e mortise com a tala; neurovascular; eleve. A cirurgia (fixação) fica para quando o edema permitir (5–10 dias) — salvo irredutível, exposta ou pele comprometida.

CONDUTA

- Quadril nativo reduzido sem fratura: sem carga ou carga protegida com muletas por 4–6 semanas; evitar flexão > 90° e rotação interna; ressonância em 6 semanas a 3 meses se dor (necrose da cabeça acontece em 5–15%, até 2 anos).
- Prótese: ensine as posições proibidas (sentar baixo, cruzar as pernas, fletir > 90° na via posterior); elevador de vaso, cadeira alta; retorno com o cirurgião.
- Joelho: imobilizador 20° até a ressonância e a cirurgia multiligamentar (2–3 semanas); fisioterapia de amplitude começa depois da reconstrução.
- Tornozelo: tala, elevação, sem carga, gelo; cirurgia em dias; pós-operatório com bota e carga progressiva a partir de 2–6 semanas conforme o cirurgião.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g/2 mL	2 mL EV lento de 6/6 h.	—
Morfina 10 mg/mL	2 a 4 mg EV a cada 10 min até controlar, com antiemético e monitorização.	—
Enoxaparina 40 mg	1 seringa SC ao dia enquanto sem carga ou internado (4–5 semanas no quadril).	Ajuste renal.
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Tramadol 50 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 3 a 5 dias, só se a dor não ceder com o resto.	Lista A2 da Portaria 344 (tarja preta): até 100 mg por unidade sai em receita de controle especial em duas vias, não na notificação A. Náusea e tontura são comuns; cuidado em idoso, epilepsia e com antidepressivo (serotonina).

IMOBILIZAÇÃO

- Quadril: tração cutânea ou repouso em posição neutra; prótese: órtese de abdução se o cirurgião pedir. Joelho: imobilizador a 20°. Tornozelo: tala posterior + estribo, elevado.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Quadril: raio-X em 6 semanas e 3 meses; ressonância ao primeiro sinal de dor na virilha (necrose); fisioterapia de marcha.

- Tornozelo operado: ferida 2 semanas, raio-X 6 semanas, carga progressiva, fisioterapia; retirada de parafuso de sindesmose se o cirurgião planejou (8–12 semanas).
- Joelho multiligamentar reconstruído: reabilitação de 9–12 meses; o retorno com você é fisioterapia, atestado e controle de dor.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: redução que falhou ou fratura associada (redução aberta — cirurgião, em horas), toda luxação de joelho (vascular + cirurgião de joelho, centro de trauma hoje), fixação do tornozelo (cirurgião, em dias; hoje se irredutível, exposta ou pele comprometida), prótese luxada recorrente (cirurgião da prótese).

Atestado	Quadril: 6–12 semanas. Joelho: 3–6 meses. Tornozelo: 8–12 semanas.
Retorno	Internado; depois 1 semana (ferida/pele e neurovascular), 6 semanas (raio-X), 3 meses.

DICAS

- Joelho que "saiu e voltou sozinho" em acidente de moto é luxação de joelho. Pulso presente não tranquiliza: ITB e observação.
- Quadril: 6 horas. Chame o sobreaviso ou a regulação antes de conseguir a sedação, não depois de falhar.

Baseado em: AAOS OrthoInfo — Hip dislocation; Knee dislocation; BOAST — Knee dislocation (vascular assessment); EAST — Penetrating/blunt popliteal injury; Rockwood & Green — Fractures in adults (dislocations).

2.5 Fraturas do tornozelo (maléolos)

CID S82.5 / S82.6 / S82.8 · **Também** fratura de tornozelo, fratura do maléolo, Weber, bimaleolar, trimaleolar, quebrou o tornozelo, fratura da fíbula distal

> A fratura isolada do maléolo lateral com o tálus no lugar (Weber A ou B estável) é sua: bota ou gesso, carga e 6 semanas; o tálus deslocado, o maléolo medial fraturado ou a sindesmose aberta (Weber C) são cirurgia — você reduz, imobiliza e agenda.

O QUE PERGUNTAR

- Mecanismo (inversão, eversão, rotação com o pé preso, queda de altura — pilão); conseguiu pisar? Dor medial também (lesão do deltoide muda tudo)?
- Diabetes, neuropatia, tabagismo, osteoporose (complicam gesso e cirurgia); trabalho e atividade.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Palpação dos quatro pontos	Maléolo lateral (fíbula até 6 cm acima), maléolo medial, ligamento deltoide (abaixo do maléolo medial) e sindesmose (anterior, acima da articulação); base do 5º metatarso; fíbula proximal (Maisonneuve!).	Dor medial com fratura lateral → instável até o raio-X com estresse provar o contrário; dor na fíbula proximal → Maisonneuve (sindesmose rota): cirurgia.
Pele e neurovascular	Pele sobre os maléolos (tensa, pálida, bolhas), pulsos, sensibilidade, dedos.	Pele em sofrimento → reduza agora.
Classificação de Weber (no raio-X)	A: fíbula abaixo da sindesmose (ligamento intacto). B: na altura da sindesmose (oblíqua — pode ser estável ou não). C: acima da sindesmose (sindesmose rota, instável).	C, bimaleolar, trimaleolar, ou B com desvio talar/espaço medial > 4 mm → cirurgia.

SINAIS DE ALARME

- Fratura-luxação: redução imediata (ver Luxações).
- Fratura de pilão tibial (queda de altura, articular cominuta): tomografia, tala, elevação; cirurgia em etapas (fixador externo e depois placa) — centro de referência, não espere o edema sozinho.
- Diabético com neuropatia: alto risco de pseudoartrose, infecção e Charcot — imobilização mais longa, sem carga, e discussão precoce com o cirurgião.

IMAGEM

- RX de tornozelo AP, perfil e mortise (AP com 15–20° de rotação interna): espaço claro medial ≤ 4 mm e igual ao superior = tálus no lugar; espaço tibiofibular, sobreposição. Dor medial com raio-X "só fíbula": teste de estresse (gravidade — perfil com o pé pendente — ou rotação externa) para ver o espaço medial abrir. Fíbula proximal dolorosa: raio-X de perna inteira. Tomografia no pilão, no maléolo posterior > 25% e pré-operatório.

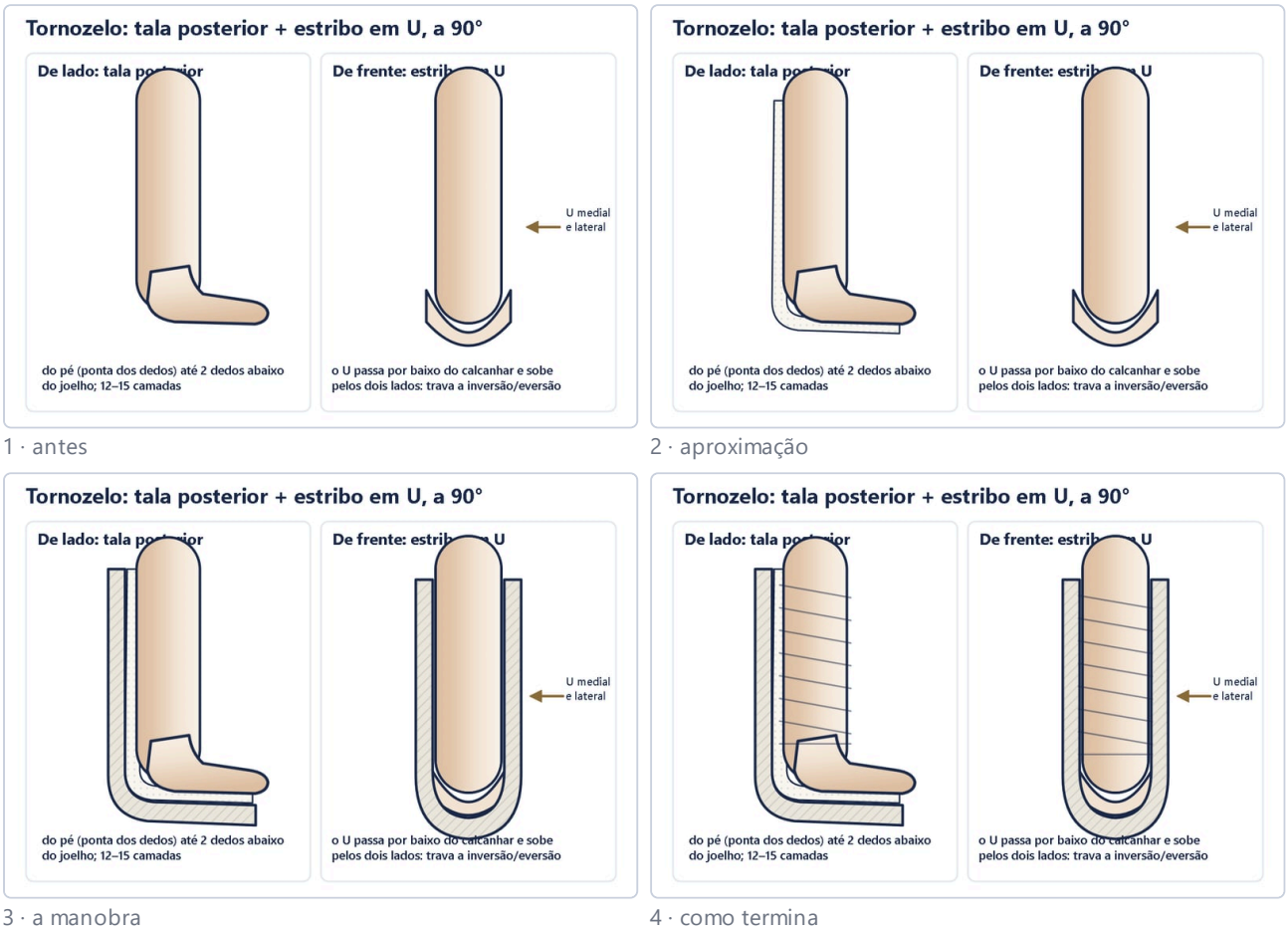
NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Weber A ou B isolada, tálus centrado, sem dor medial e estresse negativo: estável — bota imobilizadora (ou tala posterior + estribo e gesso suropodálico em 5–7 dias) com carga conforme a dor; alta com retorno em 7 dias com raio-X. É a maioria.

- Weber B com espaço medial > 4 mm, bimaleolar, trimaleolar, Weber C, Maisonneuve, desvio talar: reduza se há desvio (tração e correção), tala posterior + estribo bem moldada, elevação, raio-X de controle; cirurgia (placa e parafusos, parafuso de sindesmose) quando o edema permitir (5–10 dias, "sinal da ruga") — hoje se exposta, irredutível ou pele comprometida. Alta com a tala e o pedido na regulação, ou internação se não consegue ficar em casa sem apoiar.
- Idoso frágil, com pele ruim ou diabético descompensado, mesmo instável: o cirurgião pode optar por gesso bem moldado com controle semanal; discuta antes de agendar.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

Tala posterior + estribo (U) do tornozelo



Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Toda fratura de tornozelo na fase aguda; depois da redução de desvio.

Material e anestesia: Gesso 15 cm: tala posterior (12–15 camadas, da cabeça da fíbula aos dedos) e estribo (10–12 camadas, da face medial da perna, em volta do calcanhar, à face lateral); algodão; crepe; ajudante.

Passo a passo

1. Decúbito ventral com o joelho fletido a 90° (o pé fica a 90° sozinho) ou sentado com a perna pendente e ajudante segurando os dedos.
2. Acolchoe maléolos, calcanhar, cabeça da fíbula e base do 5º metatarso.
3. Tala posterior primeiro; depois o estribo em U sobre ela; molde com as palmas o tornozelo a 90°, sem varo nem valgo, e os maléolos sem pressão pontual.
4. Enfaixe frouxo; mantenha a posição até endurecer (5–8 minutos).

Depois: Raio-X com a tala; neurovascular; eleve acima do coração nas primeiras 48 h; orientação escrita dos sinais de aperto. Gesso circular suropodálico (bota gessada) na troca de 5–7 dias nos casos conservadores.

CONDUTA

- Conservador (estável): bota ou gesso suropodálico por 6 semanas, carga conforme a dor desde o início na Weber A e após 1–2 semanas na B estável; raio-X em 1 e 2 semanas (confirma que o tálus não deslocou) e em 6 semanas; depois tornozeleira, fisioterapia de amplitude e propriocepção por 4–6 semanas.
- Cirúrgico: pós-operatório com tala 2 semanas, bota e movimento precoce; carga a partir de 2–6 semanas conforme a fixação; parafuso de sindesmose: sem carga 6–8 semanas.
- Trombose: imobilização de perna sem carga em quem tem fator de risco (obesidade, anticoncepcional, trombose prévia, câncer, > 60 anos): enoxaparina 40 mg/dia enquanto imobilizado.
- Edema e rigidez duram meses; dizer isso evita o paciente achar que "ficou mal feito".

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).
Tramadol 50 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 3 a 5 dias, só se a dor não ceder com o resto.	Lista A2 da Portaria 344 (tarja preta): até 100 mg por unidade sai em receita de controle especial em duas vias, não na notificação A. Náusea e tontura são comuns; cuidado em idoso, epilepsia e com antidepressivo (serotonina).
Enoxaparina 40 mg	1 seringa SC 1× ao dia enquanto imobilizado sem carga, só em quem tem fator de risco de trombose.	Ajuste renal; não em alergia à heparina.

IMOBILIZAÇÃO

- Tala posterior + estribo na fase aguda; bota imobilizadora ou gesso suropodálico por 6 semanas nos estáveis; sem bota no SUS, o gesso faz o mesmo.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 7 dias com raio-X: tálus centrado e espaço medial ≤ 4 mm → segue conservador; abriu → cirurgia (regulação). Troca por gesso circular ou bota.
- 2 semanas: raio-X de novo (segunda chance do desvio tardio). 6 semanas: raio-X, retirar o gesso, iniciar carga total e fisioterapia.
- Consolidação viciosa ou dor persistente após 6 meses: tomografia e cirurgião (osteotomia, artrodese) — eletivo.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: toda fratura instável (bimaleolar, trimaleolar, Weber C, desvio talar, Maisonneuve) para fixação — cirurgião aqui ou pela regulação em dias (hoje se exposta, irredutível ou pele em sofrimento); pilão tibial (centro de referência); Charcot e pé diabético complicado (equipe de pé diabético).

Atestado	Estável: 6–8 semanas (escritório: 2–3 semanas com muletas). Operada: 8–12 semanas.
Retorno	7 dias e 14 dias com raio-X; 6 semanas; 3 meses.

DICAS

- O que decide é o espaço medial no mortise, não o tamanho da fratura da fíbula. Meça.
- Dor na fíbula alta em tornozelo torcido com raio-X normal: raio-X da perna. Maisonneuve passa batido todo plantão.

Baseado em: BOAST — Ankle fractures 2016; NICE NG38; AAOS OrthoInfo — Ankle fractures; Weber / Lauge-Hansen classifications; CAST / AIM trials (BMJ 2016; close contact casting in older adults).

2.6 Fratura do úmero proximal

CID S42.2 · **Também** fratura do ombro, quebrou o ombro, colo do úmero, fratura do colo cirúrgico, Neer, idosa que caiu e não levanta o braço

> A idosa que caiu, com o braço colado ao corpo e um hematoma que desce pelo braço: a maioria (sem desvio ou com desvio moderado, mesmo em 3 partes no idoso) trata com tipoia e movimento precoce — e é sua do início ao fim; cirurgia é para o jovem desviado, a luxação e a cabeça partida.

O QUE PERGUNTAR

- Queda da própria altura (osteoporose) ou alta energia? Dormência na lateral do ombro (nervo axilar, 20–30%)? Mão dominante, mora sozinha, consegue fazer a higiene?
- Demanda funcional e cognição (decidem conservador vs cirurgia mais que o raio-X); anticoagulante; osteoporose tratada?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Inspeção e neurovascular	Edema e equimose que aparece em 24–48 h e desce até o cotovelo e o tórax (normal, avise). Sensibilidade na face lateral do ombro (axilar), deltoide (contração isométrica), pulso radial, mão.	Déficit do axilar → anote; a maioria recupera; pulso alterado → raio-X e vascular.
Classificação de Neer (no raio-X)	Quatro segmentos: cabeça, tubérculo maior, tubérculo menor, diáfise. Uma "parte" está desviada se > 1 cm ou > 45°. 1 parte (sem desvio): 80% dos casos. 2, 3 ou 4 partes conforme os segmentos desviados; fratura-luxação; cabeça partida (head-split).	1 parte (qualquer número de traços sem desvio) → conservador sempre. 2–3 partes no idoso → conservador na maioria (PROFHER). Luxação, head-split, 4 partes no jovem, tubérculo maior > 5 mm → cirurgia.
Articulação e ombro contralateral	Mobilidade passiva suave só após o raio-X; descarte luxação associada (contorno, axilar).	Luxação → não tente reduzir no plantão sem o cirurgião: a cabeça se solta.

SINAIS DE ALARME

- Fratura-luxação do úmero proximal: cirurgia em 24–48 h; não reduzir às cegas.
- Pulso ausente, hematoma expansivo na axila: lesão da artéria axilar (rara) — vascular hoje.
- Fratura patológica (lise, dor prévia, câncer conhecido): biópsia/oncologia ortopédica antes de fixar.

IMAGEM

- RX de ombro série do trauma: AP verdadeiro (Grashey), perfil escapular (Y) e axilar (ou Velpeau se não abduz) — a axilar mostra luxação e tubérculo menor. Tomografia com reconstrução 3D se cirurgia é cogitada (3–4 partes, head-split, articular).

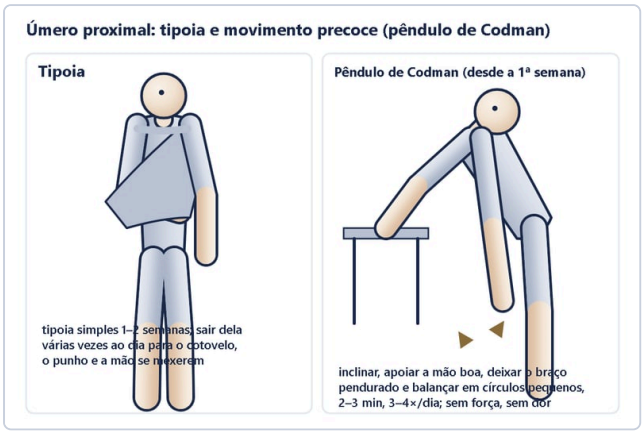
NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Sem desvio ou desvio aceitável (a maioria): tipoia, analgesia, orientação por escrito (mover cotovelo, punho e mão desde hoje; pêndulo em 7–14 dias), alta com retorno em 7–10 dias com raio-X. Internação só se não tem quem cuide em casa.
- Desviada com indicação cirúrgica (ver regulação): tipoia, analgesia, raio-X e tomografia se disponível, pedido de cirurgia em dias (não é urgência de horas); luxação: cirurgia em 24–48 h.

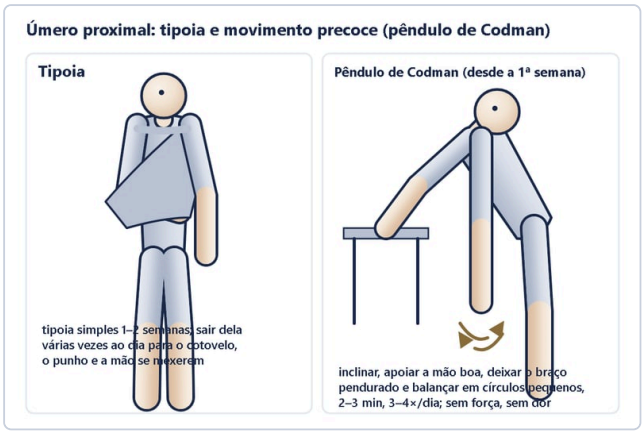
- Hematoma assusta: diga hoje que vai aparecer e descer; anticoagulado: observe sangramento e hemoglobina.
- Jovem com fratura de alta energia: tomografia, cirurgião — a tolerância ao desvio é menor.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

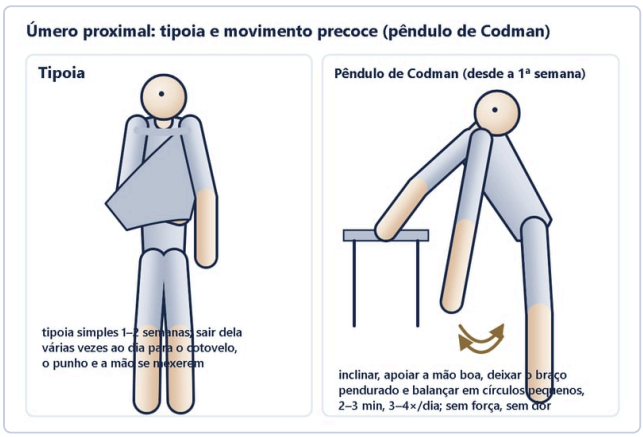
Tipoia e o programa de movimento precoce (tratamento conservador)



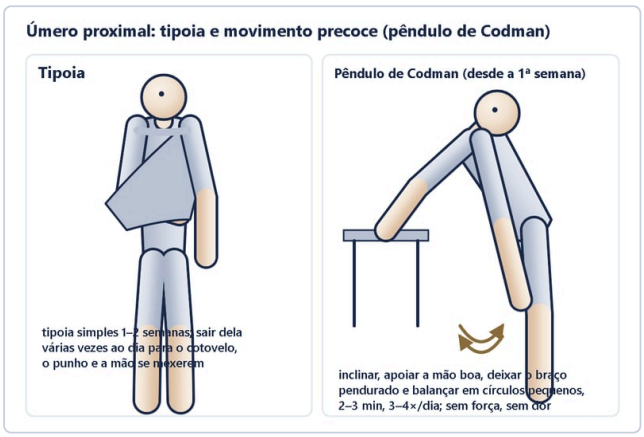
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Fratura de 1 parte, ou 2–3 partes em idoso de baixa demanda com cabeça alinhada.

Material e anestesia: Tipoia simples (sem imobilizador toracobraquial), folha de exercícios.

Passo a passo

1. Semanas 0–2: tipoia dia e noite; abrir e fechar a mão, punho e cotovelo (tirar a tipoia para isso) 5× ao dia; gelo 15 min 3× ao dia.
2. A partir de 7–14 dias (dor permitindo): pêndulo (inclinado, braço solto, círculos) 3× ao dia; retirar a tipoia em casa para o pêndulo e as refeições.
3. 3–4 semanas (raio-X mostrando calo): elevação passiva assistida com a outra mão ou bastão, deitado; rotação externa suave com bastão até neutro.
4. 6 semanas: elevação ativa, rotação interna (mão nas costas), tirar a tipoia; fisioterapia para ganhar amplitude e força até 3–6 meses.

Depois: Raio-X em 1–2 semanas (desvio secundário), 6 semanas (calo) e 3 meses. Rigidez residual de 10–20° é esperada; dor noturna por 3 meses é comum.

CONDUTA

- Conservador funciona em idoso mesmo com 2–3 partes: o ensaio PROFHER não mostrou diferença entre placa e tipoia em 2 anos. Cirurgia é para quem ganha função com ela (jovem, trabalho braçal) ou cujo padrão não consolida (luxação, head-split, 4 partes).
- Osteoporose: é fratura por fragilidade — densitometria, vitamina D, cálcio e bisfosfonato (ver Fratura vertebral). Prevenção de queda.
- Fisioterapia pelo SUS a partir da 3ª–4ª semana; enquanto não sai, a folha de exercícios é o tratamento.
- Cirurgia (placa bloqueada, haste, prótese reversa no idoso com 4 partes/head-split): pós-operatório com tipoia 2–4 semanas e reabilitação com o cirurgião e depois com você.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Tramadol 50 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 3 a 5 dias, só se a dor não ceder com o resto.	Lista A2 da Portaria 344 (tarja preta): até 100 mg por unidade sai em receita de controle especial em duas vias, não na notificação A. Náusea e tontura são comuns; cuidado em idoso, epilepsia e com antidepressivo (serotonina).
Colecalciferol (vitamina D3) 2.000 UI	1 cápsula ao dia, contínuo (fratura por fragilidade).	—
Alendronato de sódio 70 mg	1 comprimido por semana em jejum, em pé, com água, 30 min antes de comer, após conferir função renal, cálcio e vitamina D.	Esôfago e clearance > 35 mL/min; alternativa: zoledronato 5 mg EV anual.

IMOBILIZAÇÃO

- Tipoia simples por 2–4 semanas (não mais), com o cotovelo e a mão livres para mover; nada de imobilizador toracobraquial por 6 semanas.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- 7–10 dias: raio-X (desvio secundário ocorre em 10–15% — se passou do aceitável, cirurgião); comece o pêndulo.
- 3–4 semanas: raio-X, calo, avançar os exercícios; 6 semanas: tirar a tipoia, fisioterapia; 3 meses: função, raio-X final.
- Sem calo em 3 meses, dor e movimento no foco: não união (rara no proximal) → cirurgião. Rigidez importante em 3 meses: fisioterapia intensiva; capsulite pós-fratura é comum e trata como a capsulite.
- Necrose da cabeça (3–4 partes tratadas sem cirurgia) aparece em 6–18 meses: dor nova e colapso no raio-X → prótese (eletiva).

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: fratura-luxação (cirurgia em 24–48 h), head-split, 4 partes no jovem ou no idoso ativo, 2–3 partes desviadas em paciente ativo ou com desvio inaceitável (cirurgia em dias, pela regulação), tubérculo maior desviado > 5 mm (reparo), lesão vascular (vascular hoje), fratura patológica (oncologia ortopédica).

Atestado	Idoso aposentado: não se aplica; trabalho de escritório 2–4 semanas; braçal 8–12 semanas.
Retorno	7–10 dias, 3–4 semanas, 6 semanas e 3 meses, com raio-X.

DICAS

- O erro mais comum não é deixar de operar: é deixar 6 semanas na tipoia sem mover. Ombro congelado por fratura é iatrogenia que você evita com a folha de exercícios no primeiro dia.
- Tubérculo maior sozinho, desviado > 5 mm: o manguito puxa, trava o ombro — essa opera mesmo no idoso ativo.

Baseado em: PROFHER trial (JAMA 2015); AAOS OrthoInfo — Proximal humerus fractures; BESS/BOA — Proximal humeral fractures; Neer classification (JBJS 1970); ABRASSO — Osteoporose.

2.7 Fratura da patela e ruptura do aparelho extensor

CID S82.0 / S76.1 / S83.6 · **Também** quebrou a patela, fratura da rótula, ruptura do tendão patelar, ruptura do quadríceps, não consegue esticar o joelho, joelho não levanta

> A pergunta é uma só: consegue levantar a perna esticada contra a gravidade? Consegue → aparelho extensor íntegro, patela sem desvio: imobilizador em extensão e carga, é sua. Não consegue → patela desviada, tendão patelar ou quadríceps rotos: cirurgia em 1–2 semanas.

O QUE PERGUNTAR

- Queda direta sobre o joelho (patela) ou contração violenta ao tropeçar/descer degrau (ruptura de tendão)? Idade: < 40 anos sugere tendão patelar, > 40 quadríceps; corticoide, fluoroquinolona, diabetes, insuficiência renal, gota (rupturas).
- Conseguiu andar? Consegue esticar o joelho sentado e segurar?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Elevação da perna estendida (straight leg raise)	Deitado, pedir para elevar a perna com o joelho reto; se dói, aspire a hemartrose e infiltre lidocaína antes de repetir.	Não eleva (ou eleva com "lag" que não corrige) → aparelho extensor roto: patela desviada, tendão patelar ou quadríceps.
Palpação do gap	Depressão palpável acima da patela (quadríceps), abaixo (tendão patelar) ou entre os fragmentos (patela); patela alta ou baixa.	Gap → ruptura; a hemartrose pode esconder nas primeiras horas.
Derrame e pele	Hemartrose (tecla), ferida sobre a patela (fratura exposta da patela é comum em moto).	Ferida que se comunica → exposta: antibiótico e cirurgia.

SINAIS DE ALARME

- Fratura exposta da patela (queda de moto): protocolo de exposta.
- Ruptura bilateral do quadríceps ou patelar (renal crônico, corticoide): não é "fraqueza" — é cirurgia.
- Luxação de joelho associada (alta energia): pulsos.

IMAGEM

- RX de joelho AP, perfil e axial de patela: desvio (degrau articular > 2–3 mm ou separação > 3 mm), patela alta (tendão patelar roto — índice de Insall) ou baixa (quadríceps). Patela bipartida (bordo superolateral, liso, bilateral) não é fratura. Ultrassom ou ressonância confirmam a ruptura de tendão na dúvida; tomografia pré-operatória no cominuto.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Patela sem desvio e eleva a perna: aspire a hemartrose se tensa (alivia e permite examinar), imobilizador de joelho (ou gesso inguinomaleolar/cilíndrico em extensão), carga total com muletas conforme a dor, alta com retorno em 7 dias com raio-X.
- Patela desviada, cominuta, ou não eleva a perna: imobilizador em extensão, muletas, analgesia; cirurgia (banda de tensão ou sutura do tendão) em 1–2 semanas pela regulação — não é urgência de horas, mas tendão roto reparado tardio (> 3 semanas) retrai e piora o resultado. Alta com o pedido feito, ou internação se exposta ou não consegue mobilizar-se.

- Exposta: antibiótico, lavagem, curativo, imobilizador, cirurgia em 24 h.

CONDUTA

- Conservador (sem desvio, extensor íntegro): imobilizador/gesso em extensão 4–6 semanas com carga; isometria de quadríceps e elevação da perna desde a 1ª semana; a partir de 3–4 semanas, flexão progressiva até 90° fora do imobilizador; raio-X em 1, 3 e 6 semanas; fisioterapia.
- Operado: imobilizador em extensão 2–6 semanas, carga precoce, flexão progressiva conforme a fixação; retorno com o cirurgião e com você.
- Patelectomia parcial, dor residual e rigidez: fisioterapia longa; a patela consolida em 6–8 semanas mas a função leva 4–6 meses.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).
Tramadol 50 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 3 a 5 dias, só se a dor não ceder com o resto.	Lista A2 da Portaria 344 (tarja preta): até 100 mg por unidade sai em receita de controle especial em duas vias, não na notificação A. Náusea e tontura são comuns; cuidado em idoso, epilepsia e com antidepressivo (serotonina).

IMOBILIZAÇÃO

- Imobilizador de joelho em extensão (ou gesso cilíndrico) por 4–6 semanas, retirado para os exercícios a partir da 3ª–4ª semana.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- 7 dias: raio-X (desvio secundário?), ajuste do imobilizador, exercícios. 3 semanas: raio-X, iniciar flexão. 6 semanas: raio-X, retirar imobilizador, fisioterapia.
- Desvio tardio > 3 mm ou degrau articular: cirurgião — ainda dá tempo de fixar.
- Operado: ferida 2 semanas, raio-X 6 semanas; material saliente (fio de banda de tensão) incomoda em 1/3 e sai depois de 1 ano.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: patela desviada ou cominuta, qualquer ruptura do aparelho extensor (cirurgia em 1–2 semanas, pela regulação), fratura exposta (24 h).

Atestado	Conservador: 6–8 semanas (escritório 2–3 com imobilizador). Operado: 8–12 semanas.
Retorno	7 dias, 3 semanas, 6 semanas com raio-X; 3 meses função.

DICAS

- Hemartrose tensa dói demais para elevar a perna: puncione e infiltre lidocaína antes de concluir que o extensor está roto.
- Patela alta no perfil após trauma com joelho que "não estica" é tendão patelar roto mesmo sem gap palpável.

Baseado em: AAOS OrthoInfo — Patellar fractures; Patellar tendon tear; Quadriceps tendon tear; Rockwood & Green — Patella and extensor mechanism; NICE NG38.

2.8 Fraturas de pelve e sacro no idoso (e a pelve instável)

CID S32.5 / S32.1 / S32.8 · **Também** fratura de bacia, fratura do púbis, fratura de ramo, fratura de sacro, idoso que caiu e dói na virilha com raio-X de quadril normal, pelve instável, cinta pélvica

> O idoso que caiu, dói na virilha ou na nádega e tem o colo do fêmur normal costuma ter fratura de ramo púbico ou de sacro: analgesia, levantar com andador e tratar a osteoporose — é sua; a pelve de alta energia com instabilidade é cinta, sangue e centro de trauma.

O QUE PERGUNTAR

- Queda da própria altura (fragilidade) ou alta energia (atropelamento, queda de altura)? Consegue levantar e dar passos? Dor na virilha, nádega ou lombar baixa? Sangue na urina ou no reto (lesão de uretra/bexiga na alta energia)?
- Osteoporose, corticoide, radioterapia pélvica prévia (fratura por insuficiência do sacro); anticoagulante; quem cuida em casa.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Compressão da pelve e palpação	Compressão lateral e anteroposterior das cristas ilíacas uma vez só (não repita "para ver se mexe"); palpação da sínfise, ramos e sacro; log roll do quadril (afasta o colo).	Dor → raio-X de bacia; instabilidade → cinta pélvica e trauma.
Carga	Tentar sentar, levantar e dar passos com apoio.	Não consegue com raio-X normal → tomografia (fratura de sacro é invisível no raio-X em 50%).
Neurovascular e períneo	Pulsos, sensibilidade perineal e das pernas, reflexo aquileu (raízes sacrais na fratura de sacro desviada); sangue no meato ou no reto na alta energia.	Déficit sacral ou sangue → centro de trauma, urologia.

SINAIS DE ALARME

- Pelve instável de alta energia com hipotensão: cinta pélvica no nível dos trocanteres, dois acessos, sangue, não repetir a compressão, centro de trauma — a mortalidade é de horas.
- Fratura de ramo + fratura de sacro desviada (pelve de fragilidade instável, Rommens III–IV) que não consegue andar após 3–5 dias de analgesia: cirurgia (parafuso de sacro) — regulação.
- Hematúria, uretrorragia, sangue no toque retal: lesão urológica — sonda só pela urologia.

IMAGEM

- RX de bacia AP (e inlet/outlet se disponível); colo do fêmur sempre na mesma avaliação. Raio-X normal e não anda: tomografia de pelve (ou ressonância) — sacro e ramos ocultos. Alta energia: tomografia de corpo inteiro no trauma.

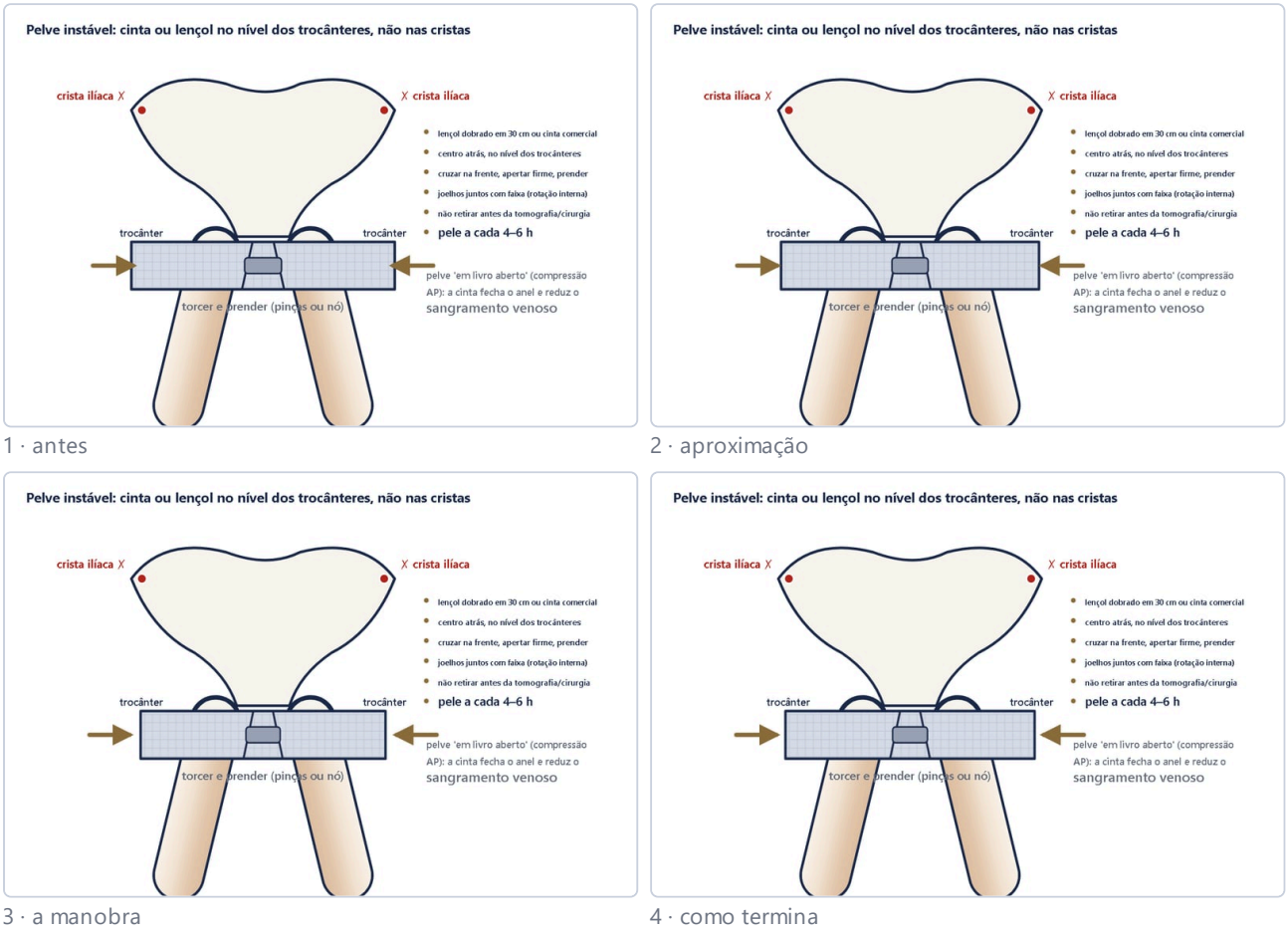
NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Fratura de ramo(s) isolada no idoso, estável, anda com apoio: analgesia multimodal, andador, profilaxia de trombose enquanto deambula pouco, alta para casa se tem quem cuide, ou internação curta (2–5 dias) para controle da dor e fisioterapia de marcha — é mais frequente internar do que parece.

- Não consegue andar após analgesia adequada, ou sacro desviado: internação, tomografia, discussão com o cirurgião de pelve (parafuso iliossacral percutâneo permite levantar em dias) — regulação em dias, não horas.
- Alta energia: ATLS, cinta pélvica, não mexer, centro de trauma pela regulação de urgência — não é para o seu hospital sem cirurgia de pelve e banco de sangue.
- Hemoglobina em 6 e 24 h na fratura de ramos em anticoagulado (sangramento retroperitoneal é raro mas acontece).

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

Cinta pélvica (ou lençol) na pelve instável



1 · antes

2 · aproximação

3 · a manobra

4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Alta energia com suspeita de instabilidade ou hipotensão, antes do raio-X. Não na fratura de ramo isolada do idoso.

Material e anestesia: Cinta pélvica comercial ou um lençol dobrado em faixa de 20–30 cm, pinças/garrotes.

Passo a passo

1. Centralize a cinta no nível dos trocanteres maiores (não nas cristas ilíacas — fecha mais e dói menos).
2. Pernas em rotação interna, pés amarrados juntos.
3. Aperte até sentir resistência firme (o anel fecha); no lençol, cruze e prenda com pinças.
4. Raio-X com a cinta; não retire até o centro de trauma avaliar (pode retirar só para o raio-X se está estável, com a cinta pronta para refechar).

Depois: Pele sob a cinta a cada 2 h; pulsos distais; registre a hora.

CONDUTA

- Pelve de fragilidade estável: carga conforme a dor desde o primeiro dia (com andador), fisioterapia de marcha, analgesia fixa (dipirona ou paracetamol + tramadol em dose baixa; AINE curto se renal permitir), laxante com opioide, profilaxia de trombose até deambular, prevenção de queda; consolidação em 6–12 semanas.
- Osteoporose: é fratura por fragilidade — densitometria, cálcio, vitamina D e bisfosfonato (zoledronato EV anual se o alendronato não serve); teriparatida acelera a consolidação das fraturas de sacro em casos selecionados (endocrinologia).
- Dor que não cede em 1–2 semanas de tratamento ou perda da capacidade de andar: tomografia de novo (progressão para instabilidade) e cirurgião.
- Pelve operada (alta energia): reabilitação longa, sondagem, lesão de nervo; o retorno é com o centro que operou e com você para o resto.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Tramadol 50 mg	1 comprimido de 8/8 h por 7 a 14 dias, com laxante (lactulose 15 mL/dia) — dose baixa no idoso.	Lista A2 da Portaria 344 (tarja preta): até 100 mg por unidade sai em receita de controle especial em duas vias, não na notificação A. Náusea e tontura são comuns; cuidado em idoso, epilepsia e com antidepressivo (serotonina).
Enoxaparina 40 mg	1 seringa SC ao dia enquanto não deambula bem (2–4 semanas).	Ajuste renal.
Colecalciferol (vitamina D3) 2.000 UI	1 cápsula ao dia, contínuo.	—
Alendronato de sódio 70 mg	1 comprimido por semana em jejum, em pé, com água, 30 min antes de comer; iniciar após corrigir cálcio e vitamina D.	Função renal e esôfago; alternativa: ácido zoledrônico 5 mg EV anual.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- 7–10 dias: dor, marcha, hemoglobina se anticoagulado; 6 semanas e 3 meses: raio-X e função. Não precisa de raio-X semanal.
- Fisioterapia de marcha e equilíbrio pelo SUS; andador e barras no banheiro pelo CER.
- Idoso que não voltou a andar em 6 semanas: tomografia, revisar diagnóstico (sacro, insuficiência bilateral) e cirurgião.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: pelve instável de alta energia (centro de trauma, agora), fratura de fragilidade que não permite andar após 3–5 dias ou sacro desviado (cirurgião de pelve — parafuso percutâneo, em dias), lesão urológica (urologia), osteoporose grave ou falha do bisfosfonato (endocrinologia).

Atestado	Idoso em geral aposentado; se trabalha, 6–8 semanas.
Retorno	7–10 dias; 6 semanas; 3 meses, com raio-X.

DICAS

- “Fratura de ramo púbico isolada” em idosa que não anda tem fratura de sacro junto em 60–80%. A tomografia não muda a conduta se ela anda; muda se não anda.
- Cinta pélvica no idoso com ramo isolado não ajuda e machuca a pele. Não é para ele.

Baseado em: BOAST — The management of fragility fractures of the pelvis; Rommens & Hofmann — Fragility fractures of the pelvis classification; ATLS 10ª ed. — pelvic trauma; AAOS OrthoInfo — Pelvic fractures; ABRASSO — Osteoporose.

CAPÍTULO 3

Coluna

Lombalgia é a consulta mais frequente; o trabalho é separar a mecânica (a maioria) do alarme (raro, mas grave).

3.1	**Lombalgia aguda mecânica** Dor lombar sem irradiação abaixo do joelho e sem alarme: analgesia, manter-se ativo e nada de raio-X nas primeiras 6 semanas.	73
3.2	**Lombociatalgia e hérnia de disco** Dor que desce abaixo do joelho num dermátomo, com Lasègue positivo: hérnia até prova em contrário, e 80% melhora sem cirurgia em 6 a 12 semanas.	76
3.3	**Cervicalgia e cervicobraquialgia** Dor cervical sem trauma e sem déficit é mecânica e melhora em semanas sem colar; dor que desce pelo braço com Spurling positivo é radicular e também costuma melhorar.	79
3.4	**Fratura vertebral por fragilidade** Dor dorsal ou lombar súbita no idoso, às vezes sem trauma: raio-X mostra o achatamento; tratar a dor e, principalmente, a osteoporose que vem atrás.	82

3.1 Lombalgia aguda mecânica

CID M54.5 · **Também** dor nas costas, dor lombar, travou a coluna, mau jeito, lumbago, dor na lombar

> Dor lombar sem irradiação abaixo do joelho e sem alarme: analgesia, manter-se ativo e nada de raio-X nas primeiras 6 semanas.

O QUE PERGUNTAR

- Começou com esforço ou de repente? Irradia para a perna, até onde (coxa ou abaixo do joelho)? Abaixo do joelho é radicular.
- Dormência, fraqueza, dificuldade para urinar ou segurar urina ou fezes, dormência na região genital? (alarme)
- Febre, emagrecimento, câncer prévio, uso de corticoide, droga injetável, mais de 50 anos com dor nova, dor noturna que não alivia com posição?
- Já teve episódios? Trabalha com carga? Está deprimido, afastado, com medo de mexer? (fatores de cronificação).

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Inspeção e marcha	Andar na ponta dos pés (S1) e nos calcanhares (L5). Olhe postura antálgica e escoliose.	Não consegue um dos dois → fraqueza radicular: examine força.
Palpação	Processos espinhosos e musculatura paravertebral; sacroilíacas.	Dor na linha média após trauma ou em idoso → raio-X (fratura).
Lasègue (elevação da perna estendida)	Deitado, eleve a perna estendida. Positivo se a dor desce abaixo do joelho entre 30° e 70°.	Radiculopatia L5/S1; Lasègue cruzado (dor na perna doente ao elevar a sã) é muito específico de hérnia.
Força, reflexos e sensibilidade	Dorsiflexão do hálux e do pé (L5), flexão plantar (S1), extensão do joelho (L4); reflexo patelar (L4) e aquileu (S1); sensibilidade no dorso do pé (L5) e borda lateral (S1).	Déficit objetivo → radiculopatia; se progressivo ou bilateral, alarme.

SINAIS DE ALARME

- Cauda equina (retenção urinária, incontinência, anestesia em sela, fraqueza bilateral): pronto-socorro com ressonância agora.
- Suspeita de fratura (trauma, > 65 anos, osteoporose, corticoide): raio-X hoje.
- Suspeita de infecção ou tumor (febre, emagrecimento, câncer, droga injetável, dor noturna constante, imunossupressão): hemograma, VHS, PCR e ressonância — sem esperar 6 semanas.
- Déficit motor progressivo: ressonância e ortopedia/neurocirurgia em 24–48 h.

IMAGEM

- Sem alarme e menos de 6 semanas: nenhum exame. Explique ao paciente por quê (achados "degenerativos" existem em quem não tem dor e assustam).
- Com alarme ou após 6 semanas sem melhora: RX de coluna lombossacra AP e perfil; ressonância se radiculopatia persistente ou suspeita de infecção/tumor.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão, a lombalgia sem alarme sai com analgesia EV (dipirona ± cetorolaco), orientação de se manter ativo, receita de poucos dias e retorno no ambulatório em 2 semanas — sem raio-X, sem internação, sem "repouso absoluto".
- Com alarme: cauda equina → ressonância e descompressão em horas (regulação de urgência); déficit motor → ressonância em 24–48 h; suspeita de fratura → raio-X hoje (e o tópico de fratura vertebral); febre, câncer ou droga injetável → hemograma, VHS, PCR, internação se toxemia.
- Dor incapacitante que não deixa andar nem com analgesia EV: observação por algumas horas com analgesia escalonada e, se não anda, internação curta — a maioria vai para casa no mesmo dia.

CONDUTA

- Manter-se ativo: caminhar, não ficar de cama (no máximo 1–2 dias nos piores casos). Repouso prolongado atrasa a melhora.
- Calor local 20 min, 3×/dia, a partir do 2º dia. Dormir de lado com travesseiro entre os joelhos.
- Melhora esperada em 2–4 semanas na maioria; 90% em 6 semanas. Diga isso — o prognóstico bom tranquiliza e reduz cronificação.
- Fisioterapia se não melhorar em 2–3 semanas; exercícios de fortalecimento (core) depois da fase aguda, para prevenir recidiva.
- Entregue as "Orientações — dor nas costas (lombalgia)" da biblioteca de documentos.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).
Ciclobenzaprina 5 mg	1 comprimido à noite por 5 a 7 dias; pode subir a 10 mg se tolerar.	Dá sono e boca seca; evitar em idoso, glaucoma, arritmia e com outros sedativos. Não dirigir após a dose.

Tramadol 50 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 3 a 5 dias, só se a dor não ceder com o resto.	Lista A2 da Portaria 344 (tarja preta): até 100 mg por unidade sai em receita de controle especial em duas vias, não na notificação A. Náusea e tontura são comuns; cuidado em idoso, epilepsia e com antidepressivo (serotonina).

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 2 semanas: reexame neurológico anotado, reduzir a medicação, fisioterapia se não melhorou; 6 semanas sem melhora → raio-X e, com radiculopatia, ressonância.
- A partir de 12 semanas é dor crônica: exercício supervisionado, abordagem do medo de mexer e do afastamento; infiltração facetária ou epidural só com alvo claro na imagem, pela regulação.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: cauda equina e déficit progressivo (descompressão — neurocirurgia ou cirurgia de coluna pela regulação de urgência); radiculopatia com déficit ou sem melhora em 6–12 semanas com ressonância compatível (cirurgia de coluna, eletiva); suspeita de infecção ou tumor (internação, biópsia — especialidade conforme o achado).
- Lombalgia que passa de 12 semanas sem alarme: fisiatria/reabilitação e, se preciso, clínica da dor pela regulação — depois de você ter revisto o diagnóstico e pedido a imagem.

Atestado	2–5 dias no trabalho de escritório; 7–14 no braçal, com retorno em função leve antes se possível.
Retorno	2 semanas; antes se sinal de alarme ou déficit.

DICAS

- Receita pronta “Lombalgia aguda” na aba Receitas prontas usa o mesmo esquema.
- Dor na coxa que para acima do joelho não é ciática: costuma ser referida (facetária ou sacroilíaca) e responde ao mesmo tratamento.
- Corticoide oral não melhora lombalgia sem radiculopatia.

Baseado em: NICE NG59 — Low back pain and sciatica; ACP 2017 — Noninvasive treatments for low back pain; Lancet Low Back Pain Series 2018.

3.2 Lombociatalgia e hérnia de disco

CID M54.4 / M51.1 · **Também** ciática, dor ciática, hérnia de disco, nervo ciático, dor que desce pela perna, radiculopatia lombar

> Dor que desce abaixo do joelho num dermátomo, com Lasègue positivo: hérnia até prova em contrário, e 80% melhora sem cirurgia em 6 a 12 semanas.

O QUE PERGUNTAR

- Até onde desce a dor e por onde (lateral da perna e dorso do pé = L5; posterior e planta ou borda lateral = S1; face anterior da coxa e medial da perna = L4)?
- Pior sentado e ao tossir ou evacuar? (típico de hérnia). Pior ao andar e melhora sentado? (estenose de canal, em idoso).
- Fraqueza (pé que arrasta, tropeça), dormência, alteração urinária, dormência genital? (alarme)

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Lasègue e Lasègue cruzado	Elevação da perna estendida; positivo entre 30° e 70° com dor radicular (não só na lombar). Bragard: baixe até parar a dor e faça dorsiflexão do pé.	Lasègue cruzado positivo tem alta especificidade para hérnia.
Teste de estiramento femoral	Em decúbito ventral, flexione o joelho; dor na face anterior da coxa.	Raiz L3/L4.
Força por raiz	L4: extensão do joelho e dorsiflexão do pé; L5: extensão do hálux, caminhar no calcanhar; S1: flexão plantar, caminhar na ponta do pé, reflexo aquileu.	Graduar de 0 a 5 e anotar — é isso que define urgência na evolução.
Toque retal e sensibilidade perineal	Só se queixa urinária, intestinal ou dormência em sela.	Tônus reduzido ou anestesia em sela → cauda equina.

SINAIS DE ALARME

- Cauda equina: pronto-socorro agora com ressonância.
- Déficit motor grau ≤ 3 ou progressivo (pé caído): ressonância em 24–48 h e cirurgia de coluna.
- Dor incapacitante que não responde a nada em 2 semanas: antecipar ressonância e especialista.

IMAGEM

- Sem alarme: nenhum exame nas primeiras 6 semanas. A ressonância mostra hérnia em 30% de assintomáticos.
- Após 6 semanas sem melhora, ou com déficit: ressonância de coluna lombossacra (“radiculopatia L5 à esquerda — hérnia discal?”). Raio-X acrescenta pouco.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: exame neurológico com a força graduada e anotada, analgesia EV, corticoide oral se dor intensa (esquema de Goldberg), orientação e alta com retorno em 2 semanas; sem ressonância de urgência se não há déficit nem alarme.

- Déficit motor ou cauda equina: ressonância hoje (regulação de urgência se o serviço não tem) e a cirurgia de coluna no mesmo dia; não mande para casa "para fazer a ressonância na semana que vem".
- Dor que não deixa andar apesar de analgesia EV e opioide: internação curta com analgesia escalonada e corticoide; reavaliação neurológica a cada 12 h.

CONDUTA

- Atividade conforme tolerado; evitar ficar muito tempo sentado e carregar peso; não repouso absoluto.
- Fisioterapia a partir da 2ª semana (McKenzie, mobilização neural).
- Curso curto de corticoide pode melhorar a função na dor radicular intensa nas primeiras semanas — benefício modesto e sem efeito claro na dor. O único ensaio bom (Goldberg, JAMA 2015) usou prednisona 60 mg por 5 dias, 40 mg por 5 e 20 mg por 5; não repetir.
- Gabapentina ou pregabalina têm evidência fraca na ciática; se usar, dose baixa e reavaliar em 4 semanas.
- Explique a história natural: a hérnia reabsorve; a cirurgia (microdiscectomia) é para déficit, cauda equina ou dor que não cede em 6–12 semanas — e tem resultado igual ao conservador a longo prazo.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).
Prednisona 20 mg	3 comprimidos (60 mg) pela manhã, após o café, por 5 dias; depois 2 comprimidos (40 mg) por 5 dias e 1 comprimido (20 mg) por 5 dias, e parar.	Só na dor radicular intensa; evitar em diabético descompensado, úlcera, infecção.
Tramadol 50 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 3 a 5 dias, só se a dor não ceder com o resto.	Lista A2 da Portaria 344 (tarja preta): até 100 mg por unidade sai em receita de controle especial em duas vias, não na notificação A. Náusea e tontura são comuns; cuidado em idoso, epilepsia e com antidepressivo (serotonina).

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 2 semanas com a força reexaminada e anotada (L4, L5, S1 de 0 a 5): piora → ressonância e cirurgia; igual ou melhor → segue conservador até 6–12 semanas.

- Ressonância pela regulação após 6 semanas sem melhora, com a pergunta escrita (“radiculopatia L5 à esquerda — hérnia discal? candidato a microdiscectomia”); enquanto espera, fisioterapia e gabapentinoide em dose baixa se for usar.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: cauda equina (descompressão em horas — regulação de urgência), déficit motor grau ≤ 3 ou progressivo (ressonância em 24–48 h e cirurgia de coluna), dor radicular que não cede em 6–12 semanas com ressonância compatível (microdiscectomia, eletiva); injeção epidural de corticoide (clínica da dor/radiologia intervencionista) quando a dor impede a reabilitação.

Atestado	7–14 dias; estender conforme a dor, com retorno em função leve.
Retorno	2 semanas, com exame neurológico repetido e anotado.

DICAS

- Anote a força a cada consulta: “L5 grau 4” que vira “grau 3” muda a conduta mesmo com a dor igual.

Baseado em: NICE NG59; NASS Clinical Guideline — Lumbar disc herniation with radiculopathy; Goldberg et al., JAMA 2015 (corticoide oral na ciática).

3.3 Cervicalgia e cervicobraquialgia

CID M54.2 / M50.1 · **Também** dor no pescoço, torcicolo, dor cervical, dor que desce pelo braço, radiculopatia cervical, formigamento no braço

> Dor cervical sem trauma e sem déficit é mecânica e melhora em semanas sem colar; dor que desce pelo braço com Spurling positivo é radicular e também costuma melhorar.

O QUE PERGUNTAR

- Trauma (acidente, queda)? Com trauma, a regra é imagem antes de mexer.
- Desce para o braço? Até a mão, em qual dedo (polegar = C6; dedo médio = C7; mínimo = C8)?
- Dificuldade para andar, mãos desajeitadas, urgência urinária? (mielopatia).
- Febre, câncer, emagrecimento, dor noturna?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Amplitude e palpação	Flexão, extensão, rotações e inclinações; palpação de espinhosos e trapézio.	Dor na linha média após trauma → tomografia antes de liberar.
Spurling	Extensão + inclinação para o lado doente + compressão axial leve.	Dor que desce pelo braço → radiculopatia cervical (específico, pouco sensível).
Força, reflexos e sensibilidade	C5: abdução do ombro, bicipital; C6: flexão do cotovelo e extensão do punho, estilorradial; C7: extensão do cotovelo, tricipital; C8: flexão dos dedos; T1: abdução dos dedos.	Déficit objetivo → radiculopatia; reflexos vivos, Hoffmann ou Babinski → mielopatia (alarme).
Hoffmann e marcha	Pinçar a unha do dedo médio; observar marcha e tandem.	Flexão do polegar ou marcha espástica → mielopatia: ressonância urgente.

SINAIS DE ALARME

- Trauma com dor na linha média, > 65 anos, mecanismo perigoso ou déficit: colar e tomografia (Canadian C-Spine). Não pedir raio-X nesse cenário.
- Sinais de mielopatia (marcha, mãos desajeitadas, reflexos vivos, Hoffmann): ressonância e cirurgia de coluna em dias.
- Febre, câncer, imunossupressão ou dor noturna: investigar infecção ou tumor.
- Cefaleia occipital intensa com dor cervical após manipulação ou trauma leve, com sintomas neurológicos: dissecção vertebral — pronto-socorro.

IMAGEM

- Sem trauma e sem déficit: nenhum exame nas primeiras 4–6 semanas.
- Radiculopatia que não melhora em 6 semanas, ou com déficit: ressonância de coluna cervical.
- Trauma: tomografia conforme a regra; raio-X só em paciente jovem de baixo risco.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão, cervicalgia sem trauma e sem déficit: analgesia EV, relaxante à noite, calor, sem colar, alta com retorno em 2–3 semanas; sem raio-X.

- Trauma cervical: colar rígido e tomografia pela regra canadense (dor na linha média, > 65 anos, mecanismo perigoso, déficit); tomografia normal e exame normal → tira o colar; fratura ou instabilidade → colar, prancha, cirurgia de coluna pela regulação de urgência.
- Mielopatia (marcha, mãos desajeitadas, reflexos vivos, Hoffmann): ressonância em dias (urgência se progressiva) e cirurgia de coluna — não é caso de fisioterapia.

CONDUTA

- Sem colar cervical. Manter-se ativo, calor local, ajustar travesseiro (altura do ombro ao deitar de lado) e a tela do computador na altura dos olhos.
- Exercícios de mobilidade e fortalecimento desde cedo; fisioterapia se não melhorar em 2–3 semanas.
- Na radiculopatia: a maioria melhora em 4–8 semanas; curso curto de corticoide ajuda na dor intensa.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).
Ciclobenzaprina 5 mg	1 comprimido à noite por 5 a 7 dias; pode subir a 10 mg se tolerar.	Dá sono e boca seca; evitar em idoso, glaucoma, arritmia e com outros sedativos. Não dirigir após a dose.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 2–3 semanas: reexame (reflexos, força C5–T1, Hoffmann); sem melhora em 6 semanas com radiculopatia → ressonância pela regulação; dor mecânica persistente → fisioterapia e exercício, não colar nem repetir corticoide.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: mielopatia (ressonância e cirurgia de coluna em dias — regulação com urgência), radiculopatia com déficit motor ou sem melhora em 6–8 semanas com ressonância compatível (cirurgia de coluna, eletiva), trauma com fratura ou instabilidade na tomografia (coluna/neurocirurgia hoje), dissecção vertebral (neurologia/vascular hoje).

Atestado	0–3 dias; mais se o trabalho exige carga ou posição fixa da cabeça.
Retorno	2–3 semanas; antes se piora neurológica.

DICAS

- Torcicolo agudo do adulto (dormiu mal) melhora em 3–5 dias com calor e relaxante; na criança, torcicolo com febre ou após infecção de garganta pede avaliação (Grisel, abscesso).

Baseado em: Canadian C-Spine Rule; NASS — Cervical radiculopathy; Cochrane — Neck pain exercises.

3.4 Fratura vertebral por fragilidade

CID M80.0 / S22.0 / S32.0 · **Também** fratura de vértebra, fratura na coluna do idoso, osteoporose, achatamento de vértebra, fratura por compressão

> Dor dorsal ou lombar súbita no idoso, às vezes sem trauma: raio-X mostra o achatamento; tratar a dor e, principalmente, a osteoporose que vem atrás.

O QUE PERGUNTAR

- Como começou (ao levantar peso, tossir, sentar com força, queda da própria altura)?
- Corticoide prolongado, menopausa precoce, fratura prévia (punho, quadril), tabagismo, baixo peso?
- Dormência, fraqueza nas pernas, alteração urinária? (compressão medular — raro nas fraturas osteoporóticas, frequente nas metastáticas).
- Câncer prévio (mama, próstata, pulmão, rim, tireoide, mieloma)? Emagrecimento?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Percussão dos espinhosos	Percutir vértebra por vértebra com o punho fechado ou o martelo.	Dor localizada no nível da fratura.
Exame neurológico das pernas	Força, reflexos, sensibilidade e marcha.	Déficit → tomografia/ressonância urgente.

SINAIS DE ALARME

- Déficit neurológico ou retenção urinária: pronto-socorro.
- Fratura acima de T5, em paciente com câncer, ou com perda de altura > 50% / retropulsão: ressonância — pode ser metástase ou instável.
- Mais de uma fratura ou fratura em homem jovem: investigar mieloma e causas secundárias (cálcio, fosfatase alcalina, eletroforese, TSH, vitamina D, PTH).

IMAGEM

- RX de coluna torácica e lombar AP e perfil ("dor dorsal súbita em idosa — fratura por compressão?").
- Ressonância se dúvida sobre idade da fratura (edema ósseo = aguda), suspeita de tumor, ou dor que não cede para avaliar vertebroplastia.
- Densitometria óssea (DXA) de coluna e fêmur, e exames de causas secundárias, nas semanas seguintes.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: raio-X de coluna torácica e lombar, exame neurológico anotado; sem déficit e com dor controlável → analgesia (dipirona fixa, tramadol em dose baixa com laxante), mobilização com apoio, colete de conforto se disponível, alta com retorno em 2 semanas e os exames da osteoporose pedidos.
- Déficit neurológico, retenção urinária, fratura acima de T5 ou com > 50% de perda de altura/retropulsão, câncer conhecido: tomografia ou ressonância hoje e cirurgia de coluna pela regulação (urgência se déficit).
- Idoso que não consegue levantar nem com analgesia EV: internação curta (analgesia, fisioterapia de marcha, profilaxia de trombose, exames) — não é "dor nas costas, pode ir".

CONDUTA

- Analgesia escalonada; calcitonina nasal não é mais usada de rotina. Mobilização precoce com apoio; evitar repouso prolongado (trombose, perda muscular).
- Colete (órtese toracolombar) só para conforto em dor intensa, por poucas semanas — não muda consolidação.
- Osteoporose: toda fratura por fragilidade indica tratamento. Cálcio na dieta (1.000–1.200 mg/dia), vitamina D 1.000–2.000 UI/dia e alendronato 70 mg/semana (após conferir função renal, cálcio e vitamina D, e sem doença do esôfago). Denosumabe ou teriparatida pelo especialista quando bisfosfonato não serve.
- Prevenção de queda: revisar medicamentos sedativos, visão, calçado, tapetes, barras no banheiro. Fisioterapia de equilíbrio.
- A dor da fratura costuma melhorar em 6–12 semanas; se não, ressonância e discutir vertebroplastia/cifoplastia com a coluna.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Tramadol 50 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 3 a 5 dias, só se a dor não ceder com o resto.	Lista A2 da Portaria 344 (tarja preta): até 100 mg por unidade sai em receita de controle especial em duas vias, não na notificação A. Náusea e tontura são comuns; cuidado em idoso, epilepsia e com antidepressivo (serotonina).
Alendronato de sódio 70 mg	1 comprimido 1× por semana, em jejum, com um copo cheio de água, em pé ou sentado, 30 minutos antes de comer ou deitar.	Clearance de creatinina > 35 mL/min; corrigir vitamina D antes; contraindicado em doença do esôfago ou quem não fica 30 min ereto.
Colecalciferol (vitamina D3) 2.000 UI	1 cápsula ao dia, com uma refeição, contínuo.	—
Carbonato de cálcio 500 mg (de cálcio elementar)	1 comprimido 1 a 2× ao dia, com as refeições, se a dieta não alcança 1.000–1.200 mg/dia.	Em outro horário do alendronato.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 2 semanas (dor, marcha, neurológico) e em 6–8 semanas com raio-X (progressão do colapso?) e os exames da osteoporose (cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, creatinina, 25-OH-vitamina D, TSH, eletroforese de proteínas, PTH se cálcio alterado) — e o bisfosfonato iniciado por você.
- Dor que não cede em 6–8 semanas: ressonância (edema persistente, pseudoartrose de Kümmell) e a discussão de vertebroplastia; dor nova em outro nível é fratura nova até o raio-X dizer o contrário.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: déficit neurológico, retropulsão com estenose ou instabilidade (cirurgia de coluna — hoje se déficit), suspeita de metástase ou mieloma (oncologia/hematologia após a investigação que você inicia), dor que não cede em 6–8 semanas apesar de tudo (vertebroplastia/cifoplastia — coluna/radiologia intervencionista, eletiva), osteoporose grave ou falha do bisfosfonato (endocrinologia).

Atestado	Idoso em geral aposentado; se trabalha, 4–6 semanas sem carga.
Retorno	2 semanas (dor e mobilidade), depois 6–8 semanas com raio-X de controle e os exames da osteoporose.

DICAS

- Uma fratura de punho ou vértebra depois dos 50 anos é a chance de evitar a fratura de quadril que vem em seguida — não deixe a osteoporose sem tratamento quando o paciente sai da sua sala.

Baseado em: ABRASSO / ABOT — Diretrizes de osteoporose; NICE CG146 / TA464; AACE 2020 — Postmenopausal osteoporosis; Endocrine Society 2019.

CAPÍTULO 4

Ombro

Quatro diagnósticos cobrem quase tudo: impacto/manguito, ombro congelado, instabilidade e artrose. Três manobras separam.

4.1	**Síndrome do impacto e tendinopatia do manguito** Dor no ombro ao elevar o braço e à noite, com movimento passivo livre: impacto subacromial ou tendinopatia do manguito — fisioterapia resolve a maioria.	86
4.2	**Capsulite adesiva (ombro congelado)** Perda de movimento passivo em todas as direções, principalmente rotação externa, com raio-X normal: ombro congelado — dura 1 a 3 anos, mas a dor cede antes.	89
4.3	**Luxação e instabilidade do ombro** Luxação aguda: raio-X, redução por você (lidocaína intra-articular ou sedação) e raio-X de novo — hoje; o jovem que luxou uma vez tem alto risco de repetir e merece a estabilização cirúrgica cedo, pedida por você.	93
4.4	**Fratura de clavícula** A maioria (terço médio, sem desvio grande) trata com tipoia e consolida em 6 a 8 semanas — sua do início ao fim; desvio de 100%, encurtamento > 2 cm ou pele ameaçada são indicação de placa, que você pede pela regulação.	97

4.1 Síndrome do impacto e tendinopatia do manguito

CID M75.4 / M75.1 / M75.5 · **Também** tendinite do ombro, bursite do ombro, dor no ombro, manguito rotador, supraespinhal, tendinite calcária, dor para levantar o braço

> Dor no ombro ao elevar o braço e à noite, com movimento passivo livre: impacto subacromial ou tendinopatia do manguito — fisioterapia resolve a maioria.

O QUE PERGUNTAR

- Dor ao levantar o braço acima da cabeça, ao vestir o casaco, deitar sobre o ombro? Acorda à noite?
- Começou após esforço repetido (pintar, carregar), queda sobre o braço esticado (ruptura?), ou do nada (calcária?)?
- Fraqueza real (não consegue levantar) ou é a dor que impede? Mais de 60 anos e fraqueza: ruptura mais provável.
- Diabetes, tireoide, ombro travado em todas as direções? (capsulite).

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Mobilidade ativa e passiva	Elevação, abdução, rotação externa com o cotovelo no corpo, mão nas costas.	Passiva limitada em todas as direções → capsulite (outro tópico); passiva livre com ativa dolorosa → manguito/impacto.
Arco doloroso	Abdução ativa do braço.	Dor entre 60° e 120° → impacto subacromial.
Neer e Hawkins	Neer: elevação passiva do braço em rotação interna com a escápula fixa. Hawkins: braço a 90° de flexão, cotovelo fletido, rotação interna forçada.	Dor → impacto (sensíveis, pouco específicos).
Jobe (supraespinhal)	Braços a 90° de abdução, 30° à frente, polegares para baixo; resistir à elevação.	Dor = tendinopatia; fraqueza = ruptura do supraespinhal.
Rotação externa resistida (infraespinhal) e Gerber (subescapular)	Cotovelos no corpo a 90°, resistir à rotação externa. Gerber: mão nas costas, afastar da lombar contra resistência.	Fraqueza → ruptura do tendão correspondente.
Drop arm	Eleve passivamente a 90° de abdução e peça para baixar devagar.	Braço cai → ruptura extensa do manguito.

SINAIS DE ALARME

- Fraqueza súbita após queda em paciente < 60 anos: ruptura aguda — ultrassom ou ressonância e cirurgião do ombro em 2–4 semanas pela regulação (reparo cedo tem melhor resultado).
- Ombro quente, vermelho, febre: artrite séptica — hospital.
- Dor sem relação com movimento, perda de peso, massa: tumor (raro) — raio-X e imagem.
- Dor no ombro com exame do ombro normal: pense em coluna cervical, coração (esquerdo), vesícula e diafragma (direito).

IMAGEM

- RX de ombro AP verdadeiro, perfil escapular e axilar — na primeira consulta se > 40 anos, trauma ou dor > 4 semanas: mostra calcificação, artrose e ascensão da cabeça (ruptura maciça).

- Ultrassom de ombro: bom para ruptura de espessura total, bursite e calcificação; pedir quando há fraqueza ou dor que não melhorou em 6 semanas.
- Ressonância: antes de cirurgia ou em dúvida; não na primeira consulta.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão, o ombro doloroso sem trauma, com movimento passivo livre e raio-X sem luxação: analgesia, AINE curto, orientação (sem tipoia!), exercícios escritos e retorno no ambulatório em 2–6 semanas; infiltração subacromial já na primeira consulta se a dor impede dormir.
- Trauma com fraqueza súbita em < 60 anos, ou ombro que não eleva após queda com raio-X normal: suspeita de ruptura aguda — ultrassom em dias e a regulação para o cirurgião do ombro; tipoia por conforto só por dias.
- Tendinite calcária aguda (dor lancinante, calcificação no raio-X): infiltração subacromial com corticoide e lidocaína no plantão resolve a crise; raio-X guarda a comparação.

CONDUTA

- Fisioterapia é o tratamento: exercícios de manguito e escápula, 3× por semana por 6–12 semanas. Em casa: rotação externa com faixa elástica, elevação deslizando na parede, 2× ao dia.
- Evitar atividades acima da cabeça por 2–4 semanas; gelo 15–20 min após atividade.
- AINE por 7–10 dias na fase dolorosa; dormir com travesseiro sob o braço.
- Infiltração subacromial com corticoide (triancinolona 20–40 mg + lidocaína): alívio de semanas a meses, útil para conseguir fazer a fisioterapia; no máximo 2–3 por ano — você faz, pela via posterior (ver Punção e infiltração).
- Tendinite calcária aguda (dor lancinante, calcificação no raio-X): mesmo esquema; se não cede, barbotagem guiada por ultrassom.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 6 semanas (2 após infiltração): força do manguito reexaminada; melhora → segue fisioterapia por 12 semanas; sem melhora ou fraqueza → ultrassom/ressonância e a indicação cirúrgica é sua.
- Até 2–3 infiltrações por ano; a terceira sem resposta é cirurgia ou outro diagnóstico (cervical, capsulite, artrose).

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: ruptura de espessura total com fraqueza em paciente ativo ou < 65 anos (reparo artroscópico — cirurgião do ombro pela regulação, em semanas na aguda), falha de 3–6 meses de fisioterapia e infiltração (descompressão/reparo, eletivo), calcária refratária (barbotagem guiada — radiologia/ombro), artropatia do manguito com dor incapacitante (prótese reversa, eletivo).

Atestado	0–7 dias; braçal com trabalho acima da cabeça: 14 dias ou restrição.
Retorno	6 semanas (resposta à fisioterapia); 2 semanas se infiltrou.

DICAS

- A rotação externa passiva livre é o que separa o manguito da capsulite — faça sempre.
- Idoso com ruptura maciça crônica e sem dor não precisa operar; o que trata é função.

Baseado em: AAOS CPG — Rotator cuff injuries 2019; BESS/BOA — Subacromial shoulder pain; NICE CKS — Shoulder pain.

4.2 Capsulite adesiva (ombro congelado)

CID M75.0 · **Também** ombro congelado, ombro travado, ombro duro, capsulite, não consigo levantar o braço

> Perda de movimento passivo em todas as direções, principalmente rotação externa, com raio-X normal: ombro congelado — dura 1 a 3 anos, mas a dor cede antes.

O QUE PERGUNTAR

- Diabetes ou tireoide? (dobra o risco e piora a evolução). Imobilizou o ombro recentemente, cirurgia, AVC?
- Fase: dor intensa à noite e travando progressivamente (congelando, 2–9 meses); rígido e menos doloroso (congelado, 4–12 meses); soltando (6–24 meses).
- Idade 40–65 e mulher? (perfil típico).

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Mobilidade passiva	Com o paciente relaxado, rotação externa com o cotovelo no corpo, elevação e rotação interna, comparando os lados.	Rotação externa passiva < 50% do outro lado e perda global → capsulite; o raio-X normal fecha o diagnóstico (exclui artrose).

SINAIS DE ALARME

- Rigidez com raio-X alterado: artrose, luxação posterior crônica ou necrose — não é capsulite.
- Diabético com dor desproporcional e febre: infecção.

IMAGEM

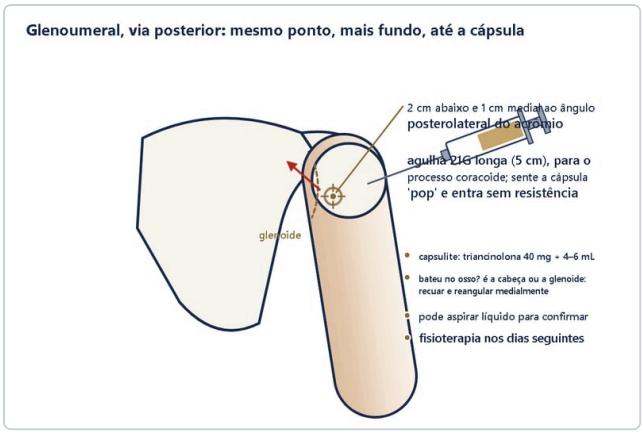
- RX de ombro AP, perfil e axilar: obrigatório, para excluir artrose e luxação posterior (clínica idêntica). Ressonância não é necessária.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

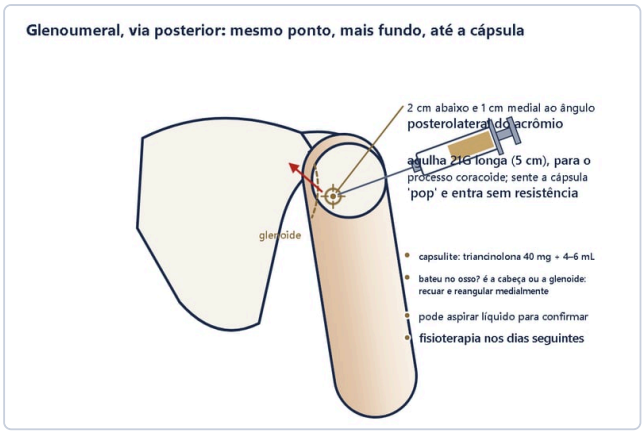
- No plantão: raio-X obrigatório (AP, perfil, axilar) para excluir luxação posterior e artrose; confirmada a capsulite, infiltração intra-articular de corticoide (ver procedimento) já na primeira consulta na fase dolorosa, analgesia, exercícios escritos e retorno em 4–6 semanas; sem tipoia.
- Diabético: avise da glicemia por 3–5 dias após o corticoide; prednisona oral é a alternativa quando a infiltração não é possível.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

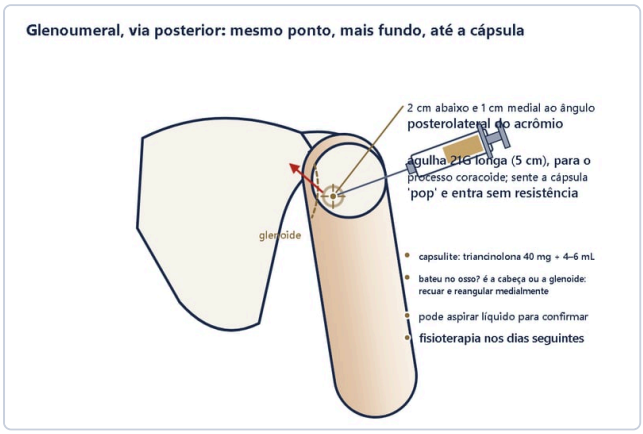
Infiltração intra-articular do ombro (glenoumeral) — via posterior



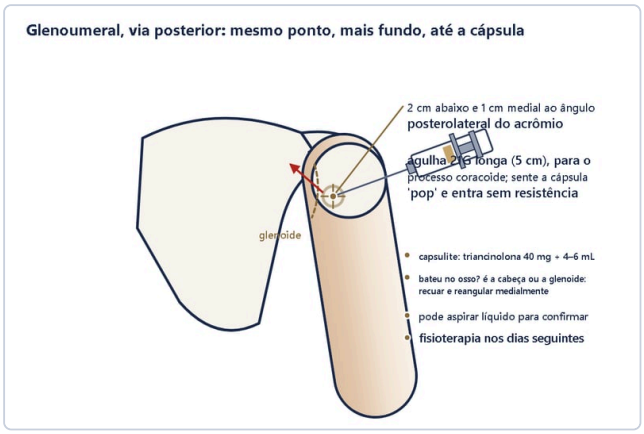
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Capsulite na fase dolorosa; artrose glenoumeral em crise. Não na dúvida de infecção nem em prótese.

Material e anestesia: Triancinolona 40 mg + lidocaína 1% 4–5 mL (na hidrodilatação: + soro 15–30 mL), agulha 21–22G 40–50 mm, antissepsia rigorosa.

Passo a passo

1. Sentado, braço pendente em rotação interna leve. Ponto: 2 cm abaixo e 1 cm medial ao ângulo posterolateral do acrômio (o mesmo da subacromial), mas a agulha aponta para o processo coracoide e vai mais fundo, até a articulação.
2. Avance até tocar a cartilagem ou sentir a cápsula ceder (4–5 cm); aspire; injete sem resistência — resistência alta é cápsula ou tendão: reposicione.
3. Mova o braço depois; o alívio imediato (anestésico) confirma o alvo.

Depois: Exercícios de pêndulo e bastão desde o dia seguinte; retorno em 4–6 semanas; no máximo 2 por fase dolorosa.

CONDUTA

- Explique a história natural: melhora sozinha, mas leva meses; tratamento encurta a dor, não a doença.
- Fase dolorosa: infiltração intra-articular de corticoide (triancinolona 40 mg) tem o melhor efeito nas primeiras semanas; alternativa, prednisona 30 mg/dia por 3 semanas e parar (Buchbinder, 2004: menos dor e mais movimento às 3 semanas, sem diferença às 12; cuidado em diabético).
- Fisioterapia com mobilização dentro da dor tolerável e exercícios em casa (pêndulo, bastão, dedos na parede) 2–3× ao dia; alongar forte em fase dolorosa piora.
- Controle glicêmico no diabético.

- Hidrodilatação (artrografia distensiva) guiada por imagem e, em casos refratários após 6–12 meses, manipulação sob anestesia ou liberação artroscópica.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).
Prednisona 20 mg	1 ½ comprimido (30 mg) pela manhã por 21 dias e parar.	Só na fase dolorosa e quando não há infiltração disponível; em diabético, monitorar glicemia.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno a cada 4–6 semanas: medir rotação externa e elevação (anote em graus) — o ganho de amplitude é o que diz que está saindo da fase congelada; repetir a infiltração uma vez se a dor voltou na fase dolorosa.
- Sem ganho em 6 meses de fisioterapia e 1–2 infiltrações: hidrodilatação ou cirurgia — pedido pela regulação com os graus anotados.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: hidrodilatação guiada por imagem (radiologia, se o serviço não faz), e o refratário após 6–12 meses de tratamento bem feito — manipulação sob anestesia ou liberação artroscópica (cirurgião do ombro, eletivo pela regulação).

Atestado	0–7 dias na fase aguda; restrição de trabalho acima da cabeça.
Retorno	4–6 semanas; a cada fase, redefinir o tratamento.

DICAS

- Capsulite num ombro imobilizado por tipoia “por precaução” é a complicação mais evitável da ortopedia: tire a tipoia cedo.

Baseado em: BESS — Frozen shoulder guideline; UK FROST trial (Lancet 2020); Cochrane — Corticosteroid injection for adhesive capsulitis.

4.3 Luxação e instabilidade do ombro

CID S43.0 / M24.4 · **Também** ombro saiu do lugar, deslocou o ombro, luxação, ombro solto, instabilidade, Bankart

> Luxação aguda: raio-X, redução por você (lidocaína intra-articular ou sedação) e raio-X de novo — hoje; o jovem que luxou uma vez tem alto risco de repetir e merece a estabilização cirúrgica cedo, pedida por você.

O QUE PERGUNTAR

- Como saiu (queda com o braço aberto, convulsão, choque elétrico — os dois últimos sugerem posterior)? Quantas vezes já saiu? Volta sozinho?
- Dormência na lateral do ombro (nervo axilar)? Formigamento na mão?
- Idade: < 25 anos → recidiva > 70%; > 40 → ruptura do manguito associada é comum.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Inspeção e neurovascular	Perda do contorno (sinal da dragona), braço em leve abdução e rotação externa (anterior). Sensibilidade na face lateral do ombro (axilar), pulso radial.	Déficit do axilar: anotar antes da redução.
Apreensão e recolocação	Deitado, braço a 90° de abdução e rotação externa progressiva; depois pressione a cabeça umeral para trás.	Medo ou sensação de sair que alivia com a mão → instabilidade anterior.
Sulco	Tração do braço para baixo com o paciente sentado.	Depressão abaixo do acrômio → frouxidão inferior (multidirecional).
Força do manguito após luxação em > 40 anos	Jobe, rotação externa resistida, Gerber (ver impacto).	Fraqueza persistente após 2–3 semanas → ruptura: ultrassom.

SINAIS DE ALARME

- Luxação aguda: raio-X (AP + axilar ou Y) antes de reduzir — fratura associada muda a conduta. Redução por você, com lidocaína intra-articular ou sedação (ver procedimento). Não reduzir sem imagem.
- Luxação posterior passa batido no AP (cabeça parece uma lâmpada): axilar ou Y obrigatória em convulsão e choque elétrico.
- Pulso ausente ou mão fria: lesão vascular — vascular hoje. Luxação com mais de 24 h ou em idoso osteoporótico: a redução pode fraturar o colo — sedação boa, manobra lenta e sem alavanca; se não vem fácil, redução sob anestesia pelo cirurgião.

IMAGEM

- Agudo: RX de ombro AP verdadeiro, perfil escapular (Y) e axilar, antes e depois da redução.
- Instabilidade recorrente: ressonância com artrografia (Bankart, Hill-Sachs, perda óssea) — pedida por você, pela regulação, para indicar a cirurgia; tomografia se suspeita de perda óssea da glenoide.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Anterior aguda: analgesia, raio-X (AP + axilar/Y), neurovascular anotado (axilar!), redução por rotação externa, Cunningham ou tração-contratração com lidocaína intra-articular 20 mL a 1% ou sedação (ver procedimento), raio-X de controle, tipoia, alta com retorno em 7 dias. Uma tentativa boa; se não reduz com sedação adequada, redução sob anestesia pelo cirurgião.
- Posterior (convulsão, choque elétrico, braço travado em rotação interna): axilar obrigatória; redução por tração com rotação externa suave sob sedação; mais de 3 semanas ou defeito ósseo grande → cirurgião.
- Fratura-luxação (tubérculo maior, colo): o tubérculo maior isolado reduz junto com a luxação; colo fraturado → não reduza fechado, cirurgia.
- Após a redução: anote neurovascular de novo (axilar: deltoide e sensibilidade lateral), oriente a tipoia por 1–3 semanas e os exercícios de cotovelo e mão.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

Redução da luxação anterior do ombro — rotação externa, Cunningham e tração-contratração



1 · antes

2 · aproximação

3 · a manobra

4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Luxação anterior aguda com raio-X feito (sem fratura do colo). Analgesia: lidocaína intra-articular 20 mL a 1% (via posterior, espere 15 min) ou sedação.

Material e anestesia: Maca, 1 ajudante (tração-contratração), lençol; lidocaína 1% 20 mL e agulha 21G 50 mm, ou sedação monitorizada.

Passo a passo

1. Rotação externa (Hennepin): deitado, cotovelo a 90° junto ao corpo; com a mão no punho, rode o braço para fora muito devagar (1–2 minutos), parando quando contrai; a maioria reduz entre 70° e 110° de rotação externa, sem tração. Se não, eleve o braço devagar em abdução mantendo a rotação externa (Milch).
2. Cunningham: sentado, braço aduzido, cotovelo a 90°, sua mão no antebraço do paciente apoiando-o; peça para relaxar os ombros para trás e para baixo; massageie trapézio, deltoide e bíceps por 1–3 minutos; o ombro entra sem força.
3. Tração-contratração: deitado, lençol em volta do tórax puxado pelo ajudante para o lado oposto; você traciona o braço em leve abdução, contínuo, 2–3 minutos, com rotação externa suave; sem alavanca no colo (fratura).
4. Reduziu: o contorno volta, o paciente alivia na hora, a rotação interna é possível.

Depois: Neurovascular (axilar), raio-X AP + axilar/Y, tipoia 1–3 semanas; anote técnica, analgesia e número de tentativas.

CONDUTA

- Após redução: tipoia 1–3 semanas (rotação interna é aceitável; a posição em rotação externa não mostrou vantagem consistente), mobilizar cotovelo e mão desde o 1º dia.
- Fisioterapia a partir da 2ª–3ª semana: fortalecimento de manguito e escápula; evitar abdução com rotação externa por 6 semanas.
- Jovem atleta ou trabalho braçal após a primeira luxação: discutir estabilização artroscópica precoce (recidiva cai de ~70% para ~10%).
- Instabilidade multidirecional (frouxo, sem trauma, sulco positivo): fisioterapia por 6 meses antes de qualquer cirurgia.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.

IMOBILIZAÇÃO

- Tipoia simples por 1–3 semanas após a redução; retirar várias vezes ao dia para mover cotovelo, punho e dedos.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 7 dias (neurovascular, raio-X se dúvida) e em 3 semanas: tirar a tipoia, fisioterapia de manguito e escápula; evitar abdução com rotação externa por 6 semanas.
- < 30 anos, atleta ou braçal: converse sobre a estabilização cirúrgica precoce já no retorno de 3 semanas (recidiva de ~70% para ~10%) e peça a artrorressonância pela regulação; recorrente: idem, sem esperar a "terceira".
- > 40 anos com fraqueza que persiste após 3 semanas: ultrassom (manguito) e reparo se roto.
- Multidirecional (frouxo, sem trauma, sulco positivo): 6 meses de fisioterapia antes de qualquer pedido de cirurgia.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a estabilização cirúrgica (Bankart artroscópico; Latarjet se perda óssea) na primeira luxação do jovem atleta/trabalhador braçal e em toda instabilidade recorrente — cirurgião do ombro pela regulação, eletivo em semanas; ruptura do manguito após luxação em > 40 anos (reparo); fratura associada desviada (tubérculo maior > 5 mm, colo) ou luxação irredutível (hoje); lesão vascular (vascular hoje).

Atestado	14–21 dias; trabalho acima da cabeça ou de carga, 6 semanas.
Retorno	1 semana após a redução (neurovascular, raio-X), depois 3 semanas.

DICAS

- Luxação que "volta sozinha" várias vezes é instabilidade estabelecida: não é benigna — cada episódio tira osso da glenoide.

Baseado em: BESS — Traumatic anterior shoulder instability; AAOS OrthoInfo — Dislocated shoulder; Cochrane — Immobilisation position after shoulder dislocation.

4.4 Fratura de clavícula

CID S42.0 · **Também** quebrou a clavícula, clavícula, fratura do ombro na queda, osso do ombro

> A maioria (terço médio, sem desvio grande) trata com tipoia e consolida em 6 a 8 semanas — sua do início ao fim; desvio de 100%, encurtamento > 2 cm ou pele ameaçada são indicação de placa, que você pede pela regulação.

O QUE PERGUNTAR

- Como caiu (sobre o ombro, braço esticado)? Dormência ou formigamento no braço? Falta de ar (pneumotórax em alta energia)?
- Mão dominante, profissão, esporte?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Inspeção da pele	Procurar pele tensa, pálida ou com fragmento em "tenda" sobre a fratura.	Pele ameaçada → cirurgia urgente antes de abrir.
Neurovascular	Pulso radial, sensibilidade e força da mão (plexo braquial); ausculta pulmonar.	Déficit → encaminhar no mesmo dia.
Articulações vizinhas	Acromioclavicular e esternoclavicular, ombro (movimento passivo suave).	Dor na esternoclavicular com deformidade posterior → tomografia (compressão de vasos/traqueia).

SINAIS DE ALARME

- Fratura exposta ou pele ameaçada; déficit neurovascular; fratura de terço medial com desvio posterior; lesão flutuante (clavícula + escápula); pneumotórax: pronto-socorro hoje.

IMAGEM

- RX de clavícula AP e com inclinação cefálica de 15–30° ("RX de clavícula D — AP e AP com angulação cefálica"). Medir desvio e encurtamento no laudo.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: raio-X (AP e cefálica), medir desvio e encurtamento, neurovascular e ausculta, tipoia, analgesia, alta com retorno em 7–10 dias com raio-X; a decisão de operar é sua e pode esperar o retorno — salvo pele em tenda, exposta, déficit, desvio posterior medial.
- Criança (galho verde ou completa do terço médio): tipoia 2–3 semanas, sem raio-X de controle, calo é normal; adolescente com desvio total: discuta com a família — a maioria ainda é tipoia.

CONDUTA

- Tipoia por 2–4 semanas (até a dor permitir), mobilizar cotovelo e mão desde o início; pendular do ombro a partir da 2ª semana; elevação acima de 90° após 4–6 semanas, quando houver calo.
- Sem contato ou peso por 8–12 semanas. Dormir semissentado ajuda na primeira semana.
- Avise que o calo fica palpável (um "caroço") para sempre e que é normal.
- Cirurgia (placa) quando: desvio total sem contato, encurtamento > 1,5–2 cm, cominuição, fratura de terço lateral instável, politrauma, atleta/ trabalhador que precisa voltar rápido — você indica e pede pela regulação (eletiva em 1–2 semanas).

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Tramadol 50 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 3 a 5 dias, só se a dor não ceder com o resto.	Lista A2 da Portaria 344 (tarja preta): até 100 mg por unidade sai em receita de controle especial em duas vias, não na notificação A. Náusea e tontura são comuns; cuidado em idoso, epilepsia e com antidepressivo (serotonina).

IMOBILIZAÇÃO

- Tipoia simples. A “tipoia em 8” não alinha melhor e machuca a axila — não usar.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 7–10 dias: raio-X (aumentou o desvio ou o encurtamento?), pele, função; indique a placa se critérios; senão tipoia até 2–4 semanas e pendular.
- 6 semanas: raio-X (calo), liberar acima de 90°; 10–12 semanas: carga e contato. Sem calo em 3–4 meses com dor: não união → placa e enxerto (eletivo).

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a fixação com placa quando há indicação (ver conduta) — cirurgião pela regulação, eletiva em 1–2 semanas; hoje se pele ameaçada, exposta, lesão vascular ou terço medial com desvio posterior (compressão) e pneumotórax (cirurgia torácica/trauma).

Atestado	21–42 dias conforme a função; escritório pode voltar em 7–14 dias com a tipoia.
Retorno	1–2 semanas com raio-X de controle; 6 semanas para liberar movimento acima da cabeça.

DICAS

- Na criança, fratura de clavícula em galho verde trata com tipoia 2–3 semanas e nem precisa de raio-X de controle.

Baseado em: AAOS OrthoInfo — Clavicle fracture; BOAST — Clavicle (adult); Cochrane — Surgical vs conservative for midshaft clavicle.

CAPÍTULO 5

Cotovelo, punho e mão

Quase tudo é tendão ou nervo e tem uma manobra com nome; a exceção que não pode escapar é a fratura de escafoide.

5.1	**Epicondilite lateral e medial** Dor no epicôndilo que piora ao segurar e torcer objetos, com cotovelo que move normal: tendinopatia por sobrecarga — melhora em meses com carga progressiva, não com repouso total.	100
5.2	**Síndrome do túnel do carpo** Dormência noturna no polegar, indicador e médio que alivia sacudindo a mão: túnel do carpo — órtese noturna e infiltração resolvem a maioria; atrofia da eminência tenar é cirurgia.	103
5.3	**Tenossinovite de De Quervain** Dor na borda radial do punho ao mover o polegar, Finkelstein positivo: inflamação dos tendões do 1º compartimento — órtese com polegar e infiltração.	105
5.4	**Dedo em gatilho** Dedo que trava em flexão e destrava com estalo, nódulo doloroso na palma na base do dedo: polia A1 — infiltração resolve a maioria.	107
5.5	**Fratura do rádio distal (Colles)** Queda sobre a mão espalmada com dor, edema e deformidade do punho: raio-X, redução com bloqueio de hematoma se desviada, tala e controle em 7 dias — tudo seu; placa para a que não segura ou é articular — e na idosa, tratar a osteoporose.	109
5.6	**Fratura de escafoide (suspeita)** Dor na tabaqueira anatômica após queda com raio-X normal é fratura de escafoide até prova em contrário: imobilizar com o polegar e repetir imagem em 10 a 14 dias — a não união custa o punho.	113
5.7	**Rizartrose (artrose da base do polegar)** Dor na base do polegar ao pinçar e abrir frascos, em mulher > 50 anos, com grind test positivo: artrose carpometacarpal — órtese e infiltração.	115

5.1 Epicondilite lateral e medial

CID M77.1 / M77.0 · **Também** cotovelo de tenista, cotovelo de golfista, tendinite do cotovelo, dor no cotovelo, epicondilite

> Dor no epicôndilo que piora ao segurar e torcer objetos, com cotovelo que move normal: tendinopatia por sobrecarga — melhora em meses com carga progressiva, não com repouso total.

O QUE PERGUNTAR

- Trabalho ou hobby repetitivo (apertar, torcer, digitar com mouse, pedreiro, tênis)?
- Dormência no 4º e 5º dedos (ulnar, na medial)? Dor noturna, cotovelo que trava ou incha (artrose, corpo livre)?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Palpação	Ponto doloroso 1 cm distal ao epicôndilo lateral (extensores) ou medial (flexores).	Dor localizada.
Cozen	Cotovelo a 90°, punho fechado e pronado; resistir à extensão do punho.	Dor no epicôndilo lateral → epicondilite lateral.
Mill	Pronação, flexão do punho e extensão passiva do cotovelo.	Dor lateral.
Flexão/pronação resistidas	Resistir à flexão do punho e à pronação com o cotovelo estendido.	Dor no epicôndilo medial → epicondilite medial. Tinel sobre o túnel cubital para o ulnar.
Mobilidade do cotovelo	Flexão, extensão, prono e supinação.	Bloqueio ou derrame → não é só tendão: raio-X.

SINAIS DE ALARME

- Cotovelo quente e com derrame, febre: artrite séptica / bursite séptica do olécrano.
- Déficit do ulnar (fraqueza de abdução dos dedos, atrofia da mão) na medial: eletroneuromiografia e ortopedia.

IMAGEM

- Não precisa na apresentação típica. RX de cotovelo AP e perfil se trauma, bloqueio, derrame ou dor > 6 meses. Ultrassom se dúvida com outra estrutura.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: diagnóstico clínico, sem raio-X na típica, AINE tópico ou curto, braçadeira, orientação de carga e os exercícios excêntricos escritos; retorno no ambulatório em 6 semanas. Não é caso de infiltração no primeiro dia.
- Cotovelo com derrame, bloqueio ou febre não é epicondilite: raio-X e, se quente, punção.

CONDUTA

- Modificar a atividade (não parar): pegar objetos com a palma para cima, mouse ergonômico, reduzir força de preensão.
- Exercícios excêntricos de extensores (ou flexores) do punho, 3 séries de 15, 2× ao dia, por 8–12 semanas — é o que tem evidência. Fisioterapia orienta.

- Órtese tipo braçadeira (tennis elbow strap) 2–3 cm abaixo do epicôndilo durante a atividade; munhequeira à noite se dor noturna.
- AINE tópico (diclofenaco gel) ou oral por 7–10 dias na fase aguda.
- Infiltração de corticoide: alivia por semanas e piora o resultado em 6–12 meses — evitar ou usar uma vez só. PRP, ondas de choque: opções do especialista no refratário.
- Prognóstico: 80–90% melhoram em 12 meses; cirurgia é rara.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Diclofenaco dietilamônio gel 11,6 mg/g	Aplicar camada fina no cotovelo, 3 a 4× ao dia, por 14 dias, com massagem leve.	—
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.

IMOBILIZAÇÃO

- Braçadeira de epicondilite durante a atividade; não imobilizar o cotovelo.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 6 semanas: aderência aos exercícios (é o que falha); sem melhora em 3 meses: uma infiltração de corticoide (alivia semanas, piora o ano) só se a dor impede trabalhar — ou nada; 6–12 meses: revisar o diagnóstico (plica, instabilidade posterolateral, túnel radial) antes de pedir cirurgia.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: o refratário após 6–12 meses de tratamento bem feito, que pode ter indicação de cirurgia (liberação/desbridamento, eletiva, rara) — cirurgião pela regulação; compressão do ulnar com déficit (eletroneuromiografia e descompressão — cirurgia da mão/nervo periférico); ondas de choque e PRP se o serviço de referência oferece.

Atestado	0 com restrição (sem preensão forçada por 2–4 semanas); 7–14 dias no braçal em fase aguda intensa.
Retorno	6 semanas.

DICAS

- Dor lateral do cotovelo que não melhora em 6 meses: pense em plica, instabilidade posterolateral ou compressão do radial (síndrome do túnel radial) antes de repetir corticoide.

Baseado em: AAOS OrthoInfo — Tennis elbow; Cochrane — Interventions for lateral elbow pain; Coombes et al., Lancet 2010 (corticoide piora a longo prazo).

5.2 Síndrome do túnel do carpo

CID G56.0 · **Também** formigamento na mão, dormência nos dedos, mão dormente à noite, túnel do carpo, nervo mediano, acordo com a mão dormente

> Dormência noturna no polegar, indicador e médio que alivia sacudindo a mão: túnel do carpo — órtese noturna e infiltração resolvem a maioria; atrofia da eminência tenar é cirurgia.

O QUE PERGUNTAR

- Quais dedos (polegar ao lado radial do anular = mediano; mínimo = ulnar; mão inteira ou braço = cervical)? Acorda à noite e sacode a mão?
- Derruba objetos, dificuldade de abotoar? (déficit motor). Gestante, hipotireoidismo, diabetes, artrite reumatoide, trabalho vibratório?
- Dor no pescoço irradiando? (radiculopatia C6 imita).

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Inspeção da eminência tenar	Comparar o volume do músculo na base do polegar com o outro lado; testar abdução do polegar contra resistência.	Atrofia ou fraqueza → grave: cirurgia, não espere.
Phalen	Flexão máxima dos punhos, dorsos encostados, 60 segundos.	Dormência nos dedos do mediano.
Tinel	Percutir o nervo mediano na face volar do punho.	Choque para os dedos.
Durkan (compressão do carpo)	Comprimir com o polegar sobre o túnel por 30 segundos.	Dormência — o mais sensível dos três.
Sensibilidade e cervical	Discriminação de dois pontos na polpa do indicador; Spurling e reflexos para excluir C6.	> 6 mm → perda sensitiva; Spurling positivo → considerar cervical.

SINAIS DE ALARME

- Atrofia tenar, fraqueza de abdução do polegar ou perda de sensibilidade constante: eletroneuromiografia e cirurgia em semanas (lesão axonal não volta).
- Início agudo após trauma ou fratura de punho com dor intensa: síndrome do túnel do carpo aguda — descompressão urgente.

IMAGEM

- Eletroneuromiografia: confirma e gradua; pedir quando vai infiltrar sem resposta, antes de cirurgia, ou em dúvida (cervical, polineuropatia do diabético). Ultrassom do nervo (área > 10 mm^2) é alternativa. Raio-X só se trauma ou artrose.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão (dormência noturna que chegou como "mão dormente, acho que é AVC"): exame dos dedos do mediano, Phalen/Tinel/Durkan, excluir cervical e AVC (déficit motor proximal, face, fala); órtese noturna (ou tala gessada de punho neutra se não há órtese), orientação e retorno no ambulatório em 6 semanas; sem AINE como tratamento.

- Fratura de punho com dormência progressiva no mediano: túnel do carpo agudo — reduza a fratura, tala sem flexão do punho e, se não melhora em horas, descompressão urgente.

CONDUTA

- Órtese de punho em posição neutra (0–10° de extensão) para dormir, por 6 semanas — 1ª linha. Durante o dia, se a atividade provoca.
- Ajuste ergonômico: punho reto ao digitar, pausas, evitar vibração.
- Infiltração de corticoide no túnel (metilprednisolona 40 mg): alívio em 70–80% por meses; boa ponte na gestante e no caso leve-moderado. Repetir no máximo uma vez.
- Tratar hipotireoidismo e diabetes. Vitamina B6 e diuréticos não têm evidência.
- Cirurgia (liberação do ligamento transverso, aberta ou endoscópica): sintomas constantes, déficit, falha de 3–6 meses de conservador — resultado excelente e rápido.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.

IMOBILIZAÇÃO

- Órtese (munhequeira rígida) de punho neutra, à noite por 6 semanas.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 6 semanas com a órtese: melhorou → mantém à noite por mais 6–12 semanas; não melhorou → infiltração (ver Punção e infiltração), retorno em 2–4 semanas; falha → eletroneuromiografia pela regulação e a indicação cirúrgica é sua.
- Atrofia tenar ou perda sensitiva constante na primeira consulta: não gaste 6 meses com órtese — eletroneuromiografia e cirurgia em semanas.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a liberação cirúrgica do ligamento transverso — você indica (atrofia tenar, déficit sensitivo constante, eletroneuromiografia moderada a grave, falha de 3–6 meses de órtese e infiltração) e pede pela regulação (cirurgia da mão ou ortopedista que opera, eletiva; em semanas se atrofia); túnel do carpo agudo após fratura de punho (descompressão urgente, cirurgia da mão hoje).

Atestado	0–7 dias com órtese; trabalho vibratório ou de força: restrição por 2–4 semanas.
Retorno	6 semanas com a órtese; 2 semanas após infiltração.

DICAS

- AINE não trata túnel do carpo. Se a receita tiver só anti-inflamatório, o paciente volta igual.
- Na gestante, costuma sumir após o parto: órtese e paciência.

Baseado em: AAOS CPG — Carpal tunnel syndrome 2016; Cochrane — Splinting / Local corticosteroid injection for CTS; NICE CKS — Carpal tunnel syndrome.

5.3 Tenossinovite de De Quervain

CID M65.4 · **Também** dor no punho perto do polegar, tendinite do polegar, De Quervain, dor ao pegar o bebê, tendinite de mãe

> Dor na borda radial do punho ao mover o polegar, Finkelstein positivo: inflamação dos tendões do 1º compartimento — órtese com polegar e infiltração.

O QUE PERGUNTAR

- Puérpera ou carrega bebê (pegar com o polegar aberto)? Trabalho repetitivo com o polegar (celular, costura)?
- Dor na base do polegar que piora ao abrir pote (rizartrose, em > 50 anos)? Trauma com queda sobre a mão (escafoide)?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Palpação do 1º compartimento	Dor e às vezes espessamento sobre o estiloide radial, 1–2 cm proximal à tabaqueira.	Dor localizada no estiloide.
Finkelstein (Eichhoff)	Polegar dentro do punho fechado, desvio ulnar passivo do punho.	Dor aguda no estiloide radial → De Quervain.
Tabaqueira anatômica e CMC do polegar	Palpar a tabaqueira (escafoide) e fazer o grind test (compressão com rotação da base do polegar).	Dor na tabaqueira após trauma → escafoide; grind doloroso → rizartrose.

SINAIS DE ALARME

- Trauma recente com dor na tabaqueira: raio-X série de escafoide e imobilizar até prova em contrário (ver fratura de escafoide).

IMAGEM

- Não precisa na apresentação típica. RX de punho PA, perfil e série do escafoide se trauma ou > 50 anos (rizartrose). Ultrassom confirma em dúvida.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: Finkelstein, excluir escafoide (tabaqueira) e rizartrose; órtese spica (ou tala gessada com polegar), AINE tópico, orientação do gesto; infiltração já no primeiro atendimento quando a dor é incapacitante ou na lactante; retorno no ambulatório em 4 semanas.

CONDUTA

- Órtese de punho com polegar (spica) por 3–4 semanas, dia e noite, depois ao esforço.
- Modificar o gesto: levantar o bebê com antebraços, não com os polegares; gelo 15 min após esforço; AINE tópico ou oral 7–10 dias.
- Infiltração de corticoide no compartimento (triancinolona 10–20 mg): cura em 80% com uma aplicação — melhor do que órtese sozinha; você faz (ver Punção e infiltração), já na primeira consulta na lactante.
- Cirurgia (abertura do compartimento) nos refratários após 2 infiltrações.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado

Diclofenaco dietilamônio gel 11,6 mg/g	Camada fina na borda do punho, 3 a 4× ao dia, por 14 dias.	—
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.

IMOBILIZAÇÃO

- Órtese spica de polegar (imobiliza punho e polegar, deixa a interfalângica livre) por 3–4 semanas.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 4 semanas: melhorou → desmame da órtese; não → infiltração (se ainda não fez), retorno em 4–6 semanas; segunda infiltração após 6 semanas se recidivou; falha de duas → cirurgia.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a abertura cirúrgica do 1º compartimento após falha de 2 infiltrações (cirurgia da mão, eletiva pela regulação).

Atestado	0–7 dias; restrição de preensão por 3 semanas.
Retorno	4 semanas.

DICAS

- Na lactante, a infiltração de corticoide local é segura e evita meses de dor.

Baseado em: Cochrane — De Quervain treatments; ASSH — De Quervain tenosynovitis; NICE CKS.

5.4 Dedo em gatilho

CID M65.3 · **Também** dedo travando, dedo que trava e estala, tenossinovite estenosante, dedo preso

> Dedo que trava em flexão e destrava com estalo, nódulo doloroso na palma na base do dedo: polia A1 — infiltração resolve a maioria.

O QUE PERGUNTAR

- Qual dedo, trava de manhã, precisa da outra mão para soltar? Diabetes (pior resposta, vários dedos)? Artrite reumatoide?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Palpação da polia A1	Nódulo doloroso na palma sobre a cabeça do metacarpo; sentir o ressalto ao flexionar e estender.	Nódulo + ressalto → dedo em gatilho. Graduar: dor sem travar / trava e destrava ativo / precisa da outra mão / preso em flexão.

SINAIS DE ALARME

- Dedo preso em flexão que não destrava (contratura fixa), ou em criança (polegar em gatilho congênito): cirurgia da mão.
- Dedo quente, com edema fusiforme, dor ao estender passivamente e trajeto doloroso: tenossinovite infecciosa (Kanavel) — urgência.

IMAGEM

- Nenhum. Raio-X só se artrite ou trauma.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: diagnóstico pela palpação da polia A1 e pelo ressalto; infiltração de corticoide na bainha (ver Punção e infiltração) no mesmo atendimento — resolve 60–90%; alta com retorno em 6 semanas. Dedo quente, fusiforme e com dor ao estender é tenossinovite infecciosa: cirurgia hoje, não infiltração.

CONDUTA

- Infiltração de corticoide na bainha, junto à polia A1 (triancinolona 10 mg + lidocaína): resolve 60–90%; segunda após 6 semanas se recidivar.
- Órtese noturna da metacarpofalângica em extensão por 6 semanas é alternativa nos leves.
- Evitar preensão repetitiva e ferramentas com pressão na palma.
- Cirurgia (liberação da polia A1, 15 minutos sob anestesia local): após falha de 2 infiltrações, diabético com vários dedos, ou dedo preso.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—

Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.

IMOBILIZAÇÃO

- Órtese de bloqueio da metacarpofalângica à noite (opcional).

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 6 semanas: resolvido → alta; travando de novo → segunda infiltração; falha de duas, ou dedo preso → cirurgia pela regulação. Diabético: avise da glicemia por 2–3 dias após cada infiltração.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a liberação da polia A1 (15 minutos sob anestesia local — cirurgia da mão ou ortopedista que opera, eletiva pela regulação) após falha de 2 infiltrações, no dedo preso em flexão, no diabético com vários dedos e no polegar em gatilho congênito da criança.

Atestado	0.
Retorno	6 semanas após a infiltração.

DICAS

- No diabético, avise que a glicemia sobe por 2–3 dias após a infiltração.

Baseado em: ASSH — Trigger finger; Cochrane — Corticosteroid injection for trigger finger.

5.5 Fratura do rádio distal (Colles)

CID S52.5 · **Também** quebrou o punho, fratura de punho, Colles, caiu com a mão espalmada, punho em dorso de garfo

> Queda sobre a mão espalmada com dor, edema e deformidade do punho: raio-X, redução com bloqueio de hematoma se desviada, tala e controle em 7 dias — tudo seu; placa para a que não segura ou é articular — e na idosa, tratar a osteoporose.

O QUE PERGUNTAR

- Como caiu? Mão dominante? Dormência nos dedos (mediano)? Idade e osteoporose? Expectativa funcional (trabalho manual, instrumentista)?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Deformidade e pele	Dorso de garfo (desvio dorsal); conferir pele íntegra.	Ferida sobre a fratura → exposta: urgência.
Neurovascular	Sensibilidade da polpa do indicador (mediano), mínimo (ulnar), pulso radial, enchimento capilar, movimento dos dedos.	Dormência progressiva no mediano → síndrome do túnel do carpo aguda: reduzir e descomprimir.
Cotovelo e ombro	Palpar cabeça do rádio e clavícula; mover ombro.	Lesões associadas na mesma queda.

SINAIS DE ALARME

- Fratura exposta (antibiótico, lavagem, cirurgia em 24 h), dormência progressiva no mediano (reduza já; sem melhora em horas, descompressão), pele em sofrimento ou pulso ausente: redução agora, por você.
- Fratura com desvio em paciente ativo: redução hoje e, se não segura ou é articular com degrau, cirurgia (placa) em 2–7 dias pela regulação; depois disso, consolida torto.

IMAGEM

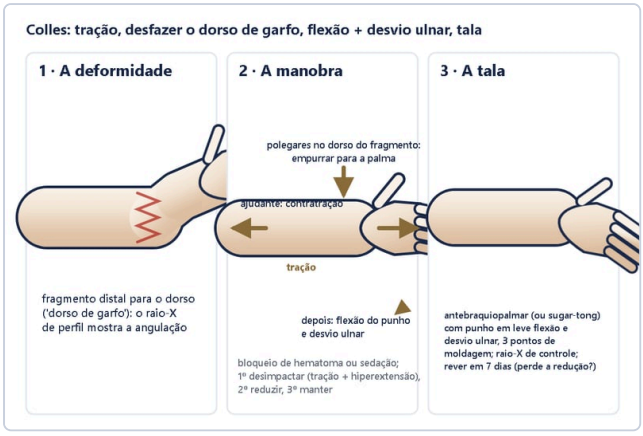
- RX de punho PA e perfil ("queda sobre a mão — fratura do rádio distal?"). Meça você: inclinação dorsal (normal: 11° volar), inclinação radial (22°), variância ulnar (encurtamento), degrau articular. Tomografia se articular complexa (pré-operatório).
- Raio-X depois da redução, com a tala, e controle em 7–10 dias (desvio secundário é comum na 1ª e 2ª semanas).

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

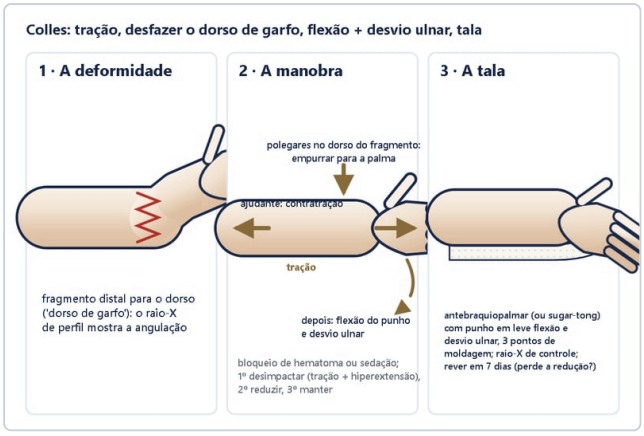
- Sem desvio (ou dentro dos critérios): tala antebraquiopalmar, analgesia, alta com retorno em 7 dias com raio-X; no idoso, já peça a densitometria e inicie vitamina D.
- Desviada: bloqueio de hematoma, redução (ver procedimento), tala bem moldada (antebraquiopalmar ou "sugar-tong" se instável), raio-X de controle; alcançou os critérios → alta com retorno em 7 dias; não alcançou ou cominuta/articular → tala e pedido de cirurgia pela regulação (2–7 dias), alta se a dor permite.
- Criança: ver Fraturas na criança (remodela; critérios diferentes). Fratura de Smith (desvio volar) e Barton (articular com luxação): reduza, mas a maioria é cirúrgica — peça a vaga.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

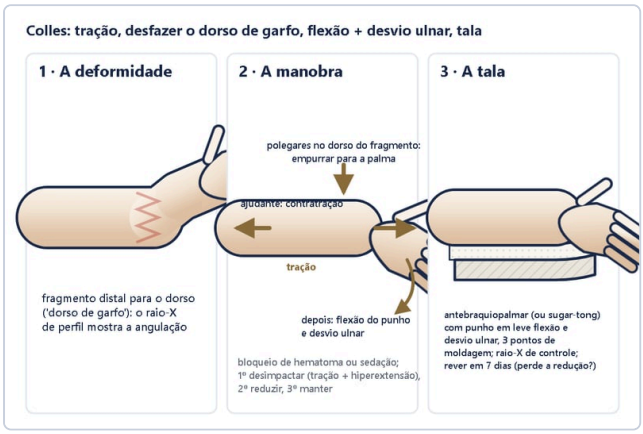
Redução fechada do rádio distal (Colles) e tala



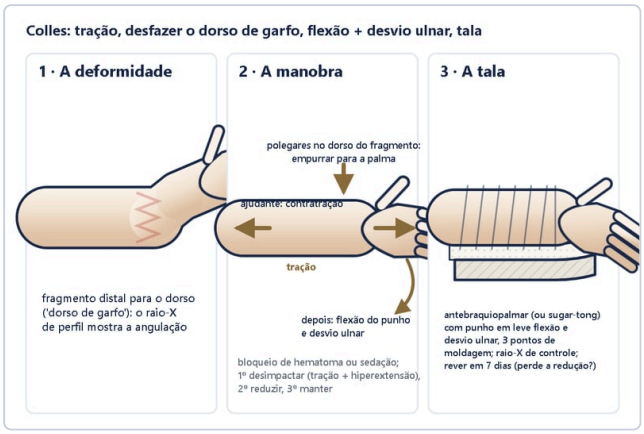
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Desvio dorsal além dos critérios, fechada, < 48 h. Bloqueio de hematoma feito (ver Anestesia local).

Material e anestesia: Bloqueio de hematoma (lidocaína 1% 10–15 mL), 1 ajudante ou tração com dedeiras (finger traps) e peso de 3–5 kg no braço, material de tala (gesso 10 cm).

Passo a passo

1. Tração longitudinal por 5–10 minutos (ajudante no braço com o cotovelo a 90°, você nos dedos; ou dedeiras com peso) — desimpacta os fragmentos e cansa a musculatura.
2. Reproduza o desvio (hiperextensão leve) para destravar, então flexione o punho e desvie para ulnar enquanto o seu polegar empurra o fragmento distal de dorsal para volar e distal; sinta o encaixe.
3. Mantenha o punho em leve flexão (≤ 15°; mais que isso comprime o mediano) e desvio ulnar enquanto o ajudante aplica a tala: antebraquiopalmar moldada em três pontos (dorsal sobre o fragmento, volar proximal e distal), ou "sugar-tong" (tala em U do dorso da mão, em volta do cotovelo, à palma) se instável ou com fratura da ulna.
4. Raio-X com a tala: confira inclinação, encurtamento e degrau; não ficou → reduza de novo agora (uma segunda tentativa), ou aceite e peça a cirurgia.

Depois: Neurovascular (mediano!); orientação escrita; dedos e ombro em movimento desde hoje; retorno em 7 dias com raio-X.

CONDUTA

- Tala gessada antebraquiopalmar (ou órtese rígida) em posição neutra, com os dedos livres, elevar o braço, gelo, mover dedos e ombro.
- Critérios aceitáveis após a redução: inclinação dorsal ≤ 10° (neutra a 10°), inclinação radial > 15°, encurtamento < 3 mm, degrau articular < 2 mm — fora disso, ou se perdeu a redução no controle, placa volar (cirurgia pela regulação em 2–7 dias). No idoso de baixa demanda, aceita-se mais desvio: função boa mesmo com punho torto.
- Gesso circular (na troca de 5–7 dias) por 5–6 semanas no total, raio-X em 1, 2 e 6 semanas; fisioterapia depois para punho e dedos.
- Osteoporose: fratura de punho após os 50 anos → densitometria, vitamina D e tratamento (ver fratura vertebral).
- Prevenção de queda em idoso.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Tramadol 50 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 3 a 5 dias, só se a dor não ceder com o resto.	Lista A2 da Portaria 344 (tarja preta): até 100 mg por unidade sai em receita de controle especial em duas vias, não na notificação A. Náusea e tontura são comuns; cuidado em idoso, epilepsia e com antidepressivo (serotonina).

IMOBILIZAÇÃO

- Tala gessada antebraquiopalmar (do terço proximal do antebraço à prega palmar, dedos livres), com o aviso escrito dos sinais de aperto.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 7–10 dias com raio-X: manteve → troca por gesso circular bem moldado (ou órtese rígida), raio-X em 2 semanas e em 6; perdeu → nova redução se < 2 semanas ou cirurgia (placa).
- 6 semanas: tira o gesso, raio-X, fisioterapia de punho e dedos; força e amplitude voltam em 3–6 meses. Dor no lado ulnar persistente: fibrocartilagem triangular ou estiloide ulnar — na maioria, tempo.
- Osteoporose: densitometria, cálcio, vitamina D e bisfosfonato iniciados por você — esta fratura é o aviso da de quadril.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a fixação (placa volar ou fios) quando a redução não alcança os critérios, perde-se no controle, é articular com degrau > 2 mm, cominuta ou em paciente jovem/ativo com desvio — cirurgia pela regulação em 2–7 dias; exposta (24 h), túnel do carpo agudo que não melhora com a redução (descompressão hoje), lesão vascular (vascular).

Atestado	4–6 semanas para mão dominante no trabalho manual; 2–3 semanas no escritório com órtese, conforme a dor.
Retorno	7–10 dias com raio-X de controle (troca por gesso circular), 2 semanas e 6 semanas; operada, conforme o cirurgião e depois com você.

DICAS

- Dor no punho com raio-X normal após queda sobre a mão: palpe a tabaqueira — é escafoide até prova em contrário (próximo tópico).

Baseado em: AAOS CPG — Distal radius fractures 2020; BOAST / BSSH — Distal radius; NICE NG38.

5.6 Fratura de escafoide (suspeita)

CID S62.0 · **Também** dor na tabaqueira, escafoide, dor no punho após queda com raio-X normal, fratura oculta do punho

> Dor na tabaqueira anatômica após queda com raio-X normal é fratura de escafoide até prova em contrário: imobilizar com o polegar e repetir imagem em 10 a 14 dias — a não união custa o punho.

O QUE PERGUNTAR

- Queda sobre a mão espalmada com o punho estendido? Quanto tempo faz? Dor ao pinçar e ao apoiar na mão?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Tabaqueira anatômica	Palpar entre os tendões do extensor longo e do abdutor longo do polegar, com desvio ulnar.	Dor → suspeita (sensível, pouco específica).
Tubérculo do escafoide	Palpar na face volar, base da eminência tenar.	Dor volar aumenta a especificidade.
Compressão axial do polegar	Empurrar o polegar no eixo em direção ao escafoide.	Dor → suspeita.

SINAIS DE ALARME

- Os três sinais positivos: trate como fratura mesmo com raio-X normal.
- Fratura com desvio > 1 mm, do polo proximal ou com mais de 3–4 semanas: cirurgia (parafuso) — tendência a não união e necrose; peça a vaga sem esperar o gesso "funcionar".

IMAGEM

- RX de punho PA, perfil, oblíqua e série do escafoide (PA com desvio ulnar e punho fechado). 20% das fraturas não aparecem no primeiro exame.
- Raio-X normal com clínica: imobilizar e repetir em 10–14 dias; ou ressonância (ideal, define em 1 consulta) ou tomografia, se disponível.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Suspeita (tabaqueira dolorosa, raio-X normal): tala ou gesso antebraquiopalmar com polegar, analgesia, alta com a segunda imagem marcada em 10–14 dias (raio-X série do escafoide; ressonância se o serviço tem — define no mesmo dia).
- Fratura confirmada sem desvio (cintura ou distal): gesso de escafoide (antebraquiopalmar com polegar) por 6–10 semanas — sua; proximal, desviada ou tardia: tala e pedido de cirurgia.

CONDUTA

- Imobilização gessada antebraquiopalmar com o polegar incluído (gesso de escafoide) até o resultado da segunda imagem.
- Fratura confirmada sem desvio (cintura ou distal): gesso por 6–10 semanas, controle radiográfico; tomografia ao final para confirmar consolidação.
- Fratura do polo proximal, desviada ou tardia: parafuso (cirurgia) — cirurgião da mão ou ortopedista que opera, pela regulação, em 1–2 semanas.
- Não liberar para esporte ou carga sem consolidação comprovada.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.

IMOBILIZAÇÃO

- Tala ou gesso antebraquiopalmar com polegar (spica) até a segunda imagem; depois conforme o diagnóstico.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 10–14 dias: segunda imagem; negativa com dor que sumiu → tira; positiva → gesso 6–10 semanas com raio-X a cada 3–4 semanas; tomografia ao final para confirmar a consolidação antes de liberar carga e esporte.
- Dor persistente após 10 semanas ou traço visível: não união → tomografia e cirurgia (parafuso e enxerto).

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a fixação com parafuso (polo proximal, desvio > 1 mm, diagnóstico tardio > 3–4 semanas, atleta ou trabalhador que não pode 10 semanas de gesso) — cirurgia da mão/ortopedista que opera, pela regulação em 1–2 semanas; não união estabelecida (enxerto, eletivo); ressonância/tomografia que o serviço não tem (regulação com a pergunta escrita).

Atestado	Suspeita: 7–14 dias com a órtese; fratura confirmada: 6–10 semanas em trabalho manual.
Retorno	10–14 dias para a segunda imagem, sem falta.

DICAS

- Quando o paciente liga dizendo que o raio-X deu normal e quer tirar o gesso: não tire pelo telefone.

Baseado em: BSSH — Scaphoid fracture guideline; NICE NG38 (scaphoid imaging: MRI first-line); AAOS OrthoInfo.

5.7 Rizartrose (artrose da base do polegar)

CID M18 · **Também** dor na base do polegar, artrose do polegar, dor para abrir pote, dor ao pinçar

> Dor na base do polegar ao pinçar e abrir frascos, em mulher > 50 anos, com grind test positivo: artrose carpometacarpal — órtese e infiltração.

O QUE PERGUNTAR

- Dor ao abrir pote, virar chave, escrever? Quanto tempo? Deformidade (base do polegar "saliente")?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Grind test	Segurar o metacarpo do polegar e fazer compressão axial com rotação.	Dor e crepitação → rizartrose.
Inspeção	Proeminência da base do polegar (subluxação), adução do metacarpo.	Deformidade em "ombro" → avançada.
Diferenciar	Finkelstein (De Quervain), tabaqueira (escafoide), Phalen (túnel do carpo).	Positivo em outra → coexistência é comum.

SINAIS DE ALARME

- Dor aguda com trauma: fratura de Bennett (base do 1º metacarpo) — raio-X.

IMAGEM

- RX de mão PA e oblíqua, com incidência de Robert (AP do polegar em pronação): estadia a artrose (Eaton). O grau radiográfico não acompanha a dor.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão (dor na base do polegar "que travou"): raio-X com Robert se trauma (Bennett?) ou se nunca fez; sem fratura, órtese spica curta (ou tala gessada curta com polegar), AINE tópico, orientação, retorno no ambulatório em 6–8 semanas; infiltração da CMC já na primeira consulta se a dor é incapacitante.

CONDUTA

- Órtese de polegar (spica curta, deixa o punho livre) à noite e nas atividades de pinça, 3–4 semanas; depois conforme necessidade.
- Adaptações: abridor de pote, canetas grossas, evitar pinça forte. Exercícios de estabilização da CMC com terapeuta da mão.
- AINE tópico; oral em crises curtas.
- Infiltração de corticoide na CMC: alívio por meses, até 2–3 por ano.
- Cirurgia (trapeziectomia com ou sem ligamentoplastia) quando a dor limita apesar de tudo: resultado bom, recuperação de 3 meses.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado

Diclofenaco dietilamônio gel 11,6 mg/g	Camada fina na base do polegar, 3 a 4× ao dia, por 14 dias, repetindo nas crises.	—
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).

IMOBILIZAÇÃO

- Órtese spica curta de polegar nas atividades e à noite.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 6–8 semanas: adaptações e exercícios de estabilização com terapeuta da mão; infiltração da CMC (até 2–3 por ano) nas crises; falha de 3–6 meses → indicação cirúrgica é sua, pela regulação.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a trapeziectomia (com ou sem ligamentoplastia) ou a artrodese quando a dor limita apesar de 3–6 meses de órtese e infiltração — cirurgia da mão, eletiva pela regulação; fratura de Bennett (base do 1º metacarpo) após trauma (cirurgia em dias).

Atestado	0 com restrição de pinça forte.
Retorno	6–8 semanas.

DICAS

- Rizartrose e túnel do carpo andam juntos na mulher após a menopausa — examine as duas coisas.

Baseado em: ASSH — Thumb CMC arthritis; Cochrane — Hand osteoarthritis; EULAR 2018 — Hand OA.

CAPÍTULO 6

Cotovelo, mão e dedos: trauma

Reduzir, imobilizar na posição certa e devolver o movimento cedo — a mão que fica rígida por 4 semanas de tala mal posta é pior que a fratura.

6.1	**Luxação de cotovelo e fratura da cabeça do rádio** Cotovelo deformado após queda é luxação posterior: raio-X, sedação e redução por tração — sua, hoje; cotovelo inchado que não estende com raio-X "normal" é fratura da cabeça do rádio: tipoia 2 dias e mover, também sua.	118
6.2	**Fraturas de metacarpo e falanges (soco e esmagamento)** A fratura do colo do 5º metacarpo (soco) aceita até 40–70° de angulação se não há rotação: redução se precisar, tala em calha ulnar 3–4 semanas e movimento — é sua; o que opera é a rotação, a articulação desviada, as múltiplas e o polegar (Bennett).	122
6.3	**Dedo luxado, dedo em martelo e lesões de tendão** A luxação dorsal da interfalângica proximal reduz com bloqueio digital e tração e volta a mexer com buddy taping; o dedo em martelo é 6–8 semanas de tala em extensão sem nunca dobrar; o dedo que não flete a ponta (jersey) é cirurgia em 7–10 dias — e o seu papel é não perder o prazo.	127
6.4	**Ferimentos da mão, unha e ponta do dedo** A ponta do dedo esmagada, a unha arrancada e o hematoma subungueal são seus: bloqueio digital, lavagem, drenar o hematoma, reparar o leito ungueal e devolver a unha como curativo; o que vai à cirurgia da mão é o tendão flexor, o nervo, a amputação com osso exposto e a mordedura profunda.	132

6.1 Luxação de cotovelo e fratura da cabeça do rádio

CID S53.1 / S52.1 · **Também** cotovelo saiu do lugar, luxação do cotovelo, cabeça do rádio, caiu com a mão espalmada e o cotovelo inchou, Mason, cotovelo travado após queda, tríade terrível

> Cotovelo deformado após queda é luxação posterior: raio-X, sedação e redução por tração — sua, hoje; cotovelo inchado que não estende com raio-X "normal" é fratura da cabeça do rádio: tipoia 2 dias e mover, também sua.

O QUE PERGUNTAR

- Queda sobre a mão com o cotovelo estendido? Dormência no 4º–5º dedos (ulnar) ou fraqueza para fazer "OK" (interósseo anterior)? Hora da luxação?
- Já luxou antes (instabilidade recorrente)? Dominância, profissão.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Inspeção e triângulo	Olécrano proeminente atrás, antebraço parece curto, cotovelo semifletido; o triângulo olécrano–epicôndilos perdido (na fratura supracondiliana está preservado).	Deformidade → luxação; não force a mobilidade.
Neurovascular antes e depois	Pulso radial, enchimento capilar; mediano (OK sign, sensibilidade do indicador), ulnar (abduzir dedos, mínimo), radial (extensão do punho e polegar).	Pulso ausente → reduza já; se não volta, vascular.
Cabeça do rádio	Dor na face lateral ao pronar e supinar; bloqueio mecânico à prono-supinação ou à extensão (teste após aspirar a hemartrose e infiltrar lidocaína).	Bloqueio mecânico verdadeiro → fragmento interposto: cirurgia.

SINAIS DE ALARME

- Luxação com fratura da cabeça do rádio e do coronoide (tríade terrível): instável, cirurgia — reduza, imobilize a 90° e peça a vaga.
- Pulso ausente após a redução, ou hematoma em expansão: artéria braquial — vascular hoje.
- Síndrome compartimental do antebraço nas 24–48 h: dor desproporcional ao estender os dedos.
- Luxação aberta ou irredutível (interposição): cirurgia hoje.

IMAGEM

- RX de cotovelo AP e perfil antes (fratura associada: coronoide, cabeça do rádio, epicôndilo medial) e depois da redução (congruente? fragmento na articulação?). Sinal do coxim gorduroso posterior no perfil = fratura oculta (cabeça do rádio no adulto). Tomografia se fratura associada ou bloqueio.

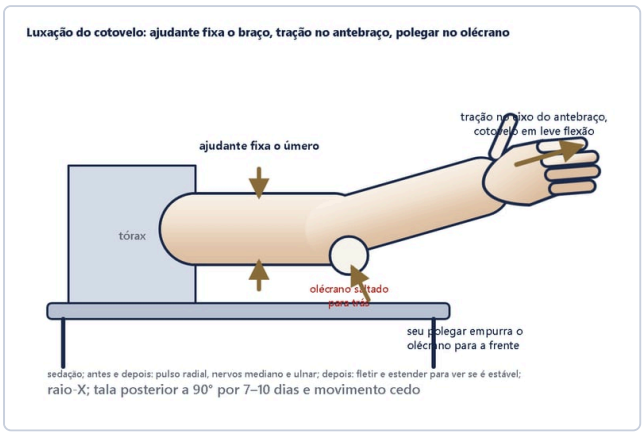
NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Luxação posterior simples: analgesia, raio-X, sedação (ou bloqueio intra-articular com lidocaína 1% 10 mL pelo triângulo lateral), redução por tração (ver procedimento), teste de estabilidade, tala posterior a 90° em pronação neutra, raio-X de controle; alta com retorno em 5–7 dias. Internação só se instável ou neurovascular alterado.
- Cabeça do rádio Mason I (sem desvio ou < 2 mm): aspire a hemartrose e infiltre lidocaína se dói muito, tipoia por 2–3 dias e mobilização ativa imediata (flexão-extensão, prono-supinação) — sem gesso. Mason II (desvio > 2 mm, 1 fragmento) sem bloqueio: mesmo tratamento, discutindo cirurgia se > 30% da cabeça ou bloqueio; Mason III (cominuta) e IV (com luxação): cirurgia.

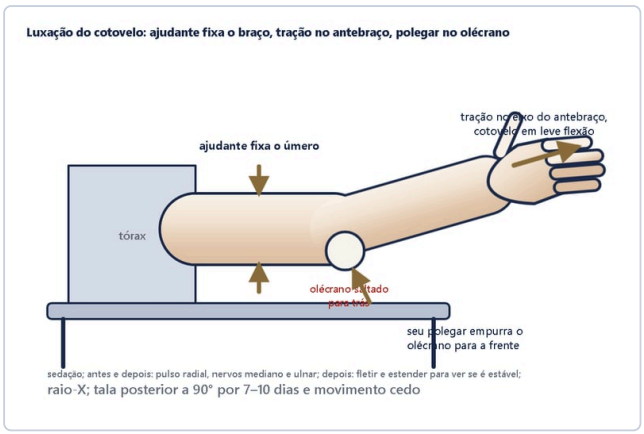
- Luxação com fratura (tríade, coronoide, olécrano): reduza, tala a 90°, tomografia, regulação em dias (não é horas se reduzida e perfundida).

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

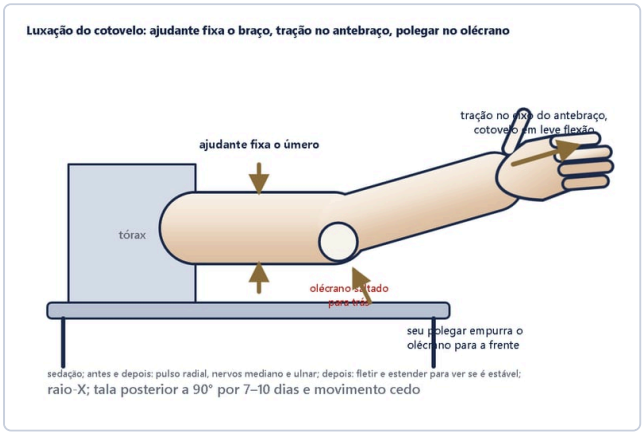
Redução da luxação posterior do cotovelo



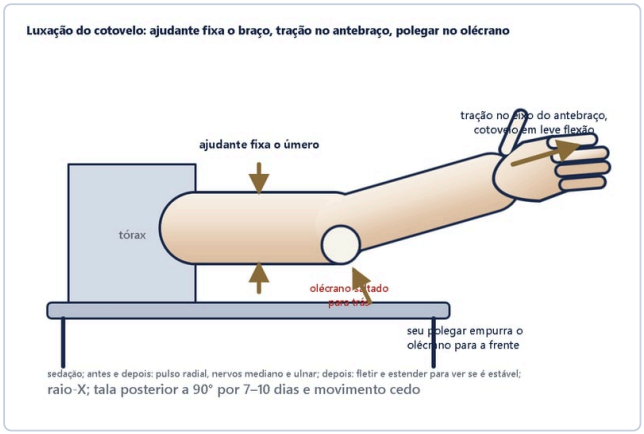
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Luxação posterior ou posterolateral, raio-X feito, sedação ou bloqueio intra-articular. Pare se não reduz em 2 tentativas.

Material e anestesia: Sedação monitorizada (cetamina/propofol) ou lidocaína intra-articular; 1 ajudante.

Passo a passo

1. Paciente deitado, ajudante segura o braço (úmero) firme; você segura o punho e o antebraço.
2. Cotovelo em leve flexão (20–30°): tração longitudinal no eixo do antebraço, contínua, 1–2 minutos; corrija o desvio lateral/medial com a outra mão.
3. Mantendo a tração, flexione o cotovelo devagar enquanto o polegar empurra o olécrano para a frente (sobre a ponta); o “clunk” é a redução.
4. Alternativa (prono, técnica de Parvin): paciente de bruços com o braço pendente, peso ou tração no punho para baixo, e o polegar guia o olécrano.
5. Teste a estabilidade: flexão-extensão completa suave; se reluxa antes de 30° de extensão, é instável (tala a 90° e cirurgião).

Depois: Neurovascular; raio-X AP e perfil (congruência, fragmentos); tala posterior a 90°, pronação neutra, 5–7 dias; tipoia.

CONDUTA

- Luxação simples: tala 5–7 dias (não mais: rigidez), depois tipoia e movimento ativo (flexão-extensão) várias vezes ao dia, evitando estender além de 30° nas primeiras 2–3 semanas se instável; órtese articulada com bloqueio de extensão se disponível; sem carga e sem esporte por 6 semanas; a perda de 10–15° de extensão é comum e não é falha.
- Cabeça do rádio Mason I–II: movimento desde o 1º–3º dia é o tratamento; dor até 6 semanas; raio-X em 2 semanas; rigidez é a complicação de quem imobiliza.
- Calcificação heterotópica (cotovelo que endurece após 3–4 semanas): indometacina 25 mg 3×/dia por 3–4 semanas pode ser usada na alta energia — discuta com o cirurgião; não massagear forçado.
- Fisioterapia de ganho de amplitude a partir da 2ª semana; alongamento ativo, não passivo forçado.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).

IMOBILIZAÇÃO

- Tala gessada posterior a 90° com pronação neutra por 5–7 dias (luxação) ou tipoia por 2–3 dias (cabeça do rádio); depois tipoia e movimento.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- 5–7 dias: retire a tala, raio-X (ainda reduzido?), comece a mobilização; 3 semanas: raio-X e amplitude; 6 semanas: liberar carga progressiva.
- Reluxação ou subluxação no raio-X de controle (sinal da gota no perfil): instável → cirurgião (reparo ligamentar).
- Rigidez > 30° de perda de extensão em 3 meses apesar de fisioterapia: cirurgião (liberação artroscópica), eletivo.
- Instabilidade posterolateral crônica (sensação de sair ao apoiar com o cotovelo estendido e supinado): ressonância e cirurgião, eletivo.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: luxação irredutível, aberta ou com lesão vascular (hoje); luxação com fratura instável — tríade terrível, coronoide, olécrano (cirurgia em dias); cabeça do rádio Mason III–IV ou com bloqueio mecânico (fixação ou prótese da cabeça, em dias); instabilidade ou rigidez crônica (eletivo).

Atestado	Luxação simples: 14–21 dias (escritório 7); cabeça do rádio: 7–14 dias; braçal: 6 semanas.
Retorno	5–7 dias (tala fora, raio-X), 3 semanas, 6 semanas.

DICAS

- Cotovelo luxado que reduziu "sozinho" no local do acidente ainda precisa do raio-X, do neurovascular e dos 5–7 dias de tala.
- Coxim gorduroso posterior com dor na cabeça do rádio é fratura, mesmo sem traço: trate como Mason I. Não peça tomografia, peça movimento.

Baseado em: AAOS OrthoInfo — Elbow dislocation; Radial head fractures; BESS — Elbow instability; Mason classification (1954) / Hotchkiss modification; Rockwood & Green — Elbow dislocations.

6.2 Fraturas de metacarpo e falanges (soco e esmagamento)

CID S62.3 / S62.6 / S62.2 · **Também** fratura do boxeador, deu um soco e quebrou a mão, fratura do 5º metacarpo, metacarpo, fratura de dedo, falange, dedo torto, Bennett

> A fratura do colo do 5º metacarpo (soco) aceita até 40–70° de angulação se não há rotação: redução se precisar, tala em calha ulnar 3–4 semanas e movimento — é sua; o que opera é a rotação, a articulação desviada, as múltiplas e o polegar (Bennett).

O QUE PERGUNTAR

- Soco (colo do 5º ou 4º), esmagamento (diáfise, múltiplas, esposta), queda (base), torção do dedo (falange, articular)? Ferida (fratura exposta — e a "mordida de dente" no soco)?
- Dominância, profissão, instrumentista ou trabalho fino (menor tolerância a desvio).

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Rotação (o exame que decide a cirurgia)	Peça para fletir os dedos devagar: todos devem apontar para o tubérculo do escafoide e nenhum cruza o vizinho; com os dedos semifletidos, compare o plano das unhas.	Dedo que cruza ou unha fora do plano → desvio rotacional: cirurgia, qualquer grau (5° de rotação = 1,5 cm de sobreposição na ponta).
Angulação e encurtamento	Perda da proeminência do nó (cabeça do metacarpo caída na palma), dedo encurtado, extensão da metacarpofalângica reduzida ("lag").	Angulação no perfil além do aceitável para o osso (ver imagem) ou lag de extensão > 20° → reduzir.
Pele, tendão e nervo	Ferida sobre o nó após soco (mordedura humana = ferida contaminada: "fight bite"), extensão ativa de cada dedo, sensibilidade das polpas.	Fight bite → lavagem, antibiótico, exploração do tendão e da articulação; não suturar.

SINAIS DE ALARME

- Ferida sobre a metacarpofalângica após soco: mordedura humana com inoculação na articulação — lavagem cirúrgica e antibiótico (amoxicilina-clavulanato), não fechar; artrite séptica em 48 h se ignorada.
- Esmagamento com múltiplas fraturas, dedos pálidos ou tensos: compartimental da mão — cirurgia hoje.
- Fratura do 1º metacarpo na base (Bennett, Rolando): quase sempre cirurgia — tala spica e cirurgião em dias.

IMAGEM

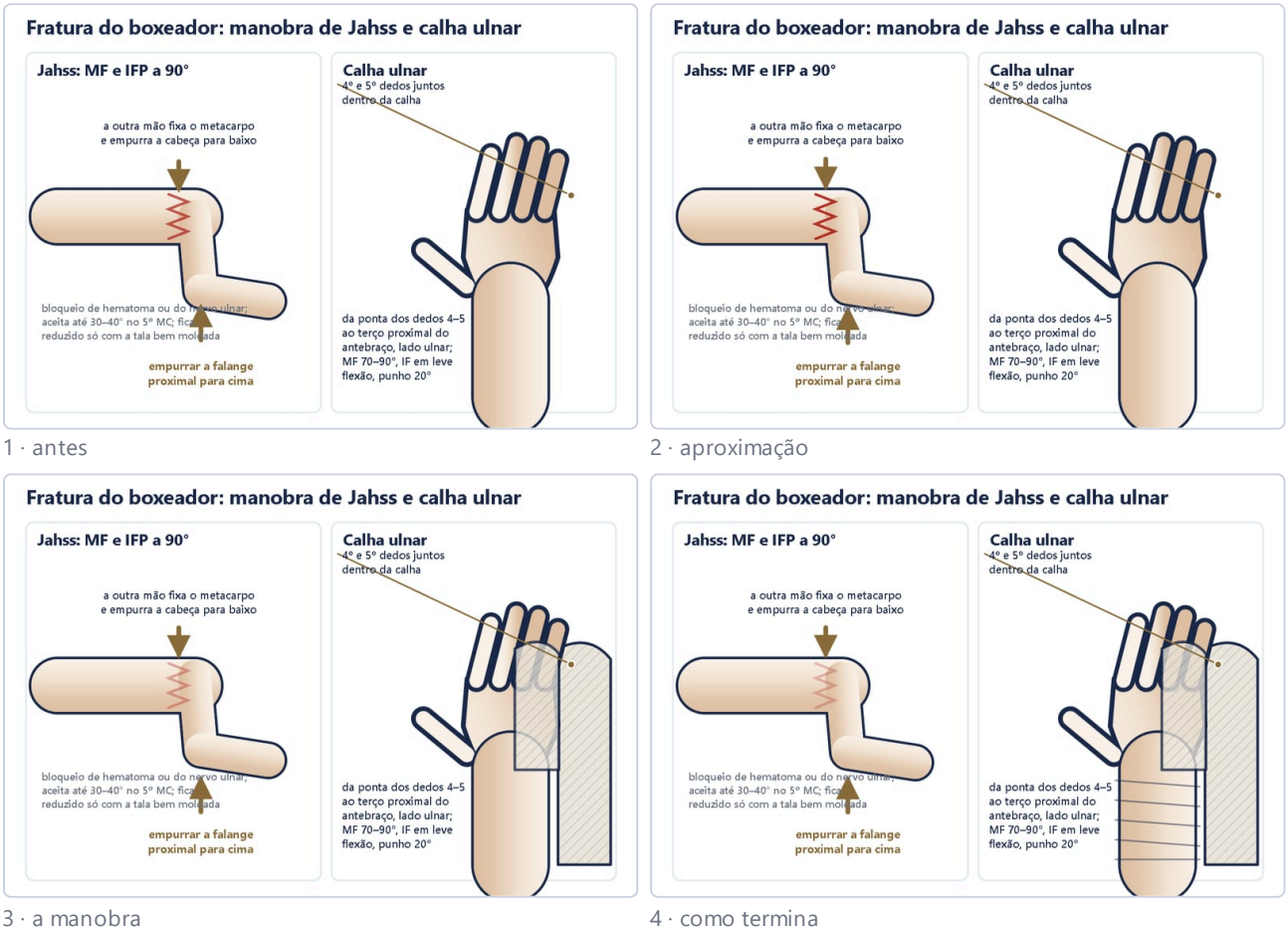
- RX de mão PA, oblíqua e perfil (dedo isolado: PA e perfil verdadeiro do dedo). Angulação aceitável no colo dos metacarpos (perfil): 5º até 40–70°, 4º até 30–40°, 3º até 10–15°, 2º até 10°; na diáfise: 5º 30°, 4º 20°, 3º–2º 10°; encurtamento até 5 mm; articular: degrau < 1–2 mm. Falange proximal: angulação aceitável < 10–15° e sem rotação.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- 5º metacarpo (colo) sem rotação, angulação aceitável: tala em calha ulnar (ou buddy taping e tala de punho nos muito estáveis) por 3–4 semanas, movimento dos dedos livres desde já, alta com raio-X em 7–10 dias. Com angulação além do aceitável ou lag de extensão: redução (Jahss, ver procedimento) com bloqueio de hematoma e a mesma tala; se não segura, cirurgião.
- Diáfise de metacarpo sem rotação, angulação e encurtamento aceitáveis: tala em calha (ulnar ou radial) 3–4 semanas, raio-X em 7–10 dias; rotação, encurtamento > 5 mm, múltiplas ou exposta: cirurgia em dias (fios ou placa).
- Falange sem desvio ou articular estável: buddy taping (dedo colado ao vizinho) 3 semanas com movimento; falange proximal angulada: redução com bloqueio digital e tala com a metacarpofalângica a 70–90° de flexão; articular desviada, rotação, condilar, instável: cirurgia da mão em dias.
- Exposta de falange distal (unha, esmagamento): lavagem, antibiótico oral, reparo da unha e tala — sua (ver Ferimentos da mão).

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

Redução da fratura do colo do 5º metacarpo — manobra de Jahss — e tala em calha ulnar



1 · antes

2 · aproximação

3 · a manobra

4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Angulação acima do aceitável ou lag de extensão; sem rotação. Não em fratura exposta.

Material e anestesia: Bloqueio de hematoma (lidocaína 1% 5 mL no foco, dorso da mão) ou bloqueio do nervo ulnar no punho; gesso 10 cm, algodão, crepe.

Passo a passo

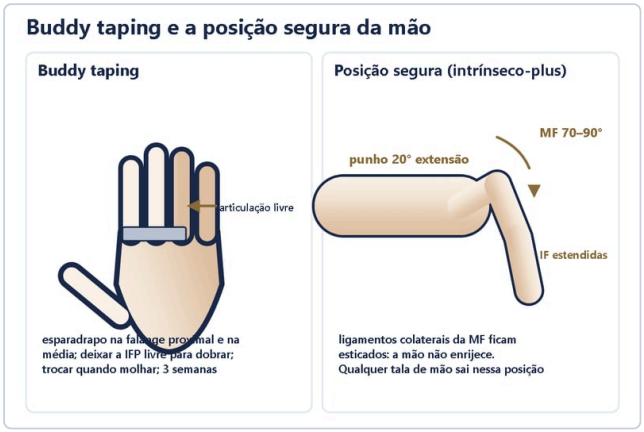
1. Espere o bloqueio (10 min). Flexione a metacarpofalângica e a interfalângica proximal a 90°.
2. Empurre a falange proximal para cima (dorsal) no eixo, enquanto o polegar da outra mão empurra o dorso do metacarpo (a diáfise) para baixo — a cabeça sobe.
3. Mantenha a redução enquanto o ajudante aplica a tala em calha ulnar: do terço proximal do antebraço, pelo bordo ulnar, até a ponta do 4º e 5º dedos, com o punho em 20–30° de extensão, a metacarpofalângica a 70–90° de flexão e as interfalângicas em extensão (posição intrínseco-plus). Molde o dorso sobre a cabeça do metacarpo.
4. Enfaixe sem apertar; dedos 2º e 3º livres para mover.

Depois: Raio-X com a tala; retorno em 7–10 dias com raio-X (perde-se parte da redução; o que importa é rotação zero e função). 3–4 semanas de tala, depois movimento e buddy taping.

Buddy taping (sindactilia) e a posição segura da mão



1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Falanges estáveis, entorses de dedo, pós-redução estável, e depois de qualquer tala para recuperar movimento.

Material e anestesia: Esparadrapo ou fita de 1–2 cm, gaze entre os dedos.

Passo a passo

1. Gaze fina entre os dedos (pele não encosta na pele); duas tiras, uma na falange proximal e outra na média, deixando as articulações livres para fletir.
2. O dedo lesado colado ao vizinho maior (4º com o 3º; 5º com o 4º; 2º com o 3º).
3. Troque a cada 2–3 dias ou se molhar; 3 semanas, movendo o tempo todo.

Depois: Toda tala de mão que precise ficar mais de alguns dias é em posição intrínseco-plus: punho 20–30° de extensão, metacarpofalângicas a 70–90°, interfalângicas retas — é a posição que não enrijece.

CONDUTA

- Movimento é o tratamento: os dedos que não estão na tala movem desde o 1º dia; o dedo fraturado começa a mover em 3 semanas (metacarpo) ou já no buddy taping (falange estável).
- Rigidez de interfalângica proximal após 3 semanas de tala mal posta (em extensão ou em flexão) é a sequela mais comum: por isso a posição intrínseco-plus.
- Consolidação clínica em 3–4 semanas (metacarpo e falange); o raio-X atrasa semanas — libere pela clínica (sem dor no foco).
- Elevação e gelo nas primeiras 48–72 h; edema de mão demora.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Cefalexina 500 mg	1 comprimido de 6/6 h por 5 a 7 dias.	Só na fratura exposta de falange distal (unha/esmagamento); na mordedura humana do soco, amoxicilina-clavulanato.
Amoxicilina + clavulanato 875/125 mg	1 comprimido de 12/12 h por 5 a 7 dias, começando no plantão.	Ferida sobre o nó após soco (mordedura humana). Alergia: clindamicina 300 mg 8/8 h + ciprofloxacino 500 mg 12/12 h.

IMOBILIZAÇÃO

- Metacarpo: tala em calha ulnar ou radial em intrínseco-plus 3–4 semanas. Falange: buddy taping 3 semanas, ou tala digital curta com a metacarpofalângica fletida. Polegar: spica.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- 7–10 dias: raio-X com a tala (perda de redução? rotação?); se rotação apareceu, cirurgião — ainda dá tempo.
- 3–4 semanas: tira a tala, buddy taping, movimento; 6 semanas: força e retorno ao trabalho; sem raio-X de rotina depois do de 3–4 semanas se clínica boa.
- Lag de extensão residual, dor na palma ao pegar objetos (cabeça caída): aceitável na maioria; cirurgia eletiva (osteotomia) só se função ruim em trabalhador manual.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: qualquer rotação, encurtamento > 5 mm, articular com degrau, múltiplas, exposta com esmagamento, Bennett/Rolando, redução que não segura (cirurgia da mão / ortopedista de mão em dias, pela regulação); fight bite (lavagem cirúrgica em 24 h); compartimental da mão (hoje).

Atestado	Escritório: 7–14 dias com a tala (mão não dominante: 0–3); braçal: 4–6 semanas.
Retorno	7–10 dias com raio-X; 3–4 semanas; 6 semanas.

DICAS

- Soco com ferida sobre o nó: pergunte "foi no dente?". A resposta muda tudo e o paciente não conta sozinho.
- A tolerância ao desvio no 5º metacarpo é grande porque a articulação carpometacarpal dele é móvel; no 2º e 3º não é — não aplique o 40° do mínimo ao indicador.

Baseado em: ASSH — Metacarpal and phalangeal fractures; AAOS OrthoInfo — Hand fractures; BSSH — Hand fracture guidelines; Jahss 1938 (redução do colo do metacarpo).

6.3 Dedo luxado, dedo em martelo e lesões de tendão

CID S63.1 / S66.3 / S66.1 / S63.6 · **Também** dedo saiu do lugar, luxação de dedo, dedo em martelo, mallet finger, ponta do dedo caída, jersey finger, não dobra a ponta do dedo, boutonnière, entorse de dedo, placa volar

> A luxação dorsal da interfalângica proximal reduz com bloqueio digital e tração e volta a mexer com buddy taping; o dedo em martelo é 6–8 semanas de tala em extensão sem nunca dobrar; o dedo que não flete a ponta (jersey) é cirurgia em 7–10 dias — e o seu papel é não perder o prazo.

O QUE PERGUNTAR

- Mecanismo: dedo "entortou para trás" na bola (luxação dorsal da IFP, placa volar), pancada na ponta do dedo estendido (martelo), puxão da camisa com o dedo fletido (jersey, anular), corte ou esmagamento (tendão)?
- Consegue esticar a ponta (martelo)? Consegue dobrar a ponta sozinha (jersey)? Reduziu sozinho ou alguém puxou no campo?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Cada articulação, cada tendão	Flexão da interfalângica distal isolada (segure a média: FDP); flexão da IFP com os outros dedos estendidos (FDS); extensão ativa da IFD (martelo) e da IFP (central slip — teste de Elson: resista à extensão da IFP com ela fletida sobre a mesa; IFD rígida em extensão = central slip roto).	Ponta caída sem extensão ativa → martelo; não flete a IFD → jersey (FDP); Elson positivo → boutonnière em formação.
Estabilidade após reduzir a IFP	Flexão-extensão ativa completa; estresse lateral em extensão e a 30°.	Estável no arco todo → buddy taping; reluxa em extensão → tala de bloqueio dorsal 20–30°; instável lateral → colateral roto (grau III).
Pele e neurovascular	Ferida (luxação aberta — comum na IFP), perfusão, sensibilidade dos dois lados do dedo.	Ferida → lavagem, antibiótico; dormência unilateral → nervo digital (sutura em dias se corte limpo).

SINAIS DE ALARME

- Luxação irredutível (botoeira da cabeça do metacarpo ou da falange presa na placa volar — típica da metacarpofalângica do indicador e do polegar): não insista, não traciona mais — redução aberta.
- Jersey finger: o tendão retrai para a palma; depois de 10 dias a sutura primária fica difícil. Cirurgia da mão em até 7–10 dias — a sua urgência é a regulação em 48 h.
- Luxação aberta: lavagem, antibiótico, redução e fechamento só se limpa; exploração se dúvida.

IMAGEM

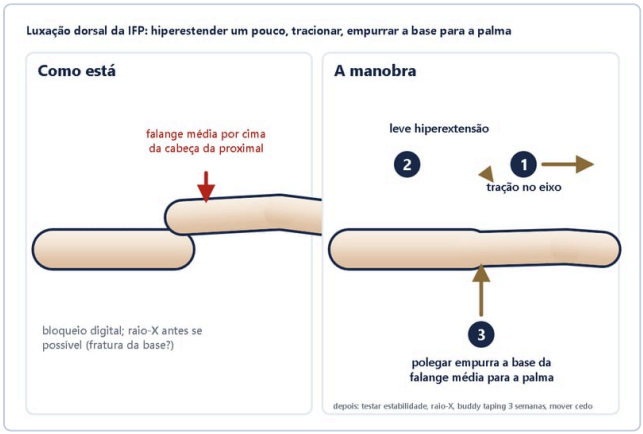
- RX do dedo PA e perfil verdadeiro antes de reduzir (fratura da base da falange média — a "fratura-luxação" que muda a conduta) e depois (congruência; subluxação residual no perfil). Martelo: perfil mostra o fragmento ósseo e a subluxação volar da IFD. Jersey: perfil pode mostrar fragmento de avulsão na palma ou junto à IFP.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

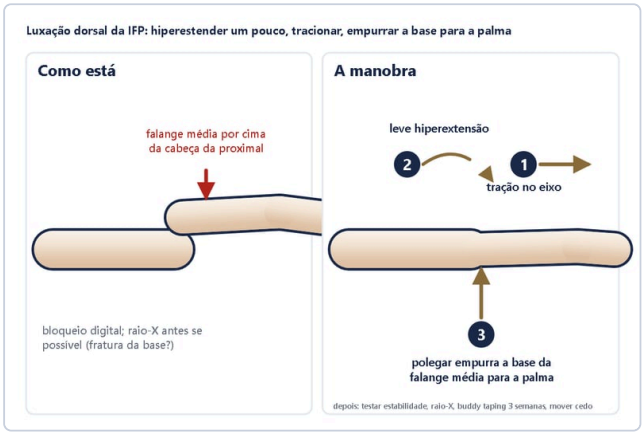
- Luxação dorsal da IFP: bloqueio digital, redução (tração leve + hiperextensão suave e flexão, ver procedimento), raio-X, teste de estabilidade; estável: buddy taping 3 semanas com movimento imediato; instável em extensão: tala de bloqueio dorsal em 20–30° por 2–3 semanas, reduzindo 10° por semana. Alta hoje.
- Fratura-luxação da IFP com fragmento volar > 30–40% da base da falange média: instável — reduza, tala de bloqueio dorsal e cirurgião em dias.
- Martelo fechado (tendinoso ou ósseo com fragmento < 1/3 e sem subluxação): tala de Stack ou alumínio em extensão (ou leve hiperextensão) da IFD, 6–8 semanas contínuas + 2–4 semanas noturnas; IFP livre. Ósseo com > 1/3 da superfície ou subluxação volar: cirurgião (fio) em dias.
- Jersey (avulsão do FDP): tala em posição segura, regulação urgente para cirurgia da mão em 7–10 dias; escreva "avulsão do flexor profundo do 4º dedo — reparo em até 10 dias".
- Boutonnière agudo (Elson positivo) sem fratura: tala da IFP em extensão por 6 semanas com a IFD livre para fletir ativamente (IFD fletir é o tratamento); cirurgião se aberta ou com fragmento.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

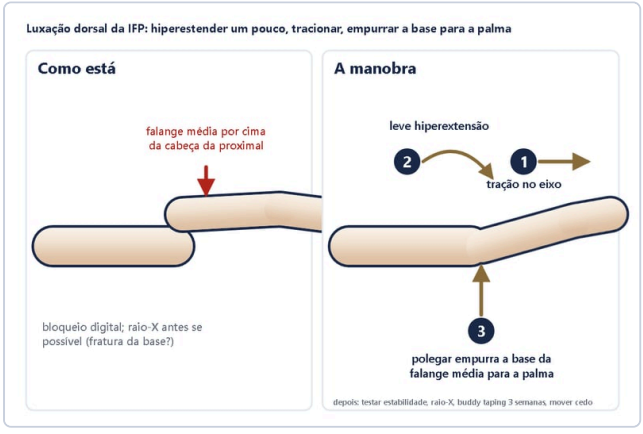
Redução da luxação dorsal da interfalângica proximal



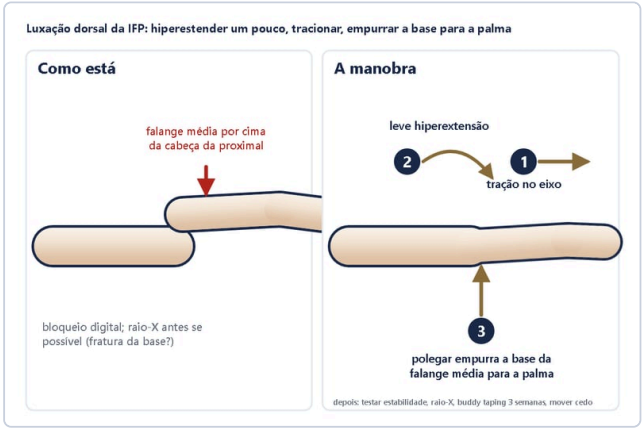
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Luxação dorsal fechada, com raio-X. Não repetir mais de duas vezes.

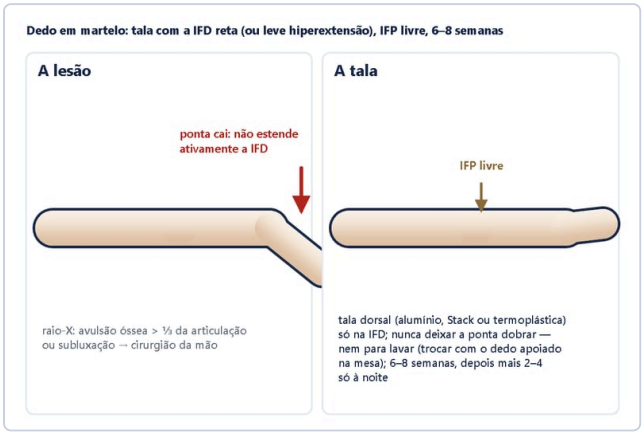
Material e anestesia: Bloqueio digital (lidocaína 1–2% sem vaso 2–4 mL), gaze seca para segurar o dedo.

Passo a passo

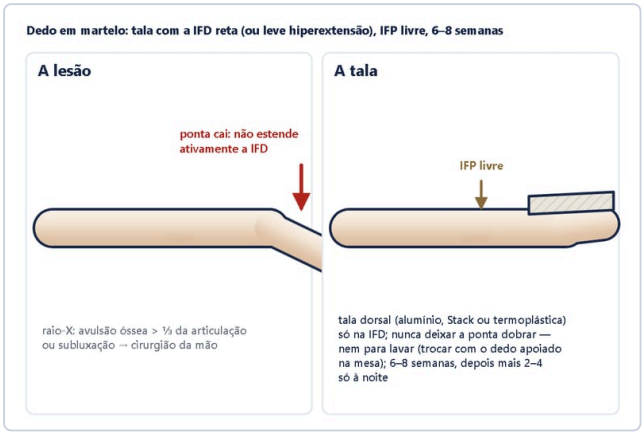
1. Com o bloqueio feito, segure a falange proximal com uma mão e a média com a outra.
2. Tração leve no eixo com discreta hiperextensão (relaxa a placa volar presa), depois empurre a base da falange média para volar e flexione — o dedo encaixa.
3. Mova ativamente: flexão-extensão completas sem reluxar = estável. Estresse lateral.
4. Raio-X de controle em perfil verdadeiro: a base da falange média alinhada com a cabeça da proximal, sem subluxação.

Depois: Buddy taping 3 semanas (estável) ou tala de bloqueio dorsal 20–30° (instável em extensão). Avise: o dedo fica inchado e duro por 3–6 meses; mover desde hoje é o que evita a rigidez.

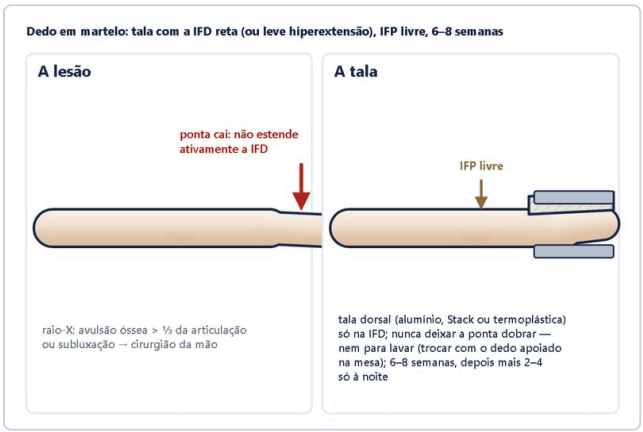
Tala do dedo em martelo



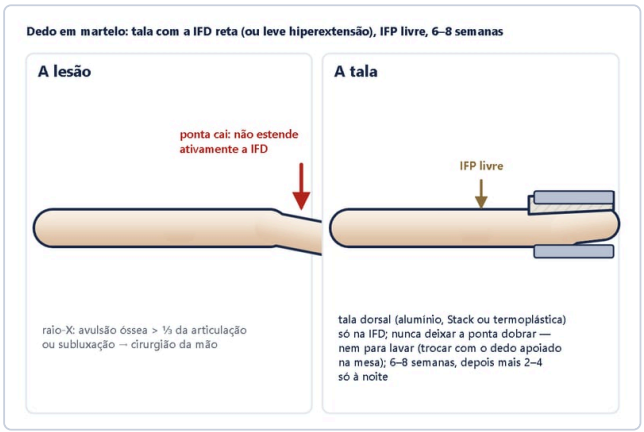
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Martelo fechado, tendinoso ou ósseo pequeno sem subluxação. Começa no dia, mesmo que o trauma tenha semanas (até 3 meses ainda responde).

Material e anestesia: Tala de Stack do tamanho certo (ou tala de alumínio acolchoada cortada para a IFD), esparadrapo.

Passo a passo

1. IFD em extensão ou leve hiperextensão (sem branquear a pele dorsal — isquemia), IFP livre.
2. Fixe com esparadrapo; o paciente troca a tala só com o dedo apoiado reto na mesa (nunca deixar a ponta dobrar, nem para lavar — explique e demonstre).
3. 6–8 semanas contínuas (8 nos ósseos e em quem demorou), depois 2–4 semanas só à noite e no esporte.

Depois: Retorno em 1 semana (pele, tala ajustada) e em 6 semanas (teste de extensão; se cair, mais 2–4 semanas). Déficit residual de 5–10° é aceitável.

CONDUTA

- Entorse da IFP (placa volar, sem luxação ou já reduzida estável): buddy taping 2–3 semanas e movimento; o edema dura meses e a dor ao apertar até 6–12 meses.
- Colateral da metacarpofalângica do polegar (polegar do esquiador, lesão de Stener): spica 4–6 semanas se estável; instável (> 30° de abertura ou sem ponto final) → cirurgia da mão em 1–2 semanas.
- Tendão extensor cortado no dorso (zona 5–6): pode ser suturado no plantão por quem sabe (fio 3-0/4-0, pontos de Kessler), tala em extensão 4–6 semanas; flexor cortado: cirurgia da mão sempre (nunca explorar "para ver" sem condições).
- Fisioterapia da mão (terapia ocupacional) a partir da retirada da tala; rigidez é a sequela que mais limita.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Cefalexina 500 mg	1 comprimido de 6/6 h por 5 dias.	Só na luxação aberta ou ferida sobre a articulação (após lavagem).

IMOBILIZAÇÃO

- IFP luxada estável: buddy taping 3 semanas. Instável: tala de bloqueio dorsal 20–30°. Martelo: tala de Stack 6–8 semanas. Boutonnière: tala da IFP em extensão 6 semanas, IFD livre. Jersey: tala em posição segura até a cirurgia.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- 1 semana: tala, pele, movimento; 3 semanas: fora o buddy taping da IFP, exercícios; 6–8 semanas: teste do martelo e desmame.
- IFP que ficou rígida em flexão (contratura) após 6 semanas: órtese dinâmica de extensão e terapia da mão; cirurgia (liberação) só após 6 meses.
- Martelo que falhou após 8 semanas bem feitas: mais 6 semanas de tala ou cirurgia (artrodese da IFD) só se incomoda muito — eletivo.
- Pescoço de cisne tardio (martelo antigo) e boutonnière crônico: cirurgia da mão, eletivo.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: luxação irredutível ou aberta complexa (hoje), fratura-luxação da IFP instável e martelo ósseo com subluxação ou > 1/3 (cirurgia da mão em dias), jersey finger (7–10 dias — é a urgência relativa deste tópico), flexor cortado, colateral do polegar instável e nervo digital cortado (cirurgia da mão em 1–2 semanas).

Atestado	Escritório: 0–7 dias; braçal: 3–4 semanas (luxação/martelo), 8–12 semanas (tendão operado).
Retorno	1 semana; 3 semanas; 6–8 semanas.

DICAS

- Todo dedo "torcido jogando bola" precisa de dois testes: estica a ponta sozinha? dobra a ponta sozinha? São 10 segundos e evitam o martelo e o jersey perdidos.
- A tala do martelo funciona se a ponta não dobrar nenhuma vez em 6 semanas. Um dobrar zera o relógio — diga assim.

Baseado em: ASSH — PIP joint dislocations; Mallet finger; Flexor tendon injuries; BSSH — Mallet finger guideline; Elson test (JBJS 1986); Leddy & Packer — FDP avulsion classification.

6.4 Ferimentos da mão, unha e ponta do dedo

CID S61.0 / S61.1 / S68.1 / S67.0 · **Também** corte na mão, esmagou o dedo na porta, unha arrancada, hematoma embaixo da unha, amputação da ponta do dedo, mordedura, ferida na mão, lesão de tendão

> A ponta do dedo esmagada, a unha arrancada e o hematoma subungueal são seus: bloqueio digital, lavagem, drenar o hematoma, reparar o leito ungueal e devolver a unha como curativo; o que vai à cirurgia da mão é o tendão flexor, o nervo, a amputação com osso exposto e a mordedura profunda.

O QUE PERGUNTAR

- Mecanismo (porta, martelo, faca, vidro, serra, mordedura de cão/gato/humano), hora, ambiente sujo? Vacina antitetânica? Dominância e profissão.
- Dormência (nervo digital), não mexe (tendão), sangramento pulsátil (artéria digital)? Parte amputada: onde está, como foi guardada?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Exame com luz, sem sangue e sem garrote demorado	Lave, bloqueio digital se preciso (depois de testar a sensibilidade!), garrote de dedo (luva cortada) por no máximo 15–20 min; explore a ferida no arco de movimento — o tendão cortado com o dedo fletido some quando estendido.	Tendão visível cortado, mesmo parcial > 50% → cirurgia da mão; cápsula/articulação aberta → lavagem cirúrgica e antibiótico.
Tendões e nervos, antes de anestesiar	FDP (flete a IFD com a média segura), FDS (flete a IFP com os outros dedos estendidos), extensores (estende cada articulação contra resistência); sensibilidade dos dois lados de cada dedo (discriminação de dois pontos < 6 mm = normal); enchimento capilar e Allen na mão.	Qualquer déficit → lesão até a exploração cirúrgica provar o contrário.
Unha e leito	Hematoma subungueal (percentual da unha), unha solta ou avulsionada, laceração do leito visível, fratura da falange distal (tuft).	Hematoma > 50% ou unha solta → remover a unha, reparar o leito; tuft com unha lesada = fratura exposta: antibiótico.

SINAIS DE ALARME

- Mordedura de gato (punção profunda, Pasteurella) e humana (soco no dente): antibiótico, nunca fechar, exploração se articulação ou tendão — artrite séptica e tenossinovite em 24–48 h.
- Tenossinovite infecciosa (dedo fusiforme, fletido, dor ao estender passivamente, trajeto doloroso — Kanavel): cirurgia hoje.
- Injeção de alta pressão (graxa, tinta, pistola de pressão) em dedo "que só tem um furinho": cirurgia de desbridamento em horas — amputação em 50% se esperar.
- Amputação proximal à IFD, polegar, múltiplos dedos, criança: candidato a reimplante — centro de reimplante pela regulação em até 6 h de isquemia quente (12–24 h resfriado).

IMAGEM

- RX do dedo ou mão PA, oblíqua e perfil em todo esmagamento, corte com vidro (fragmento retido), mordedura (dente, fratura) e amputação (nível ósseo).

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

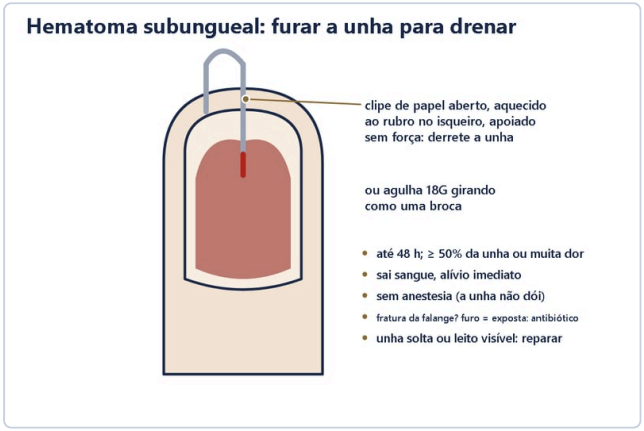
- Hematoma subungueal doloroso (< 48 h), unha íntegra e presa: trepanação (agulha 18G girando ou cautério) — alívio imediato; sem antibiótico se não há fratura exposta; curativo.
- Unha solta, laceração do leito, hematoma > 50% com unha solta: bloqueio digital, retirar a unha com cuidado (descolador sob a unha), lavar, reparar o leito com fio absorvível 6-0 (ou cola cirúrgica), recolocar a unha limpa (ou folha de alumínio/silicone) sob a prega como curativo e molde por 2–3 semanas; tuft fraturado: tala digital 2 semanas; antibiótico se fratura exposta.
- Amputação da polpa sem osso exposto (< 1 cm^2): lavagem, hemostasia por compressão (não cauterizar), curativo com gaze não aderente e cicatrização por segunda intenção — resultado excelente em 3–6 semanas; sua.
- Amputação com osso exposto: lavagem, curativo, parte amputada em gaze úmida com soro dentro de saco plástico, sobre gelo (não em contato direto), raio-X, antibiótico, tétano; regulação para cirurgia da mão (encurtamento ósseo e fechamento ou retalho; reimplante nos candidatos).
- Corte limpo sem tendão/nervo/articulação, < 6–8 h: lavagem abundante, sutura simples com nylon 4-0/5-0 (pontos frouxos), curativo, retorno em 48 h; sujo ou tardio: lavar, não suturar, antibiótico, retorno em 48 h para fechamento tardio se limpo.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

Trepanação do hematoma subungueal



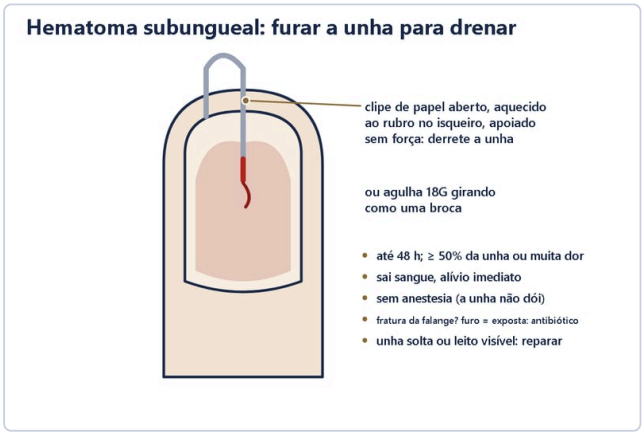
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Hematoma subungueal doloroso com menos de 48 h; unha presa. Não se unha solta (remova e repare o leito).

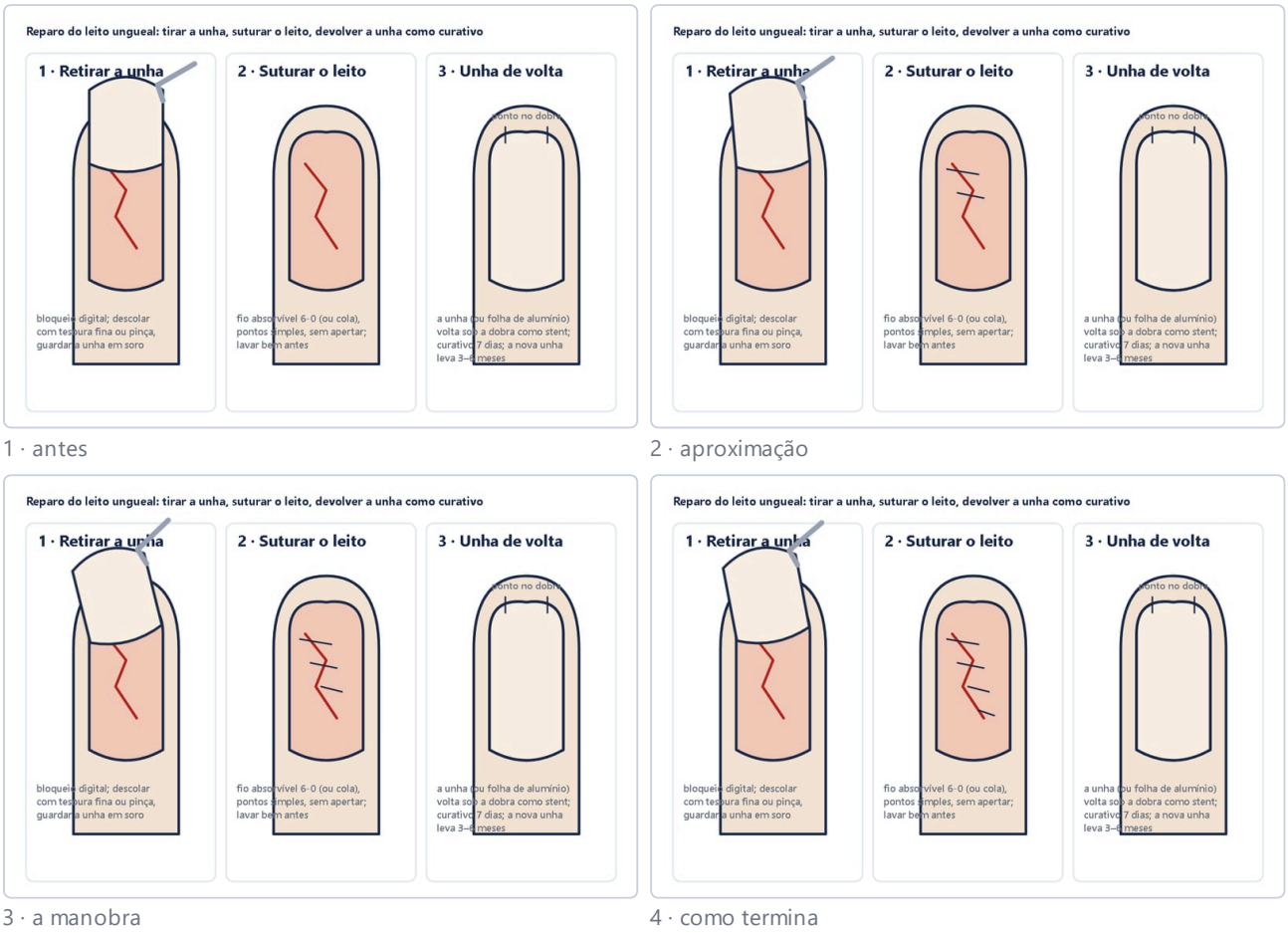
Material e anestesia: Agulha 18G ou cautério descartável; antissepsia; sem anestesia na maioria.

Passo a passo

1. Limpe a unha com clorexidina; marque o centro do hematoma.
2. Agulha 18G perpendicular, girando entre os dedos como uma broca, sem pressão, até perfurar — o sangue sai e a dor some; faça 2 furos se grande.
3. Deixe sangrar; curativo seco; mão elevada.

Depois: Retorno só se dor ou secreção. A unha pode cair em semanas e cresce em 3–6 meses.

Reparo do leito ungueal



1 · antes — 2 · aproximação

3 · a manobra — 4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Unha solta, avulsionada ou laceração visível do leito; hematoma > 50% com unha instável.

Material e anestesia: Bloqueio digital, garrote de dedo, descolador (ou tesoura fina fechada), fio absorvível 6-0 (ou cola de cianoacrilato), gaze não aderente; raio-X antes.

Passo a passo

1. Bloqueio digital; garrote; retire a unha deslizando o descolador sob ela da ponta para a base, com cuidado para não lesar mais o leito; guarde a unha em soro.
2. Lave; aproxime as bordas do leito com pontos 6-0 absorvíveis separados, sem tensão (ou cola); fragmento ósseo pequeno não se tira.
3. Limpe a unha (raspe o lado de baixo), faça um furo central e recoloque sob a prega ungueal (eponíquio), fixando com 1–2 pontos ou esparadrapo; sem a unha, use folha de alumínio do envelope de sutura ou silicone.
4. Curativo não aderente, tala digital se tuft fraturado, elevação.

Depois: Retorno em 5–7 dias (curativo), 2–3 semanas (tirar a unha/molde). Avise que a unha nova pode vir deformada se o leito cicatrizou mal.

CONDUTA

- Antibiótico: fratura exposta de falange distal — cefalexina 500 mg 6/6 h por 5–7 dias; mordedura de cão, gato ou humana — amoxicilina-clavulanato 875/125 12/12 h por 5–7 dias (profilaxia em toda mordedura na mão), lavagem copiosa, não suturar (exceto face), elevação; raiva: avaliar conforme o animal e o protocolo (soro/vacina).
- Tétano em toda ferida: esquema conforme a vacina (ver Fratura exposta); ferida limpa pequena com 3 doses e < 10 anos não precisa.
- Curativo da polpa por segunda intenção: lavar com água e sabão 1×/dia, gaze não aderente ou vaselina, não deixar secar; 3–6 semanas; sensibilidade volta em meses.
- Terapia da mão cedo após qualquer tala ou sutura de tendão: a rigidez e a hipersensibilidade da ponta são as sequelas comuns.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Cefalexina 500 mg	1 comprimido de 6/6 h por 5 a 7 dias.	Fratura exposta de falange distal (esmagamento com unha lesada).
Amoxicilina + clavulanato 875/125 mg	1 comprimido de 12/12 h por 5 a 7 dias (profilaxia) ou 10 a 14 dias (infecção).	Mordedura de cão, gato ou humana na mão. Alergia: clindamicina 300 mg 8/8 h + ciprofloxacino 500 mg 12/12 h (ou doxiciclina 100 mg 12/12 h).
Vacina dT	0,5 mL IM conforme o esquema do tétano.	—

IMOBILIZAÇÃO

- Tala digital 1–2 semanas no tuft fraturado ou reparo do leito; mão em posição segura (intrínseco-plus) se precisar de tala maior; o resto não imobiliza.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- 48 h: toda ferida suturada ou mordedura (infecção?); 5–7 dias: curativo do leito; 10–14 dias: retirar pontos de pele (mão: 10–14 dias).
- Infecção (dor crescente, secreção, febre): abrir os pontos, cultura, antibiótico; tenossinovite ou abscesso profundo → cirurgia.
- Cicatriz dolorosa, neuroma da ponta, unha deformada: terapia da mão, dessensibilização; cirurgia eletiva só se limita.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: tendão flexor (e extensor que você não sutura), nervo digital, artéria com dedo mal perfundido, amputação com osso exposto ou candidata a reimplante (cirurgia da mão / centro de reimplante — horas), injeção de alta pressão e tenossinovite infecciosa (hoje), mordedura com articulação ou tendão (lavagem cirúrgica em 24 h), perda de pele que precisa de retalho.

Atestado	Corte simples: 0–3 dias; leito ungueal ou tuft: 7–14 dias; braçal com mão dominante: 2–3 semanas.
Retorno	48 h (ferida), 5–7 dias, 2–3 semanas.

DICAS

- Teste tendão e nervo ANTES do bloqueio e anote: depois, “não mexe” e “não sente” viram efeito da anestesia.
- Ponta de dedo sem osso exposto não precisa de retalho nem de enxerto — precisa de curativo e tempo. É a lesão em que menos é mais.

Baseado em: ASSH — Fingertip injuries; Nail bed injuries; Bite wounds; BSSH — Nail bed injury guideline; IDSA — Skin and soft tissue infections 2014 (bites); Ministério da Saúde — Profilaxia da raiva e do tétano.

CAPÍTULO 7

Quadril

Dor no quadril de verdade dói na virilha; dor na lateral é bursa/glúteo; dor na nádega é coluna. O idoso que caiu e não anda vai para o hospital.

7.1	**Osteoartrite de quadril** Dor na virilha ao andar e rigidez matinal curta, rotação interna limitada e dolorosa: artrose — exercício, perda de peso, analgesia; prótese quando a vida travou.	138
7.2	**Bursite trocantérica (síndrome dolorosa do grande trocanter)** Dor na lateral do quadril ao deitar sobre o lado e ao subir escada, com ponto doloroso no trocanter: tendinopatia glútea/bursite — carga progressiva, não repouso.	141
7.3	**Fratura de quadril no idoso** Idoso que caiu, dói na virilha e não consegue apoiar, com a perna encurtada e rodada para fora: fratura de quadril — hospital hoje, cirurgia em 48 h.	143
7.4	**Criança mancando: quadril** Criança que manca sem trauma: sinovite transitória é o mais comum, artrite séptica é o que não pode escapar; adolescente gordinho com dor no joelho é epifisiólise até prova em contrário.	146

7.1 Osteoartrite de quadril

CID M16 · **Também** artrose de quadril, dor na virilha, desgaste do quadril, coxartrose, dor no quadril ao andar

> Dor na virilha ao andar e rigidez matinal curta, rotação interna limitada e dolorosa: artrose — exercício, perda de peso, analgesia; prótese quando a vida travou.

O QUE PERGUNTAR

- Onde dói (virilha e face anterior da coxa até o joelho = quadril; lateral = trocanter; nádega = coluna)? Dificuldade para calçar meia, cortar unha do pé, entrar no carro?
- Distância que anda antes de parar; dor noturna; uso de bengala?
- Corticoide, alcoolismo, anemia falciforme, lúpus (necrose da cabeça femoral, em < 50 anos)?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Marcha e Trendelenburg	Observar claudicação; em pé num pé só, a pelve do lado contrário cai.	Trendelenburg positivo → fraqueza de abdutores / dor.
Rotação interna em flexão	Deitado, quadril e joelho a 90°, rodar internamente comparando os lados.	Rotação interna < 15° e dolorosa → artrose (o sinal mais precoce).
FABER (Patrick)	Tornozelo sobre o joelho oposto, empurrar o joelho para baixo.	Dor na virilha → quadril; dor na sacroilíaca → sacroilíaca.
FADIR	Flexão, adução e rotação interna.	Dor na virilha em jovem → impacto femoroacetabular / lesão labral.
Dismetria e Thomas	Medir comprimento dos membros; teste de Thomas para contratura em flexão.	Encurtamento e contratura → artrose avançada.

SINAIS DE ALARME

- Dor na virilha em < 50 anos com corticoide, álcool ou falciforme: osteonecrose — ressonância.
- Dor de repouso e noturna com febre ou câncer: infecção ou metástase.
- Idoso com dor súbita e incapaz de apoiar, mesmo sem queda: fratura por insuficiência — raio-X e, se normal, ressonância.

IMAGEM

- RX de bacia AP com carga e RX de quadril perfil (Lauenstein) do lado doente: estreitamento, osteófitos, esclerose, cistos. Ressonância só se raio-X normal com clínica forte (necrose, labral, fratura oculta).

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão (crise de dor em artrose conhecida): excluir fratura (idoso que não apoia: raio-X e, se normal, ressonância ou tomografia — fratura por insuficiência), infecção (febre, protese) e necrose; analgesia, AINE curto se puder, bengala, alta com retorno no ambulatório.
- Prótese de quadril com dor nova, febre ou fístula: não é "artrose" — infecção ou soltura: raio-X, hemograma, PCR, VHS, e o cirurgião da prótese; sem antibiótico antes da cultura.

CONDUTA

- Exercício é o tratamento de base: fortalecimento de glúteos e quadríceps, bicicleta, hidroginástica, caminhada curta e frequente; fisioterapia para ensinar.

- Perda de peso: cada 5 kg a menos reduz a dor de forma mensurável.
- Bengala na mão oposta ao quadril doente.
- Analgesia: paracetamol ou dipirona fixo; AINE oral em cursos curtos nas crises (cuidado no idoso); tópico tem pouco efeito no quadril (profundo).
- Infiltração intra-articular de corticoide guiada por imagem: alívio de semanas, útil para crises; ácido hialurônico sem evidência no quadril.
- Prótese total de quadril: dor noturna, limitação para andar < 500 m, falha de 3–6 meses de tratamento — resultado excelente em > 90%. Indique e peça pela regulação antes de o paciente virar sedentário; a fila é longa, e fisioterapia e infiltração feitas contam como conservador cumprido.
- Glucosamina e condroitina: sem benefício consistente; não prescrever como tratamento.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 8–12 semanas: dor, distância de marcha, uso de bengala, peso; infiltração guiada por ultrassom nas crises (até 2–3 por ano); raio-X anual não muda nada — a indicação da prótese é clínica.
- Pedido da prótese pela regulação com o resumo (tempo de dor, Lequesne/WOMAC se usar, tratamento feito, raio-X); enquanto espera, exercício e peso são o que mantém a função.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a prótese total (cirurgião de quadril, eletiva pela regulação, quando a dor limita apesar de 3–6 meses de tratamento), a infiltração guiada por imagem se o seu serviço não tem ultrassom (radiologia), o jovem com impacto femoroacetabular/lesão labral (artroscopia de quadril, eletiva) e a osteonecrose em fase precoce (descompressão — cirurgião de quadril, em semanas).

Atestado	0–3 dias nas crises; trabalho braçal pesado é incompatível com artrose avançada — discutir readaptação.
Retorno	8–12 semanas.

DICAS

- “Dor no quadril” apontada com a mão na lateral é trocantérica; com a mão na nádega é coluna; com a mão na virilha (sinal do C) é o quadril.

Baseado em: AAOS CPG — Osteoarthritis of the hip 2023; NICE NG226 — Osteoarthritis; OARSI 2019.

7.2 Bursite trocantérica (síndrome dolorosa do grande trocanter)

CID M70.6 · **Também** bursite do quadril, dor na lateral do quadril, dor ao deitar de lado, tendinopatia glútea, dor na lateral da coxa

> Dor na lateral do quadril ao deitar sobre o lado e ao subir escada, com ponto doloroso no trocanter: tendinopatia glútea/bursite — carga progressiva, não repouso.

O QUE PERGUNTAR

- Dói ao deitar sobre o lado, ao cruzar as pernas, ao subir escada e levantar da cadeira? Mulher 40–60 anos? Começou após aumentar caminhada ou corrida?
- Dormência ou dor que desce abaixo do joelho (coluna L5)?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Palpação do trocanter	Deitado de lado, pressionar sobre o grande trocanter.	Dor reprodutiva → síndrome trocantérica.
Apoio unipodal 30 s	Ficar num pé só por 30 segundos.	Dor lateral → tendinopatia glútea (muito específico).
Abdução resistida e FADER	Resistir à abdução deitado de lado; flexão-adução-rotação externa.	Dor lateral.
Quadril e coluna	Rotação interna do quadril (artrose) e Lasègue (radiculopatia).	Positivos → outra causa ou coexistência.

SINAIS DE ALARME

- Dor lateral com febre, calor local (bursite séptica — rara, após infiltração): punção, cultura e antibiótico; dor lateral nova após prótese de quadril (infecção, soltura): raio-X, PCR, VHS e o cirurgião da prótese, sem antibiótico antes da cultura.

IMAGEM

- Não precisa na típica. RX de bacia AP se > 50 anos ou dúvida com artrose. Ultrassom ou ressonância se refratária (ruptura do glúteo médio).

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: diagnóstico clínico (palpação do trocanter, apoio unipodal), excluir fratura no idoso que caiu (raio-X) e artrose; AINE tópico ou curto, orientação de carga, exercícios escritos; infiltração peritrocantérica (ver Punção e infiltração) já no primeiro atendimento se a dor não deixa dormir ou andar.

CONDUTA

- Educação e carga: evitar cruzar as pernas, ficar apoiado num quadril só, deitar sobre o lado doente (travesseiro entre os joelhos); reduzir a caminhada por 2 semanas, não parar.
- Exercícios isométricos de abdutores progredindo a fortalecimento (ponte, concha, abdução em pé) por 8–12 semanas — melhor resultado que infiltração a longo prazo.
- AINE tópico ou oral curto; gelo 15 min após atividade.

- Infiltração de corticoide no espaço peritrocantérico: alívio rápido por semanas; opção para dor intensa que impede o exercício.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Diclofenaco dietilamônio gel 11,6 mg/g	Camada fina na lateral do quadril, 3 a 4× ao dia, por 14 dias.	—
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 6–8 semanas: aderência aos exercícios de glúteo (é o tratamento); infiltração nas crises que impedem o exercício (até 2–3 por ano); sem melhora em 3 meses → ultrassom ou ressonância (ruptura do glúteo médio).

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a ruptura do glúteo médio com fraqueza e Trendelenburg confirmada na ressonância (reparo — cirurgião de quadril, eletivo), e a bursite que não responde a 6 meses de exercício e 2 infiltrações (bursectomia/alongamento da banda iliotibial, eletivo, raro).

Atestado	0–3 dias.
Retorno	6–8 semanas.

DICAS

- Infiltração sem exercício depois = recidiva em meses. Combine os dois.

Baseado em: LEAP trial (BMJ 2018) — education + exercise vs corticosteroid; Grimaldi & Fearon 2015 — Gluteal tendinopathy.

7.3 Fratura de quadril no idoso

CID S72.0 / S72.1 · **Também** fratura do colo do fêmur, quebrou o quadril, idoso que caiu e não anda, fratura transtrocantérica, fratura de fêmur

> Idoso que caiu, dói na virilha e não consegue apoiar, com a perna encurtada e rodada para fora: fratura de quadril — hospital hoje, cirurgia em 48 h.

O QUE PERGUNTAR

- Queda da própria altura? Consegue levantar e dar passos? Dor na virilha ou na coxa? Anticoagulante, diabetes, insuficiência cardíaca (preparo cirúrgico)?
- Quem cuida em casa, mora sozinho, já tinha dificuldade para andar?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Inspeção	Membro encurtado e em rotação externa.	Clássico de fratura desviada; a sem desvio pode não ter sinal.
Log roll	Rolar a perna suavemente sobre o leito.	Dor na virilha → fratura até prova em contrário.
Carga	Tentar apoiar com ajuda.	Incapaz de apoiar → raio-X hoje; se normal, ressonância ou tomografia.
Neurovascular e pele	Pulsos distais, sensibilidade, procurar lesões de pele e sinais de longa permanência no chão (desidratação, úlcera).	Tempo no chão > 1 h → rabdomiólise, hipotermia: exames.

SINAIS DE ALARME

- Toda suspeita é internação hoje, com analgesia e bloqueio da fáscia ilíaca; a cirurgia é em até 48 h — aqui ou pela regulação de urgência. A mortalidade em 1 ano é de 20–30% e cada dia de atraso cirúrgico aumenta.
- Dor no quadril após queda com raio-X normal e incapaz de andar: fratura oculta até a ressonância ou tomografia dizer o contrário — fica internado até a imagem.

IMAGEM

- RX de bacia AP e quadril perfil (cross-table lateral, sem mexer a perna). Normal com clínica: ressonância (melhor) ou tomografia no mesmo dia.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Internação hoje: analgesia EV e bloqueio da fáscia ilíaca, jejum, exames, raio-X de bacia e quadril (tomografia ou ressonância se normal e não anda), tração cutânea só se dor com a mobilização, profilaxia de trombose, prevenção de úlcera de pressão e delirium (hidratação, óculos, sem benzodiazepínico), e a vaga cirúrgica em 48 h — aqui com o sobreaviso ou pela regulação com "fratura de colo/transtrocantérica, [idade], cirurgia em 48 h".
- Enquanto espera: reavaliação clínica diária (pneumonia, retenção urinária, delirium), hemoglobina (a transtrocantérica sangra), mobilização no leito; a família ouve que a cirurgia é o tratamento mesmo em 90 anos.

- Paciente que não tem condição cirúrgica (demência avançada acamada sem dor à mobilização, risco anestésico proibitivo): tratamento conservador é decisão compartilhada com clínica/geriatria e família, não "falta de vaga".

CONDUTA

- Analgesia imediata (dipirona EV; bloqueio da fáscia ilíaca — ver Anestesia local, bloqueios e sedação), não mover a perna, jejum, acesso venoso, hidratação, exames pré-operatórios (hemograma, coagulograma, creatinina, eletrólitos, glicemia, ECG, raio-X de tórax), suspender anticoagulante conforme o protocolo, internação e a vaga cirúrgica (aqui ou regulação) em até 48 h.
- Cirurgia em até 48 h (prótese parcial/total no colo desviado; parafuso deslizante ou haste na transtrocantérica), mobilização no 1º dia pós-operatório.
- Depois da alta: fisioterapia, prevenção de trombose (enoxaparina por 4–5 semanas), osteoporose (alendronato ou zoledronato após 2 semanas, vitamina D), prevenção de queda, avaliação de delirium e nutrição.
- No retorno pós-operatório, garanta o que a internação costuma esquecer: osteoporose tratada, prevenção de queda, fisioterapia de marcha, nutrição e revisão dos sedativos.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g/2 mL	2 mL EV lento agora e de 6/6 h na internação.	—
Morfina 10 mg/mL	2 mg EV a cada 10 min até controlar (idoso: até 0,05 mg/kg na primeira hora), depois 2 mg de 4/4 h se dor, com antiemético e laxante.	Prefira o bloqueio da fáscia ilíaca; morfina em dose mínima no idoso (delirium, depressão respiratória).
Enoxaparina 40 mg	1 seringa SC ao dia desde a internação (suspender 12 h antes da cirurgia) e por 4–5 semanas após.	Ajuste se clearance < 30 mL/min.
Colecalciferol (vitamina D3) 2.000 UI	1 cápsula ao dia, contínuo (no retorno pós-operatório).	—
Alendronato de sódio 70 mg	1 comprimido por semana em jejum, em pé, com água, 30 minutos antes de comer (iniciar 2 semanas após a cirurgia, com cálcio e vitamina D corrigidos).	Função renal e esôfago; alternativa: ácido zoledrônico 5 mg EV anual.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Pós-operatório de volta a você: ferida em 10–14 dias, raio-X em 6 semanas e 3 meses, carga conforme o cirurgião (quase sempre total desde o 1º dia), fisioterapia de marcha, enoxaparina até 4–5 semanas, osteoporose (alendronato ou zoledronato após 2 semanas; vitamina D e cálcio), prevenção de queda (visão, calçado, sedativos, barras), nutrição.
- Dor nova, febre ou secreção da ferida nos primeiros 3 meses: infecção da prótese/implante até prova em contrário — cirurgião, sem antibiótico antes da cultura.
- Luxação da prótese parcial (dor súbita e perna encurtada): raio-X e redução sob sedação (ver Luxações).

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a cirurgia em si (prótese parcial/total no colo desviado; parafuso deslizante ou haste na transtrocantérica) — cirurgião do seu hospital ou regulação de urgência com internação até a vaga (não em casa); a avaliação clínica pré-operatória complexa (clínica/geriatria), a osteoporose grave ou com falha (endocrinologia) e a reabilitação prolongada (fisiatria/CER).

Atestado	Acompanhante: atestado dos dias de internação, se trabalha.
Retorno	Após a alta hospitalar: 2 semanas (ferida, trombose, dor, osteoporose iniciada?).

DICAS

- Idoso com “dor no joelho” após queda e joelho normal: examine o quadril — dor referida é comum.

Baseado em: NICE NG124 — Hip fracture management; AAOS CPG — Hip fractures in the elderly 2021; ABRASSO — Osteoporose.

7.4 Criança mancando: quadril

CID M25.5 / M67.3 / M00.9 / M93.0 / M91.1 · **Também** criança mancando, sinovite transitória, dor no quadril em criança, artrite séptica do quadril, epifisiólise, Perthes, criança não quer andar

> Criança que manca sem trauma: sinovite transitória é o mais comum, artrite séptica é o que não pode escapar; adolescente gordinho com dor no joelho é epifisiólise até prova em contrário.

O QUE PERGUNTAR

- Febre, infecção viral na semana anterior? Recusa total a andar ou só manca? Há quantos dias? Dor no joelho ou coxa (referida do quadril)?
- Idade: 2–8 anos (sinovite, Perthes), 10–15 anos com sobrepeso (epifisiólise).

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Mobilidade do quadril	Deitada, flexão, abdução e rotação interna comparando os lados; log roll.	Perda de rotação interna e abdução → quadril (sinovite, Perthes, epifisiólise, séptica). Rigidez total com dor extrema → séptica.
Sinal de Drehmann	Ao flexionar o quadril, a perna roda para fora obrigatoriamente.	Epifisiólise.
Exame geral	Temperatura, estado geral, outras articulações, pele, abdome, testículos.	Toxemia → infecção.

SINAIS DE ALARME

- Critérios de Kocher (artrite séptica): febre > 38,5 °C, não apoia, VHS > 40, leucócitos > 12.000 (e PCR > 2 mg/dL). 2 critérios → punção do quadril (guiada por ultrassom, ou pela ortopedia pediátrica/cirurgia) hoje; 3 ou 4 → quase certo: antibiótico EV após a coleta e drenagem cirúrgica no mesmo dia.
- Epifisiólise (escorregamento da cabeça femoral): adolescente com dor no quadril/joelho e Drehmann — sem apoiar o pé, cadeira de rodas, raio-X, internação e fixação in situ com parafuso em 24–48 h (ortopedia pediátrica pela regulação de urgência; o desvio progride e pode necrosar).
- Dor noturna, massa, perda de peso, palidez: leucemia e tumor ósseo — hemograma e raio-X.

IMAGEM

- RX de bacia AP e Lauenstein (frog-leg) — obrigatória no adolescente (epifisiólise, que só aparece no Lauenstein no início) e na dor > 1 semana (Perthes). Ultrassom de quadril mostra derrame (séptica ou sinovite — não diferencia). Hemograma, VHS, PCR sempre que febre ou não apoia.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Criança que manca sem febre, com bom estado geral, apoia e tem exames normais (hemograma, VHS, PCR): sinovite transitória — ibuprofeno por kg, repouso relativo, alta com retorno em 48 h; ultrassom se disponível (derrame) tranquiliza, mas não diferencia da séptica.
- Febre, não apoia, Kocher ≥ 2: internação, hemocultura, punção do quadril hoje (ultrassom-guiada ou pela cirurgia) e antibiótico EV após a coleta (oxacilina 150–200 mg/kg/dia 6/6 h ou cefazolina 100 mg/kg/dia 8/8 h; < 3 meses ou imunossuprimido: pediatria define); drenagem cirúrgica no mesmo dia.

- Adolescente com Drehmann: cadeira de rodas, raio-X com Lauenstein, internação e fixação em 24–48 h; não deixa ir para casa "andando de muleta".
- Dor noturna, palidez, massa, perda de peso: hemograma e raio-X hoje; pediatria/oncologia conforme o achado.

CONDUTA

- Sinovite transitória (afebril, bom estado geral, exames normais, apoia): repouso relativo, ibuprofeno 10 mg/kg 8/8 h por 3–5 dias, retorno em 48 h e em 1 semana; melhora em 3–10 dias. Se não melhorar em 2 semanas, raio-X de controle (Perthes).
- Perthes (necrose da cabeça, 4–8 anos, manca semanas): ortopedia pediátrica, sem urgência de horas, mas em dias.
- Epifisiólise: fixação cirúrgica com parafuso in situ, com urgência.
- Artrite séptica: drenagem cirúrgica e antibiótico EV no hospital.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Ibuprofeno gotas 100 mg/mL	10 mg/kg por dose = 2 gotas/kg (20 gotas por mL); na apresentação de 50 mg/mL, 4 gotas/kg. De 8/8 h, por 3 a 5 dias, com alimento; máximo 400 mg por dose.	Só na sinovite transitória; nunca antes de excluir infecção.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Sinovite: retorno em 48 h e 7 dias (febre ou piora → volta ao alarme); não melhorou em 2 semanas → raio-X de bacia (Perthes) e ortopedia pediátrica.
- Séptica operada: antibiótico EV 1–2 semanas e oral até completar 3–4 semanas com PCR normalizando; retorno semanal; raio-X em 6 semanas e 6 meses (necrose).
- Epifisiólise fixada: raio-X do outro quadril a cada 6 meses até fechar a fise (bilateral em 20–40%); peso e endocrinologia se hipotireoidismo ou obesidade.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a drenagem cirúrgica da artrite séptica e a fixação da epifisiólise (ortopedia pediátrica/cirurgião, hoje — regulação de urgência com internação), o Perthes (ortopedia pediátrica, em dias a semanas; contenção ou osteotomia conforme a idade e a extensão), a claudicação > 2 semanas sem diagnóstico ou com exames alterados (ortopedia pediátrica/pediatria — leucemia, tumor, artrite juvenil).

Atestado	Escola: 3–5 dias na sinovite; dispensa de educação física por 2 semanas.
Retorno	48 h e 7 dias na sinovite — se piorou ou febre, volta ao alarme.

DICAS

- Criança com "dor no joelho" e joelho normal: é o quadril. Examine sempre o quadril de quem reclama do joelho.

Baseado em: Kocher et al., JBJS 1999/2004; AAOS OrthoInfo — Transient synovitis; SCFE; POSNA — Limping child.

CAPÍTULO 8

Criança: fraturas e cotovelo

O osso da criança dobra, remodela e cola rápido; o cotovelo é a exceção que vai para a cirurgia hoje — e a história que não bate com a fratura é notificação.

8.1	**Fraturas na criança: tórus, galho verde e fise** A fratura em tórus do rádio distal trata com tala removível por 3 semanas e nem precisa de raio-X de controle; o galho verde angulado reduz e vai ao gesso; a fise (Salter-Harris) reduz uma vez, com delicadeza, e tem retorno marcado por um ano — e você faz tudo isso, com a família ouvindo o que vai remodelar.	149
8.2	**Fratura supracondiliana do úmero na criança** Criança de 3 a 8 anos que caiu sobre a mão e chegou com o cotovelo inchado que não mexe: é supracondiliana até o raio-X provar o contrário — a sem desvio (Gartland I) é gesso a 90° por 3 semanas, sua; a desviada (II e III) é redução e fios no centro cirúrgico hoje, e a mão sem pulso é a urgência das urgências.	154
8.3	**Pronação dolorosa (subluxação da cabeça do rádio)** Criança de 1 a 4 anos que foi puxada ou erguida pelo braço e parou de usá-lo, sem edema nem deformidade, com o cotovelo semifletido e o antebraço pronado: é pronação dolorosa — reduz com uma manobra de 10 segundos, sem raio-X e sem imobilização, e sai da sala brincando.	158

8.1 Fraturas na criança: tórus, galho verde e fise

CID S52.5 / S52.6 / S42.0 / S72.3 / S82.2 · **Também** fratura em criança, tórus, fratura em galho verde, Salter-Harris, fise, placa de crescimento, punho da criança, antebraço da criança, clavícula na criança, fêmur na criança, fratura do deambulador

> A fratura em tórus do rádio distal trata com tala removível por 3 semanas e nem precisa de raio-X de controle; o galho verde angulado reduz e vai ao gesso; a fise (Salter-Harris) reduz uma vez, com delicadeza, e tem retorno marcado por um ano — e você faz tudo isso, com a família ouvindo o que vai remodelar.

O QUE PERGUNTAR

- Mecanismo e se bate com a lesão (altura da queda, quem viu)? Idade (quanto mais nova, mais remodela)? Dominância? Já quebrou antes (osteogênese imperfeita, maus-tratos)?
- Dor em outro lugar (criança pequena não localiza: examine o membro inteiro e o outro lado)? Dormência, formigamento?
- Vacina, alergia, jejum (se vai precisar de sedação).

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Exame do membro inteiro, comparando	Inspeção de deformidade, edema e equimose; palpação osso a osso de distal para proximal, deixando o ponto doloroso por último; articulações acima e abaixo; mobilidade ativa que a criança aceita.	Ponto doloroso localizado sobre o osso → raio-X; edema sem ponto ósseo → partes moles.
Neurovascular e compartimentos	Pulso, enchimento capilar, cor, mover os dedos (brincadeira: "faz joinha, faz garra, abre a mão"), sensibilidade por toque leve.	Antebraço tenso e dor crescente → compartimental: mais frequente na criança sedada ou no gesso circular.
Sinais de maus-tratos	Fraturas em várias idades (calos antigos), metafisárias "em alça de balde" ou de canto, costelas posteriores, fêmur ou úmero em quem não anda, história que muda, demora em procurar atendimento, outras lesões (queimadura, hematomas em padrão).	Qualquer um → esqueleto completo (raio-X de corpo inteiro), internação se preciso, notificação (SINAN e Conselho Tutelar) — obrigatória, não é acusação.

SINAIS DE ALARME

- Cotovelo inchado que a criança não mexe após queda: supracondiliana até prova em contrário (próximo tópico) — não é este tópico.
- Fratura desviada com pele tensa ou ferida, pulso alterado, dedos frios: redução e cirurgia hoje.
- Fêmur em menor de 1 ano ou em quem não anda, e qualquer fratura com história incompatível: notificação obrigatória e proteção da criança (não dê alta para o mesmo cuidador sem a rede acionada).
- Salter-Harris III, IV e V, ou fise desviada > 2 mm após redução: cirurgia (parafuso) — ortopedia pediátrica em dias.

IMAGEM

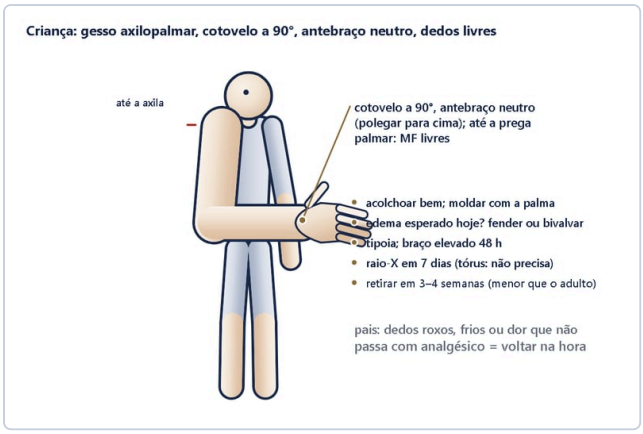
- RX em duas incidências com as articulações vizinhas; comparar com o outro lado se dúvida (fises abertas confundem). Tórus: "dobra" no córtex metafisário. Galho verde: córtex rompido de um lado, dobrado do outro. Fise: classifique Salter-Harris (I: só a fise, pode ter raio-X normal; II: fise + metáfise, a mais comum; III: fise + epífise/articular; IV: atravessa tudo; V: esmagamento). Raio-X de controle: só nas reduzidas (7–10 dias) e nas fises (3 semanas e 6–12 meses).

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Tórus (torus/buckle) do rádio distal: tala removível (órtese de punho ou tala gessada) por 3 semanas, sem raio-X de controle, alta com analgesia por kg e orientação; retorno em 3 semanas só para tirar — é a fratura mais comum e a mais simples.
- Galho verde de antebraço angulado além do aceitável (ver conduta): redução sob sedação (pediatra/anestesista) ou bloqueio de hematoma no maior, completando a fratura do córtex quando a angulação é grande (senão volta); gesso axilopalmar (acima do cotovelo) 4–6 semanas; raio-X em 7–10 dias.
- Rádio distal completo ou fise Salter-Harris I–II desviada: redução suave, uma tentativa boa (cada tentativa a mais lesa a fise), gesso antebraquiopalmar bem moldado (axilopalmar se instável), raio-X de controle em 7–10 dias; fise com mais de 5–7 dias de evolução: não reduza (lesa a fise) — aceite ou cirurgia.
- Clavícula (galho verde ou completa no terço médio): tipoia 2–3 semanas, sem raio-X de controle, calo é normal. Fêmur: < 6 meses Pavlik (ou spica); 6 meses–5 anos: gesso pelvipodálico (spica) precoce; > 5 anos: hastes flexíveis ou placa — ortopedia pediátrica em dias; tíbia do deambulador (espiral oblíqua sutil em 1–3 anos que mancou após torção): gesso ou bota por 3–4 semanas.
- Toda redução: analgesia por kg antes do raio-X; sedação é com pediatra ou anestesista; os pais ficam junto quando dá.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

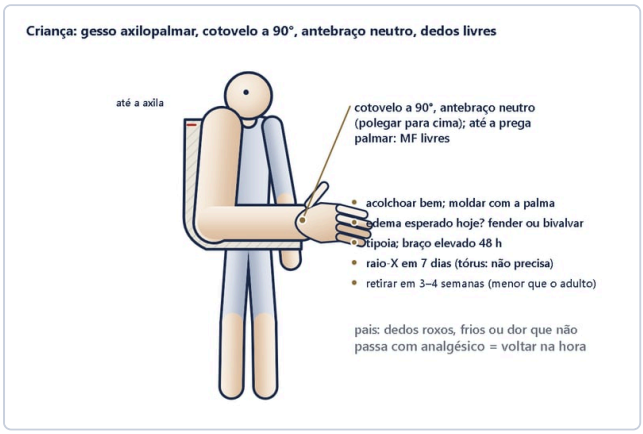
Gesso axilopalmar (acima do cotovelo) na criança



1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Fratura de antebraço reduzida ou instável, galho verde angulado, rádio distal desviado em < 10 anos. Tala nos primeiros 5–7 dias se muito edema; gesso circular bivalvado se feito no dia.

Material e anestesia: Gesso 8–10 cm, algodão ortopédico, malha tubular, ajudante segurando os dedos com o cotovelo a 90°.

Passo a passo

1. Malha e algodão da prega palmar até o terço proximal do braço, acolchoando epicôndilos, olécrano e estiloides.
2. Antebraço em neutro (ou supinação leve nas fraturas distais com desvio dorsal), punho em leve flexão e desvio ulnar (rádio distal) ou neutro (galho verde), cotovelo a 90°.
3. Molde em três pontos sobre a fratura (não aperte: molde com as palmas) e ovalize o antebraço (índice de gesso < 0,8 reduz perda de redução).
4. Dedos livres até a prega palmar (devem fletir a metacarpofalângica); bivalve se gesso circular no dia da fratura.

Depois: Raio-X com o gesso; orientação escrita (elevar, mexer os dedos, sinais de aperto, não molhar); retorno em 7–10 dias com raio-X. Tempo: 4–6 semanas (menor quanto mais nova).

CONDUTA

- O que remodela (aceitar sem reduzir): < 10 anos, rádio distal até 15–20° de angulação no plano sagital e 100% de desvio lateral (“baioneta”) com contato ósseo; antebraço (diáfise) até 10–15° em < 10 anos e 10° em 10–12 anos; rotação não remodela nunca; fise distal do rádio: até 20° em < 10 anos. Quanto mais perto da fise e mais nova, mais remodela — explique com o desenho.

- Tempo de gesso: tórus 3 semanas; rádio distal 4 semanas (< 10 anos) a 6 (adolescente); antebraço 6 semanas; tíbia 6–8; fêmur conforme a idade. Raio-X de controle em 7–10 dias nas reduzidas e instáveis (desvio secundário acontece em 20–30%), não nas estáveis.
- Fise (Salter-Harris): retorno em 6 e 12 meses com raio-X para ver a barra de crescimento (parada parcial = deformidade angular; completa = encurtamento), mais frequente em fêmur distal, tíbia distal e rádio distal; avise os pais no primeiro dia.
- Depois do gesso: rigidez de punho e cotovelo some em 2–4 semanas de uso normal; fisioterapia raramente; sem esporte de contato por 2–4 semanas.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona gotas 500 mg/mL	10–20 mg/kg por dose = de 1 gota a cada 2 kg até 1 gota/kg (25 gotas por mL; 1 gota/kg é o teto da bula), de 6/6 h se dor.	A partir de 3 meses; em dose certa é segura.
Paracetamol gotas 200 mg/mL	10–15 mg/kg por dose = 1 gota/kg (15 gotas por mL), de 6/6 h se dor; máximo 5 doses por dia.	Alternativa ou soma à dipirona.
Ibuprofeno gotas 100 mg/mL	10 mg/kg por dose = 2 gotas/kg (20 gotas por mL); na apresentação de 50 mg/mL, 4 gotas/kg. De 8/8 h, por 3 a 5 dias, com alimento; máximo 400 mg por dose.	A partir de 6 meses; não na desidratação nem na doença renal.

IMOBILIZAÇÃO

- Tórus: tala removível 3 semanas. Rádio distal e antebraço reduzidos: gesso (axilopalmar nas instáveis) 4–6 semanas, raio-X em 7–10 dias. Clavícula: tipoia 2–3 semanas. Tíbia do deambulador: gesso ou bota 3–4 semanas.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- 7–10 dias: raio-X com o gesso nas reduzidas e nas instáveis; perdeu a redução além do aceitável → nova redução (se < 2 semanas e não é fise) ou cirurgia (fios) — ortopedia pediátrica.
- Fim do gesso: retirar, examinar; raio-X só nas que foram reduzidas ou se dor no foco; liberar atividade progressiva.
- Fise: 6 e 12 meses, raio-X comparado com o outro lado; qualquer angulação nova ou encurtamento → ortopedia pediátrica (epifisiodese, osteotomia).
- Refratura de antebraço (5–10% no primeiro ano): tratar de novo; avisar os pais para não liberar barra fixa e esporte de contato nos primeiros 2–3 meses.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: fratura exposta, desviada com pele ou pulso comprometido, fêmur em > 5 anos, antebraço de adolescente instável ou que perdeu a redução, Salter-Harris III–IV e fise desviada > 2 mm após redução, Monteggia e Galeazzi (luxação associada), fise com barra de crescimento — ortopedia pediátrica (hoje nas vasculares e expostas; dias nas outras). Maus-tratos: notificação e rede de proteção, independentemente da fratura.

Atestado	Escola: dispensa de educação física e recreio pelo tempo do gesso; atestado de acompanhante para o responsável no dia e nos retornos.
Retorno	7–10 dias nas reduzidas; fim do gesso; fise: 6 e 12 meses.

DICAS

- Raio-X normal com dor sobre a fise após trauma é Salter-Harris I: imobilize 2–3 semanas e repita o raio-X. Não diga "só contusão".

- Na criança que “não mexe o braço” sem edema nem dor óssea após um puxão, pense em pronação dolorosa antes de pedir raio-X.

Baseado em: AAOS/POSNA — Pediatric distal radius and forearm fractures; NICE NG38 (children: buckle fractures); Salter & Harris 1963; AAP — The evaluation of suspected child physical abuse 2015; Lei 13.431/2017 e ECA art. 13.

8.2 Fratura supracondiliana do úmero na criança

CID S42.4 · **Também** cotovelo da criança, criança caiu e não mexe o cotovelo, supracondiliana, Gartland, fratura do cotovelo infantil, mão fria após fratura do cotovelo

> Criança de 3 a 8 anos que caiu sobre a mão e chegou com o cotovelo inchado que não mexe: é supracondiliana até o raio-X provar o contrário — a sem desvio (Gartland I) é gesso a 90° por 3 semanas, sua; a desviada (II e III) é redução e fios no centro cirúrgico hoje, e a mão sem pulso é a urgência das urgências.

O QUE PERGUNTAR

- Queda sobre a mão com o cotovelo estendido (extensão, 95%)? Hora? Dormência ou formigamento, consegue mexer os dedos? Jejum desde quando?
- Dor desproporcional, piora ao esticar os dedos (compartimental do antebraço — Volkmann)?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Pulso, perfusão e os três nervos — antes de tudo, anotado com hora	Pulso radial, enchimento capilar e cor da mão. Nervos: interósseo anterior (faz "OK" com polegar e indicador fletidos — o mais lesado na extensão), mediano (sensibilidade do indicador), radial (estende punho e polegar, sensibilidade do dorso da 1ª comissura), ulnar (abre os dedos em leque, sensibilidade do mínimo — o mais lesado na flexão e após fios mediais).	Mão rosada sem pulso → urgência cirúrgica (redução pode devolver o pulso); mão pálida e fria → emergência vascular: cirurgia agora, vascular junto.
Deformidade e pele	Cotovelo em "S" (deformidade em extensão), equimose anterior na prega (sinal da dobra: o fragmento proximal perfurou o braquial — grave), pele tensa ou com "tenda".	Equimose/ruga anterior → Gartland III com partes moles interpostas: não traciona em casa, vai para o centro cirúrgico.
Classificação de Gartland (no raio-X)	I: sem desvio (só coxim gorduroso e linha umeral anterior cruzando o capítulo). II: cortical posterior íntegra, capítulo atrás da linha umeral anterior (angulado). III: desvio completo, sem contato. IV: instável em flexão e extensão (no centro cirúrgico).	I → gesso. II e III → redução e fixação com fios sob anestesia (II sem rotação e com a linha tocando o capítulo pode ser gesso em flexão > 90° a critério do ortopedista pediátrico — não assuma sozinho).

SINAIS DE ALARME

- Mão sem pulso: alinhe suavemente o cotovelo em 20–30° de flexão (não a 90°), reavalie em minutos; sem pulso ainda → centro cirúrgico agora (sua regulação é "vaga zero": isquemia).
- Mão pálida, fria, sem enchimento capilar, com ou sem pulso Doppler: lesão da artéria braquial — vascular e ortopedia na mesma sala.
- Dor desproporcional no antebraço, dor ao estender os dedos: síndrome compartimental — abrir tudo, cotovelo em extensão, cirurgia (fasciotomia) em horas.
- Fratura aberta (ponta óssea anterior): antibiótico (cefazolina 30 mg/kg), cirurgia hoje.

IMAGEM

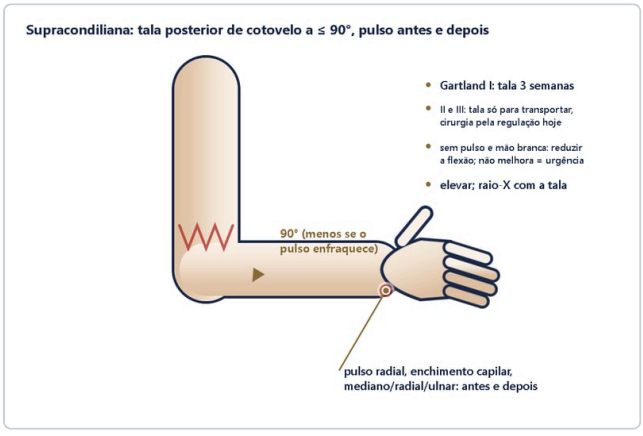
- RX de cotovelo AP e perfil verdadeiro (a 90°, sem rodar) — e do punho e úmero se dor (fratura ipsilateral de antebraço em 5%: "cotovelo flutuante", cirurgia). No perfil: coxim gorduroso posterior (= fratura oculta), linha umeral anterior deve cruzar o terço médio do capítulo (não cruza = desvio), ângulo de Baumann no AP (varo). Comparar com o outro lado se dúvida. Nada de tomografia ou ressonância de rotina.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

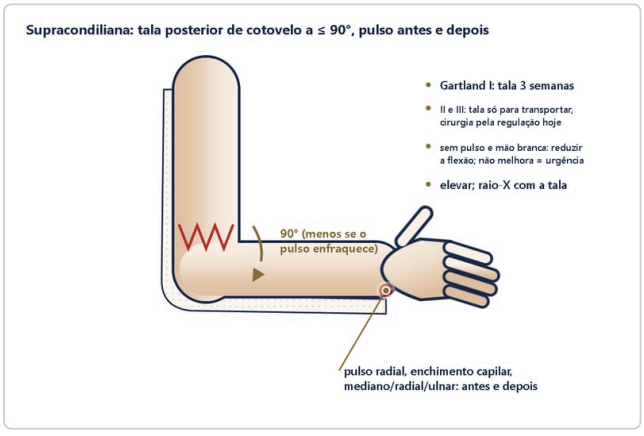
- Gartland I (sem desvio, coxim gorduroso + linha umeral anterior cruzando o capítulo): tala gessada posterior (ou gesso axilopalmar bivalvado) a 90° com antebraço neutro por 3 semanas, tipoia, raio-X em 7 dias (desvio?), alta hoje com analgesia por kg e orientação escrita.
- Gartland II e III com mão perfundida: analgesia EV por kg, tala posterior em 20–40° de flexão (nunca 90° — comprime a artéria e o antebraço edemaciado), elevação, jejum, neurovascular a cada hora anotado; cirurgia (redução fechada + fios percutâneos) em até 12–24 h — aqui com o ortopedista, ou regulação como urgência ("supracondiliana Gartland III à [lado], mão perfundida, pulso presente, nervos íntegros às [hora]"). Não tente reduzir no plantão sem centro cirúrgico: reduz-se uma vez, sob anestesia, com fluoroscopia.
- Gartland III com mão sem pulso ou com déficit nervoso: a mesma coisa, agora — transporte imediato; se o centro cirúrgico é aqui, abre-se a sala enquanto você telefona.
- Fratura de antebraço junto (cotovelo flutuante) ou exposta: cirurgia hoje.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

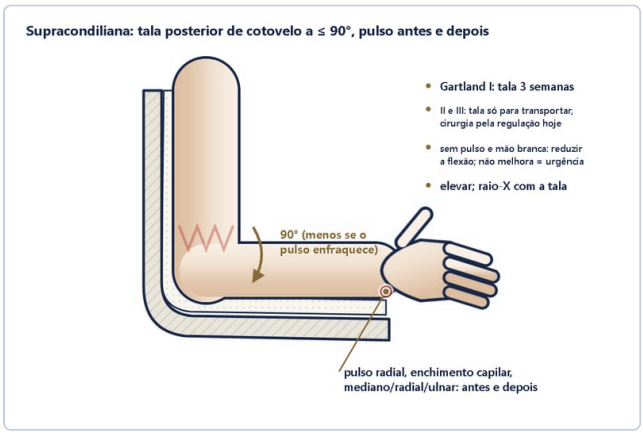
Tala posterior do cotovelo na supracondiliana (Gartland I, ou transporte das II–III)



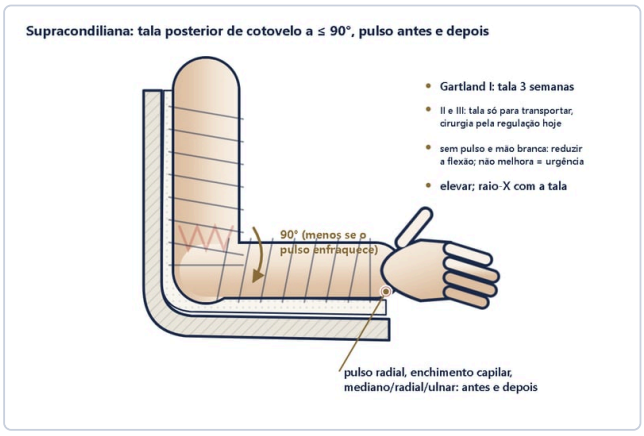
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Toda supracondiliana no plantão: a 90° na Gartland I; em 20–40° nas desviadas que aguardam cirurgia.

Material e anestesia: Gesso 8–10 cm (10–12 camadas), algodão, crepe, tipoia; um ajudante segurando a mão.

Passo a passo

1. Analgesia feita. Ajudante segura o punho sem tração; você apoia o cotovelo.
2. Acolchoe olécrano, epicôndilos e punho. Tala posterior do terço proximal do braço à prega palmar, com o antebraço em neutro.
3. Gartland I: cotovelo a 90°. II–III: 20–40° de flexão (perfusão primeiro, alinhamento depois).
4. Enfaixe frouxo (o edema vem); tipoia; mão elevada no nível do coração.

Depois: Pulso, enchimento capilar, cor e os três nervos de novo, anotados com a hora; raio-X com a tala. Nas desviadas: reavaliar de hora em hora até o centro cirúrgico.

CONDUTA

- Gartland I: tala/gesso 3 semanas (4 no adolescente), raio-X em 7 dias; depois tirar e usar — amplitude volta em 4–6 semanas sem fisioterapia na maioria; sem esporte de contato por mais 3–4 semanas.
- Operada (fios): o cirurgião tira os fios em 3–4 semanas no ambulatório (sem anestesia); gesso sai junto; retorno com você para a amplitude e o alinhamento (ângulo de carregamento) em 6 semanas e 6 meses.
- Lesão nervosa (10–15% nas III, mais o interósseo anterior): neuropraxia em quase todas — recupera em 2–4 meses; se não houve melhora em 3 meses, eletroneuromiografia e cirurgia da mão/ortopedia pediátrica.
- Cúbito varo (cotovelo "virado para dentro") é a sequela da redução ruim; osteotomia só se incomoda, anos depois.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona gotas 500 mg/mL	10–20 mg/kg por dose = de 1 gota a cada 2 kg até 1 gota/kg (25 gotas por mL; 1 gota/kg é o teto da bula), de 6/6 h se dor.	A partir de 3 meses; em dose certa é segura.
Paracetamol gotas 200 mg/mL	10–15 mg/kg por dose = 1 gota/kg (15 gotas por mL), de 6/6 h se dor; máximo 5 doses por dia.	Alternativa ou soma à dipirona.
Ibuprofeno gotas 100 mg/mL	10 mg/kg por dose = 2 gotas/kg (20 gotas por mL); na apresentação de 50 mg/mL, 4 gotas/kg. De 8/8 h, por 3 a 5 dias, com alimento; máximo 400 mg por dose.	A partir de 6 meses; não na desidratação nem na doença renal.
Morfina 10 mg/mL (diluída: 1 mg/mL)	0,05–0,1 mg/kg EV lento, pode repetir em 15–20 min; só na desviada aguardando cirurgia, com monitorização.	Criança: pediatra junto; antiemético se vômito.

IMOBILIZAÇÃO

- Tala posterior a 90° (Gartland I) por 3 semanas, ou em 20–40° (desviadas até a cirurgia).

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Gartland I: raio-X em 7 dias (linha umeral anterior ainda cruza o capítulo? Baumann simétrico?); desviou → ortopedia pediátrica (fios); 3 semanas: tira e libera movimento.
- Operada: ferida dos fios (infecção superficial em 2–5%: cefalexina e retirada), retirada dos fios em 3–4 semanas, raio-X; 6 semanas: amplitude; 6 meses: ângulo de carregamento comparado com o outro lado.
- Rigidez após 6 semanas de uso normal: fisioterapia; nunca manipulação forçada (miosite ossificante).

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: toda Gartland II e III (redução e fios no centro cirúrgico — ortopedia pediátrica/ortopedista aqui ou pela regulação de urgência em 12–24 h; agora se sem pulso, pálida, aberta, compartimental ou com déficit nervoso), cotovelo flutuante, lesão vascular (vascular), lesão nervosa sem recuperação em 3 meses.

Atestado	Escola: 3–4 semanas sem educação física; atestado de acompanhante para o responsável nos dias de cirurgia e retornos.
Retorno	7 dias com raio-X (Gartland I); 3 semanas; operada: conforme o cirurgião, depois 6 semanas e 6 meses.

DICAS

- O cotovelo da criança desviado vai para a tala em 20–40°, não a 90°. É a única imobilização em que a posição "bonita" isquemia a mão.
- O sinal de que a redução sem cirurgia não serve é a linha umeral anterior: se não cruza o capítulo, vai para os fios.

Baseado em: AAOS CPG — Pediatric supracondylar humerus fractures 2011/2022; POSNA — Supracondylar fracture; BOAST — Supracondylar fractures of the humerus in children; Gartland classification (1959) / Wilkins modification.

8.3 Pronação dolorosa (subluxação da cabeça do rádio)

CID S53.0 · **Também** cotovelo de babá, criança não mexe o braço após puxão, puxou pelo braço, nursemaid's elbow, subluxação da cabeça do rádio, braço mole da criança

> Criança de 1 a 4 anos que foi puxada ou erguida pelo braço e parou de usá-lo, sem edema nem deformidade, com o cotovelo semifletido e o antebraço pronado: é pronação dolorosa — reduz com uma manobra de 10 segundos, sem raio-X e sem imobilização, e sai da sala brincando.

O QUE PERGUNTAR

- Puxão pelo braço (segurar pela mão ao cair, levantar pelo braço, "girar" brincando)? Idade 6 meses a 5 anos (pico 1–3)? Já aconteceu (recorre em 20–30%)?
- Houve queda ou pancada no cotovelo, há edema ou deformidade? (Se sim, é fratura até o raio-X — não é este tópico.)

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Postura e inspeção	Braço pendente ao lado do corpo, cotovelo em leve flexão, antebraço pronado; a criança não usa a mão (parece "paralisia"), mas não chora em repouso; sem edema, sem equimose, sem deformidade.	Esse quadro, com história de puxão → pronação dolorosa; não precisa de raio-X.
Palpação osso a osso	Clavícula, úmero, cotovelo (epicôndilos, olécrano, cabeça do rádio), antebraço, punho e mão — a criança deixa se você não for direto ao cotovelo.	Dor óssea localizada, edema ou crepitação → raio-X antes de qualquer manobra (fratura supracondiliana, clavícula, rádio distal).

SINAIS DE ALARME

- Edema, deformidade, equimose ou história de queda: raio-X antes de manipular — a manobra em supracondiliana desloca a fratura.
- Não reduziu após duas tentativas, ou a criança não voltou a usar o braço em 30–60 minutos: raio-X de cotovelo e antebraço (fratura oculta, Monteggia) e tala.
- Pronação dolorosa em criança > 5–6 anos ou sem história de puxão: desconfie de outra coisa (fratura, artrite, osteomielite — febre?).

IMAGEM

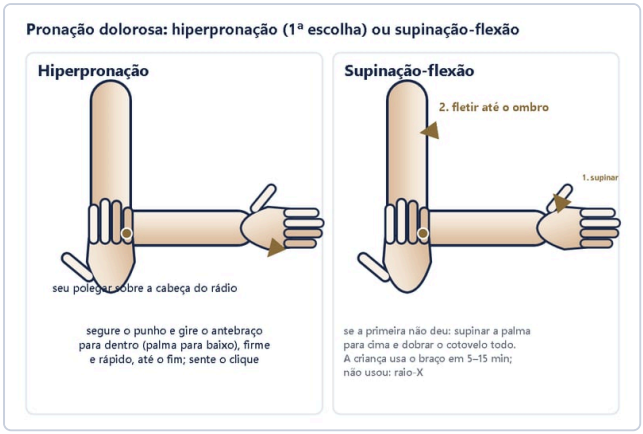
- Nenhum, na história típica sem edema. Raio-X de cotovelo AP e perfil (e antebraço) se dúvida, trauma, edema, falha da redução ou criança fora da idade — o raio-X da pronação dolorosa é normal.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

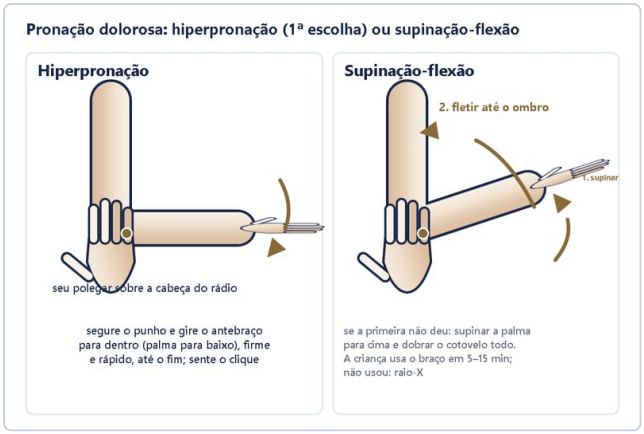
- Quadro típico: explique aos pais o que vai fazer (um estalo, um choro de 10 segundos), reduza por hiperpronação (ou supinação-flexão), dê um brinquedo ao alcance da mão doente e espere 10–30 minutos fora da sala: a criança usa o braço de novo — alta sem raio-X, sem tala, sem receita.
- Não voltou a usar em 30 minutos: repita uma vez com a outra técnica; ainda não → raio-X; normal → tipoia por 1–2 dias e retorno em 48 h (muitas reduzem sozinhas); com fratura → trate a fratura.
- Recorrente (3ª vez ou mais): a mesma redução; oriente a não levantar nem puxar pelo braço; a cabeça do rádio "amadurece" e para de sair por volta dos 5 anos.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

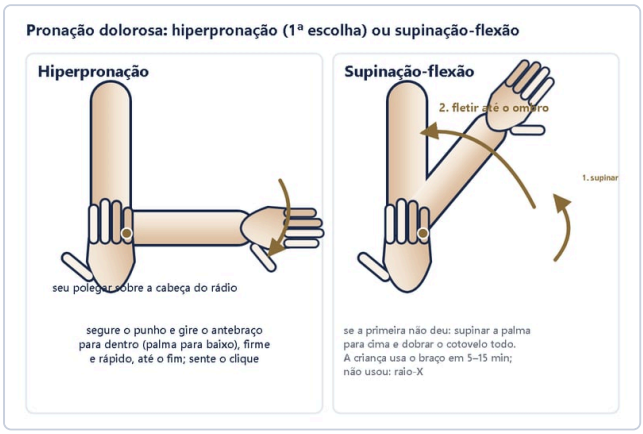
Redução da pronação dolorosa — hiperpronação (primeira escolha) e supinação-flexão



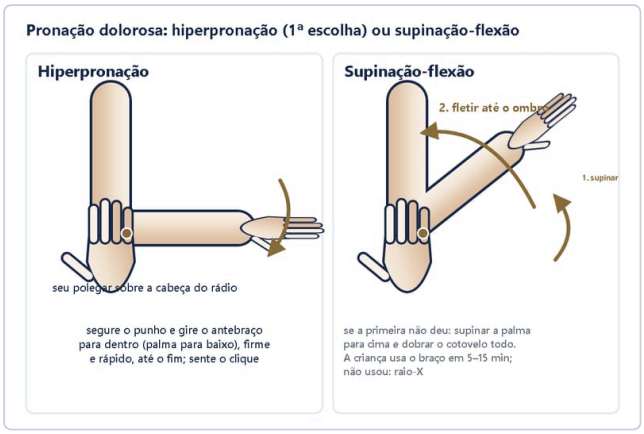
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: História típica, sem edema nem deformidade. Pais avisados do choro curto.

Material e anestesia: Nada: a criança no colo do responsável, de frente para você.

Passo a passo

1. Segure o cotovelo da criança com uma mão, o polegar sobre a cabeça do rádio (face lateral, abaixo do epicôndilo), o cotovelo a 90°.
2. Hiperpronação: com a outra mão no punho, rode o antebraço para dentro (palma para baixo e além), firme e rápido — sente-se o clique sob o polegar. Taxa de sucesso maior e menos dor do que a supinação (ensaios).
3. Se não cliques: supinação-flexão — supine o antebraço (palma para cima) com tração leve e flexione o cotovelo ao máximo em um movimento contínuo; o clique vem na flexão.
4. Saia da sala, deixe um brinquedo do lado doente; em 10–30 minutos a criança pega. Não há dor residual quando reduziu.

Depois: Sem imobilização, sem raio-X, sem retorno se usou o braço. Oriente: nunca levantar ou puxar pelo braço ou pela mão; pegar por baixo das axilas.

CONDUTA

- Nenhum tratamento além da redução; analgesia por kg só se demorou horas e está irritada.
- Orientação aos pais e cuidadores (creche): não puxar pelo braço, não balançar pela mão; recorre em 1 de 4 até os 4–5 anos e para sozinho.

- Se reduziu sozinha em casa (comum), não precisa de consulta.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona gotas 500 mg/mL	10–20 mg/kg por dose = de 1 gota a cada 2 kg até 1 gota/kg (25 gotas por mL; 1 gota/kg é o teto da bula), de 6/6 h se dor.	A partir de 3 meses; em dose certa é segura.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Não precisa de retorno se usou o braço na sala. 48 h se saiu com tipoia e dúvida: ainda não usa → raio-X (de novo se já fez) e ortopedia pediátrica.
- Família que volta pela 3ª–4ª vez: reforce a orientação; não há cirurgia nem órtese que previna — só o tempo.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: quase nada — fratura encontrada no raio-X após falha (trate conforme o tópico da fratura ou ortopedia pediátrica), e a criança que não usa o braço em 48 h com raio-X normal (ortopedia pediátrica, dias).

Atestado	Nenhum; atestado de acompanhante do dia para o responsável, se pedir.
Retorno	Nenhum se reduziu; 48 h se saiu em dúvida com tipoia.

DICAS

- O erro do plantão é pedir raio-X em toda criança que "não mexe o braço": na história típica sem edema, a manobra é o diagnóstico e o tratamento.
- O erro contrário é pior: hiperpronar um cotovelo inchado. Edema = raio-X primeiro.

Baseado em: Cochrane — Manipulative interventions for reducing pulled elbow in young children 2017; AAOS OrthoInfo — Nursemaid's elbow; POSNA — Radial head subluxation.

CAPÍTULO 9

Joelho

Trauma com derrame em horas é ligamento ou fratura; derrame no dia seguinte é menisco; dor sem trauma é patela ou artrose.

9.1	**Osteoartrite de joelho** Dor ao subir e descer escada e ao levantar, rigidez matinal < 30 min, crepitação, > 50 anos: artrose — exercício, peso, analgesia tópica; prótese quando limitar.	162
9.2	**Entorse de joelho: LCA, LCM e LCP** Torção com estalo e derrame em 1 a 2 horas é LCA até prova em contrário; dor medial após valgo é LCM, que cura sem cirurgia; o exame é no dia, antes de o joelho travar de dor.	165
9.3	**Lesão meniscal** Dor na interlinha ao agachar e torcer, com derrame que vem no dia seguinte e às vezes travamento: menisco — no jovem traumático pode operar; no > 45 anos degenerativo trata como artrose.	168
9.4	**Dor patelofemoral e condromalácia** Dor difusa na frente do joelho ao descer escada, agachar e ficar sentado, em jovem ativo, sem derrame: síndrome patelofemoral — fortalecer quadril e quadríceps; raio-X e ressonância quase nunca ajudam.	171
9.5	**Cisto de Baker e bursites do joelho** Caroço atrás do joelho é cisto de Baker, que é sintoma de outra coisa dentro do joelho; inchaço mole na frente da patela é bursite pré-patelar; dor na face medial abaixo da interlinha é bursite anserina.	174

9.1 Osteoartrite de joelho

CID M17 · **Também** artrose de joelho, desgaste do joelho, gonartrose, joelho do idoso, dor no joelho para subir escada

> Dor ao subir e descer escada e ao levantar, rigidez matinal < 30 min, crepitação, > 50 anos: artrose — exercício, peso, analgesia tópica; prótese quando limitar.

O QUE PERGUNTAR

- Dói mais ao começar a andar e melhora, ou piora ao longo do dia? Trava ou falseia (menisco degenerativo, corpo livre)? Incha?
- Peso, atividade, trabalho ajoelhado, cirurgia prévia, menisco retirado?
- Rigidez matinal > 1 h e várias articulações (artrite inflamatória)?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Inspeção e alinhamento	Varo (joelhos afastados) ou valgo em pé; atrofia de quadríceps; derrame.	Varo → artrose medial, a mais comum.
Mobilidade e crepitação	Flexão e extensão com a mão sobre a patela.	Crepitação grossa e perda de extensão → artrose.
Interlinha e sinal da tecla	Palpar as interlinhas medial e lateral; comprimir a patela com derrame.	Dor na interlinha medial → artrose medial / menisco; tecla → derrame.
Quadril	Rotação interna do quadril.	Dor → dor referida do quadril, não do joelho.

SINAIS DE ALARME

- Derrame quente com febre: artrite séptica — punção. Derrame agudo sem trauma em > 60 anos: pseudogota (condrocalcinose) — punção se possível.
- Dor noturna constante e perda de peso: tumor (raro).

IMAGEM

- RX de joelho AP com carga, perfil, axial de patela e Rosenberg (PA 45° com carga): mostra o estreitamento. Ressonância NÃO é necessária na artrose — acha menisco degenerativo em quase todos e leva a artroscopia inútil.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão (crise de dor ou derrame em artrose conhecida): joelho quente ou febre → punção e análise do líquido (ver Punção e infiltração) — séptica interna, pseudogota trata; sem sinais de infecção → punção se tenso, infiltração de corticoide, analgesia, AINE tópico, bengala, alta com retorno no ambulatório.
- Idoso com artrose que caiu e não apoia: raio-X (platô tibial? fratura por insuficiência?) antes de chamar de “crise de artrose”.

CONDUTA

- Exercício é o tratamento com melhor evidência: fortalecimento de quadríceps (cadeira extensora leve, agachamento parcial, subir degrau), bicicleta, hidroginástica; fisioterapia para ensinar e progredir. 3× por semana por 12 semanas, depois manter.

- Perda de peso ≥ 5–10% do peso reduz dor de forma clara.
- Primeira linha medicamentosa: AINE tópico (diclofenaco gel) — tão eficaz quanto oral no joelho e sem efeito gástrico. Paracetamol/dipirona têm efeito pequeno; AINE oral em cursos curtos nas crises.
- Infiltração intra-articular de corticoide: alívio de 4–8 semanas, até 3–4 por ano; ácido hialurônico: efeito pequeno e caro — não como rotina. PRP: sem evidência suficiente.
- Joelheira, palmilha, bengala na mão oposta nas crises. Glucosamina/condroitina: sem benefício.
- Artroscopia para "limpar" artrose não funciona — não indique com essa expectativa. Prótese total (ou osteotomia no jovem varo): dor que limita andar e dormir apesar de 3–6 meses de tratamento — você indica e pede pela regulação.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Diclofenaco dietilamônio gel 11,6 mg/g	Aplicar no joelho 4× ao dia, 2 a 4 g por aplicação, contínuo nas fases dolorosas.	—
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 8–12 semanas: exercício (quadríceps), peso, AINE tópico; infiltração de corticoide nas crises (até 3–4 por ano); joelheira e palmilha.
- Falha de 3–6 meses com dor noturna e marcha < 500 m: indicação de prótese (ou osteotomia no jovem varo) e pedido pela regulação com raio-X com carga; enquanto espera, mantenha o fortalecimento — chega melhor à cirurgia.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a prótese total ou a osteotomia (cirurgião de joelho, eletiva pela regulação, quando a dor limita andar e dormir apesar de 3–6 meses de tratamento com fisioterapia e infiltração), o derrame recorrente que a punção não explicou (reumatologia), e a artrose inflamatória (rigidez > 1 h, várias articulações — reumatologia).

Atestado	0–3 dias nas crises; readaptação se trabalho ajoelhado ou com carga.
Retorno	8–12 semanas.

DICAS

- Paciente de 60 anos com “menisco” na ressonância e artrose no raio-X: trate a artrose. O menisco degenerativo é parte dela.

Baseado em: AAOS CPG — Osteoarthritis of the knee 2021; NICE NG226 — Osteoarthritis 2022; OARSI 2019; Cochrane — Arthroscopic surgery for degenerative knee.

9.2 Entorse de joelho: LCA, LCM e LCP

CID S83.5 / S83.4 · **Também** torceu o joelho, joelho inchou na hora, ligamento cruzado, ligamento colateral, joelho falseia, entorse do joelho, LCA

> Torção com estalo e derrame em 1 a 2 horas é LCA até prova em contrário; dor medial após valgo é LCM, que cura sem cirurgia; o exame é no dia, antes de o joelho travar de dor.

O QUE PERGUNTAR

- Mecanismo (torção com o pé fixo, valgo, hiperextensão, impacto anterior na tíbia)? Ouviu estalo? Inchou em quanto tempo (horas = sangue = LCA/fratura; 1 dia = menisco)?
- Consegue apoiar? Trava? Falseia (instabilidade)? Esporte e profissão?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Derrame e regra de Ottawa	Sinal da tecla. Ottawa: raio-X se ≥ 55 anos, dor isolada na patela, dor na cabeça da fíbula, incapaz de fletir 90°, ou incapaz de dar 4 passos.	Um critério → RX de joelho AP, perfil e axial.
Lachman	Joelho a 20–30° de flexão, uma mão fixa o fêmur, a outra traciona a tíbia à frente.	Deslocamento sem parada firme → LCA (o teste mais sensível; faça antes da gaveta).
Gaveta anterior e posterior	A 90° de flexão, puxar e empurrar a tíbia.	Anterior → LCA; posterior (ou tíbia "afundada" de perfil) → LCP.
Estresse em valgo e varo	A 0° e a 30° de flexão.	Abertura a 30° → LCM (ou LCL); abertura também a 0° → lesão combinada (grave).
Neurovascular	Pulsos pedioso e tibial posterior, dorsiflexão do pé (fibular).	Pulso alterado após trauma de alta energia → luxação reduzida espontaneamente: angiotomografia urgente.

SINAIS DE ALARME

- Instabilidade em várias direções, pulso alterado ou dormência: luxação de joelho — lesão de artéria poplítea em 20–30%: reduza, imobilize, pulsos de hora em hora, ITB, vascular e centro de trauma hoje (ver Luxações).
- Joelho travado em flexão que não estende (alça de balde do menisco): artroscopia em 48 h — cirurgião de joelho pela regulação; não force a extensão.
- Incapaz de estender ativamente o joelho (ruptura de quadríceps ou tendão patelar, fratura de patela desviada): imobilizador em extensão e cirurgia em 1–2 semanas (ver Fratura da patela).

IMAGEM

- RX de joelho AP, perfil e axial conforme Ottawa (procure fratura de Segond: avulsão lateral da tíbia = LCA; platô tibial no idoso). Ressonância em 2–4 semanas se suspeita de LCA, LCP, lesão combinada ou menisco com bloqueio — pedida por você, pela regulação, com a pergunta clínica ("Lachman positivo, hemartrose — LCA? candidato a reconstrução").

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: Ottawa → raio-X; hemartrose tensa → punção (sangue com gordura = fratura; alivia e permite o Lachman); exame ligamentar no dia (Lachman antes do espasmo), pulsos e nervo fibular; sem alarme → imobilizador só se instável ou muita dor, muletas com carga parcial, gelo, analgesia, orientação de mobilizar, alta com retorno em 7 dias para reexaminar.
- Luxação de joelho (frouxo em 3 planos, pulso alterado): ver Luxações — internação, vascular. Bloqueio verdadeiro: cirurgião em 48 h. Extensor roto: imobilizador em extensão e cirurgia em 1–2 semanas.

CONDUTA

- Fase aguda (72 h): PRICE, muletas com carga parcial conforme a dor, imobilizador de joelho só se muita dor ou instabilidade; mover desde cedo (flexão/extensão sentado) para não enrijecer.
- LCM isolada (grau I–II): joelheira articulada 3–6 semanas, fisioterapia; cura sem cirurgia. Grau III isolada: idem, 6–8 semanas.
- LCA: fisioterapia pré-operatória (recuperar extensão e quadríceps) é obrigatória em todo caso; cirurgia (reconstrução) para quem pratica esporte de pivô, trabalho exigente ou instabilidade no dia a dia; o sedentário pode tratar sem cirurgia com fortalecimento — a indicação é sua, com o paciente, e a reconstrução sai pela regulação (eletiva, meses).
- LCP isolada: tratamento conservador na maioria (órtese em extensão, quadríceps).
- Prognóstico: retorno ao esporte 6–9 meses após reconstrução do LCA.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).

IMOBILIZAÇÃO

- Joelheira articulada (LCM) ou imobilizador de joelho só nos primeiros dias; muletas com carga conforme dor.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 7 dias (joelho menos doloroso): repita Lachman, gaveta, estresse; LCM isolada → joelheira articulada 3–6 semanas e fisioterapia; LCA suspeito → ressonância pela regulação, fisioterapia pré-operatória desde já.
- 3–4 semanas: com a ressonância, a decisão (reconstrução × conservador) é sua com o paciente; o pedido cirúrgico vai pela regulação com o laudo e o nível de atividade. Falseio recorrente ou lesão meniscal associada antecipam.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a reconstrução do LCA/LCP e o reparo das lesões combinadas (cirurgião de joelho, eletiva pela regulação após a ressonância e a fisioterapia pré-operatória), a alça de balde encravada (artroscopia em 48 h), a luxação de joelho (vascular + centro de trauma, hoje), a fratura de platô ou de Segond desviada (cirurgia em dias).

Atestado	7–14 dias (escritório, com muletas); braçal: 3–6 semanas; LCA operado: 6–12 semanas.
Retorno	1 semana (reexaminar com o joelho menos doloroso) e 3–4 semanas.

DICAS

- Derrame de sangue em 2 horas num jovem: 70% é LCA, 10% é fratura osteocondral — tome como grave.
- Faça o Lachman no primeiro dia; depois de 24 h o espasmo esconde.

Baseado em: AAOS CPG — ACL injury 2022; Ottawa Knee Rule; KANON trial (BMJ 2013); BOAST — Knee dislocation.

9.3 Lesão meniscal

CID S83.2 / M23.2 · **Também** menisco, joelho travando, joelho trava, estalo no joelho, dor na interlinha, ruptura de menisco

> Dor na interlinha ao agachar e torcer, com derrame que vem no dia seguinte e às vezes travamento: menisco — no jovem traumático pode operar; no > 45 anos degenerativo trata como artrose.

O QUE PERGUNTAR

- Torção com o joelho fletido (jovem) ou começou ao agachar/levantar sem trauma (degenerativo)? Trava (não estende) ou só estala? Incha depois de atividade?
- Idade, artrose prévia, esporte.

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Palpação da interlinha	Joelho fletido a 90°, palpar a interlinha medial e lateral.	Dor localizada → menisco (sensível).
McMurray	Flexão máxima, rotação externa da tíbia e estender (medial); rotação interna (lateral), com a mão na interlinha.	Estalo doloroso palpável.
Thessaly	Em pé no membro doente com o joelho a 20°, girar o corpo 3× para cada lado, segurando as mãos do examinador.	Dor na interlinha ou travamento — o teste com melhor acurácia.
Extensão completa	Comparar a extensão passiva com o outro lado.	Bloqueio elástico → alça de balde: urgência relativa.
Ligamentos	Lachman e estresse (lesão associada).	LCA + menisco é frequente.

SINAIS DE ALARME

- Joelho travado em flexão (não estende): artroscopia em 48 h — cirurgião de joelho pela regulação com urgência; a alça de balde encravada lesa a cartilagem. Não force a extensão; imobilizador na posição que está e muletas até a cirurgia.

IMAGEM

- RX de joelho AP com carga, perfil e axial primeiro (artrose muda tudo). Ressonância se jovem com trauma, bloqueio, ou falha de 6 semanas de conservador em paciente candidato a cirurgia. Em > 50 anos com artrose, a ressonância raramente muda a conduta.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: raio-X primeiro (artrose, fratura), punção se derrame tenso, exame (interlinha, McMurray, Thessaly, extensão completa); bloqueio verdadeiro → imobilizador e cirurgião em 48 h; sem bloqueio → muletas se preciso, gelo, AINE tópico, orientação (sem agachar 6 semanas), alta com retorno em 4–6 semanas.
- > 45 anos sem trauma com artrose no raio-X: é artrose com menisco degenerativo — explique no plantão que a ressonância não muda nada e que o tratamento é exercício.

CONDUTA

- Degenerativo (> 45 anos, sem trauma, sem bloqueio): tratar como artrose — fisioterapia (quadríceps), AINE tópico, evitar agachamento profundo por 6 semanas. Artroscopia não é melhor que fisioterapia (vários ensaios).
- Traumático no jovem, zona vermelha (periférica), com bloqueio ou associado a LCA: sutura meniscal (preservar o menisco) — indicação sua, cirurgião de joelho pela regulação em semanas.
- Lesão traumática estável, sem bloqueio: 6–12 semanas de fisioterapia antes de pensar em artroscopia; meniscectomia parcial se falhar.
- Derrame recorrente: gelo após atividade, AINE curto; infiltração de corticoide se artrose associada.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Diclofenaco dietilamônio gel 11,6 mg/g	Aplicar no joelho 3 a 4× ao dia por 14 dias.	—
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).

IMOBILIZAÇÃO

- Nenhuma; muletas nos primeiros dias só se dor para apoiar.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 4–6 semanas: jovem traumático sem melhora ou com falseio → ressonância pela regulação e a indicação cirúrgica é sua; degenerativo → fisioterapia (quadríceps), infiltração se artrose associada, sem artroscopia.
- Derrame recorrente sem artrose nem trauma → punção e análise (cristais, celularidade) e reumatologia se inflamatório.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a artroscopia — bloqueio verdadeiro (48 h), sutura no jovem com lesão traumática periférica ou associada ao LCA (semanas), meniscectomia parcial no traumático estável que falhou 6–12 semanas de fisioterapia (eletiva); o degenerativo em > 45 anos com artrose não vai à artroscopia (trate como artrose; prótese quando for o caso).

Atestado	3–7 dias; braçal com agachamento: 2–4 semanas.
Retorno	4–6 semanas.

DICAS

- "Menisco rasgado" no laudo de quem tem 55 anos e artrose não é indicação de cirurgia. Diga isso ao paciente antes que ele peça a artroscopia.

Baseado em: ESCAPE trial (JAMA 2018); FIDELITY trial (NEJM 2013); ESSKA consensus — Degenerative meniscus lesions 2017; BMJ Rapid Recommendation 2017.

9.4 Dor patelofemoral e condromalácia

CID M22.2 / M22.4 · **Também** dor na frente do joelho, condromalácia, dor ao descer escada, joelho de corredor, dor ao ficar sentado muito tempo, crepitação na patela

> Dor difusa na frente do joelho ao descer escada, agachar e ficar sentado, em jovem ativo, sem derrame: síndrome patelofemoral — fortalecer quadril e quadríceps; raio-X e ressonância quase nunca ajudam.

O QUE PERGUNTAR

- Dói ao descer escada, agachar, correr, ficar sentado (sinal do cinema)? Começou com aumento de treino? Sente que a patela "sai"?
- Derrame, trauma, bloqueio? (outro diagnóstico).

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Agachamento unipodal	Agachar num pé só olhando o joelho.	Joelho cai em valgo e quadril em adução → fraqueza de glúteo médio — o alvo do tratamento.
Compressão patelar (Clarke)	Segurar a patela proximalmente e pedir contração do quadríceps.	Dor (pouco específico; muitos normais têm).
Apreensão patelar	Empurrar a patela lateralmente com o joelho a 30°.	Medo → instabilidade patelar (luxação prévia).
Flexibilidade	Quadríceps (Ely), isquiotibiais, banda iliotibial (Ober).	Encurtamentos → alongar.

SINAIS DE ALARME

- Derrame, bloqueio, trauma com hemartrose: não é patelofemoral — ver entorse/menisco. Adolescente com dor na tuberosidade tibial: Osgood-Schlatter (benigno, repouso relativo).

IMAGEM

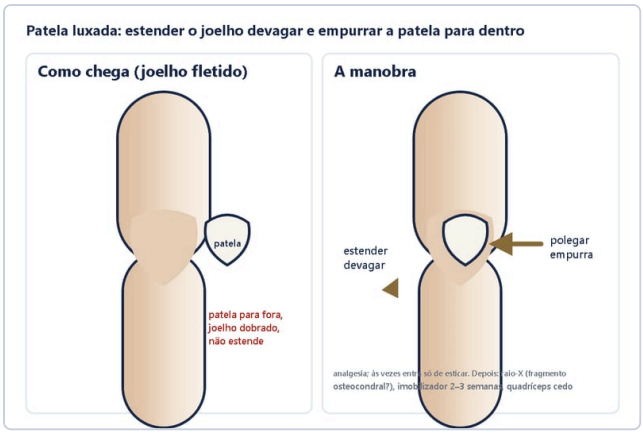
- Não precisa na típica. RX de joelho AP, perfil e axial de patela se > 40 anos, trauma, luxação ou dor > 3 meses sem resposta (displasia, artrose patelofemoral). Ressonância não muda a conduta — "condromalácia grau II" na ressonância não explica nem trata a dor.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

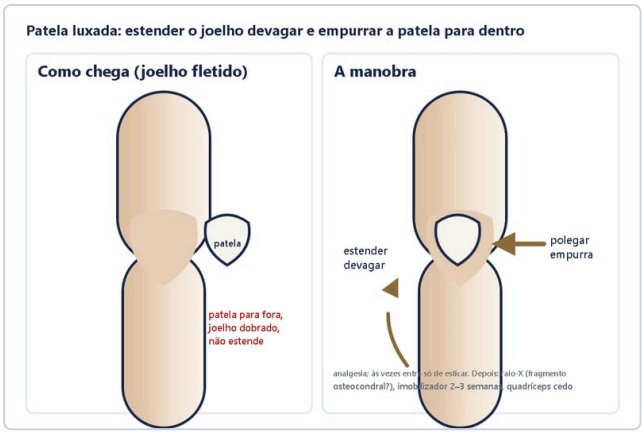
- No plantão, a luxação aguda de patela (patela lateral, joelho fletido): reduza (ver procedimento), raio-X AP, perfil e axial depois (fragmento osteocondral? avulsão medial?), punção da hemartrose se tensa, imobilizador em extensão 2–3 semanas com carga, alta com retorno em 7 dias; fragmento solto → cirurgião em dias.
- Dor anterior do joelho sem trauma nem derrame (o adolescente, a corredora): diagnóstico clínico, sem exame, exercícios escritos, analgesia curta, retorno no ambulatório em 6–8 semanas — não é caso de plantão, mas chega nele.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

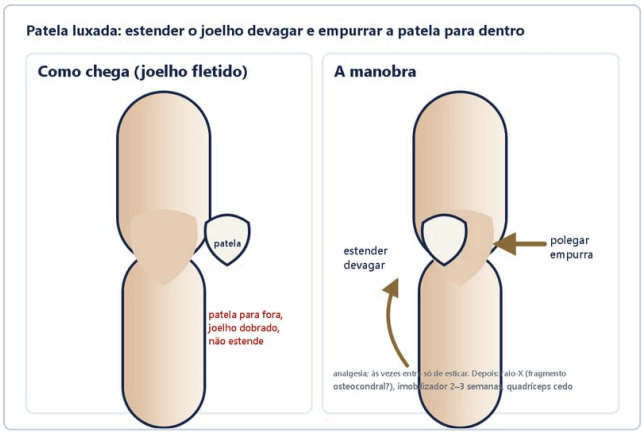
Redução da luxação lateral da patela



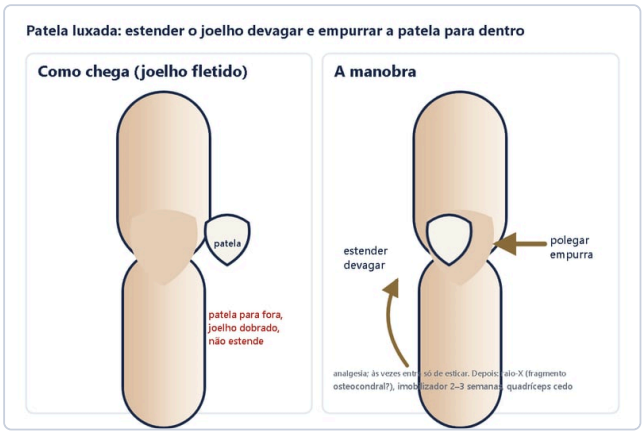
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Patela luxada para lateral com o joelho fletido (a maioria reduz sozinha ao estender). Sem raio-X antes se a deformidade é óbvia; raio-X depois sempre.

Material e anestesia: Analgesia (dipirona EV; raramente sedação), 1 ajudante opcional.

Passo a passo

1. Paciente deitado, tranquilize (a redução é rápida); segure a perna.
2. Estenda o joelho devagar enquanto o seu polegar empurra a patela de lateral para medial, suavemente — ela entra ao chegar perto da extensão.
3. Reduzida: o contorno volta e a dor cai; não force a flexão depois.

Depois: Raio-X AP, perfil e axial (fragmento osteocondral em 5–20%); punção se hemartrose tensa; imobilizador em extensão 2–3 semanas com carga; retorno em 7 dias.

CONDUTA

- Fortalecimento de quadril (abdutores e rotadores externos: concha, abdução lateral, ponte) e quadríceps (agachamento parcial 0–45°, cadeira extensora nos últimos 30°), 3× por semana por 6–12 semanas — é o tratamento.
- Reduzir carga que provoca (corrida, escada, agachamento profundo) por 2–4 semanas, mantendo bicicleta e natação.
- Alongamento de quadríceps, isquiotibiais e banda iliotibial; tape patelar (McConnell) e palmilha em quem prona ajudam no curto prazo.
- Gelo 15 min após atividade; AINE só por poucos dias nas crises — não é anti-inflamatório que trata.
- Cirurgia: praticamente nunca; só na instabilidade patelar recorrente.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Luxação reduzida: retorno em 7 dias (raio-X revisto, derrame), 3 semanas (tira o imobilizador, fisioterapia de vasto medial e quadril); segunda luxação ou apreensão persistente após 3 meses → ressonância e indicação de reconstrução.
- Dor patelofemoral: retorno em 6–8 semanas; o que falha é a aderência ao fortalecimento de quadril — refaça a prescrição, não a imagem.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a luxação de patela com fragmento osteocondral solto no raio-X/ressonância (artroscopia em dias) e a instabilidade patelar recorrente após fisioterapia (reconstrução do ligamento patelofemoral medial — cirurgião de joelho, eletiva pela regulação); a dor patelofemoral em si quase nunca é cirúrgica.

Atestado	0; restrição de agachamento e escada no trabalho por 2–4 semanas.
Retorno	6–8 semanas.

DICAS

- Não diga “condromalácia” para um jovem com joelho normal: cria a ideia de desgaste e medo de mexer. Diga “dor da patela por sobrecarga, que fortalecimento resolve”.

Baseado em: Patellofemoral Pain Consensus (BJSM 2018); Cochrane — Exercise for patellofemoral pain; APTA CPG 2019.

9.5 Cisto de Baker e bursites do joelho

CID M71.2 / M70.4 / M70.5 · **Também** caroço atrás do joelho, cisto poplíteo, bursite pré-patelar, joelho de empregada, inchaço na frente do joelho, bursite anserina, dor na parte interna abaixo do joelho

> Caroço atrás do joelho é cisto de Baker, que é sintoma de outra coisa dentro do joelho; inchaço mole na frente da patela é bursite pré-patelar; dor na face medial abaixo da interlinha é bursite anserina.

O QUE PERGUNTAR

- Cisto: dor ou sensação de peso atrás do joelho ao fletir, piora com atividade? Artrose ou menisco conhecidos? Inchou a panturrilha de repente (cisto roto × trombose)?
- Pré-patelar: trabalha ajoelhado? Ferida, febre, vermelhidão (séptica)?
- Anserina: dor medial abaixo do joelho ao subir escada e à noite, mulher com sobrepeso e artrose?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Palpação poplítea (Baker)	Em pé e deitado: massa medial na fossa poplítea, mais tensa em extensão e mole em flexão (sinal de Foucher).	Cisto de Baker; palpar também a panturrilha.
Bursa pré-patelar	Edema flutuante sobre a patela, joelho sem derrame intra-articular (tecla negativa), mobilidade preservada.	Bursite pré-patelar; calor, rubor e febre → séptica.
Pata de ganso	Ponto doloroso 5–6 cm abaixo da interlinha medial, na face anteromedial da tíbia.	Bursite/tendinopatia anserina.

SINAIS DE ALARME

- Panturrilha dolorosa e edemaciada de repente: cisto roto imita trombose venosa — ultrassom com Doppler para excluir trombose antes de rotular.
- Bursite pré-patelar com calor, rubor, febre ou ferida: séptica — punção, antibiótico (cobre estafilococo) e, se não melhora, drenagem.

IMAGEM

- Baker: ultrassom confirma e exclui trombose; RX de joelho (artrose); ressonância só para a causa intra-articular se for operar. Pré-patelar e anserina: nenhum, salvo dúvida.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: bursa pré-patelar ou do olécrano tensa, quente ou com ferida → punção (cultura, Gram, celularidade), compressão, cefalexina (ou clindamicina se risco de MRSA) e retorno em 48 h; febre alta, celulite extensa, diabético ou imunossuprimido → internação e antibiótico EV.
- Panturrilha dolorosa e inchada de repente com cisto conhecido: Doppler para excluir trombose antes de chamar de cisto roto; cisto roto trata com repouso, gelo e AINE.
- Cisto de Baker sem complicação: não puncionar o cisto; tratar a causa (artrose, menisco) — infiltração intra-articular se artrose.

CONDUTA

- Baker: tratar a causa (artrose, menisco); o cisto some ou diminui com isso. Não puncionar o cisto em si — enche de novo; infiltração intra-articular de corticoide reduz o cisto em quem tem artrose. Excisão só em casos raros.

- Pré-patelar asséptica: evitar ajoelhar (joelheira acolchoada), gelo, compressão, AINE 7 dias; punção se tensa; recorrente → bursectomia.
- Pré-patelar séptica: cefalexina 500 mg 6/6 h por 7–10 dias após punção; reavaliar em 48 h; internar se febre alta, celulite extensa ou diabético.
- Anserina: alongar isquiotibiais, fortalecer quadríceps, perder peso, AINE tópico, gelo; infiltração local de corticoide se refratária.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Diclofenaco dietilamônio gel 11,6 mg/g	Camada fina no local 3 a 4× ao dia por 14 dias.	—
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Cefalexina 500 mg	1 comprimido de 6/6 h por 7 a 10 dias.	Só na bursite séptica, após punção para cultura quando possível.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Bursite séptica: retorno em 48 h (melhorou? senão, drenagem); 7–10 dias (fim do antibiótico). Asséptica: 2 semanas (joelheira, evitar ajoelhar); recorrente após 2 punções → bursectomia.
- Baker: segue com a artrose ou o menisco; ultrassom se mudou de tamanho ou dói mais.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a bursite séptica que não melhora em 48 h de antibiótico após a punção (drenagem/bursectomia — cirurgião, em dias; internação se febre alta, celulite extensa ou diabético), o cisto de Baker com lesão intra-articular operável (artroscopia, eletiva) e a bursite pré-patelar recorrente (bursectomia, eletiva).

Atestado	0–7 dias; trabalho ajoelhado: 2 semanas e joelheira.
Retorno	2 semanas (séptica: 48 h).

DICAS

- Cisto de Baker é um sinal, não uma doença. Pergunte: o que está inflamando este joelho?

Baseado em: AAOS OrthoInfo — Baker's cyst; Prepatellar bursitis; Aaron et al., JAAOS 2011 — Septic bursitis.

CAPÍTULO 10

Tornozelo e pé

A regra de Ottawa decide o raio-X da entorse; o calcanhar que dói de manhã é fáscia; o Aquiles que estala pede Thompson.

10.1	**Entorse de tornozelo** Inversão com dor lateral e edema: regra de Ottawa decide o raio-X, carga precoce e exercício decidem a recuperação; bota só nos graus II–III por poucos dias.	177
10.2	**Fascite plantar** Dor no calcanhar nos primeiros passos da manhã, com ponto doloroso na inserção medial da fáscia: fascite plantar — alongamento, palmilha e paciência (6 a 12 meses); o esporão não é a causa.	180
10.3	**Tendinopatia e ruptura do Aquiles** Dor e espessamento 2 a 6 cm acima da inserção, pior de manhã e ao iniciar corrida, é tendinopatia e trata com excêntrico; estalo súbito com Thompson positivo é ruptura: equino hoje e a sua decisão, em 48 h, entre o protocolo funcional e a cirurgia.	182
10.4	**Fratura de metatarso e do 5º metatarso** A avulsão da base do 5º metatarso (pseudo-Jones) trata com bota ou sapato rígido e carga; a fratura de Jones (metáfise-diáfise) e a por estresse não unem bem: bota sem carga e, no atleta ou na não união, parafuso — tudo decidido por você.	186
10.5	**Hálux valgo, metatarsalgia e neuroma de Morton** Joanete dói pelo sapato e trata com sapato; queimação entre o 3º e 4º dedos que melhora ao tirar o sapato é Morton; dor sob as cabeças dos metatarsos é metatarsalgia — palmilha resolve a maioria, cirurgia é eletiva.	188

10.1 Entorse de tornozelo

CID S93.4 · **Também** torceu o pé, torceu o tornozelo, pé inchado, ligamento do tornozelo, entorse, virou o pé

> Inversão com dor lateral e edema: regra de Ottawa decide o raio-X, carga precoce e exercício decidem a recuperação; bota só nos graus II–III por poucos dias.

O QUE PERGUNTAR

- Como torceu (inversão = lateral, o comum; eversão ou rotação externa = medial/sindesmose, pior)? Conseguiu dar passos logo depois?
- Já torceu antes, falseia (instabilidade crônica)? Dor na base do 5º metatarso?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Regra de Ottawa	RX de tornozelo se dor na zona maleolar + (dor à palpação nos 6 cm distais da borda posterior ou ponta do maléolo lateral ou medial, ou incapaz de dar 4 passos logo após e na consulta). RX de pé se dor no mediopé + (dor na base do 5º metatarso ou no navicular, ou incapaz de 4 passos).	Qualquer critério → raio-X. Nenhum → não precisa (sensibilidade ~98%).
Palpação ligamentar	Talofibular anterior (anterior ao maléolo lateral), calcaneofibular (abaixo), deltoide (medial), sindesmose (acima da articulação, anterior).	Local da dor diz o ligamento; dor na sindesmose → pior prognóstico.
Gaveta anterior e inclinação talar	Pé a 10–15° de flexão plantar, puxar o calcanhar à frente; inversão do calcanhar.	Frouxidão → grau III (melhor avaliar em 4–5 dias, quando dói menos).
Squeeze e rotação externa	Comprimir a perna no terço médio; rodar o pé para fora com o joelho a 90°.	Dor na sindesmose → lesão sindesmal: raio-X com carga ou estresse em rotação externa; diástase é cirurgia (ver Alarme).
Thompson e tendão fibular	Comprimir a panturrilha (Aquiles); palpar fibulares atrás do maléolo lateral.	Sem flexão plantar → Aquiles (ver o tópico); subluxação dos fibulares → bota 4–6 semanas e, se persistir, reparo do retináculo (eletivo).

SINAIS DE ALARME

- Fratura de maléolo com desvio, bimaleolar, de tálus ou luxação: não é entorse — ver Fraturas do tornozelo e Luxações (reduza se luxado; tala posterior + estribo).
- Lesão de sindesmose (squeeze positivo, dor alta, raio-X com diástase ou com estresse em rotação externa): tala sem carga e cirurgia (parafuso/botão de sindesmose) em dias, pela regulação; sem diástase, bota sem carga 4–6 semanas e controle.
- Dor na base do 5º metatarso com fratura: ver fratura de metatarso.

IMAGEM

- Pela regra de Ottawa: RX de tornozelo AP, perfil e mortise; RX de pé AP, perfil e oblíqua. Ressonância só na instabilidade crônica ou dor > 6–8 semanas (lesão osteocondral, fibulares).

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: Ottawa decide o raio-X; sem fratura → grau I: tornozeleira e carga; grau II–III: tala posterior ou bota (quando há) por 5–10 dias com carga conforme a dor e muletas, gelo, elevação, AINE curto; alta com retorno em 5–7 dias para reexaminar os ligamentos com menos dor. Nada de gesso por 3 semanas.
- Squeeze positivo ou dor na sindesmose: raio-X com estresse em rotação externa (ou com carga); diástase → tala sem carga e regulação; sem diástase → bota sem carga 4–6 semanas.
- Thompson sem flexão plantar: é Aquiles, não entorse — equino hoje (ver Tendão de Aquiles).

CONDUTA

- Grau I (dor, pouco edema, sem frouxidão): PRICE 48 h, tornozeleira elástica, carga total desde o início, exercícios de mobilidade e equilíbrio. Volta ao esporte em 1–2 semanas.
- Grau II (edema, equimose, dor para apoiar, frouxidão leve): bota imobilizadora ou órtese semirrígida por 5–10 dias com carga conforme a dor, muletas se precisar; depois tornozeleira e fisioterapia (propriocepção) por 4–6 semanas.
- Grau III (ruptura completa, frouxidão clara): bota por 10 dias a 3 semanas, depois órtese e fisioterapia por 6–8 semanas; cirurgia raramente (atleta com instabilidade).
- Treino de equilíbrio (apoio unipodal, prancha) reduz recidiva pela metade — prescreva sempre.
- Gesso circular é inferior à órtese funcional; não usar.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Diclofenaco dietilamônio gel 11,6 mg/g	Camada fina no tornozelo 3 a 4× ao dia por 7 a 10 dias.	—

IMOBILIZAÇÃO

- Tornozeleira elástica (grau I); bota imobilizadora por poucos dias (II–III) com carga conforme a dor; nunca gesso de 3 semanas.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 5–7 dias: gaveta anterior e inclinação talar (grau), tirar a bota/tala, tornozeleira, fisioterapia de propriocepção (ou a folha de exercícios), carga total.
- 4 semanas: dor persistente na articulação ou bloqueio → raio-X de novo (lesão osteocondral? fratura do processo lateral do tálus?) e ressonância pela regulação se não melhora em 6–8 semanas; falseio recorrente após 3 meses de propriocepção → indicação de reconstrução.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a sindesmose com diástase (fixação, em dias), a fratura instável (ver Fraturas do tornozelo), a instabilidade crônica após 3–6 meses de propriocepção bem feita (reconstrução ligamentar — Broström, eletiva), a lesão osteocondral do tálus com dor > 6–8 semanas na ressonância (artroscopia, eletiva), a luxação recorrente dos fibulares (reparo do retináculo, eletiva).

Atestado	Grau I: 3–5 dias; II: 7–14; III: 14–21 (braçal: dobrar).
Retorno	5–7 dias (reexaminar ligamentos) e 4 semanas.

DICAS

- Quem "torce sempre" nunca fez propriocepção. Mande fazer: 5 minutos por dia num pé só.

Baseado em: Ottawa Ankle Rules; NATA position statement — Ankle sprain 2013; Vuurberg et al., BJSM 2018 — Ankle sprain guideline.

10.2 Fascite plantar

CID M72.2 · **Também** dor no calcanhar, esporão de calcâneo, dor ao pisar de manhã, esporão, dor na sola do pé, fasciite

> Dor no calcanhar nos primeiros passos da manhã, com ponto doloroso na inserção medial da fáscia: fascite plantar — alongamento, palmilha e paciência (6 a 12 meses); o esporão não é a causa.

O QUE PERGUNTAR

- Dor pior ao levantar da cama ou após ficar sentado, melhora ao andar e piora no fim do dia? Ficou mais tempo em pé, ganhou peso, trocou de calçado?
- Dormência no calcanhar (túnel do tarso), dor que irradia (S1), dor na parte de trás do calcanhar (Aquiles), febre?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Palpação da inserção	Pressionar o tubérculo medial do calcâneo com o pé em dorsiflexão.	Dor localizada → fascite.
Windlass	Dorsiflexão passiva do hálux com carga.	Dor na fáscia (específico).
Dorsiflexão do tornozelo	Medir com o joelho estendido.	< 10° → encurtamento do tríceps sural: o maior fator.
Compressão do calcâneo	Apertar o calcanhar lateralmente.	Dor → fratura por estresse do calcâneo (corredor, osteoporose): raio-X/ressonância.

SINAIS DE ALARME

- Dor bilateral em jovem com lombalgia inflamatória, uveíte ou psoríase: entesite de espondiloartrite — reumatologia.
- Dor noturna constante, massa, febre: tumor ou infecção (raros).

IMAGEM

- Não precisa na típica. RX de calcâneo perfil se > 6 semanas sem melhora ou dúvida (esporão é achado, não causa). Ultrassom: fáscia > 4 mm confirma, útil antes de infiltração.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão (dor no calcanhar "que não deixa pisar"): excluir fratura por estresse do calcâneo (compressão lateral dolorosa, corredor ou osteoporose → raio-X e, se normal, ressonância) e infecção; fascite típica: alongamentos escritos, palmilha de calcanhar, AINE curto, alta com retorno no ambulatório em 6–8 semanas — não é caso de plantão, mas chega nele.

CONDUTA

- Alongamento da fáscia (puxar os dedos para cima por 30 s, 10×, antes de levantar da cama) e da panturrilha (na parede, 30 s × 3, 3× ao dia) — primeira linha.
- Calçado com amortecimento e salto 2–3 cm, palmilha de calcanhar em gel ou com suporte de arco (pré-fabricada serve); não andar descalço em piso duro.
- Gelo rolando uma garrafa congelada sob o pé por 10 min, 2× ao dia. Reduzir impacto por 4–6 semanas; perder peso.

- AINE por 7–10 dias na crise; tala noturna de dorsiflexão em quem acorda com muita dor.
- Infiltração de corticoide (guiada): alívio de 4–12 semanas; risco de ruptura da fáscia e atrofia do coxim — no máximo 1–2. Ondas de choque se > 6 meses. Cirurgia: raríssima.
- Prognóstico: 80–90% melhoram em 12 meses com medidas simples.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).

IMOBILIZAÇÃO

- Tala noturna de dorsiflexão (opcional, 4–8 semanas); bota por 2–4 semanas só em dor incapacitante.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 6–8 semanas: aderência ao alongamento (90% do tratamento); tala noturna se acorda com dor; infiltração guiada (ver Punção e infiltração; no máximo 1–2, risco de ruptura da fáscia) se incapacitante; 6 meses sem melhora → ultrassom (espessura), ondas de choque pela regulação.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: ondas de choque (se o serviço de referência tem, após 6 meses), a fasciotomia parcial (raríssima, após 12 meses de falha — cirurgião de pé, eletiva), a suspeita de espondiloartrite (reumatologia) e a fratura por estresse do calcâneo que não consolida (cirurgião de pé).

Atestado	0–3 dias; restrição de ficar em pé prolongado por 2–4 semanas.
Retorno	6–8 semanas.

DICAS

- O paciente vai pedir para “tirar o esporão”. O esporão está em 15% das pessoas sem dor; a dor é da fáscia e passa com o esporão no lugar.

Baseado em: APTA CPG — Heel pain/plantar fasciitis 2023; AOFAS — Plantar fasciitis; Cochrane — Corticosteroid injection for plantar heel pain.

10.3 Tendinopatia e ruptura do Aquiles

CID M76.6 / S86.0 · **Também** dor no tendão de aquiles, tendinite do calcâneo, estalo na panturrilha, rompeu o tendão, dor atrás do calcanhar, aquiles

> Dor e espessamento 2 a 6 cm acima da inserção, pior de manhã e ao iniciar corrida, é tendinopatia e trata com excêntrico; estalo súbito com Thompson positivo é ruptura: equino hoje e a sua decisão, em 48 h, entre o protocolo funcional e a cirurgia.

O QUE PERGUNTAR

- Dor gradual com aumento de treino, rigidez matinal? Ou sensação de pedrada na panturrilha com estalo e dificuldade de ficar na ponta do pé (ruptura)?
- Uso de fluoroquinolona (ciprofloxacino, levofloxacino) ou infiltração de corticoide recente? (ruptura)
- Dor na inserção com calçado apertando (insercional, Haglund)?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Palpação	Espessamento fusiforme e dor 2–6 cm acima da inserção (não insercional) ou na inserção no calcâneo (insercional); procurar gap (depressão) no tendão.	Gap palpável → ruptura.
Thompson	Decúbito ventral, pés para fora da maca, comprimir a panturrilha.	Sem flexão plantar → ruptura completa (faça em toda dor aguda de panturrilha).
Ponta do pé unipodal	Subir na ponta do pé doente 10×.	Incapaz → ruptura ou tendinopatia grave.
Arc sign e Royal London	O espessamento move com a flexão/extensão do tornozelo; dor ao palpar some em dorsiflexão máxima.	Tendinopatia (não paratendinite).

SINAIS DE ALARME

- Ruptura: imobilizar em equino hoje (bota com cunhas ou tala posterior em flexão plantar de 20–30°), sem apoiar; em 48 h você decide — protocolo funcional (a maioria; ver procedimento) ou cirurgia (atleta, gap > 5 mm em equino no ultrassom, diagnóstico tardio > 2 semanas, reruptura) pela regulação; atraso > 2 semanas sem imobilizar piora o resultado.
- Panturrilha com edema e dor sem trauma: trombose venosa — Doppler.

IMAGEM

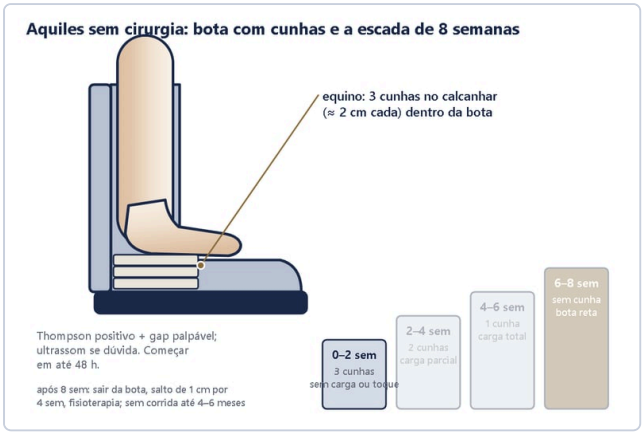
- Tendinopatia típica: nenhum. Ultrassom confirma espessamento e exclui ruptura parcial; ressonância antes de cirurgia. Ruptura: diagnóstico clínico (Thompson); ultrassom se dúvida ou para medir o gap.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

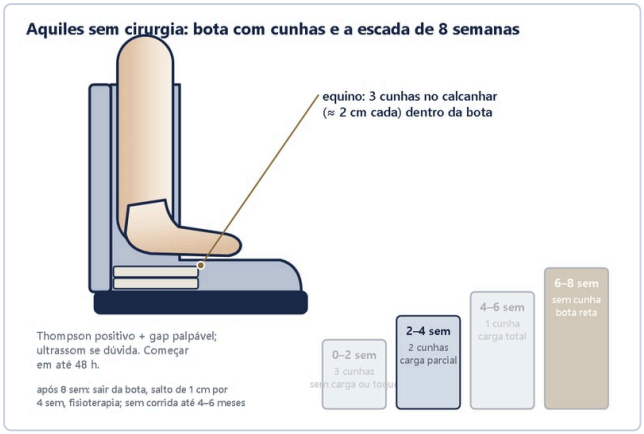
- Tendinopatia no plantão: diagnóstico clínico, Thompson negativo, salto no calçado, exercício excêntrico escrito, AINE curto, nunca infiltrar; retorno no ambulatório em 6 semanas.
- Ruptura (Thompson positivo, gap): tala posterior em equino 20–30° ou bota com 3 cunhas, sem carga, muletas, enoxaparina se fator de risco, alta com retorno em 48 h (ultrassom nesse intervalo se disponível: gap em equino); em 48 h a decisão é sua: protocolo funcional (resultados iguais à cirurgia na maioria — ensaios UKSTAR, Willits) ou cirurgia.

PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ FAZ NO SERVIÇO

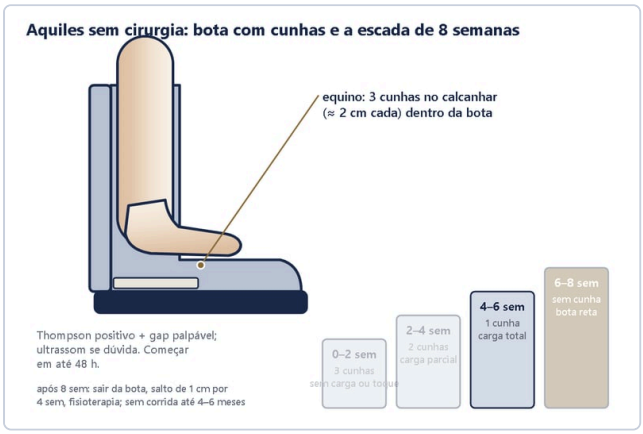
Protocolo funcional da ruptura do Aquiles (tratamento sem cirurgia)



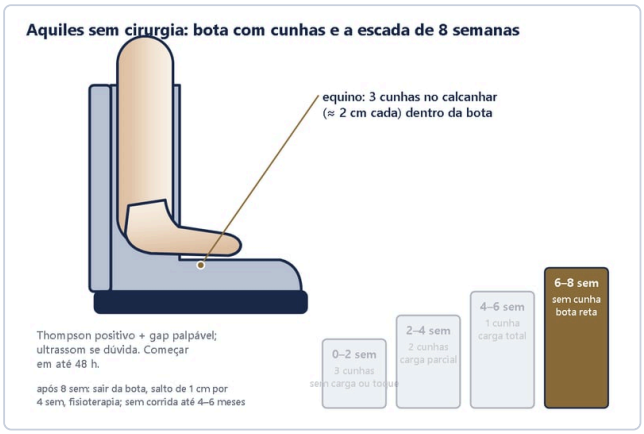
1 · antes



2 · aproximação



3 · a manobra



4 · como termina

Os quatro quadros da animação (no site e no app o desenho se mexe): a cena antes, a aproximação, o auge da manobra e como termina.

Quando: Ruptura aguda (< 2 semanas), gap que fecha em equino, paciente que aceita o protocolo. Começa em 48 h da decisão.

Material e anestesia: Bota imobilizadora com 3 cunhas de calcanhar (2 cm cada) — ou gesso suropodálico em equino trocado a cada 2 semanas se não há bota —, muletas, folha do protocolo.

Passo a passo

1. Semanas 0–2: bota com 3 cunhas (equino ~30°), sem carga ou carga de toque com muletas; dormir com a bota; enoxaparina se fator de risco.
2. Semanas 2–4: 3 cunhas, carga progressiva até total com a bota; exercícios de dedos e joelho.
3. Semanas 4–6: retire 1 cunha a cada 2 semanas (2 cunhas na 4ª, 1 na 6ª); carga total; fisioterapia começa (flexão plantar ativa dentro da bota, sem dorsiflexão passiva).
4. Semanas 6–8: sem cunha, bota a 90°, marcha; semana 8–10: retira a bota, calçado com salto de 1–2 cm por 4 semanas, fisioterapia de força (ponta de pé bilateral → unipodal).
5. Nunca dorsiflexão passiva forçada antes de 12 semanas; corrida em 4–6 meses; esporte de impacto em 6–9 meses.

Depois: Retorno a cada 2 semanas até a 10ª; Thompson e gap reavaliados em cada visita (reruptura: dor súbita + Thompson positivo → cirurgia). Anote a cunha de cada semana no prontuário.

CONDUTA

- Tendinopatia não insercional: exercício excêntrico de Alfredson (descer na ponta do pé no degrau, com joelho estendido e fletido, 3×15, 2× ao dia, 12 semanas) ou carga pesada lenta; reduzir corrida 50% sem parar; salto de 1–2 cm no calçado nas primeiras semanas.
- Insercional: mesmo esquema sem descer abaixo do nível do degrau; calçado sem contraforte rígido.
- AINE curto só na dor aguda (é degenerativa, não inflamatória). Nunca infiltrar corticoide no Aquiles (ruptura).
- Ondas de choque após 3 meses; cirurgia após 6–12 meses de falha.
- Ruptura, tratamento conservador funcional (bota em equino progressivo, carga precoce, fisioterapia): resultados iguais à cirurgia com protocolo adequado; cirurgia para atleta, gap grande ou tardia.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.

IMOBILIZAÇÃO

- Tendinopatia: nenhuma (salto no calçado). Ruptura: bota com cunhas em equino ou tala posterior em flexão plantar, sem carga, até a decisão em 48 h — e depois o protocolo funcional ou a cirurgia.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Protocolo funcional (ver procedimento): retorno a cada 2 semanas para retirar uma cunha e liberar carga; 8–10 semanas sem bota; fisioterapia; corrida em 4–6 meses; reruptura em 3–5%.
- Operado: tala 2 semanas, bota com carga precoce a partir de 2–4 semanas conforme o cirurgião; retorno com você para ferida, cunhas e fisioterapia.
- Tendinopatia: 6 e 12 semanas (aderência ao excêntrico); 3–6 meses sem melhora → ultrassom e ondas de choque pela regulação.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a sutura do Aquiles quando você a indica (atleta de alto nível, gap > 5 mm em equino, diagnóstico tardio > 2–4 semanas, reruptura) — cirurgião pela regulação em 1–2 semanas; a tendinopatia que falhou 6–12 meses de excêntrico e ondas de choque (desbridamento/transferência, eletiva, rara).

Atestado	Tendinopatia: 0–3 dias; ruptura: 6–12 semanas conforme trabalho.

Retorno	Tendinopatia: 6 e 12 semanas; ruptura: 48 h (decisão), depois a cada 2 semanas para trocar a cunha (protocolo funcional) até 8–10 semanas, e 6 meses.

DICAS

- Um terço das rupturas é rotulado de “entorse” na primeira consulta. Faça o Thompson em toda dor aguda de panturrilha ou tornozelo.
- Fluoroquinolona + corticoide em idoso: suspenda e avise do risco.

Baseado em: AAOS CPG — Achilles tendon rupture; Alfredson 1998; Beyer 2015 (heavy slow resistance); BJSM — Achilles tendinopathy consensus 2020.

10.4 Fratura de metatarso e do 5º metatarso

CID S92.3 · **Também** quebrou o pé, fratura no pé, dor na lateral do pé, fratura de Jones, quinto metatarso, fratura por estresse do pé

A avulsão da base do 5º metatarso (pseudo-Jones) trata com bota ou sapato rígido e carga; a fratura de Jones (metáfise-diáfise) e a por estresse não unem bem: bota sem carga e, no atleta ou na não união, parafuso — tudo decidido por você.

O QUE PERGUNTAR

- Torção (avulsão da base do 5º) ou dor progressiva com aumento de corrida/marcha (estresse)? Consegue andar? Diabético (pé de Charcot)?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Palpação óssea	Base e diáfise do 5º metatarso, cada metatarso, navicular.	Dor óssea localizada → raio-X (Ottawa do pé).
Edema e perfusão	Edema dorsal, pulsos, cor.	Edema tenso com dor desproporcional → compartimental do pé (raro, alta energia).

SINAIS DE ALARME

- Fratura de Jones (zona 2) e fratura por estresse do 5º (zona 3) ou do navicular: alto risco de não união — bota sem carga 6–8 semanas e raio-X seriado; no atleta ou se não consolida, parafuso (cirurgião pela regulação, eletiva).
- Luxação ou fratura de Lisfranc (dor no mediopé, equimose plantar, incapaz de pisar na ponta, diástase > 2 mm entre 1º e 2º metatarsos no raio-X com carga): reduza se luxado, tala posterior sem carga, tomografia e cirurgia (fixação) em dias — cirurgião de pé pela regulação; compartimental do pé se edema tenso.
- Múltiplas fraturas de metatarso ou desvio > 10°/3–4 mm no plano plantar: cirurgia (fios ou placa) em dias.

IMAGEM

- RX de pé AP, perfil e oblíqua com carga quando tolerar. Tomografia se suspeita de Lisfranc. Ressonância para fratura por estresse com raio-X normal.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: Ottawa do pé → raio-X AP, perfil e oblíqua (com carga se tolerar, para o Lisfranc); avulsão da base do 5º ou diáfise de 2º–4º sem desvio → sapato de sola rígida ou bota, carga conforme a dor, alta com retorno em 2 semanas; Jones → bota sem carga; Lisfranc ou desvio → tala posterior sem carga, elevação, tomografia e regulação.
- Diabético com fratura de pé: Charcot até prova em contrário se o pé é quente e inchado — sem carga, tala, e a equipe de pé diabético.

CONDUTA

- Avulsão da base do 5º (zona 1): sapato de sola rígida ou bota, carga conforme a dor, 3–6 semanas; não precisa de controle rigoroso.
- Fratura de diáfise de 2º–4º sem desvio: bota com carga 4–6 semanas, raio-X em 2 e 6 semanas.

- Jones: bota sem carga 6–8 semanas e raio-X seriado (sedentário), ou parafuso intramedular no atleta e no que não consolida em 8–12 semanas — você decide e pede pela regulação.
- Estresse (2º–3º metatarso, "fratura da marcha"): reduzir carga, sapato rígido 4–6 semanas; corrigir treino, nutrição, vitamina D e, na mulher, tríade (amenorreia).

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.

IMOBILIZAÇÃO

- Sapato pós-operatório de sola rígida ou bota imobilizadora, com carga conforme a dor (exceto Jones: sem carga).

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 2 semanas com raio-X (desvio?) e em 6 semanas (consolidação; Jones: 8–12 semanas sem carga até calo); avulsão com dor > 8 semanas → raio-X e, se não união sintomática, excisão ou parafuso (eletivo).
- Estresse (2º–3º metatarso): corrigir treino, vitamina D, nutrição e, na mulher, a tríade (amenorreia); 4–6 semanas de sapato rígido e retorno gradual.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a fixação do Lisfranc (em dias), as múltiplas ou desviadas (fios/placa, em dias), o parafuso na Jones do atleta ou na não união (eletiva), a fratura por estresse do navicular que não consolida (eletiva) — cirurgião de pé pela regulação; o pé diabético com Charcot ou infecção (equipe de pé diabético).

Atestado	2–6 semanas conforme o trabalho.
Retorno	2 semanas e 6 semanas com raio-X.

DICAS

- No raio-X da criança, a apófise da base do 5º metatarso é longitudinal; fratura é transversa. Não confunda.

Baseado em: AOFAS — Fifth metatarsal fractures; BOFAS / NICE NG38; Ottawa Foot Rule.

10.5 Hálux valgo, metatarsalgia e neuroma de Morton

CID M20.1 / M77.4 / G57.6 · **Também** joanete, dor no dedão, dor na frente do pé, neuroma de Morton, queimação entre os dedos, metatarsalgia, hálux rígido

> Joanete dói pelo sapato e trata com sapato; queimação entre o 3º e 4º dedos que melhora ao tirar o sapato é Morton; dor sob as cabeças dos metatarsos é metatarsalgia — palmilha resolve a maioria, cirurgia é eletiva.

O QUE PERGUNTAR

- Onde dói: na proeminência do joanete (sapato), sob a planta (metatarsalgia), entre os dedos com queimação e dormência (Morton)? Qual sapato usa? Diabetes (pé de risco)?
- Rigidez e dor ao dobrar o dedão para cima (hálux rígido = artrose)?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Inspeção com carga	Ângulo do hálux, calosidades sob as cabeças (2º metatarso), dedos em garra, arco.	Calo plantar → sobrecarga; garra → desequilíbrio.
Mulder	Comprimir o antepé lateralmente enquanto pressiona o espaço intermetatarsal (3º).	Estalo doloroso → neuroma de Morton.
Mobilidade da 1ª metatarsofalângica	Dorsiflexão do hálux.	< 30° com dor e osteófito dorsal → hálux rígido.
Pulsos e sensibilidade	Pedioso, tibial posterior; monofilamento no diabético.	Alterados → pé de risco: cuidado dobrado com sapato e calos.

SINAIS DE ALARME

- Diabético com calo ulcerado, rubor ou pé quente e edemaciado sem dor: infecção ou Charcot — urgência.
- Dor noturna, massa (raro tumor).

IMAGEM

- RX de pé AP, perfil e oblíqua com carga: ângulos do hálux valgo, artrose. Ultrassom ou ressonância para Morton só em dúvida.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão (dor no antepé "que não deixa andar"): excluir fratura por estresse (raio-X; ressonância se normal e dor óssea), gota (1ª metatarsofalângica quente — ver Crise de gota) e infecção no diabético; dor mecânica → calçado, palmilha de apoio retrocapital, AINE tópico, alta com retorno no ambulatório em 8–12 semanas.
- Diabético com pé quente, inchado ou com calo ulcerado: urgência — sem carga, raio-X, glicemia, e a equipe de pé diabético hoje.

CONDUTA

- Calçado: bico largo e redondo, salto < 3 cm, sem costura sobre o joanete; é o tratamento de todos os três. Separador de dedos de silicone e protetor de joanete para conforto (não corrigem).

- Palmilha com apoio retrocapital (barra metatarsal) para metatarsalgia e Morton; alongar panturrilha (encurtamento sobrecarrega o antepé).
- Morton: infiltração de corticoide no espaço (alívio em 50–70%); neurectomia se falha.
- Hálux rígido: palmilha de fibra rígida, sapato com sola em balanço; infiltração; cirurgia (queilectomia ou artrodese) no avançado.
- Cirurgia do hálux valgo (osteotomia): dor apesar do sapato correto e limitação — nunca por estética; recuperação de 2–3 meses.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Diclofenaco dietilamônio gel 11,6 mg/g	Camada fina na área dolorosa 3× ao dia por 14 dias.	—
Dipirona 1 g	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 4 g/dia).	—
Paracetamol 750 mg	1 comprimido de 6/6 h se dor (máximo 3 g/dia; 2 g/dia em hepatopata ou etilista).	Alternativa à dipirona, ou somar quando a dor não cede.
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Ibuprofeno 600 mg	1 comprimido de 8/8 h, por 5 a 7 dias, após as refeições.	Alternativa ao naproxeno — não usar os dois.

IMOBILIZAÇÃO

- Nenhuma; palmilha e calçado.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 8–12 semanas: calçado certo no pé (pergunte), palmilha; Morton → infiltração do espaço (até 2); hálux rígido → infiltração e palmilha rígida; falha de 3–6 meses → a indicação cirúrgica é sua, com raio-X com carga, pela regulação.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a osteotomia do hálux valgo, a neurectomia do Morton e a queilectomia/artrodese do hálux rígido quando a dor limita apesar de 3–6 meses de calçado, palmilha e infiltração — cirurgião de pé, eletiva pela regulação (nunca por estética); o pé diabético com úlcera, infecção ou Charcot (equipe de pé diabético, urgência).

Atestado	0.
Retorno	8–12 semanas.

DICAS

- Pergunte ao paciente se o sapato que ele veste todo dia é o que está no pé agora. A resposta costuma ser a causa.

Baseado em: AOFAS — Bunions; Morton neuroma; ACFAS CPG — Hallux valgus; Cochrane — Hallux valgus interventions.

CAPÍTULO 11

Articulação aguda e infecção

Toda monoartrite aguda com febre é séptica até a punção dizer o contrário.

11.1	**Monoartrite aguda e artrite séptica** Uma articulação quente, inchada, que não deixa mexer, com ou sem febre: é artrite séptica até a punção dizer que é gota ou pseudogota — nunca AINE e casa.	192
11.2	**Crise de gota** Dedão vermelho, quente e insuportável que começou à noite, em homem com episódios prévios: gota — AINE em dose cheia, colchicina ou prednisona nas primeiras 24 h; o alopurinol vem depois da crise, e não se suspende se já usa.	195

11.1 Monoartrite aguda e artrite séptica

CID M00.9 / M13.1 · **Também** articulação inchada e quente, artrite séptica, joelho inchado com febre, pus na articulação, artrite infecciosa

> Uma articulação quente, inchada, que não deixa mexer, com ou sem febre: é artrite séptica até a punção dizer que é gota ou pseudogota — nunca AINE e casa.

O QUE PERGUNTAR

- Em quantas horas instalou? Febre, calafrio? Infecção recente de pele, urina, dente, uso de droga injetável, prótese articular, diabete, imunossupressão?
- Episódios prévios iguais que passaram sozinhos (gota)? Uretrite, diarreia ou conjuntivite (reativa)? Picada de carrapato?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Articulação	Calor, rubor, derrame, dor à mobilização passiva mínima (o paciente segura a articulação em flexão).	Dor a qualquer grau de movimento passivo → séptica até prova em contrário (a celulite e a bursite doem na pele e deixam a articulação mexer).
Exame geral	Temperatura, pele (porta de entrada, pústulas gonocócicas), outras articulações, coração (endocardite em usuário de droga).	Toxemia → internar.
Outras articulações	Pequenas articulações, tofos (gota crônica), coluna e êntese (espondiloartrite).	Poliartrite → outra lista (reumatologia).

SINAIS DE ALARME

- Artrite séptica (mesmo sem febre: 50% não têm): punção agora, por você (celularidade, Gram, cultura, cristais — ver Punção e infiltração), hemocultura, antibiótico EV depois da coleta e internação; drenagem (artroscópica, artrotomia ou punções seriadas no joelho) pelo cirurgião no mesmo dia. Perda de cartilagem em dias.
- Prótese articular com dor nova, febre ou fístula: infecção de prótese — punção para cultura, internação e o cirurgião da prótese hoje; sem antibiótico antes da cultura.
- Criança com quadril ou joelho quente e não anda: ver Criança mancando.

IMAGEM

- Raio-X da articulação (basal; condrocalcinose na pseudogota, erosões na gota crônica). Ultrassom guia a punção do quadril e ombro. Exames: hemograma, PCR, VHS, ácido úrico (normal não exclui gota), glicemia, hemocultura se febre.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- Articulação quente que não deixa mexer: punção agora (ver Punção e infiltração), líquido para celularidade, Gram, cultura e cristais; hemograma, PCR, VHS, hemocultura; > 50.000 células, Gram positivo ou forte suspeita → antibiótico EV após a coleta, internação, drenagem no mesmo dia pelo cirurgião (punções seriadas diárias no joelho são alternativa quando não há centro cirúrgico, com o cirurgião de acordo).

- Cristais sem sinais de infecção (podagra típica, pseudogota do idoso): AINE em dose plena ou colchicina ou corticoide (intra-articular já na punção, se Gram negativo e baixa suspeita), alta com retorno em 1 semana — mas cristais não excluem infecção: cultura sempre.
- Criança com quadril ou joelho quente: ver Criança mancando (Kocher, punção, drenagem).

CONDUTA

- Punção articular é o exame: líquido > 50.000 células com > 90% neutrófilos = séptica; cristais de urato (gota) ou pirofosfato (pseudogota) decidem o resto; Gram e cultura sempre. Joelho, tornozelo, punho e cotovelo você punciona por referência anatômica; quadril e ombro, guiados por ultrassom ou pelo cirurgião — no mesmo dia.
- Gota confirmada (ou altamente provável: podagra, episódios iguais, tofo): tratar a crise (próximo tópico) e discutir alopurinol depois.
- Pseudogota (idoso, joelho ou punho, condrocalcinose): AINE, colchicina ou corticoide intra-articular — igual à gota, sem alopurinol.
- Artrite reativa (2–4 semanas após uretrite/diarreia, jovem): AINE, tratar a infecção; reumatologia se persistir.

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Dipirona 1 g/2 mL	2 mL EV lento agora e de 6/6 h.	—
Oxacilina 500 mg (frasco-ampola)	2 g EV de 4/4 h, iniciada logo após a coleta do líquido e das hemoculturas; alternativa: cefazolina 2 g EV de 8/8 h. Por 2 semanas EV, depois oral até completar 4–6 semanas conforme a cultura.	Risco de MRSA (hospitalização recente, droga injetável, diálise, colonização conhecida): vancomicina 15–20 mg/kg EV 12/12 h. Jovem sexualmente ativo com poliartralgia e pústulas (gonocócica): ceftriaxona 1 g EV/dia. Ajuste com a cultura em 48–72 h.
Colchicina 0,5 mg	2 comprimidos agora e 1 comprimido 1 hora depois; depois 1 comprimido 1 a 2× ao dia até a crise passar (máximo 7 dias).	Só com cristais no líquido (gota ou pseudogota) e sem infecção; reduzir em renal e idoso.

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Séptica: retorno após a alta em 1 semana (PCR, ferida, mobilidade), antibiótico oral até completar 4–6 semanas, fisioterapia de amplitude; raio-X em 6 semanas (destruição?).
- Gota ou pseudogota: retorno em 2 semanas (ácido úrico, creatinina) e a decisão do alopurinol (ver Crise de gota); artrite reativa persistente ou poliartrite → reumatologia.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: a drenagem cirúrgica da artrite séptica (artroscopia ou artrotomia — cirurgião, no mesmo dia; quadril e ombro sempre cirúrgicos), a infecção de prótese (cirurgião da prótese, hoje), a monoartrite sem diagnóstico após a punção e a poliartrite (reumatologia, em dias), a endocardite no usuário de droga (clínica/cardiologia).

Atestado	Internação (séptica); gota/pseudogota: 3–5 dias.
Retorno	Depois da alta: 1 semana.

DICAS

- Gota e artrite séptica podem coexistir: cristais no líquido não dispensam a cultura.

Baseado em: BSR/BOA — Hot swollen joint guideline; EULAR 2016 — Gout; Margaretten et al., JAMA 2007 — Does this adult patient have septic arthritis?.

11.2 Crise de gota

CID M10.9 · **Também** gota, dedão inchado e vermelho, podagra, ácido úrico alto, crise de gota, dor no dedão à noite

> Dedão vermelho, quente e insuportável que começou à noite, em homem com episódios prévios: gota — AINE em dose cheia, colchicina ou prednisona nas primeiras 24 h; o alopurinol vem depois da crise, e não se suspende se já usa.

O QUE PERGUNTAR

- Primeira vez? Quantas crises por ano? Já tem tofos, pedra nos rins? Álcool (cerveja), diurético, AAS baixa dose, insuficiência renal, transplante?
- Febre e calafrio (séptica?), articulação atípica (ombro, quadril → puncionar)?

EXAME FÍSICO

Manobra	Como fazer	Positiva
Articulação	1ª metatarsofalângica (podagra) ou tornozelo/joelho: calor, rubor intenso, descamação na resolução.	Podagra típica com crises prévias → gota provável sem punção; articulação grande ou febre → puncionar (séptica).
Tofos	Orelha, cotovelo, dedos, Aquiles.	Tofo → gota crônica: alopurinol indicado.

SINAIS DE ALARME

- Febre, articulação grande, estado geral comprometido ou primeiro episódio atípico: ver monoartrite — séptica até a punção.
- Insuficiência renal avançada: evitar AINE e colchicina em dose plena — corticoide.

IMAGEM

- Não precisa na típica. Ácido úrico (pode ser normal na crise; repetir 2 semanas depois), creatinina, hemograma, glicemia, lipídios. Ultrassom (duplo contorno) ou tomografia de dupla energia em dúvida.

NA URGÊNCIA — VOCÊ É O ORTOPEDISTA DE PLANTÃO

- No plantão: podagra típica com crises prévias → tratar sem punção (AINE em dose plena, colchicina ou prednisona; corticoide intra-articular se puncionou), gelo, alta com retorno em 2 semanas; articulação grande, febre ou primeiro episódio atípico → punção e o tópico de Monoartrite (séptica até a cultura).
- Não suspenda o alopurinol de quem já usa; não inicie na crise. Renal, anticoagulado ou idoso: prednisona ou corticoide intra-articular em vez de AINE e colchicina plena.

CONDUTA

- Começar em 24 h (quanto antes, melhor): AINE em dose plena por 5–7 dias (naproxeno 500 mg 12/12 h), OU colchicina (1 mg e 0,5 mg 1 h depois; depois 0,5 mg 1–2×/dia até resolver), OU prednisona 30–35 mg/dia por 5 dias (renal, anticoagulado, idoso). Combinações nas crises graves.
- Gelo, repouso da articulação, elevar. Não suspender alopurinol se já usa.
- Depois da crise (2–4 semanas): alopurinol se ≥ 2 crises/ano, tofo, pedra, erosão ou creatinina alterada — começar 100 mg/dia (50 mg se renal) e subir a cada 2–4 semanas até ácido úrico < 6 mg/dL (< 5 com tofo); profilaxia com colchicina 0,5 mg/dia por 3–6 meses ao iniciar. Explique que crises nos primeiros meses de alopurinol são esperadas.

- Dieta: menos cerveja e destilados, refrigerante com frutose, carne vermelha e frutos do mar; perder peso; trocar hidroclorotiazida se possível (losartana ajuda).

RECEITA (ADULTO SEM COMORBIDADE)

Medicamento	Posologia	Cuidado
Naproxeno 500 mg	1 comprimido de 12/12 h por 5 a 7 dias, após as refeições.	AINE por até 5–7 dias, com alimento. Evitar ou reduzir em: > 65 anos, doença renal, úlcera ou sangramento digestivo, insuficiência cardíaca, anticoagulante, AAS, corticoide, gestação (evitar a partir de 20 semanas; contraindicado no 3º trimestre — oligoâmnio e fechamento do canal arterial). Se for usar nesses casos, associar omeprazol 20 mg/dia.
Colchicina 0,5 mg	2 comprimidos agora e 1 comprimido 1 hora depois; a partir do dia seguinte, 1 comprimido 1 a 2× ao dia até a crise passar (máximo 7 dias).	Diarreia é o limite; reduzir em renal e idoso; não usar com claritromicina, ciclosporina ou estatina em dose alta sem ajuste.
Prednisona 20 mg	1 ½ comprimido (30 mg) pela manhã por 5 dias.	Alternativa quando AINE e colchicina não podem.
Omeprazol 20 mg	1 cápsula em jejum, pela manhã, enquanto usar o anti-inflamatório.	Só quando há fator de risco gástrico (ver cuidado do AINE).
Alopurinol 100 mg	1 comprimido ao dia após a refeição, iniciando 2 semanas após a crise; aumentar 100 mg a cada 2 a 4 semanas conforme o ácido úrico, até 300 mg ou mais.	Dose menor na insuficiência renal; parar e procurar atendimento se erupção cutânea (síndrome de hipersensibilidade).

NO RETORNO (AMBULATÓRIO)

- Retorno em 2 semanas (crise resolvida? ácido úrico, creatinina, glicemia, lipídios) e a decisão do alopurinol (≥ 2 crises/ano, tofo, pedra, erosão, creatinina alterada): começar 100 mg/dia com profilaxia de colchicina 3–6 meses, subir a cada 2–4 semanas até ácido úrico < 6 mg/dL; retorno a cada 4–8 semanas na titulação.
- Falha ou intolerância ao alopurinol, tofos, renal avançado → reumatologia.

CIRURGIA E REGULAÇÃO — O QUE SAI DA SUA MÃO

- Sai da sua mão: gota tofácea com destruição articular, crises frequentes apesar de alopurinol em dose ajustada, intolerância ao alopurinol (febuxostate), insuficiência renal avançada, dúvida diagnóstica — reumatologia pela regulação; tofo infectado ou ulcerado (cirurgia, raro).

Atestado	3–5 dias.
Retorno	2 semanas (crise resolvida? ácido úrico, creatinina) e 4–8 semanas após iniciar alopurinol.

DICAS

- A gota do idoso em diurético é no punho e no joelho, não no dedão — e passa por "artrose inflamada".

Baseado em: ACR 2020 — Gout management guideline; EULAR 2016; NICE NG219 — Gout 2022.

A · Índice de manobras de exame

Abdução resistida e FADER 7.2 (p. 141)
Agachamento unipodal 9.4 (p. 171)
Amplitude e palpação 3.3 (p. 79)
Angulação e encurtamento 6.2 (p. 122)
Apoio unipodal 30 s 7.2 (p. 141)
Apreensão e recolocação 4.3 (p. 93)
Apreensão patelar 9.4 (p. 171)
Arc sign e Royal London 10.3 (p. 182)
Arco doloroso 4.1 (p. 86)
Articulação 11.1 (p. 192), 11.2 (p. 195)
Articulação e ombro contralateral 2.6 (p. 61)
Articulações vizinhas 2.3 (p. 47), 4.4 (p. 97)
Bursa pré-patelar 9.5 (p. 174)
Cabeça do rádio 6.1 (p. 118)
Cada articulação, cada tendão 6.3 (p. 127)
Carga 2.8 (p. 68), 7.3 (p. 143)
Checagem antes de sedar 1.7 (p. 24)
Checagem neurovascular distal, antes e depois de tudo 1.5 (p. 18)
Checagem pós-imobilização 1.3 (p. 12)
Classificação de Gartland (no raio-X) 8.2 (p. 154)
Classificação de Gustilo (anote) 2.1 (p. 38)
Classificação de Neer (no raio-X) 2.6 (p. 61)
Classificação de Weber (no raio-X) 2.5 (p. 57)
Compressão axial do polegar 5.6 (p. 113)
Compressão da pelve e palpação 2.8 (p. 68)
Compressão do calcâneo 10.2 (p. 180)
Compressão patelar (Clarke) 9.4 (p. 171)
Cotovelo e ombro 5.5 (p. 109)
Cozen 5.1 (p. 100)
Deformidade e pele 5.5 (p. 109), 8.2 (p. 154)
Degraus 1.2 (p. 9)
Derrame e pele 2.7 (p. 65)
Derrame e regra de Ottawa 9.2 (p. 165)
Diferenciar 5.7 (p. 115)
Dismetria e Thomas 7.1 (p. 138)
Dor ao estiramento passivo 2.2 (p. 43)
Dorsiflexão do tornozelo 10.2 (p. 180)
Dose máxima do anestésico local 1.7 (p. 24)
Drop arm 4.1 (p. 86)
Durkan (compressão do carpo) 5.2 (p. 103)
Edema e perfusão 10.4 (p. 186)
Elevação da perna estendida (straight leg raise) 2.7 (p. 65)
Estabilidade após reduzir a IFP 6.3 (p. 127)
Estabilidade do joelho após redução 2.4 (p. 52)
Estresse em valgo e varo 9.2 (p. 165)
Exame com luz, sem sangue e sem garrote demorado 6.4 (p. 132)
Exame do membro inteiro, comparando 8.1 (p. 149)
Exame geral 7.4 (p. 146), 11.1 (p. 192)
Exame neurológico das pernas 3.4 (p. 82)
Extensão completa 9.3 (p. 168)
FABER (Patrick) 7.1 (p. 138)
FADIR 7.1 (p. 138)
Ferida e compartimentos 2.1 (p. 38)
Finkelstein (Eichhoff) 5.3 (p. 105)
Flexão/pronação resistidas 5.1 (p. 100)
Flexibilidade 9.4 (p. 171)
Força do manguito após luxação em > 40 anos 4.3 (p. 93)
Força por raiz 3.2 (p. 76)
Força, reflexos e sensibilidade 3.1 (p. 73), 3.3 (p. 79)
Gaveta anterior e inclinação talar 10.1 (p. 177)
Gaveta anterior e posterior 9.2 (p. 165)
Grind test 5.7 (p. 115)
Hoffmann e marcha 3.3 (p. 79)
Inspeção 5.7 (p. 115), 7.3 (p. 143)
Inspeção com carga 10.5 (p. 188)
Inspeção da eminência tenar 5.2 (p. 103)
Inspeção da pele 4.4 (p. 97)
Inspeção e alinhamento 9.1 (p. 162)
Inspeção e marcha 3.1 (p. 73)
Inspeção e neurovascular 2.6 (p. 61), 4.3 (p. 93)
Inspeção e triângulo 6.1 (p. 118)
Interlinha e sinal da tecla 9.1 (p. 162)
Jobe (supraespinhal) 4.1 (p. 86)
Lachman 9.2 (p. 165)
Lasègue (elevação da perna estendida) 3.1 (p. 73)
Lasègue e Lasègue cruzado 3.2 (p. 76)
Ligamentos 9.3 (p. 168)
Log roll 7.3 (p. 143)
Marcha e Trendelenburg 7.1 (p. 138)
McMurray 9.3 (p. 168)
Membro e partes moles 2.3 (p. 47)
Mill 5.1 (p. 100)
Mobilidade ativa e passiva 4.1 (p. 86)
Mobilidade da 1ª metatarsofalângica 10.5 (p. 188)
Mobilidade do cotovelo 5.1 (p. 100)
Mobilidade do quadril 7.4 (p. 146)
Mobilidade e crepitação 9.1 (p. 162)
Mobilidade passiva 4.2 (p. 89)
Mulder 10.5 (p. 188)
Neer e Hawkins 4.1 (p. 86)
Neurovascular 2.2 (p. 43), 4.4 (p. 97), 5.5 (p. 109), 9.2 (p. 165)
Neurovascular antes e depois 6.1 (p. 118)
Neurovascular com horário 2.3 (p. 47)

Neurovascular distal, antes e depois de tudo 2.1 (p. 38)
Neurovascular e compartimentos 8.1 (p. 149)
Neurovascular e pele 7.3 (p. 143)
Neurovascular e períneo 2.8 (p. 68)
Neurovascular, antes e depois 2.4 (p. 52)
O laudo de regulação que consegue vaga 1.6 (p. 21)
O que fazer com o líquido 1.8 (p. 30)
Os 5 P do membro em risco 1.5 (p. 18)
Outras articulações 11.1 (p. 192)
Palpação 3.1 (p. 73), 5.1 (p. 100), 10.3 (p. 182)
Palpação da inserção 10.2 (p. 180)
Palpação da interlinha 9.3 (p. 168)
Palpação da polia A1 5.4 (p. 107)
Palpação do 1º compartimento 5.3 (p. 105)
Palpação do gap 2.7 (p. 65)
Palpação do trocanter 7.2 (p. 141)
Palpação dos compartimentos 2.2 (p. 43)
Palpação dos quatro pontos 2.5 (p. 57)
Palpação ligamentar 10.1 (p. 177)
Palpação óssea 10.4 (p. 186)
Palpação osso a osso 8.3 (p. 158)
Palpação poplítea (Baker) 9.5 (p. 174)
Pata de ganso 9.5 (p. 174)
Pele e neurovascular 2.5 (p. 57), 6.3 (p. 127)
Pele, tendão e nervo 6.2 (p. 122)
Percussão dos espinhosos 3.4 (p. 82)
Phalen 5.2 (p. 103)
Ponta do pé unipodal 10.3 (p. 182)
Postura e inspeção 8.3 (p. 158)
Postura típica 2.4 (p. 52)
Pressão compartimental (se tem o aparelho ou agulha com manômetro) 2.2 (p. 43)
Pulso, perfusão e os três nervos — antes de tudo, anotado com hora 8.2 (p. 154)
Pulsos e sensibilidade 10.5 (p. 188)
Quadril 9.1 (p. 162)
Quadril e coluna 7.2 (p. 141)
Regra de Ottawa 10.1 (p. 177)
Regra dos dois 1.1 (p. 6)
Rotação (o exame que decide a cirurgia) 6.2 (p. 122)
Rotação externa resistida (infraespinhal) e Gerber (subescapular) 4.1 (p. 86)
Rotação interna em flexão 7.1 (p. 138)
Sensibilidade e cervical 5.2 (p. 103)
Sinais de maus-tratos 8.1 (p. 149)
Sinal de Drehmann 7.4 (p. 146)
Spurling 3.3 (p. 79)
Squeeze e rotação externa 10.1 (p. 177)
Sulco 4.3 (p. 93)
Tabaqueira anatômica 5.6 (p. 113)
Tabaqueira anatômica e CMC do polegar 5.3 (p. 105)
Tendões e nervos, antes de anestesiar 6.4 (p. 132)
Teste de estiramento femoral 3.2 (p. 76)
Thessaly 9.3 (p. 168)
Thompson 10.3 (p. 182)
Thompson e tendão fibular 10.1 (p. 177)
Tinel 5.2 (p. 103)
Tofos 11.2 (p. 195)
Toque retal e sensibilidade perineal 3.2 (p. 76)
Tubérculo do escafoide 5.6 (p. 113)
Unha e leito 6.4 (p. 132)
Vaga zero 1.6 (p. 21)
Windlass 10.2 (p. 180)

B · Índice de medicamentos das receitas

Alendronato de sódio 70 mg 2.6 (p. 61), 2.8 (p. 68), 3.4 (p. 82), 7.3 (p. 143)

Alopurinol 100 mg 11.2 (p. 195)

Amoxicilina + clavulanato 875/125 mg 6.2 (p. 122), 6.4 (p. 132)

Carbonato de cálcio 500 mg (de cálcio elementar) 3.4 (p. 82)

Cefalexina 500 mg 6.2 (p. 122), 6.3 (p. 127), 6.4 (p. 132), 9.5 (p. 174)

Cefazolina 1 g (frasco-ampola) 1.5 (p. 18), 2.1 (p. 38)

Ciclobenzaprina 5 mg 1.2 (p. 9), 3.1 (p. 73), 3.3 (p. 79)

Colchicina 0,5 mg 11.1 (p. 192), 11.2 (p. 195)

Colecalciferol (vitamina D3) 2.000 UI 2.6 (p. 61), 2.8 (p. 68), 3.4 (p. 82), 7.3 (p. 143)

Diclofenaco dietilamônio gel 11,6 mg/g 5.1 (p. 100), 5.3 (p. 105), 5.7 (p. 115), 7.2 (p. 141), 9.1 (p. 162), 9.3 (p. 168), 9.5 (p. 174), 10.1 (p. 177), 10.5 (p. 188)

Dipirona 1 g 1.2 (p. 9), 1.3 (p. 12), 1.7 (p. 24), 1.8 (p. 30), 2.3 (p. 47), 2.4 (p. 52), 2.5 (p. 57), 2.6 (p. 61), 2.7 (p. 65), 2.8 (p. 68), 3.1 (p. 73), 3.2 (p. 76), 3.3 (p. 79), 3.4 (p. 82), 4.1 (p. 86), 4.2 (p. 89), 4.3 (p. 93), 4.4 (p. 97), 5.1 (p. 100), 5.2 (p. 103), 5.3 (p. 105), 5.4 (p. 107), 5.5 (p. 109), 5.6 (p. 113), 5.7 (p. 115), 6.1 (p. 118), 6.2 (p. 122), 6.3 (p. 127), 6.4 (p. 132), 7.1 (p. 138), 7.2 (p. 141), 9.1 (p. 162), 9.2 (p. 165), 9.3 (p. 168), 9.4 (p. 171), 9.5 (p. 174), 10.1 (p. 177), 10.2 (p. 180), 10.3 (p. 182), 10.4 (p. 186), 10.5 (p. 188)

Dipirona 1 g/2 mL 1.5 (p. 18), 2.1 (p. 38), 2.2 (p. 43), 2.3 (p. 47), 2.4 (p. 52), 7.3 (p. 143), 11.1 (p. 192)

Dipirona gotas 500 mg/mL 8.1 (p. 149), 8.2 (p. 154), 8.3 (p. 158)

Enoxaparina 40 mg 2.3 (p. 47), 2.4 (p. 52), 2.5 (p. 57), 2.8 (p. 68), 7.3 (p. 143)

Gentamicina 80 mg/2 mL 2.1 (p. 38)

Ibuprofeno 600 mg 1.2 (p. 9), 2.5 (p. 57), 2.7 (p. 65), 3.1 (p. 73), 3.2 (p. 76), 3.3 (p. 79), 4.1 (p. 86), 4.2 (p. 89), 4.3 (p. 93), 4.4 (p. 97), 5.1 (p. 100), 5.3 (p. 105), 5.4 (p. 107), 5.6 (p. 113), 5.7 (p. 115), 6.1 (p. 118), 6.2 (p. 122), 6.3 (p. 127), 7.1 (p. 138), 7.2 (p. 141), 9.1 (p. 162), 9.2 (p. 165), 9.3 (p. 168), 9.4 (p. 171), 9.5 (p. 174), 10.1 (p. 177), 10.2 (p. 180), 10.3 (p. 182), 10.4 (p. 186), 10.5 (p. 188)

Ibuprofeno gotas 100 mg/mL 7.4 (p. 146), 8.1 (p. 149), 8.2 (p. 154)

Morfina 10 mg/mL 1.5 (p. 18), 2.1 (p. 38), 2.2 (p. 43), 2.3 (p. 47), 2.4 (p. 52), 7.3 (p. 143)

Morfina 10 mg/mL (diluída: 1 mg/mL) 8.2 (p. 154)

Naproxeno 500 mg 1.2 (p. 9), 2.5 (p. 57), 2.7 (p. 65), 3.1 (p. 73), 3.2 (p. 76), 3.3 (p. 79), 4.1 (p. 86), 4.2 (p. 89), 4.3 (p. 93), 4.4 (p. 97), 5.1 (p. 100), 5.3 (p. 105), 5.4 (p. 107), 5.6 (p. 113), 5.7 (p. 115), 6.1 (p. 118), 6.2 (p. 122), 6.3 (p. 127), 7.1 (p. 138), 7.2 (p. 141), 9.1 (p. 162), 9.2 (p. 165), 9.3 (p. 168), 9.4 (p. 171), 9.5 (p. 174), 10.1 (p. 177), 10.2 (p. 180), 10.3 (p. 182), 10.4 (p. 186), 10.5 (p. 188), 11.2 (p. 195)

Omeprazol 20 mg 1.2 (p. 9), 2.5 (p. 57), 2.7 (p. 65), 3.1 (p. 73), 3.2 (p. 76), 3.3 (p. 79), 4.1 (p. 86), 4.2 (p. 89), 5.7 (p. 115), 6.1 (p. 118), 7.1 (p. 138), 7.2 (p. 141), 9.1 (p. 162), 9.2 (p. 165), 9.3 (p. 168), 10.2 (p. 180), 11.2 (p. 195)

Oxacilina 500 mg (frasco-ampola) 11.1 (p. 192)

Paracetamol 750 mg 1.2 (p. 9), 1.3 (p. 12), 1.7 (p. 24), 1.8 (p. 30), 2.3 (p. 47), 2.4 (p. 52), 2.5 (p. 57), 2.6 (p. 61), 2.7 (p. 65), 2.8 (p. 68), 3.1 (p. 73), 3.2 (p. 76), 3.3 (p. 79), 3.4 (p. 82), 4.1 (p. 86), 4.2 (p. 89), 4.3 (p. 93), 4.4 (p. 97), 5.1 (p. 100), 5.2 (p. 103), 5.3 (p. 105), 5.4 (p. 107), 5.5 (p. 109), 5.6 (p. 113), 5.7 (p. 115), 6.1 (p. 118), 6.2 (p. 122), 6.3 (p. 127), 6.4 (p. 132), 7.1 (p. 138), 7.2 (p. 141), 9.1 (p. 162), 9.2 (p. 165), 9.3 (p. 168), 9.4 (p. 171), 9.5 (p. 174), 10.1 (p. 177), 10.2 (p. 180), 10.3 (p. 182), 10.4 (p. 186), 10.5 (p. 188)

Paracetamol gotas 200 mg/mL 8.1 (p. 149), 8.2 (p. 154)

Prednisona 20 mg 3.2 (p. 76), 4.2 (p. 89), 11.2 (p. 195)

Tramadol 50 mg 1.2 (p. 9), 2.3 (p. 47), 2.4 (p. 52), 2.5 (p. 57), 2.6 (p. 61), 2.7 (p. 65), 2.8 (p. 68), 3.1 (p. 73), 3.2 (p. 76), 3.4 (p. 82), 4.4 (p. 97), 5.5 (p. 109)

Vacina dT 2.1 (p. 38), 6.4 (p. 132)

C Cola do plantão

98 textos prontos, como vão no prontuário: história, exame e conduta por queixa; a receita para casa; a medicação na unidade; as notas de urgência e a papelada do SUS; as incidências do raio-X. Os do caderno do médico vêm como ele escreve; os marcados do guia foram acrescentados no mesmo jeito, com as doses do guia. Troque o lado, o CID, o peso e o que for do paciente. No site e no app cada um copia com um toque.

PRONTUÁRIO POR QUEIXA

história, exame e conduta prontos — troque o lado, o CID e o que for do paciente

Lombalgia aguda

CID M54.4/5 → 3.1 Lombalgia aguda mecânica, p. 73

PACIENTE COM LOMBALGIA APÓS ESFORÇO FÍSICO. SEM HISTÓRIA DE TRAUMA RECENTE.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

PCTE BEG, HIDRATADO, CORADO, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO, AFEBRIL E EUPNEICO.
DOR À PALPAÇÃO DE MUSCULATURA PARAVERTEBRAL LOMBAR, ADM LIMITADA E DOLOROSA.
SEM PARESTESIA DE MMII, NEGA FEBRE, DOR ABDOMINAL E OUTROS SINTOMAS. LASÈGUE -, GIORDANO -,
SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR E COM BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

CD: ORIENTAÇÕES GERAIS AO PACIENTE, ANALGESIA E SEGUIMENTO AMBULATORIAL.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Cervicalgia

CID M54.2 → 3.3 Cervicalgia e cervicobraquialgia, p. 79

PACIENTE COM CERVICALGIA, SEM HISTÓRIA DE TRAUMA RECENTE. NEGA FEBRE, CEFALEIA, NÁUSEAS, VÔMITOS OU OUTROS SINTOMAS.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

APRESENTA LASÈGUE -, GIORDANO -, LHERMITTE - E VALSALVA -, APRESENTA CONTRATURA DE TRAPÉZIO,
SEM PARESTESIA DE MMSS.
SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR E COM BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

CD: ORIENTAÇÕES GERAIS AO PACIENTE, ANALGESIA E SEGUIMENTO AMBULATORIAL.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Entorse de tornozelo aguda CID S93.4 → 10.1 Entorse de tornozelo, p. 177

PACIENTE REFERE ENTORSE DE TORNOZELO, COM DOR E EDEMA LOCAL.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EDEMA LOCAL LEVE, SEM EQUIMOSE OU HEMATOMAS, ADM DOLOROSA E LIVRE, DEAMBULANDO COM CARGA TOTAL. SEM DOR À PALPAÇÃO DE EXTREMIDADES ÓSSEAS, SEM DÉFICITS NEUROVASCULARES E COM BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
THOMPSON -.

CD: RX + ANALGESIA + REAVALIAÇÃO.
ORIENTAÇÕES GERAIS AO PACIENTE, ANALGESIA E SEGUIMENTO AMBULATORIAL.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Entorse de tornozelo crônica CID S93.4 → 10.1 Entorse de tornozelo, p. 177

PACIENTE REFERE ENTORSE DE TORNOZELO CRÔNICA, COM DOR PERSISTENTE AOS ESFORÇOS.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

SEM DOR À PALPAÇÃO ÓSSEA, SEM DÉFICITS NEUROVASCULARES E COM BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA. AUSÊNCIA DE EDEMA OU EQUIMOSE, COM ADM TOTAL E SEM SINAIS FLOGÍSTICOS. DEAMBULANDO COM CARGA TOTAL.

CD: ORIENTAÇÕES GERAIS AO PACIENTE, ANALGESIA E SEGUIMENTO AMBULATORIAL.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Trauma agudo (contusão) CID S60 mão · S90 pé

complete o local do trauma

TRAUMA DIRETO EM _____, COM DOR LOCAL E EDEMA.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EDEMA LOCAL, SEM DESVIOS OU CREPITAÇÕES, ADM DOLOROSA, SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, BPP, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS. SEM SINAIS DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL.

CD: RX + ANALGESIA + REAVALIAÇÃO.
ORIENTAÇÕES GERAIS AO PACIENTE, ANALGESIA E SEGUIMENTO AMBULATORIAL.

CID MÃO: S60
CID PÉ: S90

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Ombro — tendinite CID M75 → 4.1 Síndrome do impacto e tendinopatia do manguito, p. 86

DOR EM OMBRO, SEM HISTÓRIA DE TRAUMA RECENTE.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

DOR DIFUSA, TESTES DE IMPACTO + COM ADM DOLOROSA.
SEM DÉFICITS NEUROVASCULARES E COM BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA, SEM IRRADIAÇÃO OU PARESTESIA EM MMSS.
AUSÊNCIA DE EDEMAS OU EQUIMOSE.

CD: ORIENTAÇÕES GERAIS AO PACIENTE, ANALGESIA E SEGUIMENTO AMBULATORIAL.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Cotovelo — epicondilite CID M77 → 5.1 Epicondilite lateral e medial, p. 100

DOR EM COTOVELO, SEM HISTÓRIA DE TRAUMA RECENTE.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

DOR LATERAL, COZEN +, MILLS +, SEM DÉFICITS NEUROVASCULARES E COM BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA,
AUSÊNCIA DE EDEMA OU EQUIMOSE, COM ADM TOTAL E SEM SINAIS FLOGÍSTICOS.

CD: ORIENTAÇÕES GERAIS AO PACIENTE, ANALGESIA E SEGUIMENTO AMBULATORIAL.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Punho — tendinite CID M65 → 5.3 Tenossinovite de De Quervain, p. 105

DOR EM PUNHO, SEM HISTÓRIA DE TRAUMA RECENTE.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

DOR EM FACE DORSAL DE PUNHO, SEM DÉFICITS NEUROVASCULARES E COM BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
AUSÊNCIA DE EDEMA OU EQUIMOSE, COM ADM TOTAL E SEM SINAIS FLOGÍSTICOS.

CD: ORIENTAÇÕES GERAIS AO PACIENTE, ANALGESIA E SEGUIMENTO AMBULATORIAL.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Quadril — dor sem trauma CID R52 / S76 → 7.2 Bursite trocantérica (síndrome dolorosa do grande trocanter), p. 141

DOR EM QUADRIL, SEM HISTÓRIA DE TRAUMA RECENTE.
PACIENTE DEAMBULANDO SEM DIFICULDADES.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

SEM DÉFICITS NEUROVASCULARES E COM BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA,
AUSÊNCIA DE EDEMA OU EQUIMOSE, COM ADM TOTAL E SEM SINAIS FLOGÍSTICOS.

CD: ORIENTAÇÕES, RECEITA, REPOUSO E RETORNO AO PS SE NECESSÁRIO.
ENCAMINHO PARA SEGUIMENTO AMBULATORIAL.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Joelho — dor sem trauma CID M23 → 9.4 Dor patelofemoral e condromalácia, p. 171

DOR EM JOELHOS DIREITO E ESQUERDO HÁ CERCA DE 1 MÊS. NEGA TRAUMAS.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EF: SEM EDEMAS, SEM DERRAME ARTICULAR, TESTES LIGAMENTARES E MENISCAIS NEGATIVOS. DOR À PREENSÃO PATELAR.
SEM DOR À PALPAÇÃO DE INTERLINHAS E PATA DE GANSO.

CD: AINES.
ORIENTAÇÕES GERAIS.
SEGUIMENTO AMBULATORIAL.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Fascite plantar CID M72.2 → 10.2 Fascite plantar, p. 180

DOR EM PÉ, SEM HISTÓRIA DE TRAUMA RECENTE.
DOR À PALPAÇÃO DE CALCÂNEO, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, SEM DÉFICITS NEUROVASCULARES E COM BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA. ADM TOTAL E SEM SINAIS FLOGÍSTICOS.

CD: ANALGESIA, ORIENTAÇÕES GERAIS DE USO DE CALÇADO ADEQUADO, CRIOTERAPIA E ALONGAMENTO.
SEGUIMENTO AMBULATORIAL.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Trauma de hemitórax CID S20

DOR EM HEMITÓRAX, COM HISTÓRIA DE TRAUMA RECENTE, PCTE EUPNEICO, COM BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

PULSOS PRESERVADOS E SEM DÉFICITS NEUROVASCULARES, BEG, HIDRATADO, CORADO E ACIANÓTICO,
SEM HISTÓRIA DE FEBRE OU TOSSE. NEGA CANSAÇO E OUTROS SINTOMAS. RX SEM EVIDÊNCIA DE FRATURAS.

CD: ORIENTO PCTE, RETORNO EM 48H SEM MELHORA; SE FEBRE, TOSSE OU DISPNEIA PROCURAR CM.
ORIENTAÇÕES, RECEITA E ANALGESIA.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Perna — dor sem trauma CID M79.6 → 10.3 Tendinopatia e ruptura do Aquiles, p. 182

PACIENTE RELATA DOR EM PERNA, RECENTE, SEM HISTÓRIA DE TRAUMA.
SEM EDEMA OU SINAIS FLOGÍSTICOS, CACIFO -.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

PULSOS OK E PANTURRILHAS LIVRES, THOMPSON -, E FUNÇÃO E ADM DE JOELHO E TNZ SEM ALTERAÇÕES,
SEM DÉFICITS NEUROVASCULARES E BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.

CD: ANALGESIA E ORIENTAÇÕES. RETORNO S/N — ENC. PARA AMBULATÓRIO.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Reavaliação após o raio-X (sem fratura)

REAVALIAÇÃO:

RADIOGRAFIA SEM EVIDÊNCIA DE FRATURAS AGUDAS OU OUTRAS ALTERAÇÕES ÓSSEAS SIGNIFICATIVAS.

CONDUTA:
TRATAMENTO SINTOMÁTICO CONFORME NECESSIDADE.
ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO A REPOUSO RELATIVO E RETORNO EM CASO DE PERSISTÊNCIA OU PIORA DOS SINTOMAS.
ANALGESIA.
ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Consulta de retorno — fratura conservadora (30 dias)

CONSULTA DE RETORNO PARA ACOMPANHAMENTO DE FRATURA _____, TRATADA DE FORMA CONSERVADORA, COM EVOLUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30 DIAS.

SOLICITO REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DE CONTROLE E POSTERIOR REAVALIAÇÃO CLÍNICA.

--- REAVALIAÇÃO

RADIOGRAFIA EVIDENCIANDO CONSOLIDAÇÃO DE FRATURA.

CONDUTA:
RETIRADA DA TALA.
ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO À MOBILIZAÇÃO PROGRESSIVA DO MEMBRO ACOMETIDO.
ENCAMINHO PARA FISIOTERAPIA.
MANUTENÇÃO DE ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL.

Carta à UBS — acompanhamento após consolidação

CARTA À UBS:

ENCAMINHO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL APÓS CONSOLIDAÇÃO DE FRATURA _____, TRATADA DE FORMA CONSERVADORA.

SOLICITO ENCAMINHAMENTO PARA FISIOTERAPIA, COM FOCO NA RECUPERAÇÃO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO, FORTALECIMENTO MUSCULAR E REABILITAÇÃO FUNCIONAL DO MEMBRO ACOMETIDO.

CID:

GRATA.

Lombociatalgia / hérnia de disco

CID M54.4 / M51.1 do guia → 3.2 Lombociatalgia e hérnia de disco, p. 76

PACIENTE COM LOMBALGIA IRRADIADA PARA MEMBRO INFERIOR _____ (TRAJETO _____), HÁ _____ DIAS, APÓS ESFORÇO / SEM FATOR DESENCADEANTE. NEGA TRAUMA.
NEGA FEBRE, PERDA DE PESO, RETENÇÃO OU INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL, ANESTESIA EM SELA.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EF: BEG, AFEBRIL. DOR À PALPAÇÃO PARAVERTEBRAL LOMBAR, ADM LIMITADA POR DOR.
LASÈGUE + A _____° À _____ / LASÈGUE CRUZADO -. GIORDANO -.
FORÇA: DORSIFLEXÃO DO HÁLUX _____/5, DORSIFLEXÃO DO PÉ _____/5, FLEXÃO PLANTAR _____/5, EXTENSÃO DO JOELHO _____/5.
REFLEXOS PATELAR E AQUILEU PRESENTES E SIMÉTRICOS. SENSIBILIDADE _____.
TÔNUS ESFINCTERIANO PRESERVADO. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.

CD: ANALGESIA EV NO PS, ORIENTAÇÕES (MANTER ATIVIDADE CONFORME DOR, SEM REPOUSO NO LEITO), RECEITA E RETORNO EM 2 SEMANAS COM EXAME NEUROLÓGICO REPETIDO.
SINAIS DE ALARME EXPLICADOS: PERDA DE FORÇA, RETENÇÃO URINÁRIA, ANESTESIA EM SELA → RETORNAR IMEDIATAMENTE.
SEM INDICAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE URGÊNCIA (SEM DÉFICIT E SEM ALARME).

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Fratura vertebral por fragilidade (idoso) CID M80.0 do guia → 3.4 Fratura vertebral por fragilidade, p. 82

PACIENTE IDOSO(A) COM DOR DORSAL/LOMBAR AGUDA HÁ _____ DIAS APÓS QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA / ESFORÇO MÍNIMO / SEM TRAUMA.
NEGA FEBRE, PERDA DE PESO OU DOR NOTURNA PROGRESSIVA. NEGA ALTERAÇÃO DE FORÇA OU ESFÍNCTERES.
COMORBIDADES: _____. MUC: _____. ALERGIAS: NEGA.

EF: DOR À PERCUSSÃO DO PROCESSO ESPINHOSO DE _____. SEM DÉFICIT MOTOR OU SENSITIVO EM MMII, REFLEXOS PRESERVADOS, ESFÍNCTERES PRESERVADOS. DEAMBULA COM APOIO.
RX DE COLUNA TORÁCICA E LOMBAR AP + PERFIL: FRATURA EM CUNHA DE _____, SEM RETROPULSÃO.

CD: ANALGESIA (DIPIRONA FIXA; TRAMADOL EM DOSE BAIXA COM LAXANTE SE PRECISAR), MOBILIZAÇÃO PRECOCE COM APOIO, COLETE DE CONFORTO SE DISPONÍVEL.
ORIENTO SINAIS DE ALARME (PERDA DE FORÇA, ALTERAÇÃO DE ESFÍNCTERES).
RETORNO EM 2 SEMANAS; RX DE CONTROLE EM 6–8 SEMANAS.
ENCAMINHO À UBS PARA INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE (CÁLCIO, VITAMINA D, BISFOSFONATO) E PREVENÇÃO DE QUEDAS.

USO IMEDIATO - ENDOVENOSO:

DIPIRONA 1G ---------- 02 ML EV LENTO
SF 0,9% 100 ML

Capsulite adesiva (ombro congelado) CID M75.0 do guia → 4.2 Capsulite adesiva (ombro congelado), p. 89

DOR EM OMBRO _____ HÁ _____ SEMANAS/MESES, PROGRESSIVA, PIOR À NOITE, COM PERDA DE MOVIMENTO. SEM TRAUMA.
COMORBIDADES: DIABETES _____ / TIREOIDE _____. ALERGIAS: NEGA.

EF: LIMITAÇÃO ATIVA E PASSIVA DA ROTAÇÃO EXTERNA (_____°) E DA ELEVAÇÃO (_____°), DOR NO FIM DO ARCO. SEM ATROFIA, SEM DERRAME. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
RX DE OMBRO (AP VERDADEIRO + PERFIL ESCAPULAR + AXILAR): SEM LUXAÇÃO POSTERIOR, SEM ARTROSE, SEM CALCIFICAÇÃO.

CD: ANALGESIA, INFILTRAÇÃO INTRA-ARTICULAR DE CORTICOIDE (REALIZADA / INDICADA), EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO POR ESCRITO (PÊNDULO, ESCADA DE DEDOS, ROTAÇÃO EXTERNA COM BASTÃO), ORIENTAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO EM FASES (DOR → RIGIDEZ → DESCONGELAMENTO, 12–24 MESES).
ENCAMINHO PARA FISIOTERAPIA. RETORNO EM 4–6 SEMANAS.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Síndrome do túnel do carpo CID G56.0 do guia → 5.2 Síndrome do túnel do carpo, p. 103

PARESTESIA EM MÃO _____ (POLEGAR, INDICADOR E MÉDIO), PIOR À NOITE, QUE MELHORA AO SACUDIR A MÃO, HÁ _____ MESES. NEGA TRAUMA. NEGA DÉFICIT DE FORÇA PROXIMAL, ALTERAÇÃO DE FALA OU FACE.
COMORBIDADES: _____ (DIABETES, HIPOTIREOIDISMO, GESTAÇÃO). ALERGIAS: NEGA.

EF: PHALEN +, TINEL + NO PUNHO, DURKAN +. SENSIBILIDADE DIMINUÍDA NO TERRITÓRIO DO MEDIANO. SEM ATROFIA TENAR, OPONÊNCIA DO POLEGAR PRESERVADA. SPURLING -. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.

CD: ÓRTESE DE PUNHO NOTURNA EM POSIÇÃO NEUTRA (OU TALA GESSADA CURTA SE NÃO HÁ ÓRTESE), ORIENTAÇÕES, ANALGESIA.
SOLICITO ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS. ENCAMINHO PARA AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA/MÃO.
RETORNO EM 6 SEMANAS. ATROFIA TENAR OU DÉFICIT SENSITIVO CONSTANTE → INDICAÇÃO CIRÚRGICA PELA REGULAÇÃO.

Dedo em gatilho CID M65.3 do guia → 5.4 Dedo em gatilho, p. 107

DEDO _____ DA MÃO _____ QUE TRAVA EM FLEXÃO E ESTALA AO ESTENDER, HÁ _____ SEMANAS, PIOR PELA MANHÃ. NEGA TRAUMA.
COMORBIDADES: _____ (DIABETES). ALERGIAS: NEGA.

EF: NÓDULO DOLOROSO SOBRE A POLIA A1 (PREGA PALMAR DISTAL), RESSALTO À FLEXO-EXTENSÃO ATIVA. SEM SINAIS FLOGÍSTICOS, SEM DOR FUSIFORME (SEM TENOSSINOVITE INFECCIOSA). SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.

CD: INFILTRAÇÃO DE CORTICOIDE NA BAINHA DO FLEXOR (REALIZADA / INDICADA — VER PROCEDIMENTO), ORIENTAÇÕES, ANALGESIA.
RETORNO EM 6 SEMANAS. FALHA DE 2 INFILTRAÇÕES OU DEDO PRESO EM FLEXÃO → LIBERAÇÃO DA POLIA A1 PELA REGULAÇÃO.

Suspeita de fratura de escafoide CID S62.0 do guia → 5.6 Fratura de escafoide (suspeita), p. 113

QUEDA SOBRE A MÃO _____ ESTENDIDA HÁ _____ HORAS/DIAS, COM DOR EM PUNHO DO LADO RADIAL.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EF: DOR À PALPAÇÃO DA TABAQUEIRA ANATÔMICA E DO TUBÉRCULO DO ESCAFOIDE, DOR À COMPRESSÃO AXIAL DO POLEGAR. EDEMA DISCRETO, SEM DEFORMIDADE. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
RX DE PUNHO (AP + PERFIL + SÉRIE DO ESCAFOIDE): SEM FRATURA EVIDENTE.

CD: TRATADO COMO FRATURA ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO: TALA GESSADA ANTEBRAQUIOPALMAR COM INCLUSÃO DO POLEGAR, ANALGESIA, ORIENTAÇÕES.
RETORNO OBRIGATÓRIO EM 10–14 DIAS COM NOVO RX (SÉRIE DO ESCAFOIDE); RESSONÂNCIA SE DISPONÍVEL.
ORIENTADO SOBRE O RISCO DE NÃO CONSOLIDAÇÃO SE NÃO IMOBILIZAR.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Rizartrose (artrose da base do polegar) CID M18 do guia → 5.7 Rizartrose (artrose da base do polegar), p. 115

DOR NA BASE DO POLEGAR _____ HÁ _____ MESES, PIOR À PINÇA (ABRIR POTES, TORCER ROUPA). NEGA TRAUMA.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EF: DOR À PALPAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TRAPÉZIO-METACARPIANA, TESTE DE GRIND (COMPRESSÃO + ROTAÇÃO) +, PROEMINÊNCIA DA BASE DO 1º METACARPO. FINKELSTEIN -. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
RX DE MÃO/POLEGAR: ARTROSE TRAPÉZIO-METACARPIANA _____ (EATON _____).

CD: ÓRTESE CURTA DE POLEGAR (SPICA), AINE TÓPICO, ANALGESIA, ORIENTAÇÕES DE POUPAR A PINÇA FORTE.
ENCAMINHO PARA AMBULATÓRIO (INFILTRAÇÃO SE PERSISTIR). RETORNO EM 6–8 SEMANAS.

Luxação posterior de cotovelo — nota e redução CID S53.1 do guia → 6.1 Luxação de cotovelo e fratura da cabeça do rádio, p. 118

QUEDA SOBRE A MÃO _____ ESTENDIDA, COM DOR INTENSA E DEFORMIDADE DO COTOVELO _____, IMPOTÊNCIA FUNCIONAL.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES. ÚLTIMA REFEIÇÃO: _____.

EF: COTOVELO EM SEMIFLEXÃO, OLÉCRANO PROEMINENTE POSTERIORMENTE, PERDA DO TRIÂNGULO DE HÜTER. PULSO RADIAL PRESENTE, ENCHIMENTO CAPILAR < 2 S. NERVOS MEDIANO (OPONÊNCIA / SENSIBILIDADE DO INDICADOR), ULNAR (ABDUÇÃO DOS DEDOS / 5º DEDO) E RADIAL (EXTENSÃO DO PUNHO) TESTADOS E ANOTADOS: _____.
RX DE COTOVELO AP + PERFIL: LUXAÇÃO POSTERIOR, SEM / COM FRATURA ASSOCIADA (CORONOIDE / CABEÇA DO RÁDIO / EPICÔNDILO).

CD: ANALGESIA EV; SEDAÇÃO / BLOQUEIO INTRA-ARTICULAR COM LIDOCAÍNA 1% 10 ML.
REALIZADA REDUÇÃO FECHADA: AJUDANTE FIXANDO O BRAÇO, TRAÇÃO NO EIXO DO ANTEBRAÇO EM LEVE FLEXÃO E POLEGAR EMPURRANDO O OLÉCRANO — REDUÇÃO COM RESSALTO.
TESTE DE ESTABILIDADE: ESTÁVEL EM FLEXO-EXTENSÃO _____. NEUROVASCULAR APÓS A REDUÇÃO: PRESERVADO.
TALA GESSADA POSTERIOR A 90° EM PRONAÇÃO NEUTRA. RX DE CONTROLE: CONGRUENTE.
ALTA COM ANALGESIA, TIPOIA, ORIENTAÇÕES; RETORNO EM 5–7 DIAS PARA RETIRAR A TALA E INICIAR MOVIMENTO.
LUXAÇÃO IRREDUTÍVEL, ABERTA OU COM FRATURA INSTÁVEL → REGULAÇÃO DE URGÊNCIA.

Fratura da cabeça do rádio CID S52.1 do guia → 6.1 Luxação de cotovelo e fratura da cabeça do rádio, p. 118

QUEDA SOBRE A MÃO _____ ESTENDIDA, COM DOR LATERAL NO COTOVELO _____ E LIMITAÇÃO DA PRONOSSUPINAÇÃO.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EF: DOR À PALPAÇÃO DA CABEÇA DO RÁDIO, DOR À PRONOSSUPINAÇÃO, DERRAME ARTICULAR DISCRETO. SEM BLOQUEIO MECÂNICO. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
RX DE COTOVELO AP + PERFIL: SINAL DO COXIM GORDUROSO + / FRATURA DA CABEÇA DO RÁDIO SEM DESVIO (MASON I).

CD: ASPIRAÇÃO DA HEMARTROSE (SE TENSA) E ANALGESIA. TIPOIA POR CONFORTO POR 3–5 DIAS E MOVIMENTO PRECOCE (FLEXO-EXTENSÃO E PRONOSSUPINAÇÃO ATIVAS DESDE JÁ).
RETORNO EM 7 DIAS COM RX. DESVIO > 2 MM, BLOQUEIO MECÂNICO OU COMINUIÇÃO → AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA PELA REGULAÇÃO.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Luxação dorsal da interfalângica proximal — nota e redução CID S63.1 do guia → 6.3 Dedo luxado, dedo em martelo e lesões de tendão, p. 127

TRAUMA EM HIPEREXTENSÃO DO _____ DEDO DA MÃO _____ (BOLA / QUEDA), COM DEFORMIDADE E DOR.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EF: DEFORMIDADE EM BAIONETA DA IFP, IMPOTÊNCIA FUNCIONAL, PELE ÍNTEGRA, ENCHIMENTO CAPILAR < 2 S, SENSIBILIDADE DA POLPA PRESERVADA.
RX DE DEDO AP + PERFIL: LUXAÇÃO DORSAL DA IFP, SEM / COM FRATURA DA BASE DA FALANGE MÉDIA.

CD: BLOQUEIO DIGITAL COM LIDOCAÍNA 1% SEM VASOCONSTRITOR (2 ML DE CADA LADO).
REALIZADA REDUÇÃO FECHADA: LEVE HIPEREXTENSÃO, TRAÇÃO NO EIXO E PRESSÃO DA BASE DA FALANGE MÉDIA PARA A PALMA — REDUZIDA.
ESTÁVEL À FLEXO-EXTENSÃO ATIVA: BUDDY TAPING COM O DEDO VIZINHO POR 3 SEMANAS, MOVIMENTO IMEDIATO.
RX DE CONTROLE: CONGRUENTE. ALTA COM ANALGESIA E ORIENTAÇÕES; RETORNO EM 1 SEMANA.
INSTÁVEL EM EXTENSÃO OU FRATURA > 30% DA BASE → TALA DE BLOQUEIO DORSAL / CIRURGIA DA MÃO PELA REGULAÇÃO.

Dedo em martelo CID S66.3 do guia → 6.3 Dedo luxado, dedo em martelo e lesões de tendão, p. 127

TRAUMA NA PONTA DO _____ DEDO DA MÃO _____ (BOLA / "DEDO DOBRADO"), COM QUEDA DA FALANGE DISTAL. NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EF: FALANGE DISTAL EM FLEXÃO DE _____°, SEM EXTENSÃO ATIVA DA IFD, EXTENSÃO PASSIVA COMPLETA. SEM FERIDA. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
RX DE DEDO AP + PERFIL: SEM FRATURA / AVULSÃO ÓSSEA DE _____ % DA SUPERFÍCIE ARTICULAR, SEM SUBLUXAÇÃO.

CD: TALA DE EXTENSÃO DA IFD (STACK OU ALUMÍNIO ACOLCHOADO), IFP LIVRE, CONTÍNUA POR 6–8 SEMANAS — ORIENTADO A NUNCA DEIXAR A PONTA DOBRAR, NEM AO TROCAR A TALA.
ALTA COM ANALGESIA E ORIENTAÇÕES POR ESCRITO; RETORNO EM 1 SEMANA (PELE) E 6 SEMANAS.
FRAGMENTO > 1/3 OU SUBLUXAÇÃO VOLAR → CIRURGIA DA MÃO PELA REGULAÇÃO.

Osteoartrite de quadril — crise CID M16 do guia → 7.1 Osteoartrite de quadril, p. 138

DOR EM VIRILHA / QUADRIL _____ HÁ _____ MESES, PIOR AO ANDAR E AO LEVANTAR, COM RIGIDEZ MATINAL < 30 MIN. PIORA HÁ _____ DIAS. NEGA TRAUMA, FEBRE OU PERDA DE PESO.
COMORBIDADES: _____. ALERGIAS: NEGA.

EF: MARCHA ANTÁLGICA, LIMITAÇÃO DA ROTAÇÃO INTERNA E DA FLEXÃO DO QUADRIL COM DOR NO FIM DO ARCO. SEM DOR TROCANTÉRICA. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
RX DE BACIA AP + QUADRIL PERFIL: REDUÇÃO DO ESPAÇO ARTICULAR, OSTEÓFITOS, ESCLEROSE — SEM FRATURA.

CD: ANALGESIA (PARACETAMOL/DIPIRONA FIXOS; AINE CURTO SE SEM CONTRAINDICAÇÃO, COM OMEPRAZOL), BENGALA NA MÃO CONTRALATERAL, PERDA DE PESO E EXERCÍCIO DE BAIXO IMPACTO, FISIOTERAPIA PELA UBS. RETORNO EM 8–12 SEMANAS. DOR QUE LIMITA APESAR DE 3–6 MESES DE TRATAMENTO → AMBULATÓRIO DE QUADRIL (PRÓTESE) PELA REGULAÇÃO.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Fratura de quadril no idoso — admissão CID S72.0 / S72.1 do guia → 7.3 Fratura de quadril no idoso, p. 143

IDOSO(A) DE _____ ANOS, QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA HÁ _____ HORAS, COM DOR EM QUADRIL _____ E INCAPACIDADE DE APOIAR.
COMORBIDADES: _____. MUC: _____ (ANTICOAGULANTE? _____). ALERGIAS: _____. ÚLTIMA REFEIÇÃO: _____. MORA COM: _____.

EF: MEMBRO INFERIOR _____ ENCURTADO E EM ROTAÇÃO EXTERNA, DOR À MOBILIZAÇÃO DO QUADRIL. PULSOS DISTAIS PRESENTES, SENSIBILIDADE PRESERVADA. SEM OUTRAS LESÕES. PELE ÍNTEGRA, SEM ÚLCERAS DE PRESSÃO.
RX DE BACIA AP + QUADRIL _____ PERFIL: FRATURA _____ (COLO DO FÊMUR / TRANSTROCANTÉRICA), _____ DESVIADA.

CD: INTERNAÇÃO. ANALGESIA EV (DIPIRONA; MORFINA EM DOSE BAIXA TITULADA) E BLOQUEIO DA FÁSCIA ILÍACA REALIZADO / INDICADO.
JEJUM, ACESSO VENOSO, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS (HEMOGRAMA, FUNÇÃO RENAL, ELETRÓLITOS, COAGULOGRAMA, ECG, RX DE TÓRAX), AVALIAÇÃO CLÍNICA.
PROFILAXIA DE TROMBOSE (ENOXAPARINA 40 MG SC/DIA), PREVENÇÃO DE ÚLCERA DE PRESSÃO E DE DELIRIUM, HIDRATAÇÃO.
SOLICITADA VAGA CIRÚRGICA / REGULAÇÃO DE URGÊNCIA — CIRURGIA EM ATÉ 48 H.
INICIAR INVESTIGAÇÃO DA OSTEOPOROSE E ORIENTAR A FAMÍLIA.

Criança mancando — sinovite transitória do quadril CID M67.3 do guia → 7.4 Criança mancando: quadril, p. 146

CRIANÇA DE _____ ANOS, _____ KG, MANCANDO HÁ _____ DIAS, COM DOR EM QUADRIL / JOELHO _____. IVAS HÁ _____ DIAS. NEGA FEBRE, NEGA TRAUMA.
VACINAÇÃO EM DIA. ALERGIAS: NEGA.

EF: BEG, AFEBRIL (TAX _____ °C), APOIA O MEMBRO. LIMITAÇÃO LEVE E DOLOROSA DA ROTAÇÃO INTERNA DO QUADRIL _____; JOELHO SEM ALTERAÇÕES. SEM SINAIS FLOGÍSTICOS. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
EXAMES: HEMOGRAMA _____, VHS _____, PCR _____ (NORMAIS). RX DE BACIA AP + LÖWENSTEIN: SEM ALTERAÇÕES.

CD: SINOVITE TRANSITÓRIA. IBUPROFENO POR KG, REPOUSO RELATIVO, ORIENTAÇÕES AOS RESPONSÁVEIS.
RETORNO EM 48 H E EM 7 DIAS; RETORNO IMEDIATO SE FEBRE, PIORA DA DOR OU NÃO APOIAR (ARTRITE SÉPTICA?).
CRITÉRIOS DE KOCHER PRESENTES: _____/4.

RECEITA: IBUPROFENO GOTAS 100 MG/ML — _____ GOTAS (2 GOTAS/KG) DE 8/8 H POR 3–5 DIAS, COM ALIMENTO.

Fratura em tórus / galho verde na criança CID S52.5 do guia → 8.1 Fraturas na criança: tórus, galho verde e fise, p. 149

CRIANÇA DE _____ ANOS, QUEDA SOBRE A MÃO _____ HÁ _____ HORAS, COM DOR E EDEMA EM PUNHO/ANTEBRAÇO _____.
VACINAÇÃO EM DIA. ALERGIAS: NEGA.

EF: EDEMA E DOR À PALPAÇÃO DO TERÇO DISTAL DO RÁDIO, SEM DEFORMIDADE ANGULAR, SEM FERIDA. MOVE OS DEDOS, ENCHIMENTO CAPILAR < 2 S, SENSIBILIDADE PRESERVADA.
RX DE PUNHO/ANTEBRAÇO AP + PERFIL: FRATURA EM TÓRUS (ABAULAMENTO CORTICAL) / GALHO VERDE COM ANGULAÇÃO DE _____° DO RÁDIO DISTAL. FISE ÍNTEGRA (SALTER-HARRIS _____).

CD: TÓRUS — TALA ANTEBRAQUIOPALMAR (OU ÓRTESE REMOVÍVEL) POR 3 SEMANAS, SEM RX DE CONTROLE; GALHO VERDE SEM DESVIO — TALA/GESSO POR 4 SEMANAS, RX EM 7 DIAS.
ANALGESIA POR KG, ELEVAÇÃO, ORIENTAÇÕES ESCRITAS AOS RESPONSÁVEIS (DEDOS ROXOS, FRIOS OU DOR QUE NÃO PASSA = VOLTAR).
RETORNO EM _____ DIAS. ATESTADO ESCOLAR: SEM EDUCAÇÃO FÍSICA POR 4 SEMANAS.
ANGULAÇÃO ACIMA DO ACEITÁVEL PARA A IDADE OU FISE DESVIADA → ORTOPEDIA PEDIÁTRICA PELA REGULAÇÃO.

Fratura supracondiliana do úmero na criança CID S42.4 do guia → 8.2 Fratura supracondiliana do úmero na criança, p. 154

CRIANÇA DE _____ ANOS, _____ KG, QUEDA SOBRE A MÃO _____ ESTENDIDA HÁ _____ HORAS, COM DOR E EDEMA EM COTOVELO _____. ÚLTIMA REFEIÇÃO: _____.
VACINAÇÃO EM DIA. ALERGIAS: NEGA.

EF: EDEMA DO COTOVELO, DOR À PALPAÇÃO SUPRACONDILIANA, SEM FERIDA. PULSO RADIAL PRESENTE, MÃO QUENTE E CORADA, ENCHIMENTO CAPILAR < 2 S. NERVOS: INTERÓSSEO ANTERIOR (SINAL DO OK) _____, RADIAL (EXTENSÃO DO POLEGAR) _____, ULNAR (ABDUÇÃO DOS DEDOS) _____. SEM SINAIS DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL.
RX DE COTOVELO AP + PERFIL: COXIM GORDUROSO +, LINHA UMERAL ANTERIOR _____ O CAPÍTULO — GARTLAND _____.

GARTLAND I: TALA GESSADA POSTERIOR A 90° COM ANTEBRAÇO NEUTRO, TIPOIA, ANALGESIA POR KG, ORIENTAÇÕES ESCRITAS; RX EM 7 DIAS, RETIRADA EM 3 SEMANAS.
GARTLAND II/III: TALA PARA TRANSPORTE A ≤ 90°, JEJUM, ANALGESIA, REGULAÇÃO DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO E FIXAÇÃO EM 12–24 H — IMEDIATA SE SEM PULSO, MÃO PÁLIDA, ABERTA OU COM DÉFICIT.
PULSO REAVALIADO APÓS A TALA: PRESENTE.

Pronação dolorosa — nota e redução

CID S53.0 do guia → 8.3 Pronação dolorosa (subluxação da cabeça do rádio), p. 158

CRIANÇA DE _____ ANOS, PUXADA PELO BRAÇO / RODOU SOBRE O BRAÇO HÁ _____ HORAS; DESDE ENTÃO NÃO USA O MEMBRO SUPERIOR _____, QUE MANTÉM PENDENTE EM PRONAÇÃO. NEGA QUEDA OU TRAUMA DIRETO. VACINAÇÃO EM DIA. ALERGIAS: NEGA.

EF: CRIANÇA CALMA EM REPOUSO, BRAÇO PENDENTE EM PRONAÇÃO E LEVE FLEXÃO, RECUSA SUPINAÇÃO. SEM EDEMA, SEM DEFORMIDADE, SEM DOR ÓSSEA À PALPAÇÃO DE CLAVÍCULA, ÚMERO, COTOVELO, ANTEBRAÇO E PUNHO. PERFUSÃO PRESERVADA.

CD: QUADRO TÍPICO — SEM RX. EXPLICADO AOS RESPONSÁVEIS.
REALIZADA REDUÇÃO POR HIPERPRONAÇÃO (POLEGAR SOBRE A CABEÇA DO RÁDIO): ESTALO PERCEBIDO.
OBSERVAÇÃO POR _____ MINUTOS: CRIANÇA VOLTOU A USAR O BRAÇO ESPONTANEAMENTE.
ALTA SEM IMOBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÕES (NÃO PUXAR PELA MÃO; PODE REPETIR). ANALGESIA POR KG SE PRECISAR.
NÃO USOU O BRAÇO EM 30 MIN → RX DE COTOVELO E ANTEBRAÇO; NORMAL → TIPOIA E RETORNO EM 48 H.

Osteoartrite de joelho — crise

CID M17 do guia → 9.1 Osteoartrite de joelho, p. 162

DOR EM JOELHO _____ HÁ _____ ANOS, PIOR AO SUBIR/DESCER ESCADA E AO LEVANTAR, COM RIGIDEZ MATINAL < 30 MIN; PIORA HÁ _____ DIAS COM AUMENTO DE VOLUME. NEGA TRAUMA, FEBRE OU CALOR.
COMORBIDADES: _____. ALERGIAS: NEGA.

EF: DERRAME ARTICULAR _____ (LEVE / TENSO), SEM CALOR, CREPITAÇÃO, DOR À PALPAÇÃO DAS INTERLINHAS, DEFORMIDADE EM VARO/VALGO _____°. LACHMAN E GAVETAS -. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
RX DE JOELHO AP COM CARGA + PERFIL (+ AXIAL): REDUÇÃO DO ESPAÇO _____, OSTEÓFITOS, ESCLEROSE — SEM FRATURA.

CD: SEM SINAIS DE INFECÇÃO. PUNÇÃO SE DERRAME TENSO (LÍQUIDO _____) E INFILTRAÇÃO DE CORTICOIDE (REALIZADA / INDICADA).
ANALGESIA, AINE TÓPICO, AINE ORAL CURTO SE SEM CONTRAINDICAÇÃO (COM OMEPRAZOL), BENGALA, PERDA DE PESO, FORTALECIMENTO DE QUADRÍCEPS, FISIOTERAPIA PELA UBS.
RETORNO EM 8–12 SEMANAS. JOELHO QUENTE OU FEBRE → PUNÇÃO E ANÁLISE DO LÍQUIDO ANTES DE QUALQUER CORTICOIDE.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Entorse de joelho — ligamentos

CID S83.5 / S83.4 do guia → 9.2 Entorse de joelho: LCA, LCM e LCP, p. 165

TORÇÃO DO JOELHO _____ (VALGO / PIVÔ / HIPEREXTENSÃO) DURANTE _____ HÁ _____ HORAS, COM ESTALO _____, DOR E AUMENTO DE VOLUME EM _____ HORAS. SENSAÇÃO DE FALSEIO _____.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EF: DERRAME _____ (HEMARTROSE PRECOCE?), DOR À PALPAÇÃO DO LCM / INTERLINHA _____. LACHMAN _____, GAVETA ANTERIOR _____, GAVETA POSTERIOR _____, ESTRESSE EM VALGO A 30° _____, VARO _____. EXTENSÃO COMPLETA _____. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA. NERVO FIBULAR PRESERVADO.
OTTAWA _____ → RX DE JOELHO AP + PERFIL: SEM FRATURA (SEGOND _____).

CD: PUNÇÃO DA HEMARTROSE SE TENSA (LÍQUIDO _____). GELO, COMPRESSÃO, ELEVAÇÃO, MULETAS COM CARGA CONFORME A DOR; IMOBILIZADOR SÓ SE INSTÁVEL OU DOR INTENSA; ANALGESIA.
RETORNO EM 1 SEMANA PARA REEXAMINAR (LACHMAN SEM ESPASMO) E DEFINIR RESSONÂNCIA; FISIOTERAPIA.
JOELHO LUXADO / PULSO ALTERADO / BLOQUEIO VERDADEIRO → REGULAÇÃO DE URGÊNCIA.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Lesão meniscal

CID S83.2 / M23.2 do guia → 9.3 Lesão meniscal, p. 168

DOR EM JOELHO _____ APÓS TORÇÃO / AGACHAMENTO HÁ _____ DIAS, COM DOR NA INTERLINHA _____, SENSAÇÃO DE TRAVAMENTO _____ E DERRAME TARDIO (24–48 H).
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EF: DERRAME _____, DOR À PALPAÇÃO DA INTERLINHA _____, McMURRAY _____, THESSALY _____, EXTENSÃO COMPLETA PRESENTE (SEM BLOQUEIO VERDADEIRO). LACHMAN -. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
RX DE JOELHO AP COM CARGA + PERFIL: SEM FRATURA, _____ ARTROSE.

CD: PUNÇÃO SE DERRAME TENSO. GELO, AINE TÓPICO, ANALGESIA, MULETAS SE PRECISAR, ORIENTAÇÕES (SEM AGACHAR / GIRAR COM O PÉ FIXO).
FISIOTERAPIA; RETORNO EM 4–6 SEMANAS. RESSONÂNCIA SE PERSISTIR OU SE JOVEM COM TRAUMA (SUTURA?).
BLOQUEIO VERDADEIRO (NÃO ESTENDE) → IMOBILIZADOR E CIRURGIÃO DE JOELHO EM 48 H PELA REGULAÇÃO.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Bursite pré-patelar / cisto de Baker CID M70.4 / M71.2 do guia → 9.5 Cisto de Baker e bursites do joelho, p. 174

AUMENTO DE VOLUME ANTERIOR AO JOELHO _____ (SOBRE A PATELA) HÁ _____ DIAS, APÓS TRABALHO AJOELHADO / TRAUMA DIRETO. NEGA FEBRE / REFERE FEBRE _____. NEGA FERIDA / FERIDA _____.
COMORBIDADES: _____ (DIABETES). ALERGIAS: NEGA.

EF: COLEÇÃO FLUTUANTE PRÉ-PATELAR DE _____ CM, _____ CALOR E HIPEREMIA, SEM DERRAME INTRA-ARTICULAR, FLEXO-EXTENSÃO DO JOELHO PRESERVADA E POUCO DOLOROSA (A ARTICULAÇÃO NÃO É A FONTE). SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.

CD: BURSITE ASSÉPTICA — COMPRESSÃO, GELO, AINE, EVITAR AJOELHAR (JOELHEIRA), RETORNO EM 2 SEMANAS.
BURSITE SÉPTICA (QUENTE / FERIDA / FEBRE) — PUNÇÃO DA BURSA (GRAM, CULTURA, CELULARIDADE), CEFALEXINA 500 MG 6/6 H POR 7–10 DIAS, RETORNO EM 48 H; FEBRE ALTA, CELULITE EXTENSA OU DIABÉTICO → INTERNAÇÃO.
CISTO DE BAKER: MASSA POPLÍTEA MACIA, SEM SINAIS DE TROMBOSE (PANTURRILHA LIVRE); TRATAR A CAUSA INTRA-ARTICULAR, RETORNO AMBULATORIAL.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Fratura de metatarso / base do 5º metatarso CID S92.3 do guia → 10.4 Fratura de metatarso e do 5º metatarso, p. 186

TORÇÃO DO PÉ _____ / TRAUMA DIRETO HÁ _____ HORAS, COM DOR NA BORDA LATERAL DO PÉ E DIFICULDADE PARA APOIAR.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EF: EDEMA E DOR À PALPAÇÃO DA BASE DO 5º METATARSO / DIÁFISE DO _____ METATARSO, SEM DEFORMIDADE, SEM FERIDA. APOIO _____. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
RX DE PÉ AP + OBLÍQUA + PERFIL (COM CARGA SE TOLERADO): FRATURA _____ (AVULSÃO DA BASE DO 5º / DIÁFISE SEM DESVIO / JONES). LISFRANC: SEM DIÁSTASE.

CD: AVULSÃO DA BASE DO 5º OU DIÁFISE SEM DESVIO — SAPATO DE SOLA RÍGIDA OU BOTA, CARGA CONFORME A DOR, GELO, ELEVAÇÃO, ANALGESIA; RETORNO EM 2 E 6 SEMANAS COM RX.
JONES (METADIÁFISE PROXIMAL DO 5º) — BOTA SEM CARGA, MULETAS, AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA (RISCO DE NÃO UNIÃO).
MÚLTIPLAS, DESVIADAS OU LISFRANC → REGULAÇÃO.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Hálux valgo / metatarsalgia CID M20.1 / M77.4 do guia → 10.5 Hálux valgo, metatarsalgia e neuroma de Morton, p. 188

DOR NO ANTEPÉ _____ HÁ _____ MESES, PIOR COM CALÇADO FECHADO/SALTO E AO CAMINHAR MUITO; JOANETE _____. NEGA TRAUMA, FEBRE OU DOR NOTURNA.
COMORBIDADES: _____ (DIABETES — PÉ SENSÍVEL?). ALERGIAS: NEGA.

EF: HÁLUX VALGO DE _____°, BUNION _____ HIPEREMIADO, DOR À PALPAÇÃO DAS CABEÇAS DO 2º/3º METATARSOS, CALOSIDADE PLANTAR _____. 1ª MTF SEM CALOR (SEM GOTA). MULDER -. SENSIBILIDADE PLANTAR PRESERVADA. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
RX DE PÉ AP COM CARGA + OBLÍQUA + PERFIL: ÂNGULO HÁLUX VALGO _____°, SEM FRATURA POR ESTRESSE.

CD: CALÇADO LARGO DE BICO QUADRADO, PALMILHA COM APOIO RETROCAPITAL, SEPARADOR DE DEDOS, AINE TÓPICO, ANALGESIA, ORIENTAÇÕES.
RETORNO EM 8–12 SEMANAS. DOR QUE LIMITA APESAR DE 3–6 MESES → CIRURGIÃO DE PÉ PELA REGULAÇÃO (ELETIVO).

Monoartrite aguda — suspeita de artrite séptica CID M00.9 do guia → 11.1 Monoartrite aguda e artrite séptica, p. 192

DOR, CALOR E AUMENTO DE VOLUME EM _____ (ARTICULAÇÃO) HÁ _____ HORAS/DIAS, COM FEBRE _____ E INCAPACIDADE DE MOVER. NEGA TRAUMA / PORTA DE ENTRADA _____.
COMORBIDADES: _____ (DIABETES, IMUNOSSUPRESSÃO, PRÓTESE, USO DE DROGA EV). ALERGIAS: NEGA.

EF: REG, TAX _____ °C, FC _____. ARTICULAÇÃO QUENTE, DERRAME TENSO, DOR INTENSA À MÍNIMA MOBILIZAÇÃO (PSEUDOPARALISIA). SEM OUTRAS ARTICULAÇÕES ACOMETIDAS. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.

CD: PUNÇÃO ARTICULAR REALIZADA SOB ASSEPSIA (VER PROCEDIMENTO): LÍQUIDO _____ (ASPECTO), ENVIADO PARA CELULARIDADE, GRAM, CULTURA E CRISTAIS.
COLHIDOS HEMOGRAMA, PCR, VHS, HEMOCULTURAS (2 PARES), FUNÇÃO RENAL, GLICEMIA.
INICIADA ANTIBIOTICOTERAPIA EV APÓS A COLETA: OXACILINA 2 G EV 4/4 H (OU CEFAZOLINA 2 G EV 8/8 H). ANALGESIA EV.
INTERNAÇÃO; SOLICITADA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA / REGULAÇÃO DE URGÊNCIA PARA DRENAGEM (QUADRIL E OMBRO SEMPRE CIRÚRGICOS).
CRISTAIS DE URATO E CULTURA NEGATIVA → GOTA: AJUSTAR CONDUTA.

Crise de gota CID M10.9 do guia → 11.2 Crise de gota, p. 195

DOR SÚBITA, INTENSA, COM CALOR E VERMELHIDÃO EM 1ª METATARSOFALÂNGICA _____ (PODAGRA) / _____, INÍCIO HÁ _____ HORAS, À NOITE. CRISES PRÉVIAS: _____. NEGA FEBRE ALTA, NEGA TRAUMA.
COMORBIDADES: _____ (HAS, DRC, USO DE DIURÉTICO). ALERGIAS: NEGA.

EF: 1ª MTF _____ QUENTE, EDEMACIADA, HIPEREMIADA, DOR AO TOQUE DO LENÇOL; TOFOS _____. SEM PORTA DE ENTRADA. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
PRIMEIRA CRISE ATÍPICA, ARTICULAÇÃO GRANDE OU FEBRE → PUNÇÃO E CRISTAIS ANTES DE TRATAR.

CD: CRISE TÍPICA COM HISTÓRIA PRÉVIA — AINE EM DOSE PLENA (NAPROXENO 500 MG 12/12 H) OU COLCHICINA (1 MG AGORA + 0,5 MG EM 1 H) OU PREDNISONA 30 MG/DIA POR 5 DIAS CONFORME COMORBIDADES; OMEPRAZOL; GELO; REPOUSO.
NÃO INICIAR NEM SUSPENDER ALOPURINOL NA CRISE.
RETORNO EM 2 SEMANAS (ÁCIDO ÚRICO, CREATININA) PARA DEFINIR ALOPURINOL. ORIENTAÇÕES (ÁLCOOL, CARNE VERMELHA, FRUTOSE).

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Ruptura do tendão de Aquiles CID S86.0 do guia → 10.3 Tendinopatia e ruptura do Aquiles, p. 182

DOR SÚBITA NA PANTURRILHA/CALCÂNEO _____ DURANTE _____ (IMPULSO / CORRIDA) HÁ _____ HORAS, COM SENSAÇÃO DE "PEDRADA" / ESTALO E DIFICULDADE PARA FICAR NA PONTA DO PÉ.
MUC: _____ (QUINOLONA? CORTICOIDE?). ALERGIAS: NEGA.

EF: GAP PALPÁVEL A _____ CM DA INSERÇÃO, THOMPSON + (SEM FLEXÃO PLANTAR À COMPRESSÃO DA PANTURRILHA), PERDA DO EQUINO DE REPOUSO, FLEXÃO PLANTAR ATIVA FRACA. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
RX DE TORNOZELO AP + PERFIL: SEM AVULSÃO ÓSSEA.

CD: IMOBILIZAÇÃO EM EQUINO (TALA SUROPODÁLICA EM FLEXÃO PLANTAR / BOTA COM CUNHAS), SEM CARGA, MULETAS, GELO, ELEVAÇÃO, ANALGESIA.
ENCAMINHO AO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA EM ATÉ 48 H PARA DEFINIR TRATAMENTO FUNCIONAL (PROTOCOLO DE BOTA, 8 SEMANAS) OU CIRÚRGICO.
PROFILAXIA DE TROMBOSE CONFORME RISCO.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Síndrome compartimental — suspeita CID T79.6 do guia → 2.2 Síndrome compartimental e gesso apertado, p. 43

PACIENTE COM FRATURA DE _____ / ESMAGAMENTO / GESSO HÁ _____ HORAS, EVOLUINDO COM DOR DESPROPORCIONAL, PROGRESSIVA, QUE NÃO CEDE COM ANALGESIA, E PARESTESIA EM _____.

EF: COMPARTIMENTO _____ TENSO E DOLOROSO, DOR INTENSA AO ESTIRAMENTO PASSIVO DOS DEDOS/ARTELHOS (SINAL MAIS PRECOCE), PARESTESIA _____. PULSOS _____ (PULSO PRESENTE NÃO AFASTA). PRESSÃO DO COMPARTIMENTO: _____ MMHG (SE DISPONÍVEL).

CD: GESSO/TALA, ALGODÃO E ATADURAS ABERTOS ATÉ A PELE EM TODA A EXTENSÃO E AFASTADOS (BIVALVE) ÀS _____ H.
MEMBRO NO NÍVEL DO CORAÇÃO (NÃO ELEVADO), OXIGÊNIO, HIDRATAÇÃO, ANALGESIA EV E REGISTRO DA NECESSIDADE DE OPIOIDE.
REAVALIAÇÃO A CADA 1 H COM ANOTAÇÃO: _____.
SEM MELHORA EM 30–60 MIN OU PIORA → FASCIOTOMIA: ACIONADA A REGULAÇÃO DE URGÊNCIA / CIRURGIÃO ÀS _____ H. CK E FUNÇÃO RENAL COLHIDAS.

Fratura da patela / ruptura do aparelho extensor CID S82.0 / S76.1 do guia → 2.7 Fratura da patela e ruptura do aparelho extensor, p. 65

QUEDA SOBRE O JOELHO _____ / CONTRAÇÃO BRUSCA DO QUADRÍCEPS HÁ _____ HORAS, COM DOR, AUMENTO DE VOLUME E DIFICULDADE PARA ESTENDER A PERNA.
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

EF: DERRAME _____ (HEMARTROSE), DOR À PALPAÇÃO DA PATELA / DEGRAU PALPÁVEL _____, GAP SUPRA/INFRAPATELAR _____. ELEVAÇÃO DA PERNA ESTENDIDA CONTRA A GRAVIDADE: _____ (PRESERVADA / AUSENTE). PELE ÍNTEGRA. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA.
RX DE JOELHO AP + PERFIL + AXIAL: FRATURA _____ DA PATELA, DESVIO DE _____ MM / PATELA ALTA OU BAIXA (RUPTURA DO TENDÃO _____).

CD: SEM DESVIO E ELEVA A PERNA — ASPIRAÇÃO DA HEMARTROSE SE TENSA, IMOBILIZADOR DE JOELHO EM EXTENSÃO (OU GESSO CILÍNDRICO), CARGA TOTAL COM MULETAS, ANALGESIA; RETORNO EM 7 DIAS COM RX.
DESVIADA, COMINUTA OU SEM EXTENSÃO ATIVA (APARELHO EXTENSOR ROTO) — IMOBILIZADOR, SEM CARGA, REGULAÇÃO PARA CIRURGIA EM 1–2 SEMANAS.

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Fratura de ramo púbico no idoso CID S32.5 do guia → 2.8 Fraturas de pelve e sacro no idoso (e a pelve instável), p. 68

IDOSO(A) DE _____ ANOS, QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA HÁ _____ HORAS, COM DOR EM VIRILHA/NÁDEGA _____ E DIFICULDADE PARA ANDAR. CONSEGUE APOIAR: _____.
COMORBIDADES: _____. MUC: _____. ALERGIAS: _____. MORA COM: _____.

EF: HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL. DOR À PALPAÇÃO DO RAMO PÚBICO _____ E À COMPRESSÃO DA PELVE; PELVE ESTÁVEL. MEMBROS SEM ENCURTAMENTO OU ROTAÇÃO (QUADRIL LIVRE). SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR, PULSOS PALPÁVEIS E SIMÉTRICOS, BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA. SEM HEMATÚRIA.
RX DE BACIA AP (+ INLET/OUTLET): FRATURA DO(S) RAMO(S) _____ SEM DESVIO. SACRO: _____.

CD: FRATURA ESTÁVEL — ANALGESIA MULTIMODAL (DIPIRONA FIXA, PARACETAMOL, TRAMADOL EM DOSE BAIXA COM LAXANTE SE PRECISAR), ANDADOR, CARGA CONFORME A DOR, PROFILAXIA DE TROMBOSE ENQUANTO DEAMBULA POUCO (ENOXAPARINA 40 MG SC/DIA), FISIOTERAPIA DE MARCHA.
ALTA PARA CASA COM CUIDADOR / INTERNAÇÃO CURTA PARA CONTROLE DA DOR.
RETORNO EM 7–10 DIAS; RX EM 6 SEMANAS. INVESTIGAÇÃO DA OSTEOPOROSE PELA UBS.
NÃO ANDA APÓS 3–5 DIAS OU SACRO DESVIADO → CIRURGIÃO DE PELVE PELA REGULAÇÃO.

Luxação de quadril / joelho / tornozelo — urgência CID S73.0 / S83.1 / S93.0 do guia → 2.4 Luxações de quadril, joelho e tornozelo, p. 52

TRAUMA DE ALTA ENERGIA (_____) HÁ _____ HORAS, COM DEFORMIDADE E DOR INTENSA EM _____. ÚLTIMA REFEIÇÃO: _____.
ALERGIAS: _____. COMORBIDADES: _____.

EF (APÓS ATLS): _____ EM _____ (POSIÇÃO), DEFORMIDADE EVIDENTE, PELE _____ (TENSA / FERIDA). PULSOS DISTAIS _____, ENCHIMENTO CAPILAR _____, SENSIBILIDADE E MOTRICIDADE DISTAIS _____ (NERVO CIÁTICO / FIBULAR / TIBIAL). RX _____ AP + PERFIL: LUXAÇÃO _____ , _____ FRATURA ASSOCIADA.

CD: EMERGÊNCIA DO MEMBRO — ANALGESIA EV E SEDAÇÃO; REDUÇÃO FECHADA REALIZADA ÀS _____ H (TÉCNICA: _____), _____ TENTATIVA(S). NEUROVASCULAR REAVALIADO APÓS: _____.
IMOBILIZAÇÃO: _____. RX DE CONTROLE: _____.
JOELHO: ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL _____ / ANGIOTOMOGRAFIA SOLICITADA (LESÃO DA POPLÍTEA); PULSO ALTERADO → VASCULAR AGORA.
QUADRIL: TOMOGRAFIA APÓS A REDUÇÃO; INTERNAÇÃO SEM CARGA.
TORNOZELO: TALA POSTERIOR + ESTRIBO, ELEVAÇÃO.
ACIONADA A REGULAÇÃO DE URGÊNCIA PARA _____ (REDUÇÃO ABERTA / FIXAÇÃO / VASCULAR). PROFILAXIA DE TROMBOSE.

RECEITA PARA CASA

os esquemas que saem do PS de ortopedia; adulto sem comorbidade

Diclofenaco + dipirona + ciclobenzaprina

o esquema padrão do PS; com a orientação do gelo

PACIENTE REFERE _____
NEGA COMORBIDADE
NEGA ALERGIA

USO ORAL

1. DIPIRONA 500MG --------- 30 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 6/6H SE DOR

2. DICLOFENACO 50MG -------- 15 CPS
TOMAR 1 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 5 DIAS

3. CICLOBENZAPRINA 10MG ----------
TOMAR 01 CP VO À NOITE POR 5 NOITES

OBS: APLICAR COMPRESSA DE GELO NA REGIÃO POR 15–20 MINUTOS, 3–4 VEZES AO DIA, SEMPRE PROTEGENDO A PELE COM UM PANO. EVITAR APLICAR DIRETAMENTE NA PELE E NÃO ULTRAPASSAR 20 MINUTOS.

Diclofenaco 12/12h + dipirona + ciclobenzaprina

USO ORAL:

1. DICLOFENACO SÓDICO 50 MG ----------
TOMAR 01 COMP DE 12/12 HORAS, POR 5 DIAS

2. DIPIRONA 500MG ----------
TOMAR 02 CP DE 6/6H, SE DOR

3. CICLOBENZAPRINA 10MG ----------
TOMAR 01 CP VO À NOITE POR 5 NOITES

Ibuprofeno + dipirona + ciclobenzaprina

USO ORAL

1. IBUPROFENO 300MG ----------
TOMAR 01 CP DE 8/8H POR 5 DIAS

2. DIPIRONA 500MG ----------
TOMAR 02 CP DE 08/08H SE DOR

3. CICLOBENZAPRINA ----------
TOMAR 01 CP VO À NOITE POR 5 NOITES

Cetoprofeno + dipirona + prednisolona

USO ORAL:

1. CETOPROFENO 100MG ----------
TOMAR 1 CP VIA ORAL DE 12 EM 12 HS POR 5 DIAS

2. DIPIRONA 500 MG ----------
TOMAR 02 CP DE 6/6H SE DOR

3. PREDNISOLONA 20MG ----------
TOMAR 1 CP 1X AO DIA PELA MANHÃ POR 5 DIAS

Flancox (etoricoxibe) + dipirona

USO ORAL:

1. FLANCOX 600MG ----------
TOMAR 01 COMP DE 12/12 HORAS, POR 5 DIAS

2. DIPIRONA 500MG ----------
TOMAR 02 CP DE 6/6H, SE DOR

Flancox + dipirona + Miosan Caf

USO ORAL:

1. FLANCOX 600MG ----------
TOMAR 01 COMP DE 12/12 HORAS, POR 5 DIAS

2. DIPIRONA 500MG ----------
TOMAR 02 CP DE 6/6H, SE DOR

3. MIOSAN CAF 5/30MG ----------
TOMAR 01 CP À NOITE POR 5 DIAS

Adorlan (tramadol + diclofenaco) + Miosan Caf

dor moderada a intensa

USO ORAL:

1. ADORLAN 25MG ----------
TOMAR 01 COMP DE 8/8H, POR 5 DIAS

2. MIOSAN CAF 5/30MG ---------- 01 CX
TOMAR 01 CP DE 12/12H, POR 5 DIAS

Tramadol — dor intensa

USO ORAL:

1. TRAMADOL 50MG ----------
TOMAR 01 COMP DE 8/8H, SE DOR INTENSA

Toragesic (cetorolaco) sublingual + dipirona

USO ORAL:

1. TORAGESIC 10MG ----------
01 CP SUBLINGUAL DE 8/8H POR 5 DIAS

2. DIPIRONA 500MG ----------
TOMAR 02 CP VO DE 6/6H SE DOR

Tandrilax / Torsilax

paracetamol + cafeína + carisoprodol + diclofenaco

USO ORAL:

1. PARACETAMOL 300 MG + CAFEÍNA 30 MG + CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO 50 MG ----------
TOMAR 1 CP, VIA ORAL, DE 8/8 HORAS POR NO MÁXIMO 5 DIAS.

(TANDRILAX OU TORSILAX)

Ferimento — antibiótico + pomada → 6.4 Ferimentos da mão, unha e ponta do dedo, p. 132

USO ORAL:

1. CEFALEXINA 500MG ----------
TOMAR 1 CP VIA ORAL DE 6/6 H POR 7 DIAS.

2. IBUPROFENO 300MG ----------
TOMAR 01 CP DE 8/8H POR 5 DIAS

USO TÓPICO:

1. NEOMICINA + BACITRACINA POMADA ----------
APLICAR NAS LESÕES 3X AO DIA, APÓS HIGIENE LOCAL.

OBS: APLICAR COMPRESSA DE GELO NA REGIÃO POR 15–20 MINUTOS, 3–4 VEZES AO DIA, SEMPRE PROTEGENDO A PELE COM UM PANO. EVITAR APLICAR DIRETAMENTE NA PELE E NÃO ULTRAPASSAR 20 MINUTOS.

Pomada — neomicina + bacitracina, 10 dias

USO TÓPICO:

1. SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA POMADA ----------
APLICAR EM LESÃO 2X AO DIA POR 10 DIAS

Para que serve cada um — Adorlan, Hetori, Flancox

a linha de indicação que vai na receita

1. ADORLAN 25 MG ---------- 1 CX
TOMAR 1 CP, VO DE 12/12H POR 7 DIAS.
PARA: É UM MEDICAMENTO QUE COMBINA TRAMADOL E DICLOFENACO, INDICADO PARA O ALÍVIO DE DORES INFLAMATÓRIAS AGUDAS DE INTENSIDADE MODERADA A GRAVE. ELE É UTILIZADO PARA DORES PÓS-OPERATÓRIAS, DORES MUSCULARES E ARTICULARES INTENSAS, ENTRE OUTRAS.

1. HETORI 90 MG ---------- 1 CX
TOMAR 1 CP, VO 1X AO DIA POR 7 DIAS.
PARA: TRATAMENTO DA OSTEOARTRITE; TRATAMENTO DA ARTRITE REUMATOIDE; TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE (INFLAMAÇÃO DA COLUNA E DE GRANDES ARTICULAÇÕES); ALÍVIO DA DOR.

1. FLANCOX 600 MG ---------- 1 CX
TOMAR 1 CP, VO DE 12/12H, POR 7 DIAS.
PARA: ARTROSE E ARTRITE REUMATOIDE.

Pediatria — dipirona e ibuprofeno em gotas

→ 8.1 Fraturas na criança: tórus, galho verde e fise, p. 149

a dose em gotas é por peso: confira antes de copiar

USO ORAL

1. DIPIRONA 500MG/ML GOTAS ----------
TOMAR 20 GOTAS DE 6/6H SE DOR

2. IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS ----------
TOMAR 20 GOTAS DE 12/12H POR 3 DIAS

Analgesia em escada — dipirona + paracetamol + AINE com proteção

do guia

→ 1.2 Analgesia em escada, p. 9

USO ORAL:

1. DIPIRONA 1 G ----------
TOMAR 1 COMPRIMIDO DE 6/6 H SE DOR (MÁXIMO 4 G/DIA)

2. PARACETAMOL 750 MG ----------
TOMAR 1 COMPRIMIDO DE 6/6 H SE DOR, INTERCALADO COM A DIPIRONA (MÁXIMO 3 G/DIA)

3. NAPROXENO 500 MG ----------
TOMAR 1 COMPRIMIDO DE 12/12 H, POR 5 A 7 DIAS, APÓS AS REFEIÇÕES

4. OMEPRAZOL 20 MG ----------
TOMAR 1 CÁPSULA EM JEJUM, PELA MANHÃ, ENQUANTO USAR O ANTI-INFLAMATÓRIO

OBS: AINE POR NO MÁXIMO 7 DIAS. EVITAR EM > 65 ANOS, DOENÇA RENAL, ÚLCERA, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, ANTICOAGULANTE E GESTAÇÃO.

Crise de gota — AINE, colchicina ou prednisona do guia → 11.2 Crise de gota, p. 195

USO ORAL (ESCOLHER UM ESQUEMA CONFORME AS COMORBIDADES):

1. NAPROXENO 500 MG ----------
TOMAR 1 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 5 A 7 DIAS, APÓS AS REFEIÇÕES
+ OMEPRAZOL 20 MG — 1 CÁPSULA EM JEJUM ENQUANTO USAR

OU

1. COLCHICINA 0,5 MG ----------
TOMAR 2 COMPRIMIDOS AGORA E 1 COMPRIMIDO 1 HORA DEPOIS; A PARTIR DE AMANHÃ, 1 COMPRIMIDO 1 A 2X AO DIA ATÉ A CRISE PASSAR (MÁXIMO 7 DIAS)

OU

1. PREDNISONA 20 MG ----------
TOMAR 1 ½ COMPRIMIDO (30 MG) PELA MANHÃ POR 5 DIAS

OBS: NÃO INICIAR NEM SUSPENDER ALOPURINOL DURANTE A CRISE. RETORNO EM 2 SEMANAS COM ÁCIDO ÚRICO E CREATININA.

Pediatria por peso — dipirona, paracetamol e ibuprofeno em gotas do guia → 8.1 Fraturas na criança: tórus, galho verde e fise, p. 149

preencha o peso; as gotas vêm da conta

PESO: _____ KG

USO ORAL:

1. DIPIRONA GOTAS 500 MG/ML ----------
TOMAR _____ GOTAS (1 GOTA A CADA 2 KG ATÉ 1 GOTA/KG) DE 6/6 H SE DOR

2. PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML ----------
TOMAR _____ GOTAS (1 GOTA/KG) DE 6/6 H SE DOR — MÁXIMO 5 DOSES AO DIA

3. IBUPROFENO GOTAS 100 MG/ML ----------
TOMAR _____ GOTAS (2 GOTAS/KG; NA APRESENTAÇÃO DE 50 MG/ML, 4 GOTAS/KG) DE 8/8 H POR 3 A 5 DIAS, COM ALIMENTO — MÁXIMO 400 MG POR DOSE

AINE tópico — diclofenaco gel do guia

USO TÓPICO:

1. DICLOFENACO DIETILAMÔNIO GEL 11,6 MG/G ---------- 1 TUBO
APLICAR CAMADA FINA NO LOCAL DA DOR, 3 A 4X AO DIA, POR 14 DIAS, COM MASSAGEM LEVE. NÃO APLICAR EM PELE FERIDA.

Tramadol em dose baixa com laxante (idoso / fratura) do guia

USO ORAL:

1. DIPIRONA 1 G ----------
TOMAR 1 COMPRIMIDO DE 6/6 H (FIXO NOS PRIMEIROS DIAS)

2. TRAMADOL 50 MG ----------
TOMAR 1 COMPRIMIDO DE 8/8 H POR 7 A 14 DIAS SE A DOR NÃO CEDER COM A DIPIRONA

3. LACTULOSE 667 MG/ML ----------
TOMAR 15 ML AO DIA ENQUANTO USAR O TRAMADOL

OBS: TONTURA E SONOLÊNCIA — NÃO DIRIGIR; RISCO DE QUEDA NO IDOSO.

Profilaxia de trombose — enoxaparina do guia

USO SUBCUTÂNEO:

1. ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML ----------
APLICAR 1 SERINGA SC 1X AO DIA ENQUANTO ESTIVER SEM APOIAR O MEMBRO (OU PELO PERÍODO INDICADO: _____ SEMANAS)

OBS: AJUSTAR SE CLEARANCE < 30 ML/MIN (20 MG/DIA) OU PESO < 50 KG. ORIENTADA A APLICAÇÃO NO ABDOME, ALTERNANDO O LADO.

Osteoporose após fratura por fragilidade — alendronato + vitamina D do guia

→ 3.4 Fratura vertebral por fragilidade, p. 82

USO ORAL:

1. ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG ----------
TOMAR 1 COMPRIMIDO 1X POR SEMANA, EM JEJUM, COM UM COPO CHEIO DE ÁGUA, EM PÉ OU SENTADO, 30 MINUTOS ANTES DE COMER OU DEITAR

2. COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 2.000 UI ----------
TOMAR 1 CÁPSULA AO DIA

3. CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG ----------
TOMAR 1 COMPRIMIDO 2X AO DIA, COM AS REFEIÇÕES, SE A INGESTÃO ALIMENTAR FOR BAIXA

OBS: SOLICITAR DENSITOMETRIA, CÁLCIO, VITAMINA D, FUNÇÃO RENAL E TSH NA UBS. PREVENÇÃO DE QUEDAS.

Ferida de mão / fratura exposta de dedo — cefalexina do guia

→ 6.3 Dedo luxado, dedo em martelo e lesões de tendão, p. 127

USO ORAL:

1. CEFALEXINA 500 MG ----------
TOMAR 1 COMPRIMIDO DE 6/6 H POR 5 DIAS

2. DIPIRONA 1 G ----------
TOMAR 1 COMPRIMIDO DE 6/6 H SE DOR

OBS: CURATIVO DIÁRIO; RETORNO EM 48 H OU ANTES SE DOR CRESCENTE, VERMELHIDÃO QUE SOBE OU FEBRE.

MEDICAÇÃO NA UNIDADE

intramuscular e venosa de uso imediato

IM de uso imediato — o trio do PS

USO IMEDIATO - INTRAMUSCULAR:

DICLOFENACO ---------- 01 AMPOLA IM
DEXAMETASONA ---------- 01 AMPOLA IM
DIPIRONA ---------- 01 AMPOLA IM

Outras IM e a EV

o que cada unidade tem muda: Coltrax não tem no PS Engenho, cetoprofeno não tem na UPA Jandira

MEDICAÇÕES INTRAMUSCULARES

CITONEURIN ---------- 03 AMP
APLICAR 01 AMP DE 2/2 DIAS POR 5 DIAS.
DEXAMETASONA 1 AMP IM
CETOPROFENO 1 AMP IM

USO IMEDIATO:
DIPIRONA 1 AMP IM
COLTRAX 1 AMP IM

CETOPROFENO ---------- 01 AMPOLA IM

BETAMETASONA (DIPROSPAN) 1 AMP IM AGORA (MEDICAÇÃO DE DEPÓSITO)

MEDICAÇÃO EV:
TRAMADOL 100MG EV + SF 200 ML — CORRER LENTO

Analgesia EV no plantão — dipirona, cetorolaco, morfina titulada do guia

→ 1.2 Analgesia em escada, p. 9

USO IMEDIATO - ENDOVENOSO:

DIPIRONA 1 G/2 ML ---------- 02 ML EV LENTO (DILUÍDO EM SF 0,9% 100 ML)
CETOROLACO 30 MG ---------- 01 AMPOLA EV, DOSE ÚNICA (15 MG SE > 65 ANOS OU RENAL)
ONDANSETRONA 4 MG ---------- 01 AMPOLA EV SE NÁUSEA

FRATURA OU LUXAÇÃO (DOR INTENSA):
MORFINA 10 MG/ML — 2 A 4 MG EV A CADA 5–10 MIN ATÉ CONTROLAR (ATÉ 0,1 MG/KG NA PRIMEIRA HORA), COM ANTIEMÉTICO E MONITORIZAÇÃO. IDOSO: 2 MG POR VEZ.
ANOTAR A DOSE TOTAL E O HORÁRIO.

Nota de bloqueio de hematoma / digital do guia

→ 1.7 Anestesia local, bloqueios e sedação para reduzir, p. 24

PROCEDIMENTO: BLOQUEIO DE HEMATOMA / BLOQUEIO DIGITAL.
CONSENTIMENTO VERBAL OBTIDO. ASSEPSIA COM CLOREXIDINA.
LIDOCAÍNA 1% SEM VASOCONSTRITOR _____ ML (HEMATOMA: 5–10 ML NO FOCO APÓS ASPIRAÇÃO DE SANGUE ESCURO; DIGITAL: 2 ML DE CADA LADO DA BASE DO DEDO).
AGUARDADOS 10–15 MINUTOS. ANALGESIA ADEQUADA PARA O PROCEDIMENTO.
SEM INTERCORRÊNCIAS. NEUROVASCULAR PRESERVADO APÓS.

Nota de sedação para redução do guia

→ 1.7 Anestesia local, bloqueios e sedação para reduzir, p. 24

SEDAÇÃO PARA REDUÇÃO — CHECKLIST E NOTA:
JEJUM: _____ H. VIA AÉREA AVALIADA (MALLAMPATI _____). ASA _____. ALERGIAS: _____.
MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA (SPO2, FC, PA; CAPNOGRAFIA _____). OXIGÊNIO, ASPIRADOR, BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA E CÂNULAS À MÃO. SEGUNDA PESSOA SÓ NA VIA AÉREA: _____.
FENTANIL _____ MCG EV + MIDAZOLAM _____ MG EV LENTO (OU CETAMINA _____ MG EV).
REDUÇÃO ÀS _____ H, SEM INTERCORRÊNCIAS. SPO2 MÍNIMA _____ %. RECUPERAÇÃO COMPLETA ÀS _____ H (ACORDADO, ORIENTADO, DEAMBULA).
ALTA COM ACOMPANHANTE; ORIENTADO A NÃO DIRIGIR, NÃO TRABALHAR EM ALTURA OU COM MÁQUINAS POR 24 H.

NOTAS DE URGÊNCIA

luxação, sutura, trauma do SAMU, fratura exposta e os mecanismos de fratura

Luxação de ombro — nota, sedação e receita → 4.3 Luxação e instabilidade do ombro, p. 93

DOR INTENSA EM OMBRO APÓS TRAUMA (QUEDA / MOVIMENTO BRUSCO).
NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES.

AO EXAME: IMPOTÊNCIA FUNCIONAL DO OMBRO, DOR INTENSA À MOBILIZAÇÃO.
DEFORMIDADE EM "SINAL DA DRAGONA", SUGESTIVO DE LUXAÇÃO GLENOUMERAL.
ADM MUITO LIMITADA POR DOR.

AVALIAÇÃO NEUROVASCULAR: PULSOS PRESENTES, BOA PERFUSÃO DISTAL.
SEM DÉFICIT NEUROLÓGICO APARENTE (NERVO AXILAR PRESERVADO).
SEM PARESTESIAS.

CD:
- RX DE OMBRO
- REDUÇÃO FECHADA SE NECESSÁRIO

ORIENTAÇÕES:
COLOCAÇÃO DE TIPOIA
GELO LOCAL 20MIN 3–4X/DIA
EVITAR MOVIMENTOS DO OMBRO
RETORNO IMEDIATO SE DOR INTENSA, FORMIGAMENTO OU FRIEZA EM MEMBRO

PRESCRIÇÃO: ANTES DA REDUÇÃO (ANALGESIA / SEDAÇÃO)
DIPIRONA 1G EV 6/6H SE DOR
TRAMADOL 50–100MG EV SE DOR INTENSA
ONDANSETRONA 4MG EV SE NÁUSEAS

SEDAÇÃO PARA REDUÇÃO (SE NECESSÁRIO):
MIDAZOLAM 2–5MG EV LENTO
FENTANIL 50–100MCG EV

PÓS-REDUÇÃO:
DIPIRONA 1G VO/EV 6/6H SE DOR
IBUPROFENO 400–600MG VO 8/8H SE DOR
CODEÍNA + PARACETAMOL (SE DOR MODERADA/INTENSA)

Sutura — ferimento corto-contuso → 6.4 Ferimentos da mão, unha e ponta do dedo, p. 132

PACIENTE COM FCC EM _____ DE APROXIMADAMENTE 3 CM HÁ MENOS DE 6 HORAS, SEM PREJUÍZO MOTOR, TENDÕES EXTENSORES SUPERFICIAL E PROFUNDO ÍNTEGROS, SEM DNV, SEM SANGRAMENTO ATIVO.
AO EXAME:
BEG, CHAAA, EUPNEICO. LOTE.
AR: MV+ SIMÉTRICO, SEM RA.
ACV: BCRNF, 2T, S/S.
ABD: FLÁCIDO, RHA+, SEM ORGANOMEGALIAS.
NEUR: ECG 15/15, FM E REFLEXOS PRESERVADOS.
EXT: SEM EDEMAS, PANTURRILHAS LIVRES.

CONDUTA:
REALIZADA ANTISSEPSIA, ANESTESIA LOCAL E SUTURA.
CURATIVO COMPRESSIVO.
PRESCREVO SINTOMÁTICOS + ATB PARA CASA.
ORIENTO TROCA DE CURATIVO E RETIRADA DE SUTURA EM UBS.
ORIENTO BUSCAR UBS E RETORNO SE SINAIS DE ALARME.

Trauma trazido pelo SAMU — ABCDE

complete o acidente e o local do trauma

PACIENTE TRAZIDO PELO SAMU EM MACA RÍGIDA, IMOBILIZADO COM COLAR CERVICAL, VÍTIMA DE ACIDENTE _____ COM TRAUMA DIRETO EM _____, SEM PRESENÇA DE SANGRAMENTO ATIVO, SEM FRATURA EXPOSTA, SEM DEFORMIDADE NO MEMBRO ACOMETIDO. TRAUMA DE MÉDIA ENERGIA.

NEGA TCE, N/V OU PERDA DE CONSCIÊNCIA. NEGA DOR CERVICAL OU EM REGIÃO ESPINAL. NEGA DOR TORÁCICA, DISPNEIA OU DOR ABDOMINAL, NEGA DOR EM DEMAIS MEMBROS. NEGA SANGRAMENTOS, SEM DEMAIS QUEIXAS.

ALERGIA: NEGA
MUC: NEGA
COMORBIDADES: NEGA
NEGA TABAGISMO, ETILISMO, DROGAS
ÚLTIMA REFEIÇÃO: _____

EXAME FÍSICO:
A: VA PÉRVIAS. COLUNA CERVICAL SEM DOR À PALPAÇÃO/MOBILIZAÇÃO; COLAR CERVICAL RETIRADO.
B: MV+ BILATERAL E SIMÉTRICO, SEM RA, EXPANSIBILIDADE PRESERVADA, $SATO_2$ 98% EM AA.
C: HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL (PA 125/80 MMHG, FC 76 BPM). AC: RCR 2T BNF S/S. EXTREMIDADES PERFUNDIDAS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES. SEM HEMORRAGIA ATIVA. ABDOME FLÁCIDO, INDOLOR, PELVE ESTÁVEL.
D: ECG 15 (O4V5M6), LOTE, PIFR. SEM DÉFICITS MOTORES OU SENSITIVOS. SEM SINAIS DE TCE. COLUNA SEM DOR À PALPAÇÃO.
E: AUSÊNCIA DE FRATURAS EXPOSTAS OU DEFORMIDADES. COLUNA TORÁCICA/LOMBOSSACRA SEM DOR. DEMAIS MEMBROS SEM DEFORMIDADES OU OUTRAS LESÕES APARENTES. EXAME NEUROVASCULAR DISTAL PRESERVADO.

CONDUTA:
PRESCREVO ANALGESIA + HIDRATAÇÃO.
RADIOGRAFIA E REAVALIAÇÃO.

Trauma no box — fratura de perna após acidente de carro → 2.3 Fraturas da diáfise: fêmur, tíbia e úmero, p. 47

AVALIADO PACIENTE EM BOX DA EMERGÊNCIA, TRAZIDO PELOS BOMBEIROS CIVIS APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. QUEIXA-SE DE DOR EM MEMBRO INFERIOR _____.
AO EXAME:
LÚCIDO, ORIENTADO, SEM HISTÓRICO DE TCE.
EUPNEICO EM AA. SAT 96% EM AA. EXPANSIBILIDADE TORÁCICA BILATERAL. SEM ESTIGMAS DE TRAUMA TORÁCICO.
RCR, 2T, BNF, S/S. PA: 130 X 90 MMHG, FC 89 BPM. SEM SANGRAMENTOS EXTERNOS. ABDOME PLANO, FLÁCIDO, INDOLOR, SEM DB. PELVE ESTÁVEL.
LOTE, GLASGOW 15, PIFR. SEM ALTERAÇÃO AO EXAME FÍSICO DE COLUNA CERVICAL, TORÁCICA E LOMBOSSACRA.

DOR EM MI _____, EDEMA 2+/4+ NO PÉ.
FCC DE 2 CM EM FACE ANTEROLATERAL DE TERÇO MÉDIO DA PERNA.

RADIOGRAFIA EVIDENCIA FRATURA TRANSVERSA DE OSSOS DA PERNA.
RADIOGRAFIA DE PÉ: SEM ALTERAÇÃO AGUDA.
CLASSIFICAÇÃO: _____
ENCAMINHO PACIENTE PARA SEGUIMENTO NO AMBULATÓRIO DE FRATURAS.

Fratura exposta — nota, antibiótico e tétano → 2.1 Fratura exposta, p. 38

PACIENTE VÍTIMA DE TRAUMA, COM LESÃO EM MEMBRO _____ ASSOCIADA A FERIMENTO ABERTO.
REFERE DOR INTENSA, SANGRAMENTO E IMPOTÊNCIA FUNCIONAL.
AO EXAME, OBSERVA-SE FERIMENTO EM REGIÃO DE (DESCREVER), COM EXPOSIÇÃO ÓSSEA / SUSPEITA DE FRATURA EXPOSTA, ASSOCIADO A EDEMA E SANGRAMENTO.
AVALIADA PRESENÇA DE CONTAMINAÇÃO (TERRA, DETRITOS, CORPO ESTRANHO).

EF: AVALIADA PERFUSÃO DISTAL (PREENCHIMENTO CAPILAR < 2 SEG), SENSIBILIDADE E MOBILIDADE, SEM/COM DÉFICIT NEUROVASCULAR.
CLASSIFICAÇÃO DE GUSTILO (SE POSSÍVEL): TIPO I / II / III.

CONDUTA IMEDIATA (PS):
REALIZADA ANALGESIA.
REALIZADA IRRIGAÇÃO ABUNDANTE COM SF 0,9% E COBERTURA COM CURATIVO ESTÉRIL (SEM FECHAMENTO PRIMÁRIO).
IMOBILIZAÇÃO DO MEMBRO COM TALA ADEQUADA.
REALIZADO ACESSO VENOSO.
INICIADA ANTIBIOTICOTERAPIA PRECOCE.
VERIFICADO/ATUALIZADO ESTADO VACINAL PARA TÉTANO.
ENCAMINHO PARA O SERVIÇO DE ORTOPEDIA CIRÚRGICA.

ANTIBIÓTICOS (COLINHA PRÁTICA)
GUSTILO I (LEVE CONTAMINAÇÃO E LESÃO DE PARTES MOLES, < 1 CM) E II (MODERADA CONTAMINAÇÃO E LESÃO DE PARTES MOLES, > 1 CM):
CEFAZOLINA 1G EV 8/8H

GUSTILO III (ALTA CONTAMINAÇÃO E LESÃO DE PARTES MOLES, > 10 CM):
CEFAZOLINA 1G EV 8/8H
GENTAMICINA 5 MG/KG EV 1X/DIA

CONTAMINAÇÃO COM TERRA / RISCO ANAERÓBIO: METRONIDAZOL 500 MG EV 8/8H

TÉTANO
VACINA DESATUALIZADA OU DESCONHECIDA: → VACINA + IMUNOGLOBULINA ANTITETÂNICA
VACINA ATUALIZADA: → NÃO NECESSITA IG, AVALIAR REFORÇO

Fratura de rádio distal sem desvio → 5.5 Fratura do rádio distal (Colles), p. 109

PACIENTE COM HISTÓRIA DE TRAUMA EM MEMBRO SUPERIOR (QUEDA SOBRE MÃO ESTENDIDA / TRAUMA DIRETO).
REFERE DOR EM REGIÃO DE PUNHO, ASSOCIADA A EDEMA LOCAL E LIMITAÇÃO DE MOVIMENTOS.
AO EXAME, APRESENTA DOR À PALPAÇÃO EM REGIÃO DE RÁDIO DISTAL, COM EDEMA LOCAL, SEM DEFORMIDADE EVIDENTE. SEM FERIMENTOS ASSOCIADOS.
EF: MOBILIDADE DO PUNHO LIMITADA POR DOR. AVALIADA PERFUSÃO DISTAL (PREENCHIMENTO CAPILAR < 2 SEG), SENSIBILIDADE PRESERVADA E MOVIMENTAÇÃO DOS DEDOS PRESENTE, SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR.
RX DE PUNHO: EVIDENCIA FRATURA DE RÁDIO DISTAL, SEM DESVIO.

CONDUTA:
REALIZADA IMOBILIZAÇÃO COM TALA GESSADA TIPO ANTEBRAQUIOPALMAR, MANTENDO PUNHO EM POSIÇÃO FUNCIONAL.
ORIENTADO ELEVAÇÃO DO MEMBRO E APLICAÇÃO DE GELO LOCAL (20 MIN, 3-4X/DIA) NAS PRIMEIRAS 48H.
PRESCRITA ANALGESIA CONFORME NECESSIDADE.
MANTER IMOBILIZAÇÃO, EVITAR APOIO DO MEMBRO ACOMETIDO.
ORIENTADO OBSERVAR SINAIS DE ALERTA: AUMENTO IMPORTANTE DA DOR, PARESTESIAS, PALIDEZ OU FRIEZA DISTAL, EDEMA PROGRESSIVO (→ SUSPEITA DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL OU COMPROMETIMENTO VASCULAR).
ENCAMINHADO PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA / RETORNO AMBULATORIAL EM 7 DIAS PARA REAVALIAÇÃO E NOVO RX.

Fratura de Colles (rádio distal com desvio dorsal) → 5.5 Fratura do rádio distal (Colles), p. 109

PACIENTE COM HISTÓRIA DE QUEDA SOBRE MÃO ESTENDIDA.
REFERE DOR INTENSA EM PUNHO, EDEMA E DEFORMIDADE LOCAL.
AO EXAME, OBSERVA-SE DEFORMIDADE TÍPICA EM "DORSO DE GARFO", EDEMA E DOR À PALPAÇÃO.
EF: AVALIADA PERFUSÃO DISTAL, SENSIBILIDADE E MOBILIDADE DOS DEDOS, SEM/COM ALTERAÇÃO NEUROVASCULAR.
RX: FRATURA DE RÁDIO DISTAL COM DESVIO DORSAL.

CONDUTA:
REALIZADA ANALGESIA.
REALIZADA REDUÇÃO FECHADA (SE INDICADO).
IMOBILIZAÇÃO COM TALA GESSADA ANTEBRAQUIOPALMAR.
ENCAMINHADO PARA ORTOPEDIA.
ORIENTAÇÕES DE ALERTA (NEUROVASCULAR + COMPARTIMENTAL).

Entorse de tornozelo sem fratura → 10.1 Entorse de tornozelo, p. 177

PACIENTE COM ENTORSE DE TORNOZELO (INVERSÃO/EVERSÃO).
REFERE DOR, EDEMA E DIFICULDADE PARA DEAMBULAR.
AO EXAME, EDEMA EM REGIÃO MALEOLAR, DOR À PALPAÇÃO LIGAMENTAR, SEM DEFORMIDADE.
EF: APOIO POSSÍVEL/IMPOSSÍVEL. SEM DÉFICIT NEUROVASCULAR.
RX: SEM FRATURA.

CONDUTA:
RICE (REPOUSO, GELO, COMPRESSÃO, ELEVAÇÃO).
IMOBILIZAÇÃO COM TORNOZELEIRA OU TALA.
ANALGESIA.
ORIENTAR EVITAR CARGA SE DOR INTENSA.
REAVALIAÇÃO SE PIORA.

Fratura de tornozelo (maleolar) → 2.5 Fraturas do tornozelo (maléolos), p. 57

PACIENTE COM TRAUMA EM TORNOZELO, COM DOR INTENSA E INCAPACIDADE DE APOIO.
AO EXAME, EDEMA IMPORTANTE, DOR À PALPAÇÃO MALEOLAR, +/- DEFORMIDADE.
EF: CHECAR PERFUSÃO, SENSIBILIDADE E MOBILIDADE DISTAL.
RX: FRATURA MALEOLAR.

CONDUTA:
IMOBILIZAÇÃO COM TALA SUROPODÁLICA.
NÃO APOIAR MEMBRO.
ANALGESIA.
ENCAMINHAMENTO ORTOPEDIA (URGENTE SE DESVIO).

Fratura de metacarpo (boxer — 5º metacarpo) → 6.2 Fraturas de metacarpo e falanges (soco e esmagamento), p. 122

PACIENTE COM TRAUMA EM MÃO (SOCO/IMPACTO).
REFERE DOR E EDEMA EM REGIÃO DE MÃO.
AO EXAME, DOR À PALPAÇÃO EM 5º METACARPO, EDEMA, +/- DESVIO.
EF: AVALIAR ALINHAMENTO DOS DEDOS (ROTAÇÃO!), PERFUSÃO E SENSIBILIDADE.
RX: FRATURA DE METACARPO.

CONDUTA:
IMOBILIZAÇÃO COM TALA ULNAR (TIPO "LUVA").
ANALGESIA.
ENCAMINHAR ORTOPEDIA.

Fratura de falange → 6.2 Fraturas de metacarpo e falanges (soco e esmagamento), p. 122

PACIENTE COM TRAUMA EM DEDO, COM DOR, EDEMA E LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO.
AO EXAME, EDEMA LOCAL, DOR À PALPAÇÃO, SEM/COM DEFORMIDADE.
EF: MOBILIDADE, SENSIBILIDADE E PERFUSÃO PRESERVADAS.
RX: FRATURA DE FALANGE.

CONDUTA:
IMOBILIZAÇÃO (SINDACTILIA OU TALA).
ANALGESIA.
ORIENTAÇÃO FUNCIONAL.

Fratura de clavícula → 4.4 Fratura de clavícula, p. 97

PACIENTE COM QUEDA SOBRE OMBRO.
REFERE DOR EM REGIÃO CLAVICULAR.
AO EXAME, DOR LOCAL, CREPITAÇÃO, POSSÍVEL DEFORMIDADE.
EF: AVALIAR PLEXO BRAQUIAL E PERFUSÃO.
RX: FRATURA DE CLAVÍCULA.

CONDUTA:
IMOBILIZAÇÃO COM TIPOIA.
ANALGESIA.
ORIENTAR EVITAR ELEVAÇÃO DO MEMBRO.
SE DESVIO IMPORTANTE → ORTOPEDIA.

Fratura de úmero proximal → 2.6 Fratura do úmero proximal, p. 61

PACIENTE COM QUEDA, DOR EM OMBRO E LIMITAÇÃO IMPORTANTE.
AO EXAME, DOR À PALPAÇÃO E IMPOTÊNCIA FUNCIONAL.
EF: AVALIAR NERVO AXILAR (SENSIBILIDADE DO DELTOIDE!).
RX: FRATURA DE ÚMERO PROXIMAL.

CONDUTA:
TIPOIA.
ANALGESIA.
ENCAMINHAMENTO ORTOPEDIA.

Pedido de regulação — urgência (vaga zero) do guia → 1.6 Regulação no SUS: quem vai para a cirurgia e como pedir, p. 21

SOLICITAÇÃO DE VAGA — URGÊNCIA ORTOPÉDICA

PACIENTE: _____, _____ ANOS, _____ KG. CNS: _____.
DIAGNÓSTICO: _____ (CID _____). MECANISMO: _____ ÀS _____ H.
ESTADO ATUAL: HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL (PA _____, FC _____, SPO2 _____ %). GLASGOW 15. SEM OUTRAS LESÕES.
MEMBRO: PULSOS _____, ENCHIMENTO CAPILAR _____, SENSIBILIDADE/MOTRICIDADE _____. PELE _____ (ÍNTEGRA / FERIDA DE _____ CM).
JÁ REALIZADO: ANALGESIA (_____), IMOBILIZAÇÃO (_____), ANTIBIÓTICO (_____ ÀS _____ H), TÉTANO (_____), JEJUM DESDE _____ H, ACESSO VENOSO, EXAMES (_____).
IMAGEM: RX _____ — _____ (ANEXO / DISPONÍVEL NO SISTEMA).
MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA: NECESSIDADE DE _____ (DESBRIDAMENTO / REDUÇÃO ABERTA / FIXAÇÃO / FASCIOTOMIA / DRENAGEM / AVALIAÇÃO VASCULAR) NÃO DISPONÍVEL NESTA UNIDADE.
PRIORIDADE: _____ (EMERGÊNCIA — EM HORAS / URGÊNCIA — EM 24 H).
TRANSPORTE SUGERIDO: _____ (USA / USB) COM ACOMPANHANTE.
MÉDICO SOLICITANTE: _____ CRM _____. UNIDADE: _____. TELEFONE: _____. DATA/HORA: _____.

Encaminhamento eletivo — ambulatório de ortopedia (SISREG/CROSS) do guia → 1.6 Regulação no SUS: quem vai para a cirurgia e como pedir, p. 21

ENCAMINHAMENTO PARA ORTOPEDIA — _____ (SUBESPECIALIDADE: MÃO / OMBRO / JOELHO / QUADRIL / PÉ / COLUNA / PEDIÁTRICA)

PACIENTE: _____, _____ ANOS. CNS: _____. PROFISSÃO: _____.
HIPÓTESE DIAGNÓSTICA: _____ (CID _____).
HISTÓRIA RESUMIDA: _____ HÁ _____ MESES/SEMANAS. LADO _____. MECANISMO: _____.
EXAME FÍSICO: _____ (ACHADOS QUE JUSTIFICAM).
EXAMES: RX _____ EM _____/_____/_____: _____. OUTROS: _____.
TRATAMENTO JÁ FEITO E RESULTADO: _____ (ANALGESIA / IMOBILIZAÇÃO / INFILTRAÇÃO / FISIOTERAPIA POR _____ SEMANAS) — SEM MELHORA SATISFATÓRIA.
MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO: AVALIAÇÃO PARA _____ (CIRURGIA / INFILTRAÇÃO GUIADA / SEGUIMENTO ESPECIALIZADO).
PRIORIDADE: _____ (ROTINA / PRIORITÁRIO — JUSTIFICATIVA: _____).
COMORBIDADES: _____. MUC: _____. ALERGIAS: _____.
MÉDICO: _____ CRM _____. UNIDADE: _____. DATA: _____.

Atestado médico — afastamento com restrição do guia → 1.4 Atestado e afastamento, p. 16

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A) SR(A). _____, PORTADOR(A) DO RG/CPF _____, FOI ATENDIDO(A) NESTA UNIDADE EM _____/_____/_____ ÀS _____ H E NECESSITA DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS/ESCOLARES POR _____ (_____) DIAS, A PARTIR DESTA DATA, POR MOTIVO DE DOENÇA.
RESTRIÇÃO: _____ (SEM APOIAR O MEMBRO _____ / SEM CARGA ACIMA DE 5 KG / SEM USO DO MEMBRO SUPERIOR _____ / SEM EDUCAÇÃO FÍSICA).
CID: _____ (INFORMADO COM AUTORIZAÇÃO DO(A) PACIENTE).
RETORNO MARCADO PARA _____/_____/_____.

_____, _____/_____/_____

_____
DR(A). _____ — CRM _____

Atestado de acompanhante (criança / idoso dependente) do guia → 1.4 Atestado e afastamento, p. 16

ATESTADO DE ACOMPANHANTE

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A) SR(A). _____, RG/CPF _____, ACOMPANHOU O(A) PACIENTE _____ (_____ ANOS), SEU/SUA _____ (FILHO(A) / MÃE / PAI), EM ATENDIMENTO NESTA UNIDADE EM _____/_____/_____, DAS _____ ÀS _____ H, E NECESSITA PERMANECER COMO ACOMPANHANTE POR _____ DIA(S) EM RAZÃO DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS.
CID DO(A) PACIENTE: _____ (COM AUTORIZAÇÃO).

_____, _____/_____/_____

_____
DR(A). _____ — CRM _____

Declaração de comparecimento do guia → 1.4 Atestado e afastamento, p. 16

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A) SR(A). _____, RG/CPF _____, COMPARECEU A ESTA UNIDADE EM _____/_____/_____, DAS _____ ÀS _____ H, PARA ATENDIMENTO MÉDICO.

_____, _____/_____/_____

_____
DR(A). _____ — CRM _____

Orientações por escrito — tala / gesso / tipoia do guia → 1.3 Imobilizações e órteses, p. 12

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE — IMOBILIZAÇÃO

1. MANTENHA O MEMBRO ELEVADO (ACIMA DO CORAÇÃO) NAS PRIMEIRAS 48 HORAS, PRINCIPALMENTE À NOITE.
2. MEXA OS DEDOS VÁRIAS VEZES AO DIA. NÃO MOLHE A TALA/GESSO; PROTEJA COM SACO PLÁSTICO NO BANHO.
3. NÃO COLOQUE NADA DENTRO DA TALA PARA COÇAR. NÃO APERTE A ATADURA.
4. NÃO APOIE / NÃO PEGUE PESO COM O MEMBRO ATÉ A REAVALIAÇÃO.
5. TOME A ANALGESIA CONFORME A RECEITA.

VOLTE IMEDIATAMENTE AO PRONTO-SOCORRO SE:
- DOR QUE AUMENTA E NÃO MELHORA COM O REMÉDIO;
- DEDOS ROXOS, BRANCOS, FRIOS, INCHADOS OU DORMENTES;
- FORMIGAMENTO OU PERDA DE FORÇA NOS DEDOS;
- TALA/GESSO APERTADO, QUEBRADO OU MOLHADO;
- FEBRE OU MAU CHEIRO.

RETORNO MARCADO: _____/_____/_____ ÀS _____ H, EM _____.
TELEFONE DA UNIDADE: _____.

Nota de alta — fratura tratada com tala no PS do guia → 1.3 Imobilizações e órteses, p. 12

ALTA DO PRONTO-SOCORRO

DIAGNÓSTICO: _____ (CID _____), _____ (LADO).
REALIZADO: ANALGESIA, _____ (REDUÇÃO FECHADA / BLOQUEIO), IMOBILIZAÇÃO COM _____, RX DE CONTROLE: _____.
NEUROVASCULAR NA ALTA: PULSOS PRESENTES, ENCHIMENTO CAPILAR < 2 S, SENSIBILIDADE E MOTRICIDADE DOS DEDOS PRESERVADAS.
ORIENTAÇÕES DA IMOBILIZAÇÃO ENTREGUES POR ESCRITO (SINAIS DE ALERTA, ELEVAÇÃO, NÃO MOLHAR, NÃO APOIAR).
RECEITA: _____. ATESTADO: _____ DIAS, COM RESTRIÇÃO _____.
RETORNO: _____ DIAS, COM RX DE CONTROLE, NO _____ (AMBULATÓRIO / UBS / ESTE PS).
ENCAMINHAMENTO: _____ (ORTOPEDIA PELA REGULAÇÃO, PRIORIDADE _____).
PACIENTE E ACOMPANHANTE CIENTES. SAI DEAMBULANDO / EM CADEIRA DE RODAS / COM MULETAS.

Nota de procedimento — redução de luxação de ombro do guia → 4.3 Luxação e instabilidade do ombro, p. 93

PROCEDIMENTO: REDUÇÃO FECHADA DE LUXAÇÃO ANTERIOR DO OMBRO _____.
RX PRÉ-REDUÇÃO (AP + AXILAR/Y): LUXAÇÃO ANTERIOR, SEM FRATURA / COM FRATURA DO TUBÉRCULO MAIOR.
NERVO AXILAR ANOTADO ANTES: SENSIBILIDADE LATERAL DO OMBRO _____.
ANALGESIA: LIDOCAÍNA 1% 20 ML INTRA-ARTICULAR / SEDAÇÃO (_____).
TÉCNICA: ROTAÇÃO EXTERNA LENTA / CUNNINGHAM / TRAÇÃO-CONTRATRAÇÃO — _____ TENTATIVA(S), REDUZIDA ÀS _____ H, COM RESSALTO E ALÍVIO IMEDIATO.
NEUROVASCULAR APÓS: PRESERVADO (DELTOIDE E SENSIBILIDADE LATERAL).
RX DE CONTROLE: CONGRUENTE, SEM FRATURA NOVA.
TIPOIA POR 1–3 SEMANAS; MOVIMENTO DE COTOVELO E MÃO DESDE JÁ. ANALGESIA. ORIENTAÇÕES.
RETORNO EM 7 DIAS. JOVEM COM PRIMEIRA LUXAÇÃO: ENCAMINHADO AO AMBULATÓRIO DE OMBRO (RISCO DE RECIDIVA).

Nota de procedimento — redução de Colles e tala do guia → 5.5 Fratura do rádio distal (Colles), p. 109

PROCEDIMENTO: REDUÇÃO FECHADA DE FRATURA DO RÁDIO DISTAL _____ COM DESVIO DORSAL.
ANALGESIA: BLOQUEIO DE HEMATOMA COM LIDOCAÍNA 1% SEM VASOCONSTRITOR _____ ML (SANGUE ESCURO ASPIRADO — NO FOCO). AGUARDADOS 10 MIN.
TÉCNICA: AJUDANTE EM CONTRATRAÇÃO NO BRAÇO; TRAÇÃO NO EIXO, DESIMPACTAÇÃO COM HIPEREXTENSÃO, POLEGARES NO FRAGMENTO DISTAL EMPURRANDO PARA A PALMA, FLEXÃO DO PUNHO E DESVIO ULNAR.
IMOBILIZAÇÃO: TALA GESSADA ANTEBRAQUIOPALMAR (OU SUGAR-TONG) COM PUNHO EM LEVE FLEXÃO E DESVIO ULNAR, MOLDAGEM EM 3 PONTOS, MF LIVRES.
RX DE CONTROLE: INCLINAÇÃO RADIAL _____°, TILT VOLAR _____°, ENCURTAMENTO _____ MM — REDUÇÃO ACEITÁVEL / INSUFICIENTE.
NEUROVASCULAR APÓS: PRESERVADO (MEDIANO TESTADO).
ALTA COM ANALGESIA, ELEVAÇÃO, ORIENTAÇÕES ESCRITAS; RETORNO EM 7 DIAS COM RX (PERDA DE REDUÇÃO?).
INSTÁVEL OU ARTICULAR COM DEGRAU → REGULAÇÃO PARA FIXAÇÃO.

Nota de procedimento — punção / infiltração de joelho do guia → 1.8 Punção e infiltração: joelho, ombro, punho e mão, quadril, p. 30

PROCEDIMENTO: ARTROCENTESE DE JOELHO _____ (VIA SUPEROLATERAL) _____ INFILTRAÇÃO.
CONSENTIMENTO VERBAL. ASSEPSIA COM CLOREXIDINA, CAMPO E LUVAS ESTÉREIS. AGULHA 21G.
ASPIRADOS _____ ML DE LÍQUIDO _____ (CITRINO / TURVO / HEMÁTICO / COM GORDURA).
ENVIADO PARA: CELULARIDADE, GRAM, CULTURA, CRISTAIS.
INFILTRAÇÃO: TRIANCINOLONA 40 MG + LIDOCAÍNA 1% _____ ML (SÓ APÓS EXCLUIR INFECÇÃO).
SEM INTERCORRÊNCIAS. CURATIVO OCLUSIVO.
ORIENTADO: REPOUSO RELATIVO 24–48 H; A DOR PODE PIORAR POR 1–2 DIAS; RETORNO EM 48 H SE DOR CRESCENTE, CALOR OU FEBRE.

O que não espera — a lista para a passagem de plantão do guia → 1.5 O que não espera: o que você resolve hoje e o que vai para a cirurgia, p. 18

URGÊNCIA CIRÚRGICA HOJE (REGULAÇÃO DE URGÊNCIA / CENTRO CIRÚRGICO):
- FRATURA EXPOSTA (ANTIBIÓTICO ANTES DO RX, DESBRIDAMENTO EM 24 H)
- MEMBRO SEM PULSO / SÍNDROME COMPARTIMENTAL (FASCIOTOMIA EM HORAS)
- LUXAÇÃO QUE NÃO REDUZIU (QUADRIL, JOELHO, TORNOZELO, COTOVELO, OMBRO)
- LUXAÇÃO DE JOELHO (AVALIAÇÃO VASCULAR)
- ARTRITE SÉPTICA (DRENAGEM NO MESMO DIA)
- CAUDA EQUINA (DESCOMPRESSÃO EM HORAS)
- FRATURA DE QUADRIL NO IDOSO (CIRURGIA EM 48 H — INTERNAÇÃO)
- SUPRACONDILIANA DESVIADA NA CRIANÇA (GARTLAND II/III)
- LESÃO DE TENDÃO FLEXOR / REIMPLANTE / LESÃO VASCULAR

PODE ESPERAR DIAS (AMBULATÓRIO PELA REGULAÇÃO):
- FRATURA QUE A TALA NÃO SEGURA, ARTICULAR COM DEGRAU, INSTÁVEL
- RUPTURA DO APARELHO EXTENSOR, TENDÃO DE AQUILES
- LESÃO DE LISFRANC, FRATURA DE JONES

RESOLVE AQUI: ENTORSES, FRATURAS SEM DESVIO, LUXAÇÕES SIMPLES REDUZIDAS, INFILTRAÇÕES, FERIMENTOS SIMPLES.

INCIDÊNCIAS DO RAIO-X

o que pedir por região

Incidências por região → 1.1 Como pedir o raio-X, p. 6

PÉ: AP + OBLÍQUO + PERFIL
TORNOZELO: AP + PERFIL + MORTISE
PERNA: AP + PERFIL
JOELHO: AP + PERFIL
PATELA: AP + PERFIL + AXIAL
COXA: AP + PERFIL
QUADRIL: AP + PERFIL
BACIA: AP
COLUNA (LOMBAR, TORÁCICA, CERVICAL): AP + PERFIL
MÃO: AP + OBLÍQUO + PERFIL
PUNHO: AP + PERFIL
ANTEBRAÇO: AP + PERFIL
COTOVELO: AP + PERFIL
BRAÇO: AP + PERFIL
OMBRO: AP VERDADEIRO + PERFIL ESCAPULAR + AXILAR
CLAVÍCULA: AP + ZANCA (BICOMIAL OU BILATERAL)